



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JUNI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang	2
2.1 Visi.....	2
2.2 Misi.....	2
2.3 Motto.....	2
2.4 7 Nilai Budi Utama.....	2
2.5 Struktur Organisasi.....	3
Bab III Laporan Kinerja Pelayanan	4
3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI).....	4
3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO.....	4
3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO.....	4
3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut.....	4
3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan.....	5
3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada.....	6
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan.....	16
3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik.....	16
3.3.2 Rawat Inap.....	19
3.3.3 Intensive Care Unit (ICU).....	29
3.3.4 High Care Unit (HCU).....	30
3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD).....	31
3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO).....	32
3.4 Kinerja Bidang Penunjang.....	33
3.4.1 Instalasi Farmasi.....	33
3.4.2 Laboratorium.....	58
3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran.....	64
3.4.4 Radiologi.....	73
3.4.5 Gizi.....	80
3.4.6 CSSD - Laundry.....	85
3.5 Kinerja Bidang Umum.....	90
3.5.1 SDM.....	90
3.5.2 IPSRS.....	99
3.5.3 Security.....	108
3.5.4 Parkir.....	113
3.5.5 Humas Marketing.....	113
3.5.6 Penjaminan.....	144
3.5.7 PIPP – MOD – MPP.....	144
3.5.8 <i>Cleaning Service</i>	153
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum.....	153
3.5.10 IT - SIMRS.....	155
3.5.11 Driver.....	166
3.5.12 PRIMANTARA.....	166
3.6 Komite dan Tim.....	168
3.6.1 Komite Mutu.....	168
3.6.2 Komite PPI.....	244
3.6.3 Tim PKRS.....	264
3.6.4 Tim Prognas.....	265
3.6.5 Tim PPRA.....	307
3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT.....	313
3.7 Permasalahan Rumah Sakit.....	316
3.8 Profil SDM.....	324
Bab IV Kesimpulan dan Saran	328
Bab V Penutup	329

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Juni Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



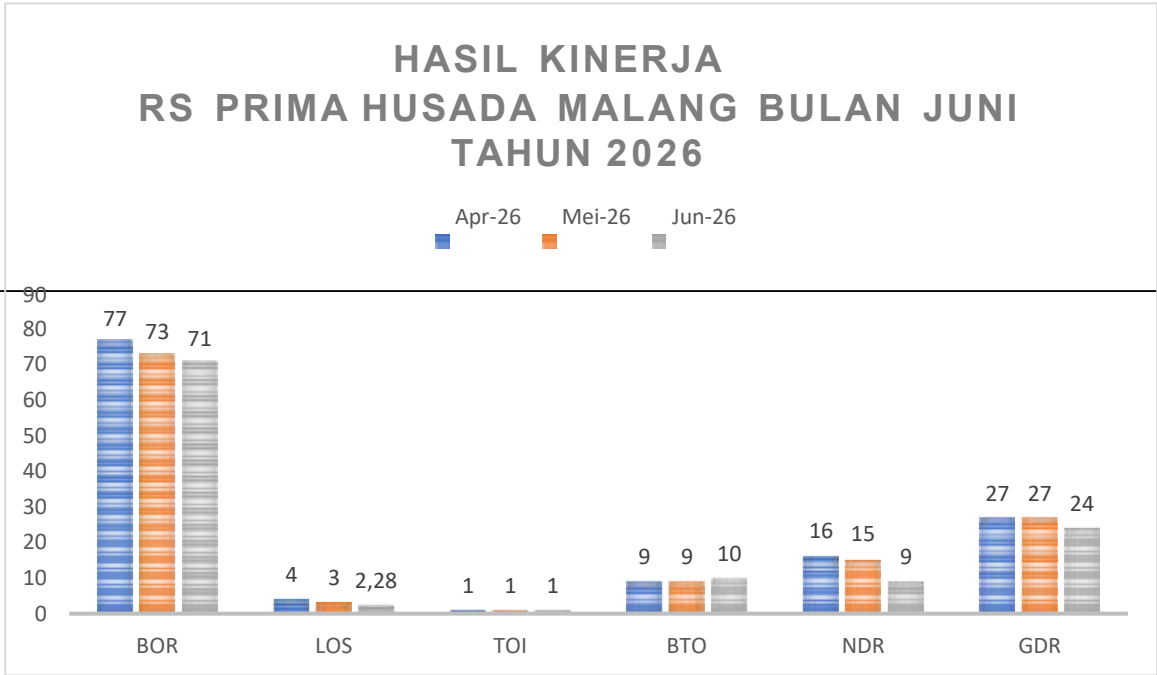
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
BOR	77	73	71
LOS	4 hari	3 hari	2,28 hari
TOI	1 hari	1 hari	1 hari
BTO	9 hari	9 hari	10 hari

Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

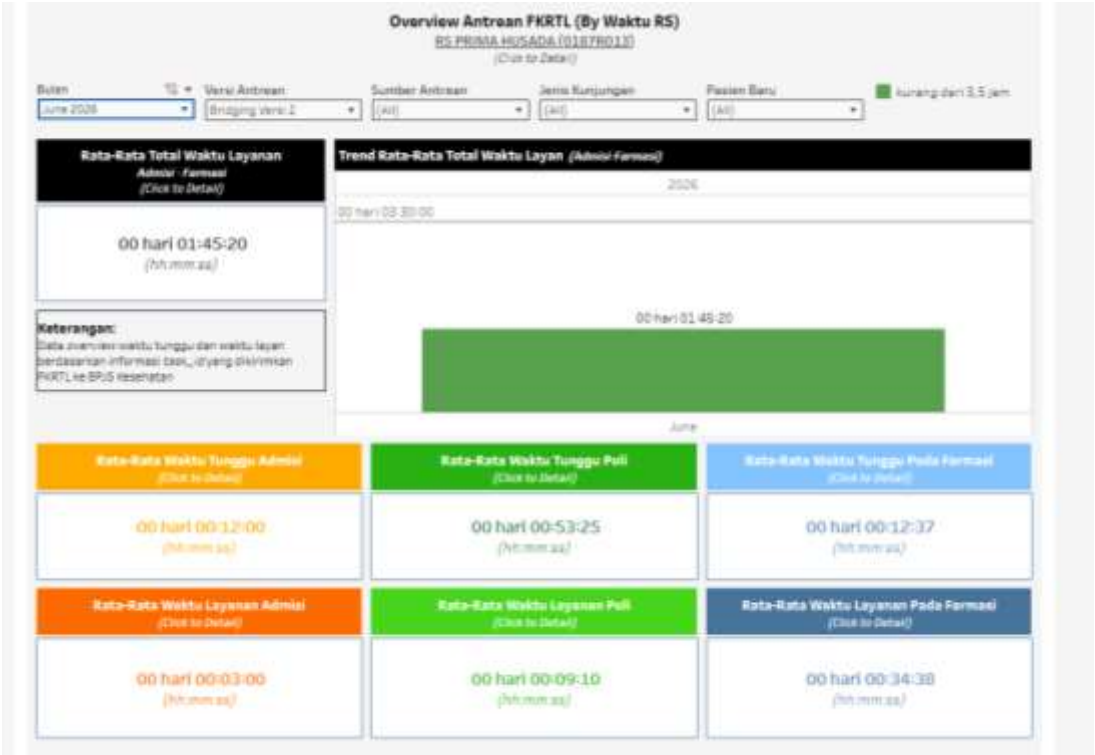


3.1.1 Tabel Analisa, Masalah dan Tindak Lanjut

INDIKATOR	ANALISA	MASALAH	RTL (RENCANA TINDAKLANJUT)
BOR (Bed Occupancy Rate)	Nilai BOR rumah sakit masih berada pada kisaran yang baik, namun terdapat variasi antar unit. ICU memiliki BOR relatif rendah, sedangkan ruang kelas III dan maternitas memiliki tingkat hunian lebih tinggi.	Pemanfaatan tempat tidur belum merata di seluruh unit perawatan.	Melakukan monitoring BOR perunit setiap bulan, evaluasi distribusi pasien, serta optimalisasi penempatan pasien sesuai kapasitas dan kelas perawatan.
ALOS (Average Length of Stay)	Lama rawat rata-rata masih sesuai karakteristik kasus, namun terdapat beberapa pasien dengan lama rawat yang lebih panjang karena komplikasi atau menunggu rujukan.	Lama rawat beberapa pasien meningkat akibat keterlambatan pemeriksaan penunjang, konsultasi, atau proses rujukan.	Mempercepat koordinasi DPJP, pemeriksaan penunjang, discharge planning sejak awal perawatan, serta monitoring pasien dengan LOS tinggi.
TOI (Turn Over Interval)	TOI menunjukkan masih terdapat tempat tidur yang kosong sebelum digunakan kembali, terutama pada unit dengan BOR rendah.	Belum optimalnya pemanfaatan tempat tidur pada beberapa ruang perawatan.	Melakukan evaluasi manajemen bed setiap hari melalui bed management meeting dan mempercepat proses cleaning bed setelah pasien pulang.

BTO (Bed TurnOver)	Frekuensi penggunaan tempat tidur cukup baik pada sebagian besar unit, namun masih terdapat perbedaan antar ruang.	Distribusi pasien belum merata sehingga turnover antar ruang tidak seimbang.	Mengoptimalkan sistem informasi ketersediaan tempat tidur dan koordinasi admission dengan seluruh unit.
--------------------	--	--	---

3.1 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN	BULAN (2026)							
		Rata-Rata Tahun 2024	Rata - rata Tahun 2025	1	2	3	4	5	6
1	Total Waktu Layanan	2:12:37	01:46:32	1:46:40	1:41:56	1:43:59	1:32:41	1:56:26	1:45:20
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	0:08:14	0:12:00	00:12:00	0:12:00	0:12:00	0:12:00	0:12:00
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	0:06:01	0:03:00	0:03:00	0:03:00	0:03:00	0:03:00	0:03:00
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	0:58:16	00:56:31	00:53:52	00:50:51	00:55:59	00:55:53	00:53:25
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	0:09:55	0:10:13	0:10:01	0:09:30	0:10:20	0:10:33	0:09:10
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	0:09:02	0:09:57	0:14:48	0:16:30	0:17:06	0:16:04	0:12:37
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	0:36:47	0:32:48	0:36:36	0:31:05	0:33:49	0:39:30	0:34:48

Analisis :
Pada bulan ini masih Lebih rendah dari rata-rata tahun 2024 dan tahun 2025.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.3 Bidang Pelayanan dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRJA	MCU premium	1. Mengidentifikasi pasien Perusahaan atau mandiri yang berencana MCU dengan dokter spesialis dan paket pemeriksaan lengkap 2. Menjaring Kerjasama koordinasi dengan Humas untuk MCU ditawarkan menggunakan dokter spesialis bukan dokter umum dengan harga terjangkau	1. Kunjungan pasien masih sedikit 2. Dengan standart harga yang cukup tinggi, dibutuhkan untuk marketing lebih konsisten dan mengenalkan ke masyarakat luas tidak hanya lewat sosmed atau door to door ke perusahaan.
2	IRJA-Poli MCU	Penerimaan MCU corporate	1. Humas menghubungi Perusahaan untuk penawaran MCU 2. Surat penawaran untuk Perusahaan sudah di acc PT dengan tarif margin yang paling rendah	1. MCU Perusahaan BSI masih belum bisa terlaksana karena ada kendala IKS dengan Mandiri Inhealth. 2. BSI menggunakan Mandiri inhealth untuk general check up 38 karyawannya 3. Karena di malang hanya ada 3 RS yang di tetapkan untuk MIH, sehingga PHM belum bisa menerima MCU

				tsb tahun ini, bisa pengajuan untuk tahun depan 4. Koordinasi dan follow up kembali terkait pengajuan RSPHM sebagai RS penerima layanan MCU Perusahaan
4	IRJA-IRNA	Meningkatkan kewaspadaan pelaporan kasus PD31	1. Karena wabah KLB campak di berbagai daerah, dinkes menghimbau RS untuk waspada terhadap peningkatan kasus campak 2. Pelaporan dan pengambilan sampel harus real time dan dilaporkan ke puskesmas agar dipantau dan di petakan daerah yang positif terpapar 3. Meningkatkan komunikasi dengan puskesmas baik di grup maupun tata laksana pelaporan kasus	1. Kasus pelaporan yang sulit ada di rawat jalan, karena pasien sudah KRS dan kesulitan dalam pengambilan sampel 2. Koordinasi dengan PKM agar diteruskan ke Perawat desa untuk ditindaklanjuti
5	IRJA	Absensi fingerprint DPJP	1. Mitigasi resiko untuk kepatuhan DPJP terhadap HFIS, setiap praktek poli atau yang terdaftar di HFIS wajib melakukan absensi datang dan pulang 2. Membuat surat edaran terkait pelaksanaan dan pendaftaran fingerprint 3. Pendaftaran fingerprint dilakukan oleh SDM, yanmed, karu irja dan dibantu IT	1. Pelaksanaan fingerprint dimulai tanggal 4 Juni 2026 2. Kendala ada beberapa DPJP yang kesulitan absen karena dengan sidik jari tidak terdetect 3. Untuk tindaklanjut dilakukan pendaftaran finger

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Fitur cetak KPO sudah terlaksana pada tanggal 17 Desember 2025. b. Belum tersedia cover untuk arsip KPO pasien. c. Jumlah KPO tertinggal : 151.	Cover KPO tidak acc oleh managemen. Rencana menggunakan scan barcode untuk melihat data e-kpo.
		2. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam vaccine refirigerator disertai Log tag. b. Tersedia cctv dan smart door lock.	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan vaccine refirigerator.
		3. Pendaftaran pengantaran obat primantara di Farmasi	Fitur “antar obat” di SIMRS sudah tersedia dan ada laporan penjualan obat diantar. Namun kekurangannya tidak ada kolom asal poli, jam pemesanan, obat selesai, biaya, cara bayar, jarak pengiriman dan serah terima farmasi dan kurir primantara sehingga pendataan pasien menggunakan google spreadsheet primantara.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet.
		4. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga vokasi farmasi kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Belum ada fitur pemisahan resep	Pengajuan fitur ke progamer.

			masuk kronis dan non kronis.	
		5. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		6. Pelayanan retriaksi obat kronis: penambahan fitur Centang “Perlu Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi.	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		7. Penambahan Fitur Laporan Rekap Penjualan Obat Kronis Per Nota, Laporan Resep Iter, Dan Laporan Resep PRB Di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu: a. Format “Laporan Rekap Penjualan Obat Kronis Per Nota”, berisi: nomor, nomor registrasi, tanggal registrasi, no. rm, nama pasien, nama dokter unit asal, no. kartu, no. sep, no. nota, tgl. Nota, nama obat, jumlah obat, hasil pemeriksaan penunjang. b. Format laporan resep iter, berisi: nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah	Pengajuan fitur ke progamer.

			obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi: nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKRTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		8. Rekam medis beralih ke E-RM	Fitur E-RM yang sudah tersedia di SIMRS : - Rekonsiliasi obat - Daftar pemberian obat - Catatan Riwayat Penggunaan Obat - Daftar Tilik Serah Terima Obat Farmasi - Rawat Inap Fitur E-RM yang belum tersedia di SIMRS : - Pemantauan Terapi Obat	Fitur E-RM yang belum tersedia di SIMRS : Pemantauan Terapi Obat. Dalam antrian progamer.
		9. ERM :Pemberian edukasi penggunaan obat pulang (Pasien rawat inap)	Penambahan fitur Pemberian Edukasi Penggunaan Obat Pulang. Data “Resep Final” langsung muncul sesuai obat yang ada di “Ringkasan Pulang” bagian “Obat Pulang” sehingga farmasi bisa langsung ttd serah terima obat di depo farmasi.	Pengajuan fitur ke progamer.
		10. Pemberian informasi tentang obat yang akan diberikan kepada pasien rawat jalan	Pemberian informasi tentang obat yang akan diberikan kepada pasien rawat jalan sudah tersedia di resep namun belum ada	Pengajuan fitur ke progamer.

			keterangan di kolom penerima obat "Pasien telah menerima KIE serta instruksi obat oleh petugas farmasi". Mengajukan fitur di SIMRS agar langsung tercetak di kolom penerima obat	
		11. Penambahan fitur potensi PRB	Belum tersedia fitur identifikasi obat-obatan rutin dinotifikasi dalam SIMRS farmasi untuk dijadikan data potensi PRB dan disampaikan ke DPJP.	Pengajuan fitur ke progamer.
		12. Penambahan fitur validasi resep di poli untuk obat yang ditinggal dan ditunggu	a. Belum tersedia fitur validasi resep di poli untuk obat yang ditinggal dan ditunggu b. Meminimalisir waktu tunggu pasien yang menunggu di farmasi dan mengurangi complain pasien.	Pengajuan fitur ke progamer.
		13. Penambahan fitur obat near ed muncul di SIMRS saat dokter input resep	Belum tersedia fitur obat near ed muncul di SIMRS saat dokter input resep, agar DPJP mengetahui obat yang akan habis kurang dari 6 bulan	Pengajuan fitur ke progamer.
		14. Penambahan fitur kelas terapi/ golongan obat saat input resep	Belum tersedia fitur kelas terapi/ golongan obat saat input resep untuk memudahkan DPJP jika terjadi kekosongan obat bisa langsung substitusi obat yang lain sesuai kelas terapi tanpa perlu konfirmasi ke farmasi.	Pengajuan fitur ke progamer.
		15. Penambahan fitur warning di SIMRS saat DPJP input resep yang sama	a. Tersedia fitur warning di SIMRS saat DPJP input resep yang sama. b. Memudahkan DPJP saat input resep agar tidak terjadi input resep yang sama dan mempercepat farmasi proses resep.	Pengajuan fitur ke progamer.
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024.	Monitoring dan evaluasi system elektronik

			c. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024. d. Scan barcode di SIMRS sudah di trial. Hasil evaluasi : - Penerimaan barang memerlukan waktu lama karna scanning hanya untuk pencarian nama barang namun jumlah, no. batch dan expired data di ketik manual. - Penyiapan barang memerlukan waktu lama dan meningkatkan kebutuhan tenaga. - Penggunaan sistem barcode menambah tahapan kerja karena petugas harus melakukan scanning satu per satu pada item yang disiapkan sehingga proses penyiapan menjadi lebih panjang dan memperlambat alur kerja. - Proses terhambat karena harus menambah master barcode terlebih dahulu. - Membutuhkan waktu lebih lama dalam pencarian item. Petugas harus melakukan pencarian manual dengan scroll daftar item sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan	
--	--	--	--	--

			dan menambahkan master barang. - Monitoring barang yang belum disiapkan menjadi sulit/kurang efektif karena petugas harus mengklik nama barang terlebih dahulu untuk melihat jumlah keluar, sehingga menyulitkan monitoring barang yang: • sudah disiapkan, • belum disiapkan, • maupun yang masih kurang. - Proses scanning terhambat, membutuhkan input manual, dan memperlambat penyiapan barang. - Efisiensi operasional belum tercapai. Proses masih membutuhkan tambahan tenaga dan waktu dibandingkan metode sebelumnya. - Menyebabkan ketidaksesuaian data, kebingungan dalam monitoring stok, dan potensi kesalahan pencatatan distribusi barang.	
		2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Follow up pengadaan katrol.
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Aplikasi ERM IRJA	1. Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan ERM 2. Kendala teknis sistem 3. Keterbatasan SDM	Sebagian besar poli telah menggunakan ERM, namun Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan

			dan adaptasi pengguna	ERM
		2. Pengiriman data kunjungan dan diagnosis pasien rawat jalan (ERM maupun non-ERM) ke SATU SEHAT	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	Monitoring dan Evaluasi.
		3. APM (Pendaftaran pasien BPJS yang sudah reservasi melalui mobile JKN)	Pasien BPJS yang sudah reservasi Mobile JKN tidak dapat diproses di APM masih harus diarahkan ke loket. TL: Memaksimalkan petugas menjaga APM dan memberikan arahan pada pasien.	Sebagian pasien BPJS sudah menggunakan APM, namun masih terdapat kegagalan proses pendafataran. Sosialisasi ulang kepada pasien terkait alur APM dan Mobile JKN.
		4. Retensi dan Pemusnahan Berkas DRM	1. Masih terdapat penumpukan DRM inaktif 2. Keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan 3. Proses digitalisasi (scan) belum seluruhnya selesai	1. Melanjutkan pemilahan DRM sesuai jadwal retensi 2. Prioritas penyelesaian DRM kematian dan DRM inaktif lama 3. Penjadwalan kegiatan scanning sebelum pemusnahan
Unit Laboratorium				
1	Laboratorium	1. Pengembangan Pelayanan LIS	Pemasangan server dan proses dari vendor sudah slesai, menunggu proses blicing dari SIMRS Rumah sakit.	Proses Blicing SIMRS
Unit Gizi				

1	Gizi	Pemesanan diet dari klinik Mitra (luar).	-Sudah ada kerjasama terkait pemesanan diet dari klinik luar. -Sudah dibuatkan SPO dan alur pemesanan diet melalui spreadsheet dan whatsapp. -Sudah dilakukan pengajuan tarif pelayanan pemesanan diet pada PT. -Sudah berjalan mulai awal Juni 2026.	- Tarif pelayanan pemesanan diet dari PT sudah disetujui dan dijalankan.
CSSD-LAUNDRY				
1	CSSD-Laundry	Monitoring pelayanan berbasis elektronik	-Sudah dilakukan dokumentasi indikator steril digital dengan spreadsheet. -Sudah dilakukan pencatatan serah terima paper less dengan spreadsheet.	- Monitoring kepatuhan pengisian
2	CSSD	Optimalisasi Tata Ruang dan Alur Kerja (Workflow)	-Penerapan Alur Satu Arah (One-Way Flow) -Sistem Transportasi Tertutup -Sekat Fisik yang Tegas -Sistem Tekanan Udara Sederhana	-Memastikan batas fisik yang tegas antara area kotor (Decontamination), area bersih (Packing/Assembly), dan area steril (Storage) -Menggunakan kontainer atau troli tertutup khusus untuk distribusi instrumen kotor dan instrumen steril demi menjaga sterilitas selama perjalanan -Sudah terpasang exhaust fan di area bersih.
RADIOLOGI				
1	Radiologi	Pengadaan upgrade system IT (SIMRS/PACS)	-Sudah dilakukan pengajuan bulan Maret 2026 -Sudah dilakukan penerapan PACS di pelayanan rontgen.	- Masih proses penambahan jaringan ke USG dan CT-Scan.

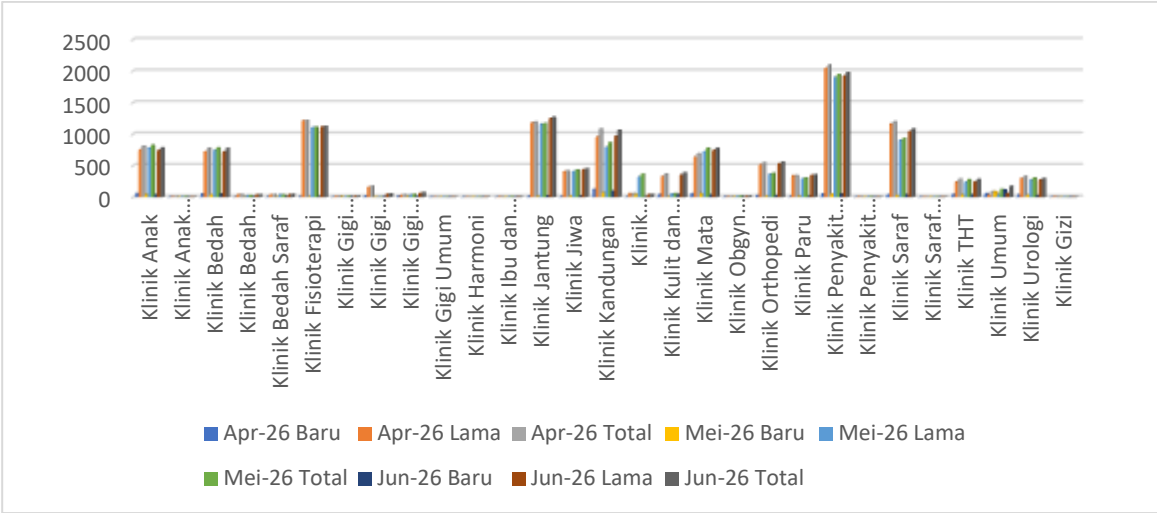
3.3 Kinerja Bidang Pelayanan

3.3.3 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.3.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru (April - Juni 2026)

Nama Unit	Apr-26			Mei-26			Jun-26		
	Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total
Klinik Anak	56	752	808	43	779	822	37	742	779
Klinik Anak Sakura	1	5	6	1	5	6	0	1	1
Klinik Bedah	52	723	775	37	742	779	52	719	771
Klinik Bedah Plastik	1	38	39	0	25	25	2	34	36
Klinik Bedah Saraf	3	37	40	0	34	34	2	40	42
Klinik Fisioterapi	4	1209	1213	2	1104	1106	2	1117	1.119
Klinik Gigi Ortodonti	1	13	14	5	7	12	2	13	15
Klinik Gigi Pedodontis	15	159	174	0	0	0	6	44	50
Klinik Gigi Periodonti	14	27	41	6	36	42	8	63	71
Klinik Gigi Umum	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Klinik Harmoni	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Klinik Ibu dan Anak	0	5	5	0	3	3	0	3	3
Klinik Jantung	15	1177	1192	9	1159	1168	21	1246	1.267
Klinik Jiwa	10	405	415	17	411	428	14	437	451
Klinik Kandungan	122	958	1080	72	791	863	94	967	1.061
Klinik Konservasi Gigi	2	56	58	44	318	362	1	39	40
Klinik Kulit dan Kelamin	39	328	367	2	52	54	38	350	388
Klinik Mata	53	635	688	54	723	777	35	739	774
Klinik Obgyn Sakura	2	5	7	3	12	15	3	13	16
Klinik Orthopedi	28	514	542	13	364	377	24	533	557
Klinik Paru	6	338	344	10	292	302	8	348	356
Klinik Penyakit Dalam	51	2045	2096	48	1897	1945	50	1924	1.974
Klinik Penyakit Dalam Sakura	0	3	3	1	2	3	1	0	1
Klinik Saraf	37	1158	1195	29	902	931	36	1042	1.078
Klinik Saraf Sakura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klinik THT	45	240	285	36	240	276	38	242	280
Klinik Umum	53	36	89	88	35	123	114	59	173
Klinik Urologi	35	297	332	32	271	303	23	272	295
Klinik Gizi	1	2	3	0	0	0	0	0	0

Grafik Pasien Lama dan Baru Bulan (April - Juni 2026)



Analisis :

1	Total kunjungan rawat jalan pada bulan Juni 2026 relatif stabil dibandingkan bulan Mei. Beberapa poli mengalami peningkatan kunjungan, terutama Klinik Jantung (1.267), Klinik Penyakit Dalam (1.974), Klinik Saraf (1.078), Klinik Kandungan (1.061), Klinik Orthopedi (557), dan Klinik Jiwa (451).
2	Kunjungan Instalasi Gawat Darurat menurun dari 1.065 pasien pada Mei menjadi 878 pasien pada Juni.
3	Beberapa poli menunjukkan peningkatan cukup signifikan, seperti Klinik Orthopedi (+180 kunjungan dibanding Mei), Klinik Kandungan (+198), Klinik Saraf (+147), dan Klinik Jantung (+99).
4	Terdapat beberapa poli dengan jumlah kunjungan sangat rendah bahkan nihil, seperti Klinik Gizi (0), Klinik Harmoni (0), Klinik Gigi Umum (0), Klinik Saraf Sakura (0), Klinik Anak Sakura (1), dan Klinik Penyakit Dalam Sakura (1).
5	Klinik Fisioterapi tetap menjadi salah satu layanan dengan kunjungan tinggi (1.119 pasien), meskipun sedikit meningkat dibanding bulan Mei.
6	Secara umum distribusi kunjungan antar poli masih didominasi oleh Klinik Penyakit Dalam, Klinik Jantung, Klinik Fisioterapi, Klinik Saraf, dan Klinik Kandungan.

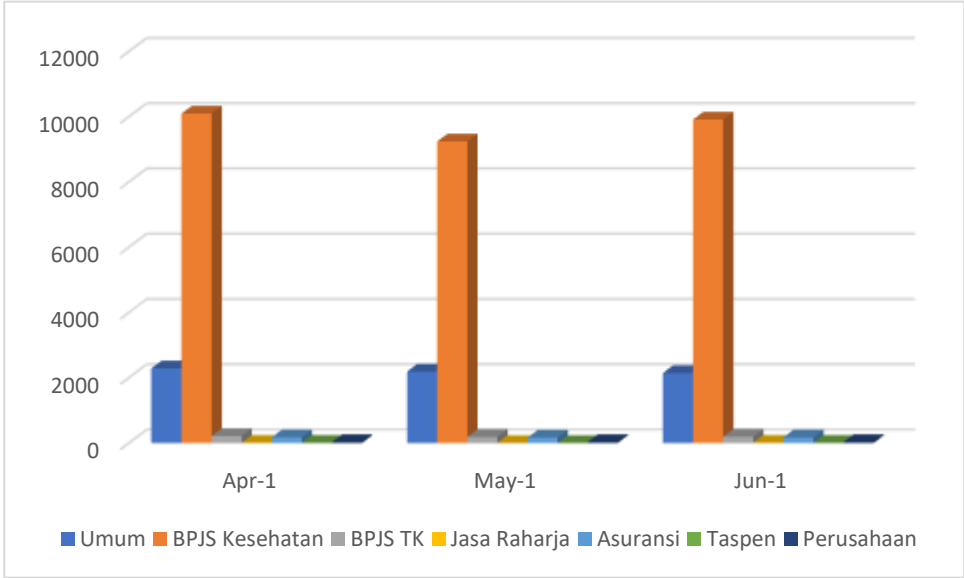
Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum, asuransi tentang pelayanan poli Sakura
3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran
April-Juni 2026

No	Jenis Pembayaran	Apr-26	%	May-26	%	Jun-26	%
1	Umum	2290	17,86%	2189	18,52%	2146	17,20%
2	BPJS Kesehatan	10099	78,78%	9243	78,19%	9911	79,44%
3	BPJS TK	213	1,66%	188	1,59%	195	1,56%
4	Jasa Raharja	7	0,05%	2	0,02%	10	0,08%
5	Asuransi	178	1,39%	167	1,41%	173	1,39%
6	Taspen	6	0,05%	0	0,00%	8	0,06%
7	Perusahaan	27	0,21%	32	0,27%	33	0,26%
TOTAL		12820	100%	11821	100%	12476	100,00%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran April – Juni 2026



Analisis :

1	Kunjungan pasien poli didominasi oleh peserta BPJS Kesehatan sebanyak 9.911 kunjungan (79,44%) dari total 12.476 kunjungan.
2	Pasien Umum menempati urutan kedua dengan 2.146 kunjungan (17,20%).
3	Kunjungan pasien BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 195 kunjungan (1,56%), sedangkan Jasa Raharja sebanyak 10 kunjungan (0,08%).
4	Pasien dengan penjamin Asuransi Swasta sebanyak 173 kunjungan (1,39%), Perusahaan sebanyak 33 kunjungan (0,26%), dan Taspen sebanyak 8 kunjungan (0,06%).
5	Komposisi cara bayar menunjukkan sumber pembiayaan pasien belum beragam dan masih terkonsentrasi pada satu penjamin utama.

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

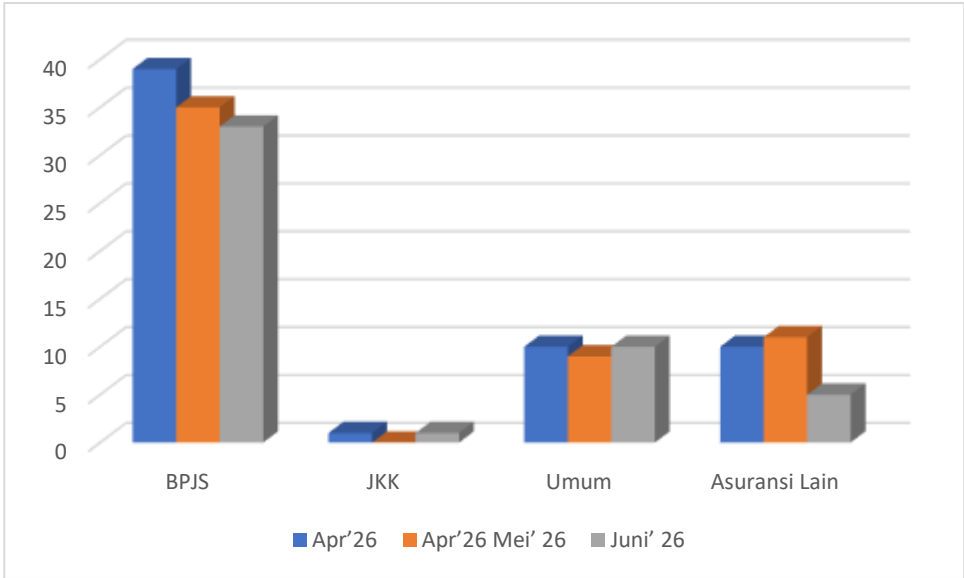
3.1.3 Rawat Inap

3.1.3.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar April - Juni 2026)

NO	Hal	Apr'26	Mei' 26	Juni' 26	Persentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	39	35	33	↓5,71%
2	JKK	1	0	1	↑100%
3	Umum	10	9	10	↑0,1%
4	Asuransi Lain	10	11	5	54,54%
Total Pasien		33	60	55	↓12,72%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2026)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Bulan	RAWAT INAP				Total Pasien
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	April 2026	39	10	1	10	60
	Analisa	Bulan April pasien BPJS mengalami kenaikan agak banyak dari 25 menjadi 39	Bulan April pasien umum mengalami kenaikan drastic dari 3 menjadi 10	Pasien JKK bulan April ada 1 dikarenakan px JKK naik kelas ke VIP	Untuk pasien asuransi di bulan April mengalami kenaikan dari 5 menjadi 10	Total bulan April jumlah pasien mengalami kenaikan drastis dari 33 menjadi 60
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas				

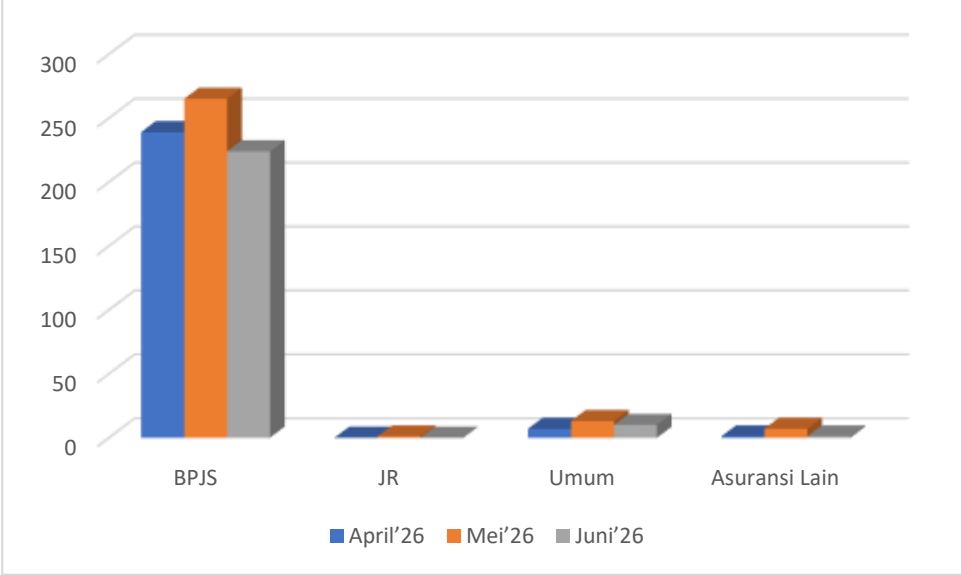
		tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
2	Mei 2026	35	9	0	11	55
	Analisa	Bulan Mei pasien BPJS mengalami penurunan dari 39 menjadi 35	Bulan Mei pasien umum mengalami penurunan dari 10 menjadi 9	Pasien JKK bulan Mei tidak ada	Untuk pasien asuransi di bulan Mei naik sedikit dari 10 ke 11	Total bulan Mei jumlah pasien mengalami penurunan lagi dari 60 menjadi 55
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
3	Juni 2026	33	9	1	5	48
	Analisa	Bulan JUNI pasien BPJS mengalami penurunan dari 39 menjadi 35	Bulan Mei pasien umum mengalami penurunan dari 10 menjadi 9	Pasien JKK bulan Mei ada 1 dikarenakan px JKK naik kelas ke VIP	Untuk pasien asuransi di bulan Mei naik sedikit dari 10 ke 11	Total bulan Mei jumlah pasien mengalami penurunan lagi dari 60 menjadi 55
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar
(Maret-Mei 2026)

NO	Hal	April'26	Mei'26	Juni'26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	239	265	224	↓18%
2	JR	0	1	0	↓100%
3	Umum	7	13	10	↓30%
4	Asuransi Lain	1	7	1	↓60%
Total Pasien		216	247	286	↓21%

Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2026)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR	Asuransi	
	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami peningkatan di bulan februari dan mengalami penurunan sebesar 7% di bulan maret, serta meningkat lagi sebebsar 15% di bulan April Mengalami peningkatan 10% di bulan Mei, Pada bulan Juni kepesertaan BPJS mengalami penurunan 18%	Pasien umum mengalami peningkatan sebesar 66%pada Maret dan mengalami penurunan sejumlah 71% di bulan April, dikarenakan semua orang mempunyai BPJS, dan mengalami peningkatan sebesar 46% di bulan mei, di bulan juni pasien umum mengalami penurunan sebesar 30%	Pasien JR mengalami penurunan 200% pada bulan maret dan mengalami penurunan lagi di bulan April sebanyak 100%, serta di bulan mei menglamai peningkatan sebesar 100%, pada bulan juni pasien JR mengalami penurunan 100%	Pasien Asuransi sama dengan bulan sebelumnya dan mengalami penurunan 100% di bulan April karena hanya beberapa orang saja yang mempunyai jaminan asuransi, di bulan mei pasien asuransi mengalami peningkatan sebesar 85%, pada bulan juni pasien Asuransi ,mengalami penurunan 60%, karena rata-rata pasien Asuransi semuanya naik kelas VIP	Jumlah pasien BPJS di bulan Februari mengalami peningkatan sebanyak 6% dan mengalami penurunan di bulan maret sebesar 7% dan penurunan 200% pada pasien umum pada bulan februari dan mengalami peningkatan 66% di bulan maret dan kenaikan 66% pasien JR pada bulan februari serta mengalami penurunan sebesar 200% di bulan maret Dan pada bulan April pasien BPJS mengalami peningkatan sebebsar 15%

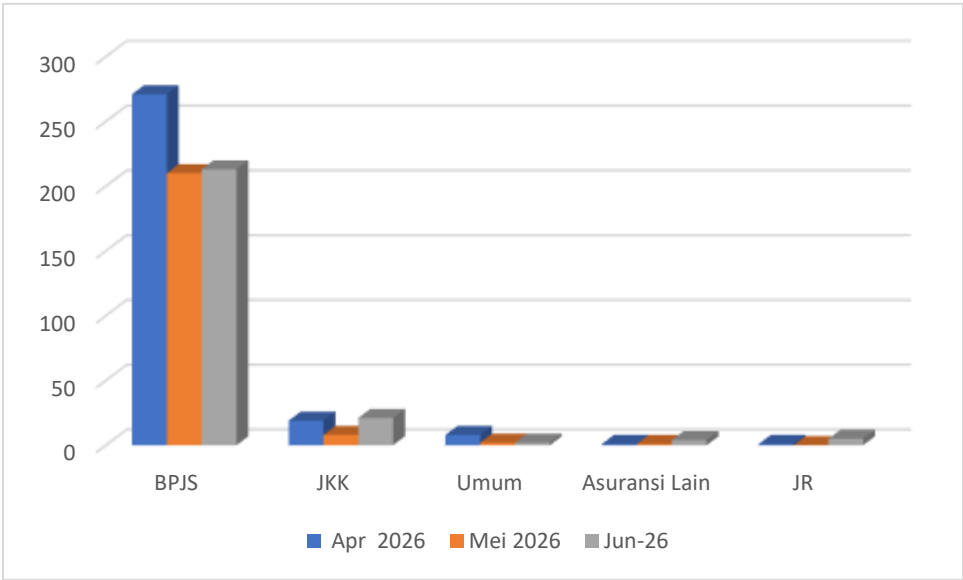
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial	serta jumlah keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 13% Pada bulan Mei jumlah keseluruhan pasien mengalami peningkatan sebesar 14% yaitu sejumlah 286 Pada bulan Juni jumlah pasien di ruang anak mengalami penurunan sebesar 21%
--	-----	---	--

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2026)

NO	Hal	Apr 2026	Mei 2026	Jun 2026	Persentase 2026
1	BPJS	271	210	213	↑ 1,42 %
2	JKK	19	8	21	↑ 162,5%
3	Umum	8	2	2	0 %
4	Asuransi Lain	1	1	4	↑ 100%
5	JR	1	0	5	↑100 %
Total Pasien		173	300	221	↑ 10,85 %

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April – Juni 2026)



3.1.1.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

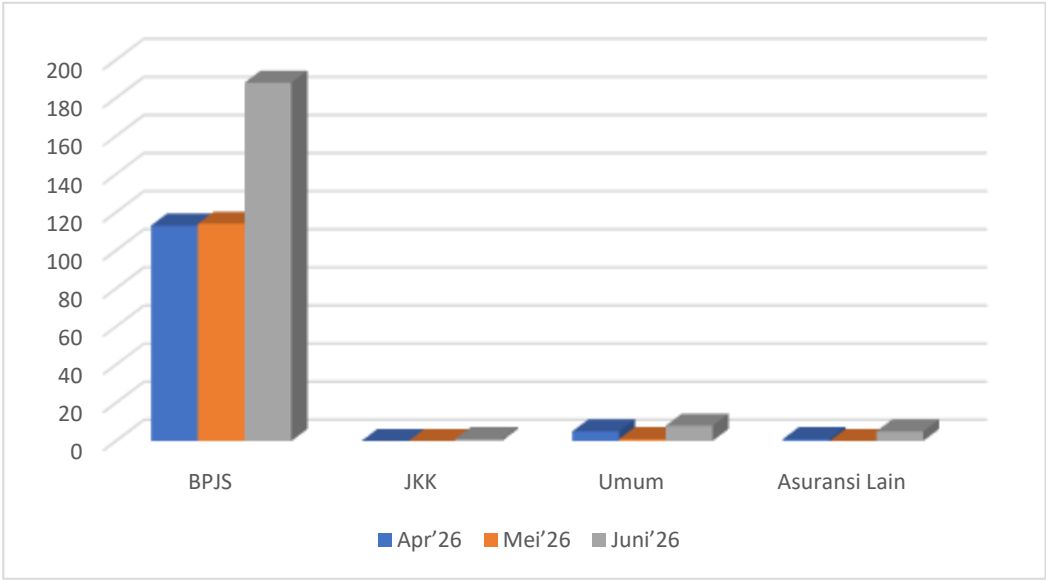
No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Juni 2026	Pasien BPJS mengalami peningkatan pada bulan Juni 2026 sebanyak 213 (1,42%) pasien dibandingkan bulan Mei	Pasien Umum pada bulan Juni 2026 sama/ tetap dengan bulan Mei yaitu 2 pasien	Jumlah Pasien JKK pada bulan Juni 2026 meningkat sebanyak 21 pasien (162,5%) dibandingkan bulan Mei	Jumlah pasien JR bulan Juni 2026 naik 100% (5 pasien) mengganakan penjamin JR dibandingkan bulan Mei, Untuk pasien Asuransi naik 4 pasien (100%) dibulan Juni 2026 ini	Peningkatan jumlah pasien selama 3 bulan terakhir ini yang paling banyak pasien dibulan April sebanyak 300 (10,85%) dan bulan Juni sebanyak 245 (10,85%)
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Untuk Irna 3A sementara tutup dan dialihkan ke Irna 2A dikarenakan TT dilantai 2A 15 TT serta terdapat ruang transit 6. Lantai 3A dibuka jika memang disemua lantai penuh.				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2026)

NO	Hal	Apr'26	Mei'26	Juni'26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	113	114	188	↑23,40%
2	JKK	0	0	1	↑100%
3	Umum	5	1	8	↑87,5%
4	Asuransi Lain	1	0	5	↑100%
Total Pasien		93	119	115	↑43%

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (April - Juni 2026)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian April 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak $\uparrow 14,60\%$ dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami penurunan sebanyak $\downarrow 33,33\%$ dari bulan sebelumnya	Pasien JKK sama dengan kunjungan bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak $\downarrow 66,66\%$ dari bulan sebelumnya	Pada bulan April 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar $\uparrow 22\%$
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
2	Analisis capaian Mei 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak $\uparrow 21,23\%$ dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak $\uparrow 40\%$ dari bulan sebelumnya	Pasien JKK sama dengan kunjungan bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR sama dengan kunjungan bulan sebelumnya	Pada bulan Januari 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar $\downarrow 3,36\%$
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
3	Analisis capaian Juni 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak $\uparrow 23,40\%$ dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak $\uparrow 87,5\%$ dari bulan sebelumnya	Pasien JKK sama mengalami peningkatan sebanyak $\uparrow 100\%$ dengan kunjungan bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami peningkatan sebanyak $\uparrow 100\%$ dari bulan sebelumnya	Pada bulan Januari 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar $\uparrow 43\%$

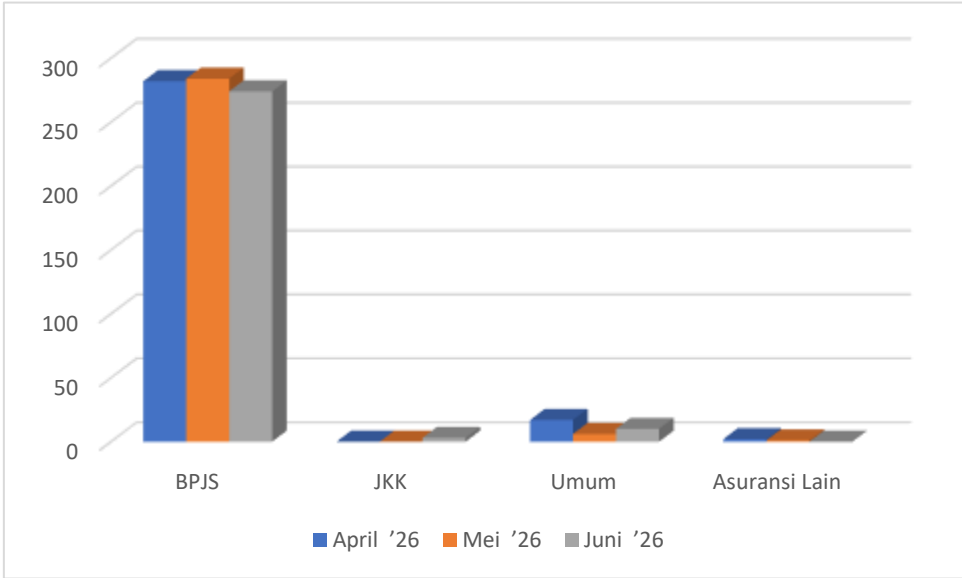
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya	
--	-----	---	--

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)

NO	Hal	April '26	Mei '26	Juni '26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	282	284	274	↓ 3,5%
2	JKK	0	0	3	↑ 100%
3	Umum	17	6	10	↑40%
4	Asuransi Lain	2	1	0	↓100 %
Total Pasien		301	291	287	↓1,3%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

Bulan	Rawat Inap				Kesimpulan
	BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami penurunan pada bulan juni 2026 yaitu sebanyak 10 pasien disebabkan banyaknya kunjungan pasien di IGD dengan penjamin kelas 3 sedang	Pasien Umum mengalami peningkatan pada bulan juni 2026 yaitu sebanyak pasien, yang datang ke IGD rata rata menggunakan penjamin BPJS untuk kelas 3	Pasien JKK mengalami peningkatan pada bulan juni 2026 yaitu sebanyak 3 pasien	Jumlah pasien Asuransi / JR mengalami penurunan 100% pada bulan juni 2026	Secara keseluruhan, kunjungan pasien pada bulan Juni 2026 mengalami penurunan tipis sebesar 1,3% dibandingkan bulan Mei. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya

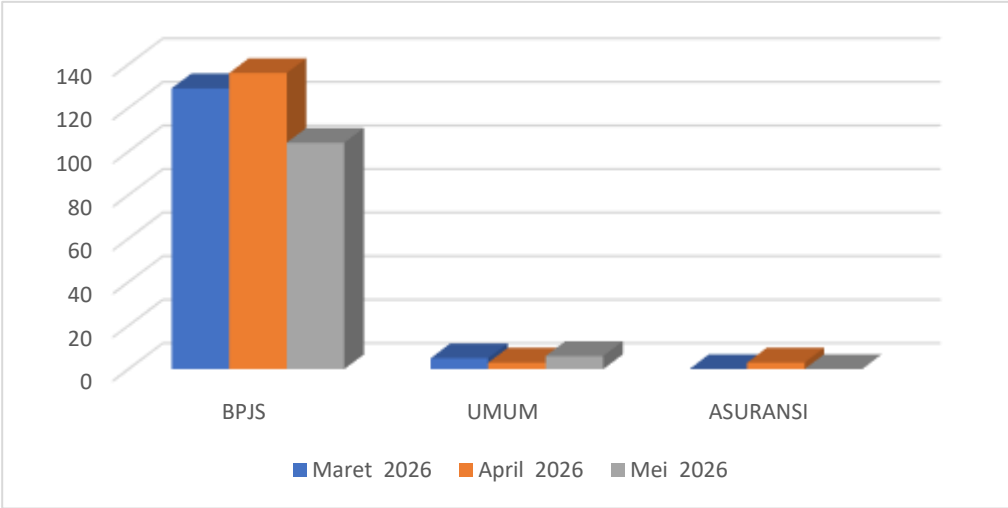
	menurun				jumlah pasien BPJS, yang merupakan kelompok pasien terbesar. Di sisi lain, terdapat peningkatan jumlah pasien Umum serta mulai adanya kunjungan pasien JKK, meskipun kontribusinya terhadap total kunjungan masih kecil. Dominasi pasien BPJS tetap sangat tinggi, yaitu sekitar 95,5% dari total kunjungan, sehingga fluktuasi jumlah pasien BPJS akan sangat memengaruhi total kunjungan rumah sakit
RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)

NO	HAL	April 2026	Mei 2026	Juni 2026	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
1	BPJS	136	104	130	↑20%
2	UMUM	3	6	2	↓66%
3	ASURANSI	3	0	1	↑100%
Total Pasien		134	142	110	↑17,2%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

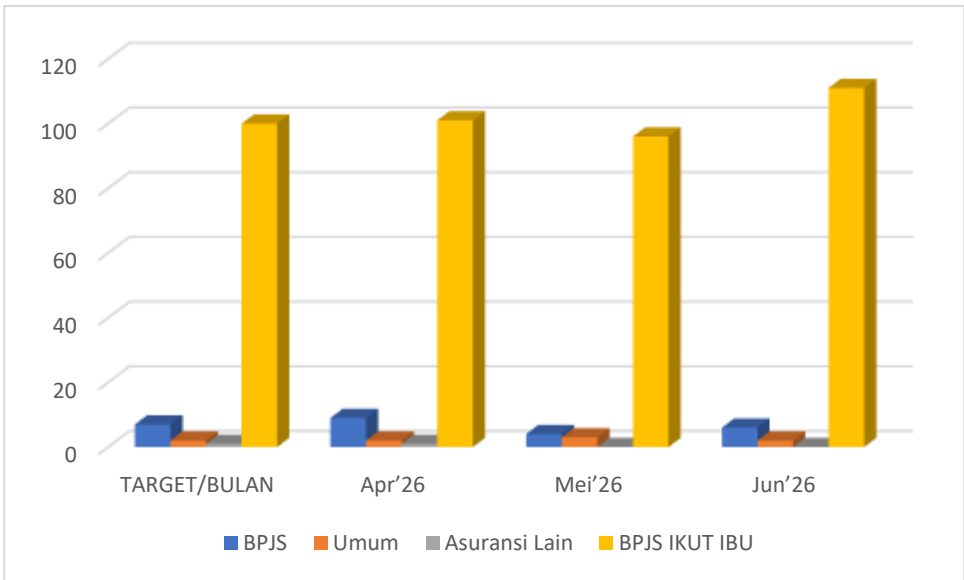
No	Bulan	RAWAT INAP			Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR/Asuransi	
	Analisis capaian Bulan April-Juni	Pasien BPJS pada bulan Juni mengalami Kenaikan 20 %	Pasien umum pada bulan Juni mengalami penurunan 66%	Terdapat 1 pasien Asuransi pada bulan Juni	Kunjungan turun dengan bulan sebelumnya. Selalu melakukan Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)

NO	HAL	TARGET/BULAN	Apr'26	Mei'26	Jun'26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	7	9	4	6	↑4,96%
2	Umum	2	2	3	2	↓1,6%
3	Asuransi Lain	1	1	0	0	0
4	BPJS IKUT IBU	100	101	96	111	↑91,7%
Total Pasien		110	107	113	104	↑16,35%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	Rawat Inap				Total Pasi en
		BPJS	UMUM	ASURANS I	BPJS IKUT IBU	
1	April 2026	9	2	1	101	113
		Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebanyak 7,96%	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 1,77%	ada 1 pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan sebanyak 89,38%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasma dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
2	Mei 2026	4	3	0	96	104
		Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebanyak 3,85%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,89%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 4,95%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasma dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	

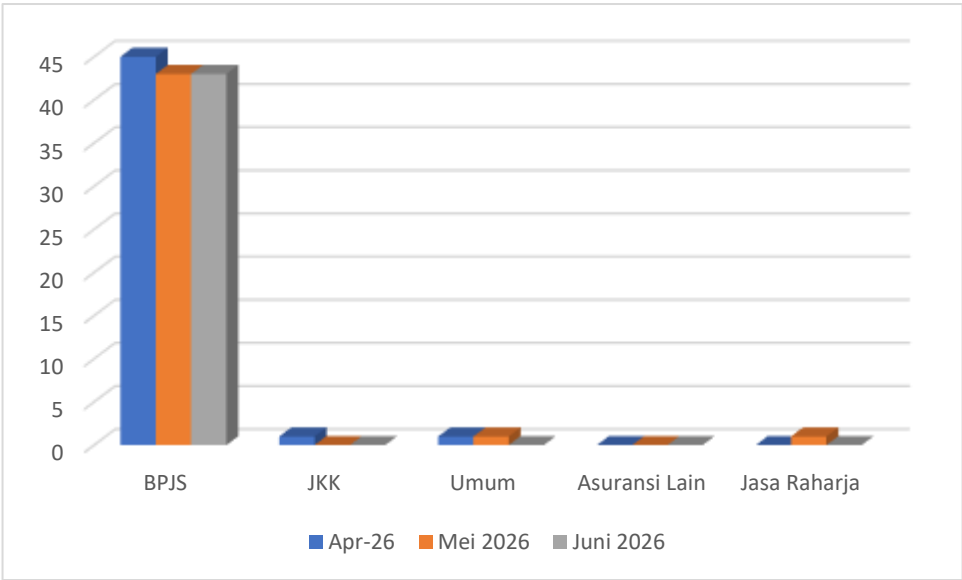
3		6	2	0	111	121
	Juni 2026	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebanyak 4,96 %	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 1,6%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan sebanyak 91,7%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)

NO	Cara Bayar	Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	45	43	43	Tetap
2	JKK	1	0	0	Tetap
3	Umum	1	1	0	↓100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	Jasa Raharja	0	1	0	↓100%
Total Pasien		47	45	43	↓0,04%

3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

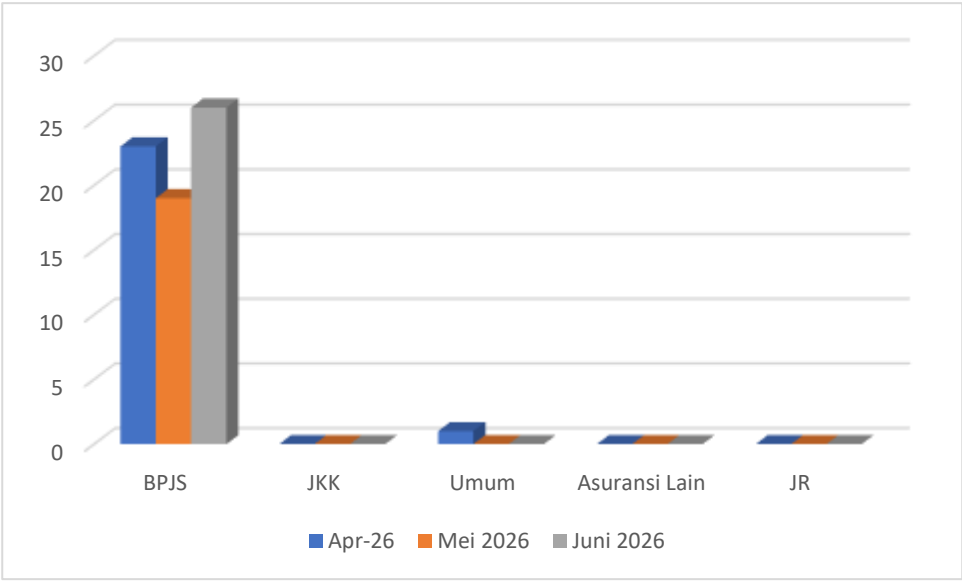
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Juni 2026 sama bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir jumlahnya turun dari bulan sebelumnya	Pasien JKK dalam 3 bulan terakhir ada 1 di bulan april	ada 1 pasien penjamin JR di bulan Mei 2026	Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada mengalami penurunan sebesar 0,04 % dibandingkan dari bulan sebelumnya.
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr - Jun 2026)

NO	HAL	Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	23	19	26	↑0,36%
2	JKK	0	0	0	Tetap
3	Umum	1	0	0	Tetap
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	0	0	0	Tetap
Total Pasien		24	19	26	↑0,36%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

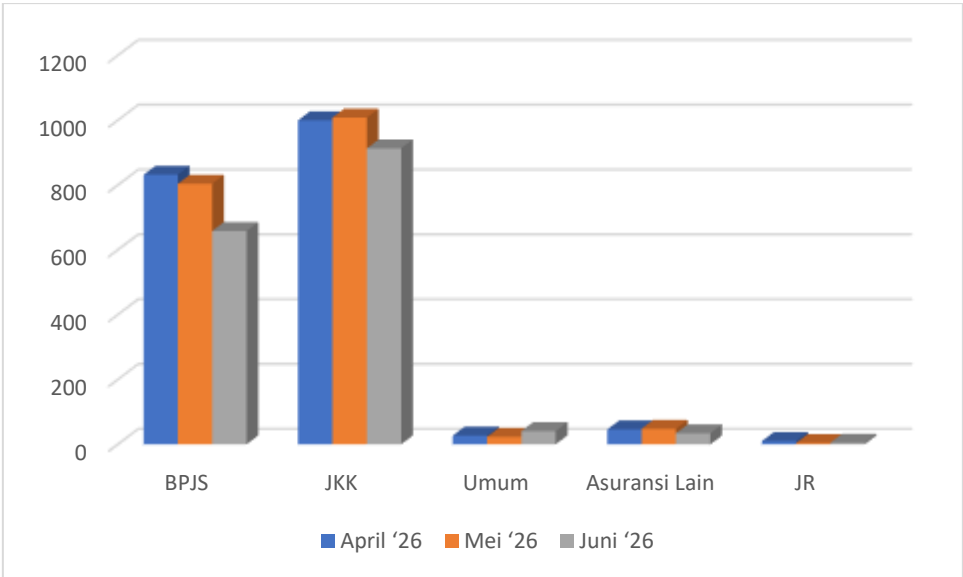
NO.	BULAN AGUSTUS	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil, untuk bulan april 2026 mengalami peningkatan 0,36%diban dingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Juni 2026 kunjungan 0	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan terakhir	Tidak ada Pasien JR/ Asuransi bulan Juni 2026	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada meningkat 0,36% dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HCU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)

NO	HAL	April '26	Mei '26	Juni '26	PERSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA
1	BPJS	832	804	658	18,15%
2	JKK	1.000	1.008	913	9,4%
3	Umum	27	23	41	43,9%
4	Asuransi Lain	46	48	34	29,1%
5	JR	10	4	5	20%
Total Pasien		1.661	1.915	1.887	12,5%

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Apr-Jun 2026)



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

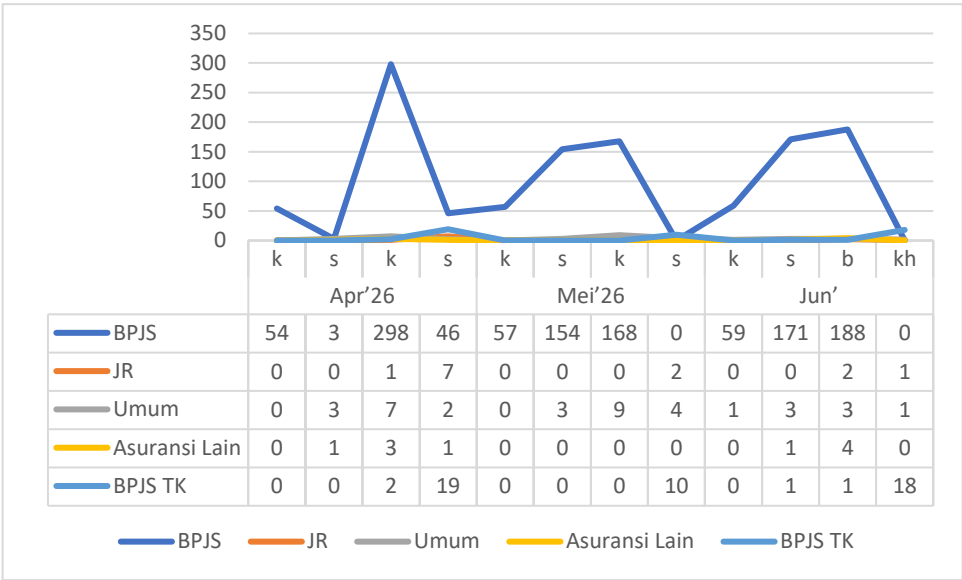
No	BULAN	INSTALASI GAWAT DARURAT					
1	Juni	BPJS	UMUM	JKK	ASURANSI	JR	TOTAL PASIEN
	Analisis	Kunjungan pasien BPJS di bulan Juni mengalami peningkatan 18,15%	Kunjungan pasien UMUM dari bulan Juni mengalami peningkatan 9,8%	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK mengalami peningkatan sebanyak 43,9% dari bulan Mei 2026	Kunjungan pasien dengan jaminan Asuransi lain pada bulan Juni mengalami penurunan 29,1%	Kunjungan pasien dengan jaminan JR bulan Juni meningkat 20% dari bulan Mei 2026	Total kunjungan pasien IGD semua jaminan di bulan Juni 2026 mengalami penurunan 12,5%
	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Apr-Jun 2026)

NO	HAL	Apr'26				Mei'26				Jun'			
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh
1	BPJS	54	3	298	46	57	154	168	0	59	171	188	0
2	JR	0	0	1	7	0	0	0	2	0	0	2	1
3	Umum	0	3	7	2	0	3	9	4	1	3	3	1
4	Asuransi Lain	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	4	0
5	BPJS TK	0	0	2	19	0	0	0	10	0	1	1	18
	Total Pasien	447				413				454			

Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Apr-Jun 2026)



3.1.4.2 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	BULAN	Instalasi Kamar Operasi			
1	Juni	Kecil	Sedang	Besar	Khusus
	Analisis	Jumlah pasien ODC Pacho meningkat	Jumlah pasien meningkat karena jumlah pasien orthopedi meningkat	Operasi besar menurun karena jumlah pasien orthopedic meningkat	Operasi khusus menurun karena banyak yang turun menjadi kategori operasi besar atau sedang
	RTL	Tingkatkan capaian dengan meningkatkan jumlah pasien operasi	Meningkatkan capaian dengan sosialisasi ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Meningkatkan capaian dengan sosialisasi ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Tingkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.

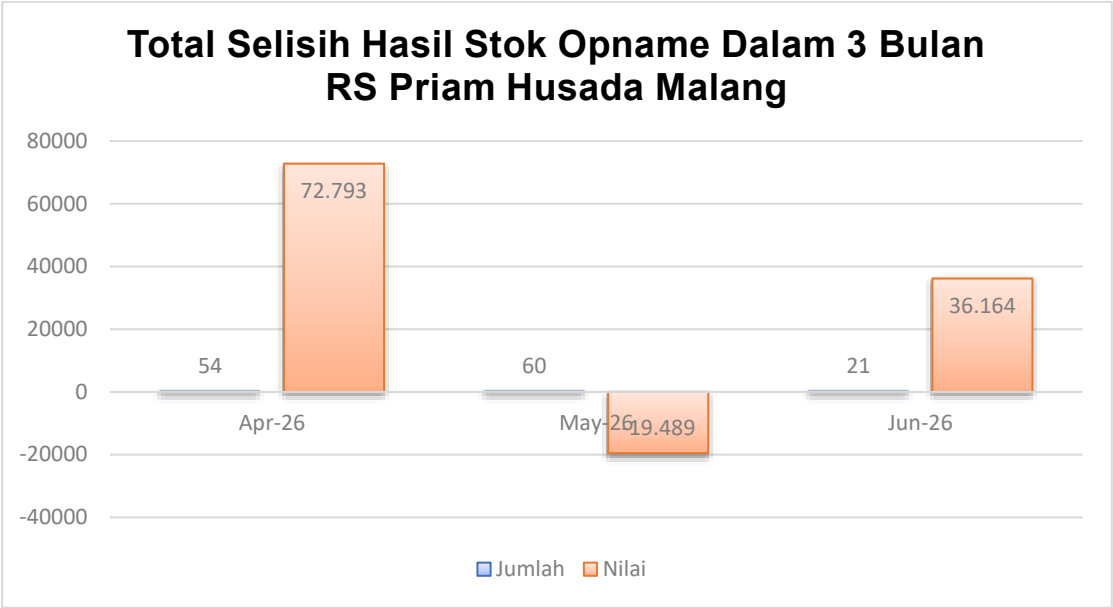
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Apr-Jun 2026

Unit	Stok	April 2026		Mei 2026		Juni 2026	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
GUDANG	Fisik	670.702	1.360.931.713,52	590.337	1.223.051.252,46	630.948	1.183.344.389,15
	Sistem	670.702	1.360.931.713,52	590.337	1.223.051.252,46	630.948	1.183.344.389,15
	Selisih	0	0	0	0	0	0
DEPO FARMASI	Fisik	212.376	606.900.154,96	225.240	598.610.614,39	242.640	629.752.776,95
	Sistem	212.385	606.827.362,35	225.276	598.630.103,01	242.629	629.716.612,03
	Selisih	54	72.793	60	-19.489	21	36.164,92
IKO	Fisik	3.081	79.179.236,02	2.870	83.093.295,68	3.349	87.660.000,65
	Sistem	3.081	79.179.236,02	2.870	83.093.295,68	3.349	87.660.000,65
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		54	72.793	60	-19.489	21	36.164

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Apr - Jun 2026



No	Analisa	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut
Gudang Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :			
1	Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan.	-	Supervisi secara berkala
Depo Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih jauh dari target (0) yaitu sebesar Rp 36.165 , hal ini disebabkan karena :			
1	Ketidaksesuaian antara jumlah obat yang di input dan jumlah obat yang disiapkan.	Staf Farmasi tidak melakukan double check terkait ketepatan obat dan jumlah obat sebelum di serahkan pada petugas kie atau perawat.	1. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan. 2. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala. 3. Monitoring dan evaluasi oleh Kabid terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. Jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki.
2	Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD dan inputan resep di SIMRS.	1. Staf Farmasi tidak melakukan double check dengan perawat 2. Siap obat dan bmhp hanya menggunakan etiket tanpa melihat resep	1. Petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan → supervisi oleh kains farmasi. 2. Perbaikan alur ERM khususnya peresepan IGD diinput terlebih dahulu dan resep manual hanya untuk pasien KLL (case emergency) jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup dan meminta bukti inputan.

3	Hutang input resep saat SO berjalan.	Kurang pencatatan saat pelaksanaan SO.	1. PJ shift rekap pengeluaran saat stok opname berlangsung. 2. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan.
IKO : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :			
1	1. Perawat patuh melakukan input resep; 2. Retur penjualan barang yang tidak terpakai sudah rutin dilakukan; 3. Stok opname harian IKO	-	Supervisi secara berkala

3.1.1.1 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan Jun – Des 2026)

1. Depo Farmasi

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Laporan Penjualan Jan 25 – Juni 26 (Depo+IKO)	Keterangan	Indikasi	Tindak Lanjut dan Hasil
							Apr 26	Mei 26	Juni 26					
1.	F0045 5	Lovenox 60 mg/0,6 ml - sanofi	Amp	120.000	31/07/2026	5JS410CB	-	-	18	2.160.000	445	Faktur pembelian terakhir tanggal 09/06/2026 dari distributor sejumlah 20 ampul. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.	Antikaogulan	Retur ke distributor 01/07/2026
2.	F0060 6	Phenobarbital inj 50 mg/ml - phapros	Amp	1.532	30/07/2026	76803001	23	23	19	29.108	22	Faktur pembelian terakhir tanggal 06/03/2025 dari distributor sejumlah 30 ampul.	Untuk sedasi, status epilepticus. Penggunaan obat slow moving	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.

3.	F0067 2	Rifampicin tab 450 mg (hibah)	Tab	0	30/08/ 2026	TSJ02853	144	47	63	0	1.130	Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 07/02/2026 sejumlah 112 tablet.	Untuk terapi tuberculosis	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
4.	F0511 7	Skycellflu quadrivalen t - dextra medica	Vial	167.200	30/08/ 2026	Q0225009	6	5	3	501.600	50	Faktur pembelian terakhir tanggal 28/04/2026 dari distributor sejumlah 8 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.	Untuk vaksin influenza	Program vaksin ICV dan poli anak. Koordinasi dengan humas dan marketing.
5.	F00494	Miconazole cr 2% 10 g - kimia farma	Tub	3.407	30/09/ 2026	14171700	92	92	25	85.175	373	Faktur pembelian terakhir tanggal 18/12/2025 dari distributor sejumlah	Antibiotik topikal	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 130626.

												120 tube. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor		
6.	F00182	Cendo tonor mds - cendo	Pcs	6.934	30/10/ 2026	37R6023	300	285	260	1.802.840	230	Faktur pembelian terakhir tanggal 19/02/2024 dari distributor sejumlah 200 pcs.	Untuk pengobatan glaukoma sudut terbuka kronis dan hipertensi okular.	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
7.	F00635	Proferro tab - fahrenheit	Tab	8.000	30/10/ 2026	IRJ220	183	143	101	808.000	1.345	Faktur pembelian tanggal 23/04/2025 dari distributor sejumlah 450 tab (ED 30/10/2026). Penataan tidak FEFO di gudang farmasi karna faktur	Membantu memenuhi kebutuhan zat besi pada keadaan anemia karena kekurangan zat besi.	Diberi stiker near ED dan dikeluarkan terlebih dahulu.

												terakhir 15/01/2026 sejumlah 300 tab ED 30/09/2027.		
8.	F00653	Quetvell tab 200 mg - novell	Tab	10.640	30/10/ 2026	26I026	-	255	63	670.320	1.499	Faktur pembelian terakhir tanggal 04/06/2026 dari distributor sejumlah 360 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.	Mengatasi episode manik akut gangguan bipolar, skizofrenia, mencegah gangguan bipolar, dan fase depresi gangguan bipolar.	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
9.	F05144	Repimid tab 100 mg - novell	Tab	2.520	30/10/ 2026	EHJ160	45	310	306	771.120	541	Faktur pembelian terakhir tanggal 21/05/2026 dari distributor sejumlah 200 tablet. Penerimaan	Tukak lambung dalam kombinasi dengan penghambat pompa proton, antikolinergik atau antagonis H2; gastritis.	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.

												obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.		
10	F05121	Teorol caps - novell	Caps	2.211	30/10/ 2026	264085	30	16	1	2.211	59	Faktur pembelian terakhir tanggal 25/12/2025 dari distributor sejumlah 90 kaps. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.	Suplemen untuk Meningkatkan absorpsi kalsium di usus & reabsorpsi kalsium di ginjal serta mengurangi resiko fraktur & jatuh.	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
11	F00546	Nutrisi lactogen lactose free 400 g - nestle	Klg	116.036	31/10/ 2026	51100346 AD	1	1	1	116.036	2	Faktur pembelian terakhir tanggal 09/10/2025 dari distributor sejumlah 2 box.	Sumber nutrisi atau sebagai makanan pendamping bagi bayi usia 0-12 bulan	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.

12	F03254	Furamin inj - mepro	Amp	9.4 25	30/11/2026	F5E027	12	12	12	113.100	164	Faktur pembelian terakhir tanggal 27/08/2025 dari distributor sejumlah 50 ampul (ED 30/11/2026). Penataan tidak FEFO di gudang farmasi karna faktur terakhir 19/05/2026 sejumlah 10 ampul (ED 30/05/2027).	Mengatasi defisiensi (kekurangan) vitamin B1	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
13	F00569	Onbrez breezhaler inh 150 mcg - novartis	Caps	11.564	30/11/2026	B9345H	150	120	150	1.734.595	2.130	Faktur pembelian terakhir tanggal 09/10/2025 dari distributor sejumlah 2 caps.	Sebagai bronkodilator untuk mengatasi obstruksi jalan napas pada pasien dewasa dengan PPOK	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.

14	F04795	Pyrimethamine tab 25 mg (hibah)	Tab	0	30/11/ 2026	E02002	-	85	80	0	20	Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 21/04/2026 sejumlah 100 tablet.	obat antiparasit yang digunakan untuk menangani penyakit toksoplasmosis dan sistosisporiasi s	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
15	F04866	Susu lactogen pro (6-12bln) 180gr - nestle	Box	28.285	30/11/ 2026	KWG5139 6761A2	1	1	1	28.285	0	Faktur pembelian terakhir tanggal 13/08/2025 dari distributor sejumlah 1 box.	Produk nutrisi	Rencana retur ke distributor H-1 bulan ED
16	F05242	Zenon tab 10mg/10mg - sanofi	Tab	19.692	30/11/ 2026	dlb07818	30	30	30	590.760	60	Penerimaan hibah dari prinsipal tanggal 09/04/2026	Antikolesterol	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
Sub Total Depo Farmasi										9.413.155				

2. Gudang Farmasi

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Keterangan	Indikasi	Tindak Lanjut dan Hasil
							Apr 26	Mei 26	Juni 26				
1.	F04921	Forixtra injeksi - kalbe	Vial	156.250	30/06/2026	a1250005	-	12	12	1.875.000	Faktur pembelian terakhir tanggal 21/05/2026 dari distributor sejumlah 12 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.	Mencegah pembekuan darah / deep vein thrombosis (DVT) dan emboli paru akut	Retur ke distributor 01/07/2026
2.	F00968	Benang t-vio 2-0 v9 - triton	Pcs	83.000	30/07/2026	230701BV	24	24	24	1.992.000	Penggunaan alat kesehatan slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 27/12/2023 dari distributor sejumlah 24 pcs → Proses tukar barang dengan distributor	Untuk operasi	Tukar barang ED jauh pada tanggal 10/07/2026, no batch : 26010IEL, ED 30/01/2031
3.	F01413	Guedel airway 50 mm/no 00 - forsch	Pcs	10.800	30/07/2026	2114423h	2	2	2	21.600	Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor tanggal 08/01/2026 sebanyak 5 pcs. Bisa di retur H-1 bulan mendekati kedaluwarsa.	Digunakan untuk mempertahankan saluran napas tetap terbuka.	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.

4.	F00696	Sanprima forte kaps - sanbe	Tab	2.100	30/07/2026	CG2905	300	300	300	630.000	Penggunaan obat slow moving. Faktur pembelian terakhir tanggal 29/11/2022 dari distributor sejumlah 400 tablet.	Infeksi saluran kemih (UTI); Bronkitis akut; Otitis media; Shigellosis, gastroenteritis; Infeksi saluran empedu; Pneumocystis jirovecii pneumonia (PCP) terapi & profilaksis; Infeksi kulit & jaringan lunak.	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
5.	F00672	Rifampicin tab 450 mg (hibah)	Tab	0	30/08/2026	TSG75153	1.082	1.082	620	0	Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 07/02/2026 sejumlah 112 tablet.	Untuk terapi tuberculosis	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.

6.	F00951	Benang t-plain 4-0 p119 - triton	Pcs	60.500	30/09/ 2026	210918IN	-	-	20	1.210.000	Faktur pembelian terakhir tanggal 01/09/2022 dari distributor sejumlah 24 pcs.	Digunakan untuk operasi	Tukar barang dengan kode lain ke distributor pada H-1 bulan ED.
7.	F00806	Vaksin rotateq - gsk	Vial	245.395	30/07/ 2026	z007996	9	9	9	2.208.555	Faktur pembelian terakhir tanggal 12/09/2025 dari distributor sejumlah 10 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor	Mencegah infeksi saluran cerna akibat 5 strain Rotavirus (Pentavalen) yang menular lewat makanan terkontaminasi.	Retur ke distributor H-1 bulan ED.
8.	F00972	Benang t-vio 5- 0 v38 – triton	Pcs	85.000	30/08/ 2026	230801RF	-	-	20	1.700.000	Faktur pembelian terakhir tanggal 27/07/2024 dari distributor sejumlah 12 pcs.	Untuk operasi	Retur ke distributor 29/06/2026

9.	F00653	Quetvell tab 200 mg - novell	Tab	10.640	30/10/ 2026	26L026	-	180	420	4.468.800	Faktur pembelian terakhir tanggal 09/06/2026 dari distributor sejumlah 360 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.	Mengatasi episode manik akut gangguan bipolar, skizofrenia, mencegah gangguan bipolar, dan fase depresi gangguan bipolar.	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
10.	F05144	Repimid tab 100 mg - novell	Tab	2.520	30/10/ 2026	EHJ160	100	200	100	252.000	Faktur pembelian terakhir tanggal 21/05/2026 dari distributor sejumlah 200 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.	Tukak lambung dalam kombinasi dengan penghambat pompa proton, antikolinergik atau antagonis H2; gastritis.	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
11.	F00546	Nutrisi lactogen lactose free 400 g - nestle	Klg	116.036	31/10/ 2026	51100346 AD	2	2	1	116.036	Faktur pembelian terakhir tanggal 09/10/2025 dari distributor sejumlah 2 box.	Sumber nutrisi atau sebagai makanan pendamping bagi bayi usia 0-12 bulan	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.

12.	F00557	Oat dewasa 2 fdc dosis harian (hibah) - kimia farma	Tab	0	29/11/2026	K42421N	3.024	2.016	3.360	0	Penerimaan hibah dari Dinkes Kesehatan dengan ed < 1 tahun pada tanggal 11/06/2026 sejumlah 5.040 tab.	Untuk terapi tuberculosis	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
13.	F05384	Pitavastatin 20 mg - yarindo	Tab	0	30/11/2026	a11502kb	-	-	1.500	0	Penerimaan hibah dari prinsipal tanggal 02/04/2026.	Antihiperlipidemia	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
14.	F03254	Furamin inj - mepro	Amp	9.425	29/11/2026	F5E027	20	15	5	47.125	Faktur pembelian terakhir tanggal 27/08/2025 dari distributor sejumlah 50 ampul (ED 30/11/2026). Penataan tidak FEFO di gudang farmasi karna faktur terakhir 19/05/2026 sejumlah 10 ampul (ED 30/05/2027).	Mengatasi defisiensi (kekurangan) vitamin B1	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 200726.
Sub Total Gudang Farmasi										14.521.116			

3. IKO

No.	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tgl. Expired	No. Batch	Jumlah Fisik Baik			Total Harga	Keterangan	Indikasi	Tindak Lanjut dan Hasil
							Apr 26	Mei 26	Juni 26				
1.	F01389	Foley cath no 18 - rusch	Pcs	19.250	30/07/2026	T21H05	3	3	3	57.750	Faktur pembelian terakhir tanggal 10/04/2025 dari distributor sejumlah 10 pcs	Dimasukkan melalui uretra ke kandung kemih untuk mengalirkan urine	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 130626.
2.	F01370	Extension tube 75 cm - terumo	Pcs	16.800	30/08/2026	210909B	2	2	2	33.600	Faktur pembelian terakhir tanggal 09/03/2023 dari distributor sejumlah 11 pcs.	Untuk operasi	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 130626.
3.	F01400	Foley cath silicon no 8 - rusch	Pcs	222.000	30/08/2026	KME20J1263	4	4	4	888.000	Faktur pembelian terakhir tanggal 04/02/2023 dari distributor sejumlah 20 pcs.	Untuk operasi	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 130626.
4.	F01394	Foley cath silicon no 10 - rusch	Pcs	110.000	30/09/2026	KME20K30008	1	1	1	110.000	Faktur pembelian terakhir tanggal 25/01/2025 dari distributor sejumlah 7 pcs.	Untuk operasi	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 130626.
5.	F00973	Benang vicryl 1 vcp359h - ethicon	Pcs	161.098	30/11/2026	TPBDFTWD	2	2	2	322.196	Faktur pembelian terakhir tanggal 20/08/2024 dari distributor sejumlah 36 pcs.	Untuk operasi	Dihabiskan terlebih dahulu

6.	F01681	Nelaton cath no 14 - rusch	Pcs	16.500	30/11/2 026	KMA20M08 01	1	1	1	16.500	Faktur pembelian terakhir tanggal 03/07/2024 dari distributor sejumlah 3 pcs.	Untuk operasi	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP tgl 130626.
Sub Total IKO										1.428.046			
Grand Total										25.362.317			

3.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

Analisis	Tindak Lanjut
1. Berdasarkan data obat Near Expired Date (Near ED) Juni–Desember 2026 , masih ditemukan sejumlah obat dan BMHP dengan masa kedaluwarsa kurang dari 6 bulan, baik di Depo Farmasi, Gudang Farmasi, maupun IKO. Penyebab utama terjadinya obat near ED antara lain penerimaan barang dari distributor dengan ED kurang dari 1 tahun, item slow moving , penerimaan hibah dengan masa ED pendek, serta penataan stok yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip FEFO (First Expired First Out) . Nilai total obat near ED mencapai Rp25.362.317 , sehingga perlu dilakukan pengelolaan untuk mencegah kerugian akibat kedaluwarsa.	1. Melakukan monitoring daftar obat near ED setiap bulan dan menyebarkan informasi kepada DPJP/unit terkait. 2. Mengoptimalkan penerapan sistem FEFO dalam penyimpanan dan distribusi obat. 3. Melakukan retur atau tukar barang ke distributor untuk item yang memungkinkan sebelum mendekati ED. 4. Meningkatkan koordinasi dengan bagian pengadaan agar tidak menerima barang dengan ED pendek apabila tidak mendesak. 5. Melakukan percepatan penggunaan obat slow moving melalui sosialisasi kepada dokter dan unit pelayanan. 6. Mengevaluasi pola perencanaan dan pengadaan untuk mencegah terjadinya penumpukan obat near ED di masa mendatang.

3.2.1.6 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Juni 2026

No	Instalasi	Umum	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Instalasi Rawat Inap						
	Jumlah Resep Obat Racikan	18	244	0	0	0	262
	Jumlah Resep Obat Jadi	458	7367	0	344	29	8.198
	Jumlah Resep Obat	476	7.611	0	344	29	8.460
2	IGD						
	Jumlah Resep Obat Racikan	87	24	0	0	0	111
	Jumlah Resep Obat Jadi	1.242	2.224	0	171	10	3.647
	Jumlah Resep Obat	1.329	2.248	0	171	10	3.758
3	Instalasi Rawat Jalan						
	Jumlah Resep Obat Racikan	270	1.701	0	0	0	1.971
	Jumlah Resep Obat Jadi	974	7.230	0	310	12	8.526
	Jumlah Resep Obat	1.244	8.931	0	310	12	10.497
4	IKO						
	Jumlah Resep Obat Racikan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Resep Obat Jadi	22	1.122	0	86	11	1.241
	Jumlah Resep Obat	22	1.122	0	86	11	1.241
TOTAL		3.071	19.912	0	911	62	23.956

Analisis:

1. Kunjungan pasien Umum pada bulan Juni 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026, dengan total resep yaitu : bulan Mei 2026 sebanyak 3.390 resep umum dan bulan Juni 2026 sebanyak 3.071 resep umum.
2. Kunjungan pasien BPJS Kesehatan pada bulan Juni 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026, dengan total resep yaitu : bulan Mei 2026 sebanyak 19.806 resep BPJS Kesehatan dan bulan Juni 2026 sebanyak 19.912 resep BPJS Kesehatan.
3. Kunjungan pasien Asuransi Swasta dan Jasa Raharja pada bulan Juni 2026 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026, dengan total resep yaitu : bulan Mei 2026 sebanyak 847 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja, sedangkan bulan Juni 2026 sebanyak 973 resep Asuransi Swasta dan Jasa Raharja.
4. Secara keseluruhan total resep pada bulan Juni 2026 mengalami penurunan :
 - Adanay pembatasan rujukan kedua dokter spesialis dari FKTP,
 - Adanya pembatasan kunjungan pasien per poli untuk pasien rawat jalan,
 - Adanya target PRB dimana pasien rujuk balik ke FKTP jika pasien sudah stabil di poli,
 - Retur obat tertinggal rawat jalan yang tidak diambil pasien di poli,
 - Kurangnya promo tarif vaksin di poli,
 - Kurangnya promo tarif poli sakura untuk poli lain,
 - DPJP tidak praktek karena libur,
 - Adanya batasan plafon BPJS Kesehatan sehingga tidak semua obat dapat di cover sesuai kebutuhan pasien

dengan pertimbangan biaya obat untuk pasien rawat inap.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan promosi tarif dan tindakan RS di sosial media RS agar kunjungan pasien meningkat.
2. Meningkatkan pelayanan resep yang tepat, cepat, dan akurat sehingga meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan di Farmasi.
3. Kolaborasi dengan Petugas Pendaftaran untuk menjaring pasien-pasien yang mempunyai jaminan kesehatan lebih dari 1 untuk menggunakan asuransi swasta terlebih dulu.
4. Koordinasi dengan programmer menciptakan website primantara untuk memudahkan pendaftaran pasien.
5. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
6. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
7. Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.

3.2.1.7 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Apr - Jun 2026

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Apr 26	Mei 26	Juni 26	
1	Pengkajian resep	100%	99,39%	99,47%	99,54%	Jumlah pengkajian resep yaitu: April 2026 = 25.662 Mei 2026 = 24.043 Juni 2026 = 23.956 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep yaitu: April 2026 = 157 Mei 2026 = 127 Juni 2026 = 110
2	Dispensing Sediaan Steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.
3	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.
4	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	0	Terdapat kejadian pelaporan efek samping obat
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat
6	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Tidak ada visite ronde besar

9	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM.
10	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape
11	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	35	31	30	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur

Analisa :

- Pengkajian resep :
- Penulisan resep yang lengkap bulan Juni 2026 mengalami peningkatan mendekati target 100% jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026, dengan prosentase evaluasi kelengkapan resep yaitu: bulan Mei 2026 sebanyak 99,47% dan bulan Juni 2026 sebanyak 99,54%. Dari data di atas ditemukan pengkajian resep:
 - Dari segi telaah adminitrasi : sudah lengkap karena menggunakan e-resep melalui SIMRS.
 - Dari segi telaah farmasetik : ditemukan 127 resep dimana dokter salah input dosis dan jumlah obat, aturan dan cara penggunaan serta rute pemberian tidak lengkap terisi.
 - Dari segi telaah klinis : sudah terlaksana oleh apoteker karena jika ada interaksi obat langsung diberi jeda pemberian obat oleh apoteker.
- Dispensing Sediaan Steril
 - Staf yang melakukan dispensing sediaan obat steril non sitostatika terlatih dan kompeten. Apoteker yang memiliki sertifikat pelatihan prinsip penyiapan obat dan teknik aseptik tersertifikasi kemenkes yaitu 1 orang. Sedangkan Apoteker, TVF, bidan, dan perawat sudah memiliki sertifikat pelatihan dispensing sediaan obat steril non sitostatika di pelatihan internal.
 - Tersedia bukti hasil pemantauan suhu, kelembaban, tekanan ruang, pemeliharaan LAF. Fasilitas dispensing sesuai standar praktik kefarmasian sesuai dengan perundang-undangan.
 - Kebersihan ruangan dispensing sediaan obat non steril dan obat steril selalu terjaga. Petugas melakukan desinfeksi sebelum melakukan dispensing obat non steril dan obat steril. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl. Tata letak ruang sudah di sekat dimana terdapat ruang persiapan dan ruang ganti APD, ruang antara, dan ruang steril (ada alat UV ruangan, pass box, LAF).
 - Pencampuran obat IV dilakukan di LAF dengan dilengkapi APD sesuai ketentuan setiap pukul 13.00 WIB, untuk resep obat injeksi sore dan malam. Tidak ditemukan keterlambatan pengiriman obat ke ruangan.
- Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Tersedia bukti pelaksanaan Pemantauan Terapi Obat dan sudah terisi lengkap oleh apoteker sesuai kriteria PTO.
- Kejadian Efek Samping Obat
 - Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Mei 2026 tidak ditemukan kejadian efek samping obat.
 - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.
- Edukasi Obat pada pasien dan keluarga
 - Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi.
 - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.

7. Konseling

Pelaksanaan konseling sudah dilakukan pada pasien di rawat jalan dan/ataupun rawat inap yang mendapatkan terapi polifarmasi dan penyakit kronis. Apoteker memanggil pasien, identifikasi, menyerahkan obat dan edukasi. Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan).

8. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak ada pelayanan di RS.

9. Visite Ronde Besar

Visite ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta professional kesehatan lainnya tidak pernah dilakukan, hal ini disebabkan waktu visite DPJP dan tenaga kesehatan lainnya tidak secara bersamaan.

10. Visite Pasien/ Farmasi Klinik

Visite dilakukan kepada setiap pasien rawat inap di RS dan di dokumentasikan di rekam medis pasien. Visite dilakukan untuk meminimalisir terjadinya medication error dan meningkatkan keberhasilan terapi pada pasien rawat inap

11. Pelayanan Informasi Obat (PIO)

PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli, dan e-book yang tersedia di SIMRS.

12. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien

Data obat tertinggal yang tidak diambil pasien Mei 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan April 2026, dengan total resep yang di retur yaitu bulan April 2026 sebanyak 35 dan bulan Mei 2026 sebanyak 31. Hal ini disebabkan beberapa pasien tidak mengetahui mendapatkan resep sehingga obat ditinggal dalam waktu 3x24 jam, keterlambatan penyediaan obat sehingga waktu tunggu obat lama, dan pasien tidak rutin minum obat sehingga obat kunjungan sebelumnya masih ada.

Tindak Lanjut :

1. Pengkajian resep :

- Koordinasi dengan tim SIMRS untuk membuat sistem jika resep tidak terinput dengan lengkap maka resep tidak dapat masuk ke Depo Farmasi.
- Inputan resep harus dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis yang kompeten dan berwenang mulai dari identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tandatangan dokter (untuk resep manual).
- Pelatihan penulisan resep untuk semua dokter dan dokter spesialis.

2. Dispensing Sediaan Steril

- Pelatihan penyediaan obat IV dan teknik aseptik tahun 2025 target peserta Apoteker, TTK, Perawat, Bidan di laksanakan pada tanggal 08 Desember 2025.
- Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo farmasi, gudang farmasi, dan ruang pencampuran obat (LAF) oleh apoteker setiap hari.
- Supervisi Kains secara berkala dan mempertahankan kinerja yang sudah berjalan dengan baik

3. Pemantauan Terapi Obat (PTO) : supervisi secara berkala

4. Kejadian Efek Samping Obat

- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat,

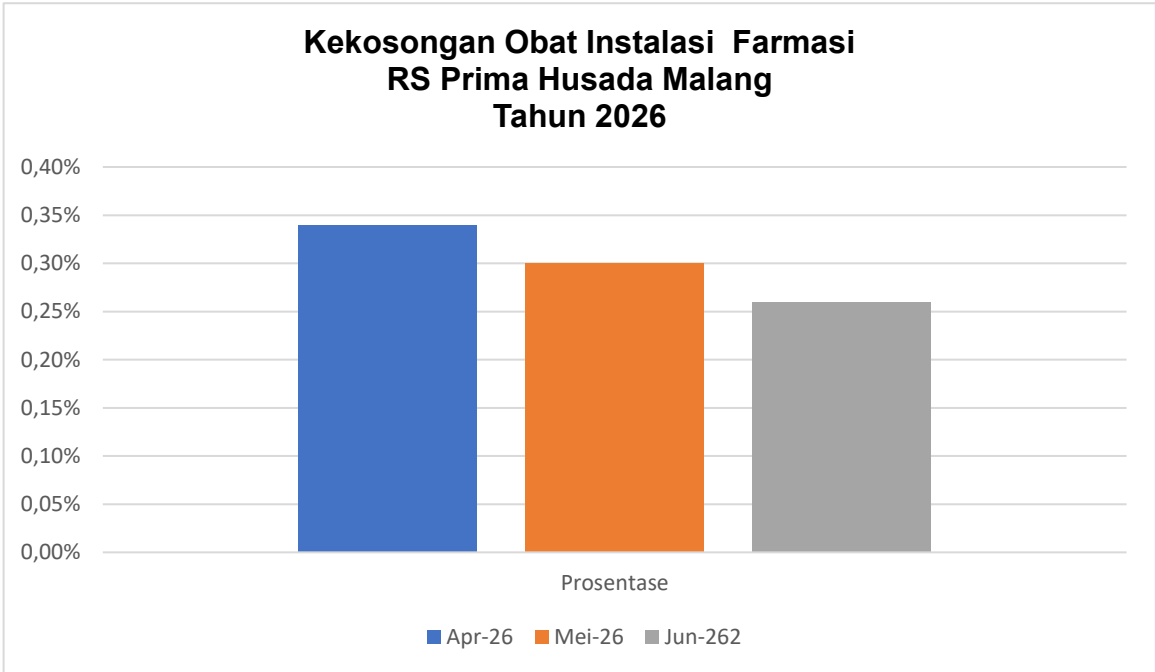
- interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
 - Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
 - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
 - Menganalisa laporan ESO.
 - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
 - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
 - Konsul ke DPJP terkait keluhan pasien dan advice DPJP obat di stop.
5. Edukasi Obat pada pasien dan keluarga : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
 6. Konseling : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan konseling di rawat inap dan rawat jalan.
 7. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak dilakukan di RS.
 8. Visite Ronde Besar
Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
 9. Visite Pasien/ Farmasi Klinik : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan visite pasien di rawat inap.
 10. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape sudah tersedia di unit pelayanan, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
 11. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien
 - Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
 - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
 - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.

Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	01/04/2026-30/04/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	01/04/2026-30/04/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	01/04/2026-30/04/2026	Pramivex 0.125 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
4	01/04/2026-30/04/2026	Pramivex 0.25 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
Total prosentase April 2026 = 0.34%					
1	01/05/2026-31/05/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	01/05/2026-31/05/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	01/05/2026-15/05/2026	Pramivex 0.125 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
4	01/05/2026-31/05/2026	Pramivex 0.25 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
Total prosentase Mei 2026 = 0.30%					
1	01/06/2026-30/06/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria

2	01/06/2026-30/06/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	01/06/2026-30/06/2026	Hydrochlorothiazide tab 25 mg	Diuretik (anti hipertensi)	PT. Kimia Farmas	Konsul DPJP substitusi obat lain
Total prosentase Juni 2026 = 0.26%					

1.2.1.11 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Apr - Jun 2026



Analisis :

- Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok Hydrochlorothiazide tab 25 mg di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Borraginol-N Suppositoria dan Borraginol-S Suppositoria (produk paten originator) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
- RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

- Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
- Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
- Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
- RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
- Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.12 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Juni 2026

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1	Pemusnahan Obat	Ethambutol Tab 400 mg	153 tablet	No. Batch: SL516MFD06/21; ED : 05/26 (sudah kedaluwarsa)	Dilakukan pemusnahan obat pada tanggal 05 Juni 2026.
2	Perbekalan Farmasi yang Diduga Tidak Stabil	-	-	-	Tidak ada perbekalan farmasi yang tidak stabil

3	Perbekalan Farmasi Terkontaminasi	-	-	-	Tidak ada perbekalan farmasi yang terkontaminasi
4	Perbekalan Farmasi Rusak	Bloodset GSTC 18 - prodevice	1 pc	1. Jika digunakan untuk menyedot cairan pungsi, sulit disedot karena selang bloodset tipis dan terlalu lentur, sehingga cairan sulit masuk dan ditarik. 2. Selang bloodset tidak cukup untuk dimasukkan ke threeway sehingga sering bocor, dan harus mengulang kembali untuk lepas dan pasang kembali set pungsi nya.	Form laporan tanggal 09/06/2026 dari SMF paru di laporkan ke ke Kepala Bidang dan telah di verifikasi oleh IFRS. Kemudian koordinasi dengan Apoteker Gudang Farmasi dan Pengadaan PT. DPM untuk pengadaan blood set merk Otsuka untuk tindakan pungsi sebanyak 5 pcs.
5	Perbekalan Farmasi yang Diduga Palsu	-	-	-	Tidak ada perbekalan farmasi yang palsu
6	Recall/ Penarikan	-	-	-	Tidak ada recall

1.2.2. Laboratorium

Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Maret – Mei 2026

	Target	Apr 26%	%	Mei 26%	%	Jun 26%	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
HEMATOLOGI	1950	1727	>17,3%	1677	<2,9%	1578	<5,1%
FAAL HEMOSTASIS	716	823	>13,7%	748	<9,3%	826	>10,4%
HEMATOLOGI LAIN	1	1	>100%	0	<100%	3	>300%
URINALISIS	418	278	>16,5%	252	<9,3%	241	<4,4%
ANALISA FEACES	30	17	< 22,7	15	<11,7%	12	<20,0%
FUNGSI HATI	611	397	>29,2%	311	<21,6%	323	>3,9%
LEMAK DARAH	806	828	>10,14%	956	>1,1%	776	<18,8%
GINJAL HIPERTENSI	1394	1570	>19,9%	1515	<3,5%	1320	<12,9%
GULA DARAH	1187	2662	>21,8%	2458	<7,6%	2386	<2,9%
JANTUNG	583	669	>23,0%	716	>6,5%	670	<6,4%
ELEKTROLIT DAN BGA	334	242	>27,27%	242	0%	186	<23,1%
IMUNO SEROLOGI	481	165	>16,9%	212	>22,1%	150	<29,2%
REMATIK	6	3	<25%	6	>50%	6	0%
ENDOKRINOLOGI	60	81	>46,6%	94	>13,8	65	<30,9%
REPRODUKSI	44	32	>31,9%	52	>38,4%	56	<7,7%
MIKROBIOLOGI	32	56	>23,2%	55	<1,7%	43	<21,8%

Jumlah	8654	9551	>23,7%	9303	<2,5%	8641	<7,1%
--------	------	------	--------	------	-------	------	-------

Analisis :

Berdasarkan data bulan Maret–Juni 2026, jumlah pemeriksaan laboratorium pada bulan Juni mengalami penurunan sebesar 7,1% dibandingkan bulan Mei. Sebagian besar jenis pemeriksaan menunjukkan tren penurunan, terutama pada pemeriksaan Elektrolit dan BGA, Imuno Serologi, Endokrinologi, dan Mikrobiologi.

Meskipun demikian, beberapa parameter mengalami peningkatan, yaitu Faal Hemostasis, Fungsi Hati, Hematologi Lain, dan Reproduksi, yang menunjukkan adanya perubahan kebutuhan pemeriksaan sesuai kondisi klinis pasien.

Penurunan jumlah pemeriksaan secara umum kemungkinan dipengaruhi oleh penurunan kunjungan pasien, variasi kasus penyakit, perubahan pola rujukan, serta faktor internal pelayanan laboratorium.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Dilakukan analisis lebih lanjut terhadap pemeriksaan yang mengalami penurunan jumlah, khususnya pada pemeriksaan fungsi hati dan hemostasis, dengan meninjau faktor penyebab seperti jumlah kunjungan pasien, pola rujukan klinis, serta ketersediaan alat dan bahan.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien serta unit pelayanan terkait guna mendorong optimalisasi permintaan pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi medis.
3. Memastikan ketersediaan reagen, bahan kontrol, serta optimalisasi fungsi alat laboratorium agar tidak terjadi hambatan pelayanan yang dapat mempengaruhi jumlah pemeriksaan.
4. Melakukan upaya promosi layanan laboratorium, khususnya untuk pemeriksaan dengan volume rendah, melalui edukasi kepada pasien maupun tenaga medis terkait pentingnya pemeriksaan tersebut.
5. Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap tren jumlah pemeriksaan setiap bulan guna mengidentifikasi pola peningkatan atau penurunan serta sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya.
6. Tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang telah mencapai target dengan melakukan pengawasan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan.

1.2.2.1 Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan Juni 2026

No	Tanggal	No RM	Unit	Jenis Specimen	Pemeriksaan	Alasan Kerusakan	Tindakan
1	02/06/2026	202117	IGD	DARAH	DARAH LENGKAP	CLOTHING	MINTA SAMPEL ULANG
2	09/06/2026	250460	ICU	DARAH	DARAH LENGKAP	CLOTHING	MINTA SAMPEL ULANG
3	12/6/2026	238598	7A	DARAH	FH	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
4	22/6/2026	203098	8A	DARAH	DARAH LENGKAP	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
5	23/06/2026	112798	ICU	DARAH	UR, CR, SE	LISIS	MINTA SAMPEL ULANG
6	26/06/2026	251143	IGD	DARAH	DARAH LENGKAP	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
7	26/06/2026	251143	IGD	DARAH	FAAL HEMOSTASIS	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG

8	29/06/2026	196672	5C	DARAH	FAAL HEMOSTASIS	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
---	------------	--------	----	-------	--------------------	----------	--------------------------

Analisis :

Selama periode tersebut terdapat 8 kejadian penolakan sampel, terdiri dari 7 kejadian clotting dan 1 kejadian lisis. Pemeriksaan yang paling sering terdampak adalah Darah Lengkap dan Faal Hemostasis, dengan unit asal sampel dari IGD, ICU, dan ruang perawatan.

Kejadian ini kemungkinan disebabkan oleh teknik pengambilan sampel yang kurang tepat, keterlambatan pencampuran dengan antikoagulan, ketidaksesuaian volume darah, serta penanganan dan distribusi sampel yang kurang optimal. Meskipun seluruh sampel telah dilakukan pengambilan ulang, kondisi ini tetap berdampak pada keterlambatan waktu pelayanan (TAT).

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan edukasi ulang kepada petugas pengambil sampel terkait teknik phlebotomy yang benar.
2. Mengingatkan pentingnya pencampuran sampel segera setelah pengambilan (inversi tabung).
3. Melakukan monitoring khusus pada unit dengan kejadian terbanyak (IGD dan ICU).
4. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pengiriman sampel ke laboratorium.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap kejadian penolakan sampel sebagai indikator mutu.

1.2.2.2 Jumlah Pemeriksaan Patologi Klinik (Permeriksaan Rujukan)

No	Golongan PA	April 2026	Mei 2026	Juni 2026	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	PA Golongan 1	9	4	4	0%
2	PA Golongan 2	5	5	7	↑40%

3	PA Golongan 3	103	84	89	↑5,95%
4	Total	126	93	155	↑66,6%

Analisis:

Jumlah pemeriksaan Patologi Anatomi pada bulan Juni 2026 mengalami peningkatan signifikan menjadi 155 pemeriksaan, meningkat 66,6% dibandingkan bulan Mei (93 pemeriksaan).

Peningkatan terutama terjadi pada:

- PA Golongan 2, meningkat dari 5 menjadi 7 pemeriksaan (↑40%).
- PA Golongan 3, meningkat dari 84 menjadi 89 pemeriksaan (↑5,95%) dan tetap menjadi jenis pemeriksaan dengan volume tertinggi.

Sementara itu, PA Golongan 1 tetap stabil sebanyak 4 pemeriksaan dan tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya.

Peningkatan jumlah pemeriksaan PA kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah tindakan operatif, biopsi, dan kebutuhan penegakan diagnosis definitif pada pasien. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan layanan Patologi Anatomi pada bulan Juni 2026.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan monitoring tren jumlah pemeriksaan PA setiap bulan.
2. Memastikan kesiapan alur pengiriman spesimen dan koordinasi dengan laboratorium rujukan.
3. Melakukan evaluasi kebutuhan anggaran dan logistik seiring meningkatnya jumlah pemeriksaan PA.
4. Berkoordinasi dengan unit bedah dan DPJP untuk memastikan ketepatan pengiriman spesimen dan kelengkapan data klinis.

1.2.2.3 Permintaan Labu Darah pada Bank Darah Rumah Sakit

No	Bulan	Permintaan Labu darah				Total Permintaan Labu darah
	Golda	A	AB	O	B	
1	Januari	21	6	24	29	80

2	Februar i	16	27	37	7	87
3	Maret	33	11	57	40	141
4	April	15	32	30	7	84
5	Mei	21	11	24	22	78
6	Juni	20	9	22	25	76

Catatan: Tidak ada hasil incompatible crossmatch pada Bulan Juni 2026

Tabel Jumlah Permintaan Return Labu Darah Juni 2026

No	Bulan	Permintaan Return Labu darah				Total Permintaan Labu darah
	Golda	A	AB	O	B	
1	Januari	4	1	4	2	11
2	Februari	2	6	0	0	8
3	Maret	14	11	20	20	65
4	April	-	2	4	-	6
5	Mei	2	7	6	5	15
	Juni	3	8	1	6	18

Analisis:

Jumlah permintaan labu darah pada bulan Juni 2026 sebanyak 76 kantong, mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan Mei (78 kantong) atau turun 2,6%. Golongan darah yang paling banyak diminta adalah golongan B (25 kantong) dan golongan O (22 kantong).

Pada bulan Juni tidak ditemukan hasil incompatible crossmatch, yang menunjukkan proses pemeriksaan pra-transfusi berjalan dengan baik dan aman. Sementara itu, jumlah permintaan return labu darah pada bulan Juni meningkat menjadi 18 kantong dibandingkan bulan Mei (15 kantong) atau meningkat 20%. Return terbanyak berasal dari golongan darah AB (8 kantong) dan B (6 kantong). Peningkatan return kemungkinan disebabkan oleh perubahan kondisi klinis pasien, pembatalan tindakan, atau darah yang tidak jadi digunakan. Hal ini perlu dievaluasi untuk meningkatkan efisiensi

pengelolaan persediaan darah dan meminimalkan potensi pemborosan.

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi jumlah permintaan serta return labu darah setiap bulan.
- 2. Meningkatkan koordinasi dengan DPJP dan unit pelayanan terkait ketepatan perencanaan kebutuhan transfusi darah.
- 3. Melakukan sosialisasi mengenai ketepatan permintaan darah untuk mengurangi kejadian return yang tidak diperlukan.
- 4. Memastikan pengelolaan stok darah berjalan optimal untuk mencegah pemborosan dan menjaga ketersediaan darah.
- 5. Mempertahankan pelaksanaan prosedur crossmatch sesuai standar agar tetap tidak terjadi kejadian incompatible crossmatch.

3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

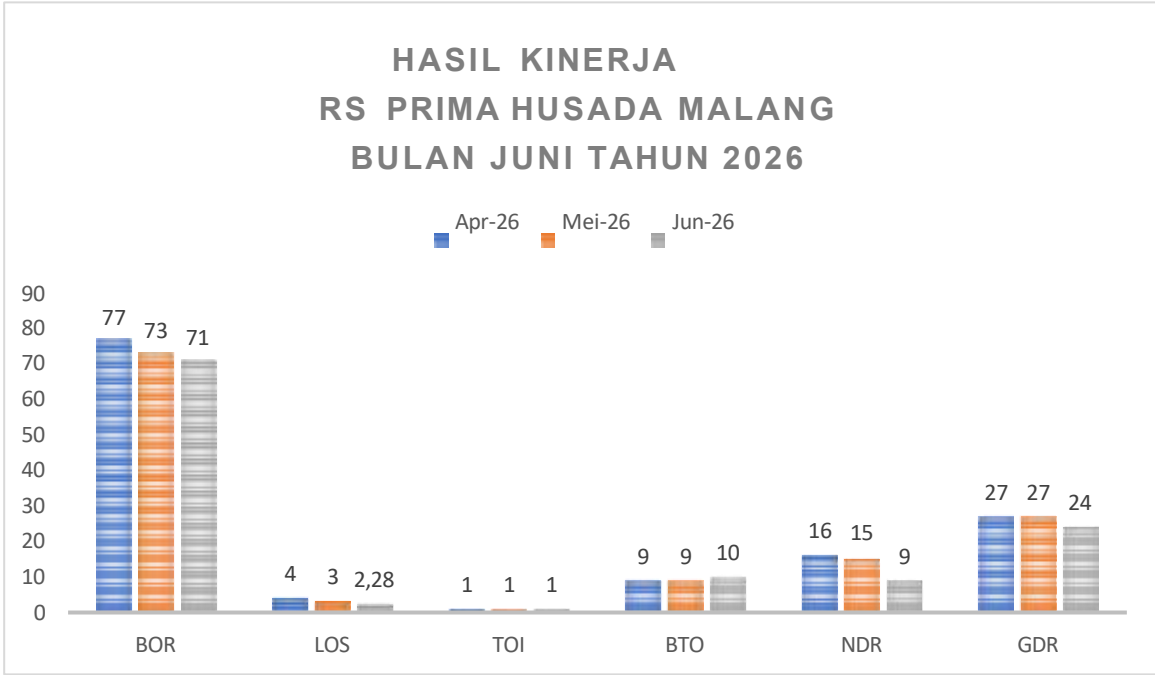
Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Juni 2026

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang													
						LT 2C	LT 2A	LT 3A	LT 3C	LT 4a b	LT 5C	LT 6	LT 7	LT 8	MT S	NIC U	HC U	IC U	TOTAL
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP / (\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60 - 80 %	April 26	62	61	32	70	78	68	87	76	87	71	20	53	39	77
					Mei 26	52	54	0	97	64	62	72	75	76	57	34	34	38	73
					Juni 26	55	64	15	69	70	62	67	76	79	72	27	33	29	71
ALOS (Average)	Rata-rata lama rawat	$LD / \sum px \text{ keluar } (H+M)$	jumlah lama dirawat,	6 - 9 hari	April 26	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	7	5	4
					Mei	3	3	0	3	3	3	3	3	3	2	5	3	5	3

Length of Stay)	seorang pasien		jumlah pasien keluar		Juni 26	2,49	2,51	2,06	2,33	2,25	2,54	2,76	2,66	2,65	1,99	1,67	0,77	1,36	2,28
3TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum \text{hari}) - HP) / \sum \text{pasien keluar (H+M)}$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	April 26	1	2	5	1	1	1	0	1	0	4	5	1	10	1
					Mei 26	2	2	0	0	1	1	1	1	1	1	10	5	8	1
					Juni 26	1	1	11	1	1	3	1	1	1	1	3	1	2	1
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode	$\sum Px \text{ keluar (H+M)} / \sum TT$	jumlah pasien. Jumlah TT	4 - 5 kali	April 26	8	8	5	9	9	8	9	8	9	4	3	11	.3	9
				(dalam hitungan bulan)	Mei 26	7	7	0	11	8	8	7	9	9	9	2	4	2	9
					Juni 26	7	8	2	9	9	7	7	9	9	11	3	13	6	10
NDR (Net Death Rate)	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ Mati } >48\text{jm}) / \sum Px \text{ keluar (H+M)} \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25%	April 26	0	11	0	0	14	17	28	0	10	0	625	0	0	16
					Mei 26	0	0	0	0	8	8	45	10	9	0	0	250	438	15
					Juni 26	19	0	0	4	0	9	11	9	0	0	0	0	189	9

GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar (H+M)}) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	April 26	16	22	0	0	14	17	36	0	20	125	750	0	0	27
					Mei 26	0	13	0	0	8	8	56	19	18	0	0	625	87 5	27
					Juni 26	19	11	0	4	0	9	11	9	18	0	0	154	454	24

3.1.1.1 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Juni 2026



INDIKATOR	ANALISA	MASALAH	RTL (RENCANA TINDAK LANJUT)
BOR (Bed Occupancy Rate)	Nilai BOR rumah sakit masih berada pada kisaran yang baik, namun terdapat variasi antar unit. ICU memiliki BOR relatif rendah, sedangkan ruang kelas III dan maternitas memiliki tingkat hunian lebih tinggi.	Pemanfaatan tempat tidur belum merata di seluruh unit perawatan.	Melakukan monitoring BOR per unit setiap bulan, evaluasi distribusi pasien, serta optimalisasi penempatan pasien sesuai kapasitas dan kelas perawatan.
ALOS (Average Length of Stay)	Lama rawat rata-rata masih sesuai karakteristik kasus, namun terdapat beberapa pasien dengan lama rawat yang lebih panjang karena komplikasi atau menunggu rujukan.	Lama rawat beberapa pasien meningkat akibat keterlambatan pemeriksaan penunjang, konsultasi, atau proses rujukan.	Mempercepat koordinasi DPJP, pemeriksaan penunjang, discharge planning sejak awal perawatan, serta monitoring pasien dengan LOS tinggi.
TOI (Turn Over Interval)	TOI menunjukkan masih terdapat tempat tidur yang kosong sebelum digunakan kembali, terutama pada unit dengan BOR rendah.	Belum optimalnya pemanfaatan tempat tidur pada beberapa ruang perawatan.	Melakukan evaluasi manajemen bed setiap hari melalui bed management meeting dan mempercepat proses cleaning bed setelah pasien pulang.
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi penggunaan tempat tidur cukup baik pada sebagian besar unit, namun masih terdapat perbedaan antar ruang.	Distribusi pasien belum merata sehingga turnover antar ruang tidak seimbang.	Mengoptimalkan sistem informasi ketersediaan tempat tidur dan koordinasi admission dengan seluruh unit.

3.1.1.2 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan Juni 2026

NO	CODE ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
1	E11.4	With neurological complications	607
2	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	340
3	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	311
4	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	271
5	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	233
6	F41.2	Mixed anxiety and depressive disorder	208
7	K80.8	Other cholelithiasis	199
8	J47	Bronchietasis	197
9	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	171
10	A09.9	Gastroenteritis and colitis of unspecified origin	171

3.1.1.1 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Juni 2026

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	Cerebrovascular Accident Infark	I63.9	48
2.	Pneumonia	J18.9	37
3.	Gastroenteritis Acute	A09.9	33
4.	Dengue Fever	A90	26
5.	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	J44.1	23
6.	Calculus of the kidney	N20.0	23
7.	Diabetes Mellitus Hyperglykemia	E14.9	21
8.	Concussion	S06.0	19
9.	Necrotizing Fascitis	M72.6	17
10.	Tumor Mammae	D24	14

Analisis :

- 1) Pada bulan Juni 2026, diagnosis rawat jalan didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM), terutama Diabetes Mellitus dengan komplikasi neurologis (E11.4) sebanyak 607 kasus, diikuti penyakit jantung seperti Decompensatio Cordis, Chronic Ischemic Heart Disease, dan Hypertensive Heart Disease. Hal ini menunjukkan tingginya beban penyakit kronis degeneratif yang memerlukan pengelolaan jangka panjang dan kontrol rutin.

Selain itu, masih ditemukan kasus gangguan kesehatan mental, penyakit saluran napas kronis, serta penyakit saluran cerna yang cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pelayanan promotif, preventif, dan manajemen penyakit kronis secara berkesinambungan.
- 2) Diagnosis rawat inap bulan Juni 2026 didominasi oleh CVA Infark (48 kasus), diikuti Pneumonia (37 kasus) dan Gastroenteritis Akut (33 kasus). Tingginya kasus CVA, COPD, dan Diabetes Mellitus menunjukkan masih besarnya beban penyakit degeneratif dan komplikasinya pada pasien rawat inap.

Selain itu, terdapat peningkatan kasus penyakit infeksi seperti Pneumonia dan Dengue Fever, serta kasus bedah dan trauma seperti batu ginjal, concussion, necrotizing fasciitis, dan tumor mammae. Variasi kasus ini menunjukkan kebutuhan pelayanan multidisiplin dan kesiapan sumber daya rumah sakit dalam menangani kasus akut maupun kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Rawat Jalan:
- 3) Mengoptimalkan program pengelolaan penyakit kronis (DM, hipertensi, penyakit jantung) melalui edukasi dan monitoring kepatuhan pasien.

4) Meningkatkan kegiatan promotif dan preventif terkait faktor risiko PTM.

-
- 5) Mengoptimalkan Program lansia dengan pemnyakit kronis bagi pasien DM dan hipertensi.
 - 6) Meningkatkan skrining komplikasi DM untuk mencegah progresivitas penyakit.
 - 7) Melakukan monitoring tren kasus PTM secara berkala sebagai dasar perencanaan layanan.
2. Rawat Inap:
- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap Clinical Pathway kasus stroke, pneumonia, dan diabetes.
 - 2) Mengoptimalkan Program PPRA terutama pada kasus infeksi bakteri, pneumonia, dan necrotizing fascitis.
 - 3) Meningkatkan kepatuhan pemeriksaan kultur dan sensitivitas pada kasus infeksi yang memerlukan antibiotik spektrum luas.
 - 4) Memperkuat edukasi pasien dan keluarga terkait pencegahan kekambuhan stroke, diabetes, dan penyakit jantung.
 - 5) Melakukan evaluasi berkala terhadap tren penyakit infeksi dan non-infeksi sebagai dasar penyusunan program mutu dan keselamatan pasien.

3.1.1.2 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Juni 2026

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	-	-	-	-	1090	93,70	61	6,30	1080	93,37	69	5,16	1147	99,66	4	0,34
Februari	-	-	-	-	920	84	119	16	929	86,4	110	13,6	1005	97	34	3
Maret	-	-	-	-	1001	95,30	54	16	1000	94,93	55	5,07	1031	96,67	24	,33
April	1244	99	12	1	1070	88	149	12	1113	89	142	11	1162	93	94	7
Mei	14	100	0	0	996	85	179	15	1039	87	157	13	1087	93	81	7
Juni	1149	99	7	1	790	70	345	30	1007	87	156	13	701	60	462	40
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1013	97,18	38	2,82	-	-	-	-	1051	100	0	0	1051	100	0	0
Februari	1008	98	27	2	-	-	-	-	1034	100	2	0,3	1036	100	0	0
Maret	1047	100	7	0	-	-	-	-	1043	100	11	0	1054	100	0	0
April	1148	91	107	9	1203	96	52	4	1203	96	52	4	1220	97	35	3
Mei	1112	93	84	8	1154	96	42	4	1171	98	25	2	1080	90	116	10
Juni	1099	95	62	6	1113	96	48	4	1140	98	21	2	1093	94	68	6

Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	556	52	484	48	1040	100	0	0	1133	100	0	0	1010	91	123	9
Februari	528	61	398	39	926	100	0	0	1027	100	0	0	965	94	62	6
Maret	587	65	341	35	927	100	1	0,07	1034	90	13	10	291	33	756	67
April	564	99	99	3	1130	99	11	1	1206	97	42	3	1171	99	13	1
Mei	517	98	8	2	1061	99	14	1	1121	94	72	6	1067	98	21	2
Juni	522	98	12	2	994	96	40	4	1117	96	42	4	1043	97	33	3
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

Analisis :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP

Pada bulan Juni 2026, kelengkapan Ringkasan Keluar Masuk tetap baik sebesar 99%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada Pengkajian Awal Medis menjadi 70% dibandingkan bulan Mei (85%) dan pada Ringkasan Pulang menjadi 60% dibandingkan bulan Mei (93%). Kelengkapan CPPT DPJP tetap stabil di angka 87%. Penurunan pada pengkajian awal medis dan ringkasan pulang menunjukkan masih perlunya peningkatan kepatuhan pengisian dokumen oleh DPJP.

2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:

Kelengkapan dokumen keperawatan pada bulan Juni menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Pengkajian Keperawatan meningkat

menjadi 95%, CPPT Perawat tetap baik di 96%, Asuhan Keperawatan meningkat menjadi 98%, dan Resume Keperawatan meningkat menjadi 94%. Secara umum, kepatuhan pengisian dokumen oleh perawat sudah baik dan menunjukkan tren perbaikan.

3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker

Kelengkapan dokumentasi ahli gizi pada bulan Juni tetap tinggi, dengan Pengkajian Awal Gizi sebesar 98% dan CPPT Ahli Gizi sebesar 96%. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada CPPT dibandingkan bulan Mei (99%), secara umum dokumentasi gizi masih berada dalam kategori baik. Kelengkapan Rekonsiliasi Obat pada bulan Juni mencapai 96%, meningkat dibandingkan bulan Mei (94%). Kelengkapan CPPT Apoteker juga tetap baik sebesar 97%. Hal ini menunjukkan kepatuhan dokumentasi farmasi klinis sudah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan monitoring untuk mencapai kelengkapan 100%.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP:

- 1) Melakukan monitoring kelengkapan rekam medis DPJP setiap minggu.
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi kepada masing-masing DPJP sebagai umpan balik.
- 3) Mengoptimalkan peran Kepala SMF dan Komite Medik dalam pengawasan kepatuhan dokumentasi.
- 4) Melakukan reminder kepada DPJP untuk melengkapi rekam medis sebelum pasien pulang.
- 5) Melakukan audit rekam medis secara berkala dan membahas hasilnya dalam rapat mutu.

2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:

- 1) Melakukan supervisi pengisian Resume Keperawatan/SBAR oleh kepala ruang.
- 2) Mengingatkan perawat penanggung jawab pasien untuk melengkapi dokumen sebelum pasien pulang.
- 3) Melakukan audit dokumentasi keperawatan secara rutin.
- 4) Memberikan edukasi dan refreshment terkait pentingnya dokumentasi keperawatan yang lengkap.
- 5) Menjadikan kelengkapan rekam medis sebagai salah satu indikator evaluasi kinerja ruangan.

3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker:

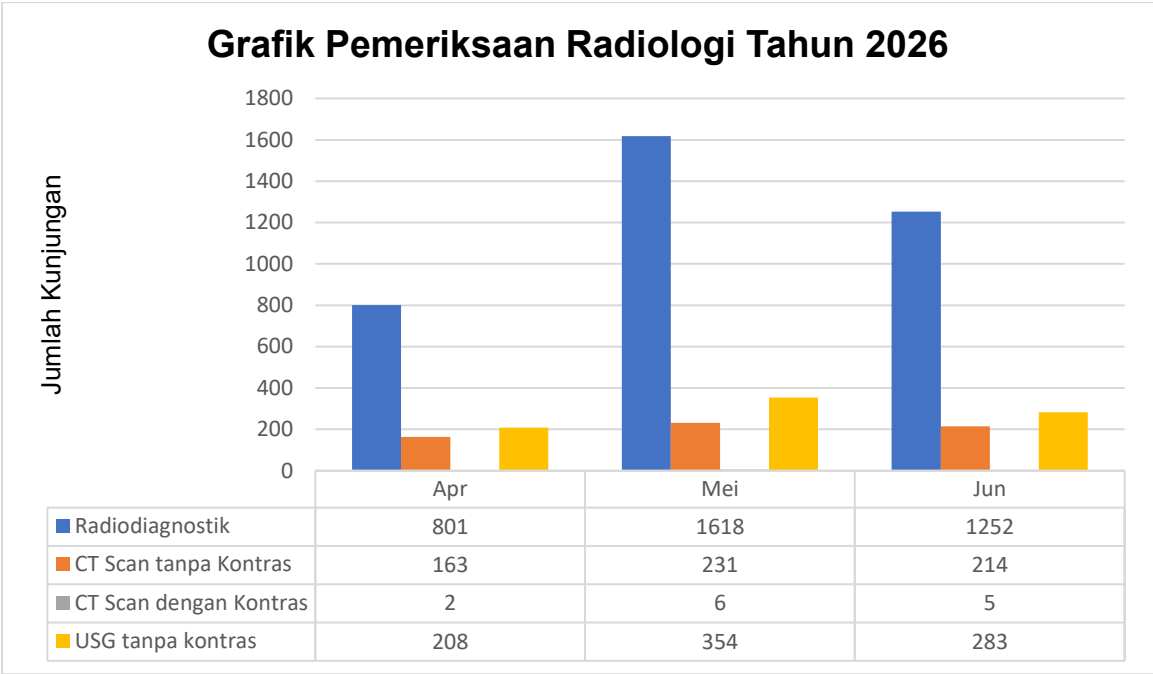
- 1) Meningkatkan monitoring kepatuhan rekonsiliasi obat pada pasien masuk, pindah ruang, dan pulang.
- 2) Melakukan audit dokumentasi farmasi dan gizi secara berkala.
- 3) Memberikan umpan balik kepada petugas yang belum melengkapi dokumentasi sesuai standar.
- 4) Memastikan dokumentasi dilakukan secara real time pada saat pelayanan diberikan.
- 5) Mempertahankan capaian CPPT Gizi dan Farmasi yang telah mencapai $\geq 98\%$.

1.2.4 Radiologi

1.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juni 2026

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			APR	MEI	JUNI
1.	RADIOLOGI	UMUM	324	180	217
		BPJS KESEHATAN	1105	702	951
		BPJS TK	157	44	50
		ASURANSI SWASTA	10	17	18
		JASA RAHARJA	22	5	8
		RSPHS	0	0	0
		RSDH	0	0	8
		TOTAL	801	1.618	1.252
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	19	22	28
		BPJS	136	195	173
	KONTRAS	KESEHATAN			
		BPJS TK	1	4	8
		ASURANSI SWASTA	3	4	3
		JASARA HARJA	4	6	2
		TOTAL	163	231	214
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	0	0
		BPJS KESEHATAN	2	6	5
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
		TOTAL	2	6	5
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	30	1	3
		BPJS KESEHATAN	174	351	280
		BPJS TK	0	1	0
		ASURANSI SWASTA	4	1	0
		JASARAHARJA	0	0	0
		TOTAL	208	354	283

1.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juni 2026



Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
1. Radiodiagnostik (Rontgen): Mengalami lonjakan signifikan pada bulan Mei (1.618 pasien) dari sebelumnya April (801 pasien), lalu sedikit melandai di bulan Juni (1.252 pasien). BPJS Kesehatan mendominasi lebih dari 75% total pasien. 2. CT Scan Tanpa Kontras: Stabil dan cenderung meningkat (April: 163, Mei: 231, Juni: 214). Ini merupakan lini produk penunjang canggih dengan volume yang solid. 3. CT Scan Dengan Kontras: Volume sangat rendah (April: 2, Mei: 6, Juni: 5). 4. USG Tanpa Kontras: Mengalami penurunan yang signifikan, bulan juni 283 sedangkan bulan mei 304 dan bulan April 338	Plan: - Mengidentifikasi penyebab penurunan jumlah pemeriksaan USG pada bulan Juni dan mengembalikan volume pelayanan menjadi >300 tindakan per bulan. - Mengantisipasi peningkatan volume Radiodiagnostik dan CT Scan agar waktu tunggu pelayanan tetap memenuhi standar mutu. - Melakukan audit ketersediaan dokter spesialis radiologi, kondisi alat USG, serta kecukupan BMHP penunjang. - Menyesuaikan jadwal dan distribusi SDM pada jam kunjungan puncak pasien BPJS. - Indikator: Alat USG beroperasi 100%, tidak terjadi keterlambatan pelayanan, dan ketersediaan BMHP tetap terjaga. Do: - Menelaah logbook pemeliharaan alat USG untuk mengidentifikasi adanya downtime atau gangguan teknis. - Berkoordinasi dengan instalasi farmasi terkait ketersediaan film radiologi, zat kontras, dan BMHP lainnya. - Mengoptimalkan koordinasi alur pendaftaran pasien BPJS agar tidak terjadi penumpukan pasien. - Mendistribusikan beban kerja radiografer secara proporsional sesuai tren peningkatan kunjungan. Study: - Menganalisis dominasi pasien BPJS sebagai penjamin utama sehingga diperlukan ketelitian dalam proses administrasi dan verifikasi klaim. - Mengevaluasi faktor penyebab rendahnya jumlah pemeriksaan CT Scan dengan kontras, termasuk kemungkinan hambatan persyaratan pemeriksaan penunjang sebelum tindakan. - Membandingkan tren kunjungan bulan April–Juni untuk mengidentifikasi pola penurunan USG dan peningkatan radiodiagnostik. Action:

	• Melanjutkan monitoring dan evaluasi volume pemeriksaan setiap bulan. • Meningkatkan kerja sama dengan bagian Humas dan Marketing dalam promosi Medical Check Up (MCU) dan layanan radiologi. • Melaksanakan pemeliharaan preventif serta kalibrasi alat secara berkala dan tertib. • Menyusun rencana perbaikan alur pelayanan berdasarkan hasil evaluasi agar kapasitas pelayanan tetap optimal dan waktu tunggu terkendali.
--	--

Tabel Jumlah Laporan Pembacaan Ulang Hasil Radiologi Tahun 2026

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Januari 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Abd Salam	Brain Atrofi Senilis	Brain Atrofi senilis, Infark	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	-	-	-	-
Bulan Februari 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Damiasih / 135744	Infark akut di periventrike	Tambahan bacaan Hydrocefalus obstrukti	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	M Danendra Al Hussen / 201495	Normal	Normal	1
Bulan Maret 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Asiyo Waga/24520	Fraktur distal ulna dan radius	Tambahan bacaan keterlibatan intra articular (epyphysis)	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	Sumarmi/011074	Fractura caput Os Humerus sinistra.Dislokasi sendi(+)	Tambahan bacaan fraktur epiphisis	1
Bulan April 2026					
1	dr. Agung, Sp.Rad (K)	1. Gusti fardi/192214 2. Ummu aimanah/231796 3. Tasir/091111	Normal Normal Susp cerebritis	Infark sub akut Infark sub akut Cerebritis	3
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	1. Ngadinem/125411 2. Rasmini/247707 3. Kasanah/248579	Cardiomegali Normal Bronchitis	Cardiomegali, Pneumonia Atelectasis Paru kiri. Kp Duplex	3
Bulan Mei 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	1. Sugito/245224 2. Sumardji/249022	Prostat enlargement Pneumonia	Vesicolitiasis, Prostat enlargement Tetap pneumonia	2

2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	1. Kasanah/248579 2. Romadlon/249845 3. Wisnu attar/206655 4. Sriamah/128436	KP OA Dislokasi Cardiomegali	KP, Infected bronchiectais Fractura os Patela Tidak ada efyphyse Fraktur costae, cardio megali	4
Bulan Juni 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	-	-	-	-
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	1. Sulastri/103381 2. Edi/250273 3. Siti yuliasih/123966 4. Nabila Agusandhya/101522	Normal Linier fractura Fractura Os Humerus Fractura os tibia	Fraktur neck femur Close reduction of ephiphisis Efiphysis Efiphysis	4

Analisis :

1. Jumlah kasus pembacaan ulang masih relatif sedikit, menunjukkan tingkat kesesuaian hasil pembacaan awal cukup baik atau belum semua kasus tertentu dilakukan second reading.
2. Temuan pembacaan ulang didominasi oleh kasus **tulang dan trauma (fraktur)**, sehingga diperlukan perhatian khusus pada interpretasi radiografi kasus ortopedi.
3. Tidak ditemukan laporan terkait perbedaan interpretasi mayor yang berdampak signifikan terhadap tata laksana pasien.
4. Kegiatan pembacaan ulang tetap penting sebagai bagian dari **program kendali mutu (quality assurance)** untuk meningkatkan akurasi diagnostik dan menurunkan risiko kesalahan interpretasi.

Rencana Tindak Lanjut :

Plan:

1. Meningkatkan pelaksanaan pembacaan ulang secara rutin terutama pada kasus trauma, ortopedi, dan kasus dengan tingkat kesulitan tinggi.
2. Menetapkan target minimal jumlah kasus yang dilakukan second reading setiap bulan.

Do:

1. Melaksanakan diskusi kasus (case review) antara dokter spesialis radiologi terhadap kasus-kasus dengan temuan fraktur kompleks.
2. Mendokumentasikan hasil pembacaan ulang dan perbedaan interpretasi pada formulir audit radiologi.

Study:

1. Mengevaluasi tingkat kesesuaian hasil pembacaan pertama dan kedua serta mengidentifikasi pola kesalahan yang berulang.
2. Menganalisis kebutuhan pelatihan atau penyegaran kompetensi pada interpretasi radiologi muskuloskeletal.

Action

1. Menyusun rekomendasi perbaikan dan pembelajaran dari hasil audit pembacaan ulang.
2. Melaksanakan monitoring pembacaan ulang secara berkala sebagai indikator mutu pelayanan radiologi.
3. Meningkatkan koordinasi dengan dokter pengirim untuk memastikan hasil interpretasi yang akurat dan mendukung keselamatan pasien.

1.2.4.3 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

1. dr.Agung Setyawan, Sp.Rad (K)

JENIS PEMERIKSAAN	Rata-rata bulan April		Rata-rata bulan Mei		Rata-rata bulan Juni	
	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan
RO THORAX	00:02:40	00:15:00 (waktu efektif) 05:00:00 (diatas jam 12 malam)	00:03:10	00:45:34 (waktu efektif) 04:32:24 (diatas jam 12 malam)	00:01:50	00:40:34 (waktu efektif) 05:40:25 (diatas jam 12 malam)
RO VERTEBRAE	-	-	-	-	-	-
RO ABDOMEN	-	-	00:08:00	00:28:00(waktu efektif)	-	-
RO EKSTREMITAS	-	-	-	-	-	-
RO SKULL	-	-	-	-	-	-
USG	00:05:00	00:05:00	00:05:51	00:05:51	00:04:53	00:05:00
CT SCAN NON KONTRAS	00:05:00	00:30:00 (waktu efektif) 18:49:00 (diatas jam 12 malam)	00:05:00	01:33:52 (waktu efektif) 05:45:00 (diatas jam 12 malam)	00:06:00	00:45:00 (waktu efektif) 11:37:56 (diatas jam 12 malam)
CT SCAN KONTRAS	00:15:00	00:25:00 (waktu efektif) 18:49:00 (diatas jam 12 malam)	-	-	00:12:02	00:45:00 (waktu efektif) 11:37:56 (diatas jam 12 malam)
RADIOLOGI CITO	00:10:00	00:04:00 (waktu efektif) 00:25:00 (diatas jam 12 malam)	00:10:00	00:04:00 (waktu efektif) 00:20:00 (diatas jam 12 malam)	00:10:00	00:10:00 (waktu efektif) 00:30:00 (diatas jam 12 malam)

2. dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad (K)

JENIS PEMERIKSAAN	Rata-rata bulan April		Rata-rata bulan Mei		Rata-rata bulan Juni	
	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan
RO THORAX	00:03:04	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:03:00	0:43:38 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:02:00	0:27:26 (pada saat jam praktek) 10:05:00 (diluar jam praktek)

RO VERTEBRAE	00:04:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:04:00	0:27:26 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:03:45	0:45:08 (pada saat jam praktek) 11:10:05 (diluar jam praktek)
RO ABDOMEN	00:10:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:10:00	0:20:48 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:05:00	0:20:48 (pada saat jam praktek) 13:05:25 (diluar jam praktek)
RO EKSTREMITAS	00:02:00	0:10:00 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:02:00	0:28:37 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:02:00	0:26:00 (pada saat jam praktek) 10:05:25 (diluar jam praktek)
RO SKULL	-	-	00:03:00	0:23:30 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	03:00	0:50:00 (pada saat jam praktek) 11:20:15 (diluar jam praktek)
USG	00:05:00	00:10.00	00:05:00	00:06.18	00:05:00	00:08:12
CT SCAN NON KONTRAS	-	-	-	-	-	-
CT SCAN KONTRAS	-	-	-	-	-	-
RADIOLOGI CITO	00:10:00	0:15:00	00:10:00	0:15:00	-	-

Analisa :

1. Response time penyelesaian pemeriksaan oleh radiografer sudah baik dan masih memenuhi standar pelayanan.
2. Response time pembacaan pada jam praktik dokter masih dalam batas yang dapat diterima, meskipun terdapat peningkatan pada beberapa jenis pemeriksaan seperti RO Skull dan RO Vertebrae.
3. Kendala utama terdapat pada pembacaan di luar jam praktik, yang menyebabkan waktu tunggu hasil menjadi panjang, terutama pada pemeriksaan yang dilakukan malam hari.
4. Peningkatan jumlah pasien radiagnostik pada bulan Juni turut berkontribusi terhadap meningkatnya beban pembacaan dokter radiologi.

Rencana Tindak Lanjut :

- Plan:
- 1. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan pembacaan hasil radiologi di luar jam praktik.
 - 2. Mengevaluasi kesesuaian jadwal praktik dokter radiologi dengan tren kunjungan pasien.
 - 3. Menetapkan target response time pembacaan hasil radiologi sesuai standar mutu rumah sakit.
- Do:
- 1. Melakukan koordinasi dengan dokter spesialis radiologi mengenai mekanisme pembacaan hasil pemeriksaan yang dilakukan di luar jam praktik.
 - 2. Mengoptimalkan penggunaan sistem RIS/PACS dan notifikasi otomatis agar hasil pemeriksaan segera terbaca.
 - 3. Menyusun prioritas pembacaan untuk kasus cito dan pasien rawat inap.
- Study:
- 1. Melakukan monitoring bulanan terhadap rata-rata response time pembacaan berdasarkan jenis pemeriksaan dan dokter pembaca.
 - 2. Menganalisis hubungan antara peningkatan volume pasien dengan keterlambatan pembacaan hasil.
 - 3. Mengevaluasi jumlah kasus yang melebihi standar waktu pelayanan.
- Action
- 1. Menyusun kebijakan pelayanan pembacaan hasil radiologi di luar jam praktik, termasuk mekanisme on-call atau teleradiologi apabila diperlukan.
 - 2. Melakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan response time sebagai indikator mutu unit radiologi.
 - 3. Meningkatkan koordinasi antara radiografer, petugas administrasi, dan dokter radiologi untuk mempercepat distribusi hasil pemeriksaan.
 - 4. Melakukan monitoring dan pelaporan indikator response time setiap bulan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

1.2.4.4 Tabel PMI dan PME di Radiologi

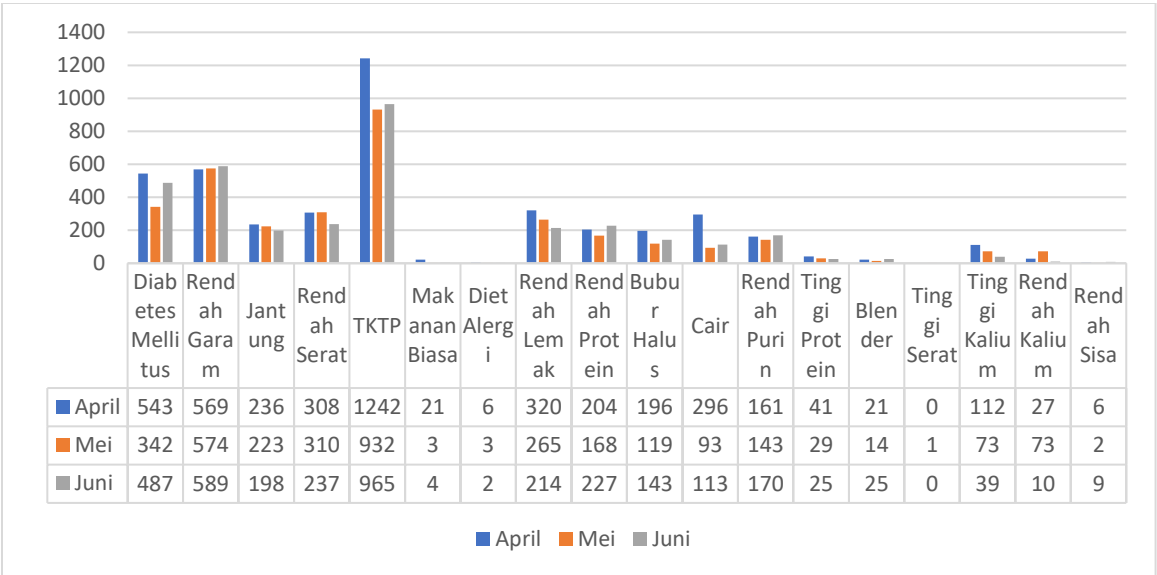
No	Nama Alat (Merk dan Tipe)	No. Seri	Frekuensi			Terakhir Kalibrasi	PJ	Pihak Ketiga (Kalibrator)
			Mingguan	Bulanan	Tahunan			
1	Rontgen Stationer	-	-	-	√	08/09/2025-08/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica
2	Rontgen Portable				√	08/09/2025-08/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica
3	CT Scan	-	-	-	√	02/09/2025-02/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica
4	USG				√	04/09/2025-04/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica

2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit 2026

No	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	
1.	Diabetes Mellitus	543	342	487	42,4
2.	Rendah Garam	569	574	589	2,6
3.	Jantung	236	223	198	↓11,2
4.	Rendah Serat	308	310	237	↓23,5
5.	TKTP	1242	932	965	3,5
6.	Makanan Biasa	21	3	4	33,3
7.	Diet Alergi	6	3	2	↓33,3
8.	Rendah Lemak	320	265	214	↓19,2
9.	Rendah Protein	204	168	227	35,1
10.	Bubur Halus	196	119	143	20,2
11.	Cair	296	93	113	21,5
12.	Rendah Purin	161	143	170	18,9
13.	Tinggi Protein	41	29	25	↓13,8
14.	Blender	21	14	25	78,6
15.	Tinggi Serat	0	1	0	↓100,0
16.	Tinggi Kalium	112	73	39	↓46,6
17.	Rendah Kalium	27	73	10	↓86,3
18.	Rendah Sisa	6	2	9	>100,0
Jumlah		4309	3321	3457	

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit 2026



Analisis :
Jumlah pemesanan diet pasien rawat inap meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pasien di rawat inap. Jumlah pemesanan diet meningkat 4,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Beberapa jenis diet yang meningkat pada bulan Juni adalah diet DM, Rendah Garam, TKTP, Rendah protein, dan rendah purin.

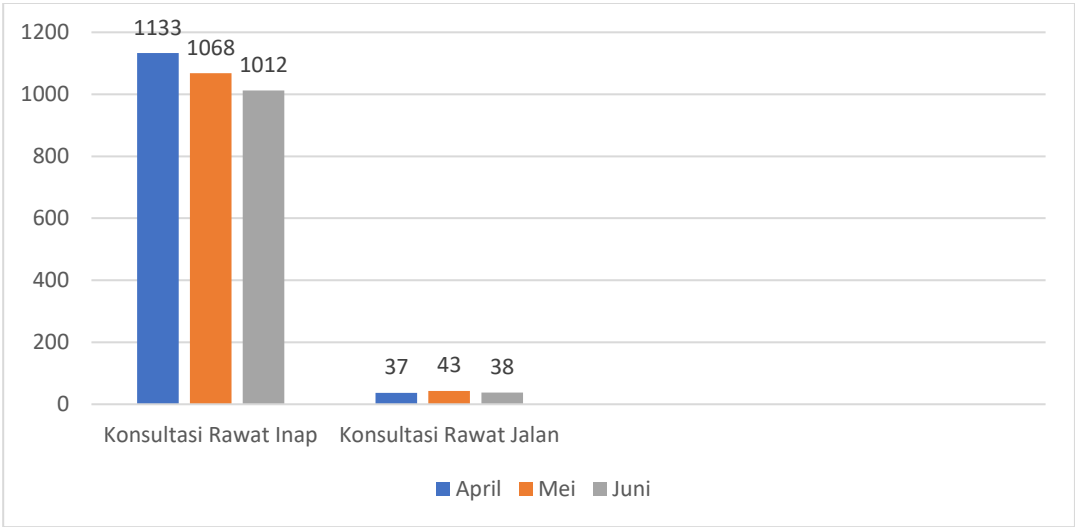
- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Melakukan monitoring tren pemesanan diet setiap bulan.
 - 2. Menyesuaikan perencanaan kebutuhan bahan makanan sesuai peningkatan diet DM, rendah garam, TKTP, rendah protein, dan rendah purin.

3. Meningkatkan koordinasi dengan unit rawat inap terkait perubahan dan ketepatan pesanan diet pasien.
4. Melakukan monitoring bulanan dengan melihat tren permintaan diet pasien.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi 2026

No.	Indikasi	Jumlah Pasien April 2026	Jumlah Pasien Mei 2026	Jumlah Pasien Juni 2026
1.	Konsultasi Rawat Inap	1133	1068	1012
2.	Konsultasi Rawat Jalan	37	43	38

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada 2026



Analisis :
 Jumlah konsultasi gizi rawat inap dan jalan pada bulan Juni menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Poli Spesialis yang sering merujuk pasien untuk konseling gizi adalah poli jantung (dokter Mira Sp.JP) dan poli penyakit dalam (dr. Ard hany Sp.PD, dokter Ardhi Bustami, Sp.PD dan dr.Heriyatmo, Sp.PD).

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Meningkatkan koordinasi dengan DPJP dan poli spesialis untuk optimalisasi rujukan konsultasi gizi.
 2. Melakukan sosialisasi kembali mengenai indikasi rujukan konsultasi gizi kepada tenaga medis.
 3. Melakukan monitoring tren jumlah konsultasi gizi setiap bulan dan mengidentifikasi faktor penyebab penurunan.
 4. Meningkatkan edukasi kepada pasien terkait pentingnya konsultasi gizi sebagai bagian dari terapi komprehensif.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Juni 2026

No	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan April 2026	Jumlah Komplain Bulan Mei 2026	Jumlah Komplain Bulan Juni 2026
1.	Benda asing dalam makanan pasien	0	1	0
	ISI KOMPLAINAN	(Tidak ada komplain)		
	Analisis	-		
	RTL	-		

2.4.5.6 Tabel Rekap *Food Waste* (Sisa Makanan) 2026

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026	
1.	Karbohidrat	Nasi	68,8	74,7	64,8	75,5% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH pada bulan April 2026 meningkat 0,5% dari bulan Maret 2026. Perlu adanya evaluasi pemorsian KH pada menu pasien
		Nasi Tim	98,8	91,7	90,6	
	Total		138	166,1	155,4	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0	Untuk konsumsi snack di Prima Husada Malang pada bulan April tidak ada sisa yang kembali dari pasien diakarenakan pasien memindahkan snack yang masih ada kedalam wadah pribadi saat pengambilan alat makan snack pasien
		Setup Pisang	0	0	0	
		Kacang Hijau	0	0	0	
		Kue Hongkong	0	0	0	
		Terang Bulan	0	0	0	
		Bubur Sagu	0	0	0	
		Kue Lumpur	0	0	0	
		Puding	0	0	0	
		Donat	0	0	0	
		Tahu Fantasi	0	0	0	
		Brule Bomb	0	0	0	
	Total		0	0	0	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 11,7 Kg pada bulan Maret.
	Bulan		Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	3,8	4,1	5,1	
		Rolade Ayam				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	4,5	3,8	4,9	
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)				
		Ayam Kecap				
		Tahu Bumbu Tomat				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	4,2	3,7	3,8	
	Sore	Sup (Suun, wortel, polong, bakso)				
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Ayam fillet panggang teflon	12,5	11,6	13,8	
	Total					
2.	Menu 2					
	Bulan		Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026	
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	4,7	3,5	4,8	
		Tahu Rempah (Remet)				
		Abon				
	Tambahan VIP	Telur Rebus	4,6	3,7	6	
	Siang	Sayur Bening				

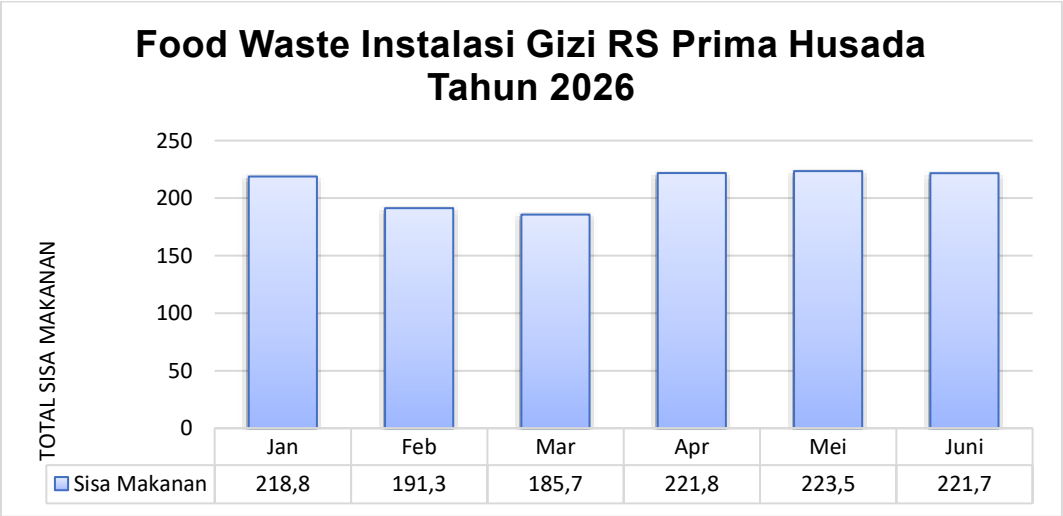
		(Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)				
		Ayam Wijen				
		Bakwan Jagung				
	Tambahan VIP	Telur Gulung				
	Sore	Capjae (wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)	4,2	3,3	5,3	
		Telur dadar tebal				
	Tambahan VIP	Tempe goreng				
Total		13,5	10,5	16,1		
3.	Menu 3					
	Bulan		Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026	
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	4,2	3,7	6,5	
		Tahu Krispy				
		Abon				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok				
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	4	3,9	4,1	
		Rolade Ayam				
		Tahu Goreng				
	Tambahan VIP	Tempe Bacem				
	Sore	Sapo (tahu goreng, wortel, bakso,dedaunan, saos tiram)	0,5	3,9	3,7	
		Telur rebus				
	Tambahan VIP	Tempe goreng				
	Total		8,7	11,5	14,3	
4.	Menu 4					
	Bulan		Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026	
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	3,8	4,8	4,3	
		Tahu Nugget				
		Abon				
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar				
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	4,2	3,8	4,2	
		Ayam Kecap				
		Jamur Krispy				
	Tambahan VIP	Tahu Bacem				
	Sore	Fuyunghai (telur, wortel,daunan)sasu polong orang	0,9	4	3,8	
		Jamur goreng				

	Tambahan VIP	abon			
	Total		8,9	12,6	12,3
5.	Menu 5				
	Bulan		Apr 2026	Mei 2026	Juni 2026
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	2,7	4,5	3,9
		Opor Tahu			
		Oper Telur			
	Tambahan VIP	Tempe Goreng			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	3,9	3,6	2,9
		Ayam Bombay			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Tahu Krispy			
	Sore	Soto ayam	4	2,8	3
		Telur rebus			
		VIP= Perkedel ayam			
	Total		9,9	10,9	9,8
	Total Sisa Menu tanpa KH		53,3	54,2	66,3
	Total Keseluruhan dengan KH		191,3	221,8	221,7

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2026

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)
1.	Januari 2026	218,8
2.	Februari 2026	191,3
3.	Maret 2026	185,7
4.	April 2026	221,8
5.	Mei 2026	223,5
6.	Juni 2026	221,7
7.	Juli 2026	-
8.	Agustus 2026	-
9.	September 2026	-
10.	Oktober 2026	-
11.	November 2026	-

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Tahun 2026



Analisis :

Total sisa makanan pada bulan Juni 2026 sebesar 221,7 kg, mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan Mei 2026 (223,5 kg), namun masih lebih tinggi dibandingkan bulan Februari dan Maret. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sisa makanan masih relatif tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Tingginya sisa makanan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan jumlah pasien rawat inap, ketidaksesuaian menu dengan selera pasien, kondisi klinis pasien yang menyebabkan penurunan nafsu makan, pembatasan diet tertentu, serta ketidakhadiran pasien di ruang perawatan saat waktu makan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi sisa makanan pasien secara rutin setiap bulan.
- 2. Mengidentifikasi jenis menu yang paling banyak menyisakan makanan untuk dilakukan perbaikan menu.
- 3. Meningkatkan koordinasi dengan perawat ruangan terkait kondisi pasien dan status makan pasien.
- 4. Melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya pemenuhan asupan gizi selama perawatan.
- 5. Melakukan evaluasi tingkat kepuasan pasien terhadap cita rasa, variasi, dan penyajian makanan sebagai dasar perbaikan pelayanan gizi.

1.4.7 CSSD – Laundry

1.4.7.1 CSSD

1.4.7.2 Tabel Jumlah Pemakaian Alat Sterilisasi 2026

No	Nama Alat	Jumlah Penggunaan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Memert	124	112	121	118	121	118						
2	Autoklaf	17	16	15	17	17	19						

Analisis:

Penggunaan Memert pada bulan Juni sebanyak 118 kali, sedikit menurun dibandingkan bulan Mei (121 kali) atau turun 2,5%, namun secara umum masih stabil. Penggunaan Autoklaf meningkat dari 17 kali menjadi 19 kali (↑11,8%), menunjukkan peningkatan kebutuhan sterilisasi.

Secara keseluruhan, penggunaan kedua alat masih stabil dan operasional alat berjalan dengan baik, namun tetap diperlukan pemeliharaan berkala untuk menjaga kinerja alat dan mencegah gangguan pelayanan.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan monitoring penggunaan alat setiap bulan untuk memastikan utilisasi alat tetap optimal.
- 2. Melaksanakan pemeliharaan dan kalibrasi alat secara berkala sesuai jadwal.
- 3. Memastikan ketersediaan bahan pendukung dan kesiapan alat guna mencegah gangguan pelayanan.
- 4. Melakukan evaluasi apabila terjadi peningkatan atau penurunan penggunaan yang signifikan.

Tabel Jumlah permintaan alat steril dari unit perawatan Tahun 2026

NO	NAMA UNIT	Jumlah Penggunaan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	IKO	445	456	461	480	466	445						
2	IRJA	115	106	126	136	130	121						

3	IGD	106	121	121	129	101	101						
4	IRNA 2 A	1	-	1	1	5	2						
5	IRNA 3 A	1	1	1	2	1	0						
6	IRNA 4 A	2	3	4	4	5	5						
7	IRNA 6 A	5	3	4	5	8	6						
8	IRNA 7 A	9	9	9	11	10	6						
9	IRNA 8 A	8	7	3	8	5	2						
10	IRNA 2 C	2	2	2	3	2	4						
11	ICU/HCU	4	3	2	3	2	0						
12	IRNA 3 C	4	2	1	0	5	3						
13	IRNA 4C/MATER	178	171	189	197	126	110						
14	PERINA	65	46	55	57	34	85						
15	IRNA 5 C	4	3	3	2	1	2						
	JUMLAH	949	933	982	1038	901	892						

Analisis :

Jumlah penggunaan pada bulan Juni 2026 sebanyak 892 kali, mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan Mei (901 kali) atau turun 1,0%. Penggunaan tertinggi masih berasal dari IKO (445 kali), diikuti IRJA (121 kali) dan IRNA 4C/Mater (110 kali).

Terdapat peningkatan signifikan pada unit Perina, yaitu dari 34 menjadi 85 kali (↑150%), sedangkan beberapa unit mengalami penurunan, terutama IRNA 4C/Mater dan beberapa ruang rawat inap lainnya. Secara umum, utilisasi antar unit masih didominasi oleh unit pelayanan dengan jumlah pasien yang tinggi

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Melakukan monitoring tren penggunaan pada setiap unit secara berkala.
 2. Melakukan evaluasi terhadap peningkatan penggunaan di Perina dan penurunan pada unit tertentu.
 3. Menyesuaikan perencanaan kebutuhan alat dan bahan berdasarkan pola penggunaan masing-masing unit.
 4. Meningkatkan koordinasi dengan unit pelayanan untuk memastikan ketersediaan pelayanan tetap optimal sesuai kebutuhan.

Tabel Rekap Produksi Kassa dan Linen Steril Tahun 2026

No	Nama Produksi	Jumlah Produksi Kassa (Pouches)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
*	BAHAN BJ												
1	Kasa IKO	685	685	690	715	660	577						
2	Kasa Deapress	274	270	276	280	220	188						
3	Kasa Bigkass	134	166	133	134	132	101						
4	Kasa Tampon Hidung	20	20	20	20	20	0						
5	Kasa Tampon Roll	15	15	15	15	15	0						
*	BAHAN HIDROFIL												

1	Kasa Ruang	1081	1079	1310	1391	995	1515						
*	LINEN STERIL												
1	Linen IKO	206	201	213	221	230	256						
2	Linen Mata	11	8	8	11	12	14						

Analisis:

Produksi kasa steril pada bulan Juni 2026 mengalami variasi dibandingkan bulan Mei. Produksi kasa hidrofил (kasa ruang) meningkat dari 995 menjadi 1.515 pouches (↑52,3%), menunjukkan peningkatan kebutuhan pelayanan. Produksi linen steril IKO juga meningkat dari 230 menjadi 256 pouches (↑11,3%).

Sebaliknya, produksi beberapa kasa bahan BJ mengalami penurunan, yaitu Kasa IKO (577 pouches), Kasa Deapress (188 pouches), dan Kasa Bigkass (101 pouches). Produksi Kasa Tampon Hidung dan Tampon Roll tidak ada pada bulan Juni karena tidak terdapat permintaan. Secara umum, produksi disesuaikan dengan kebutuhan unit pelayanan dan pola penggunaan bahan steril.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan monitoring produksi kassa dan linen steril berdasarkan tren permintaan dari unit pengguna.
2. Melakukan evaluasi kesesuaian antara jumlah produksi dengan jumlah distribusi untuk menghindari overstock maupun kekurangan stok.
3. Memastikan ketersediaan bahan baku kasa, linen, dan bahan pendukung sterilisasi tetap mencukupi.
4. Melakukan koordinasi dengan unit pengguna terkait estimasi kebutuhan bulanan agar produksi lebih tepat sasaran.
5. Mempertahankan ketersediaan stok minimum (buffer stock) untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan mendadak.
6. Melakukan evaluasi bulanan terhadap jenis produk yang mengalami penurunan atau peningkatan signifikan sebagai dasar perencanaan produksi berikutnya.

1.4.7.2 Laundry

Tabel Jumlah Pencucian Linen 2026

No	Nama Alat	Jumlah Pencucian											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Infeksius	2496	2256	2278	2366	2189	2180						
2	Non infeksius	2402	2309	2443	2480	2568	2374						

Tabel Jumlah linen kotor setiap unit Tahun 2026

No	Nama Unit	Jumlah Penggunaan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	IKO	2.030	1869	1812	2005	1847	1712						
2	IRJA	107	100	123	120	147	130						
3	IGD	173	175	232	240	224	181						
4	IRNA 2 A	155	143	165	193	177	106						
5	IRNA 3 A	80	55	14	127	15	27						
6	IRNA 4 A	248	247	247	269	261	217						
7	IRNA 6 A	172	164	182	167	180	135						
8	IRNA 7 A	166	155	187	158	179	160						
9	IRNA 8 A	191	168	171	198	170	186						
10	IRNA 2 C	280	248	193	201	246	239						

11	ICU	202	218	201	198	221	249						
12	IRNA 3 C	342	389	400	410	428	377						
13	MATERNITAS	425	356	382	390	341	380						
14	IRNA 5 C	232	183	195	196	241	256						
15	M.S	58	56	28	31	29	24						
16	Umum	9	7	24	9	14	41						
17	CSSD	13	7	11	11	9	12						
18	DAPUR/GIZ	9	7	6	6	5	10						
19	RAD	9	11	8	8	6	9						
20	LAB	8	7	6	7	7	9						

Analisa:

1. Berdasarkan data jumlah linen kotor dari setiap unit pada periode April hingga Juni 2026, jumlah linen yang diterima Unit Laundry menunjukkan variasi sesuai dengan tingkat aktivitas pelayanan masing-masing unit. Secara keseluruhan, jumlah linen kotor mengalami penurunan dari 4.844 linen pada bulan April, menjadi 4.557 linen pada bulan Mei, dan kembali menurun menjadi 4.160 linen pada bulan Juni. Perubahan jumlah linen tersebut masih dalam batas normal dan dipengaruhi oleh jumlah pelayanan, tingkat hunian pasien, serta aktivitas tindakan di masing-masing unit.
2. Unit dengan kontribusi linen kotor terbesar selama periode tersebut adalah IKO (Instalasi Kamar Operasi) dengan jumlah 2.005 linen pada April, 1.847 linen pada Mei, dan 1.712 linen pada Juni. Tingginya jumlah linen dari IKO berkaitan dengan aktivitas tindakan operasi yang menghasilkan linen dalam jumlah besar dan memerlukan pengelolaan khusus. Selain itu, unit lain dengan jumlah linen cukup tinggi adalah IRNA 3 C (410, 428, dan 377 linen), Maternitas (390, 341, dan 380 linen), IRNA 5 C (196, 241, dan 256 linen), serta ICU (198, 221, dan 249 linen).
3. Beberapa unit mengalami perubahan jumlah linen yang cukup terlihat, seperti IRNA 3 A yang meningkat pada bulan April menjadi 127 linen kemudian menurun pada bulan Mei menjadi 15 linen dan meningkat kembali menjadi 27 linen pada bulan Juni. Umum juga mengalami peningkatan jumlah linen pada bulan Juni menjadi 41 linen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, unit dengan jumlah linen relatif rendah seperti CSSD, Dapur/Gizi, Radiologi (RAD), dan Laboratorium (LAB) menunjukkan jumlah yang stabil sesuai aktivitas pelayanan.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan monitoring jumlah linen kotor setiap unit secara berkala sebagai dasar perencanaan kapasitas kerja, kebutuhan bahan pencuci, dan pengaturan jadwal petugas laundry.
2. Memprioritaskan pengawasan terhadap unit dengan volume linen tinggi seperti IKO, IRNA 3 C, Maternitas, ICU, dan IRNA 5 C untuk memastikan proses pengelolaan linen berjalan sesuai standar.
3. Mempertahankan penerapan SPO pemilahan dan penanganan linen infeksius maupun non infeksius guna mencegah terjadinya kontaminasi silang.
4. Melakukan koordinasi dengan unit penghasil linen apabila terjadi peningkatan atau penurunan jumlah linen yang signifikan agar proses pencucian dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Melakukan pemeliharaan rutin mesin laundry dan sarana pendukung untuk menjaga kelancaran proses pencucian.
6. Melakukan evaluasi data linen setiap bulan sebagai bahan peningkatan mutu pelayanan laundry dan memastikan ketersediaan linen bersih yang aman untuk mendukung pelayanan pasien.

Tabel Pemakaian Chemical Laundry Tahun 2026

No	Nama Chemical	Jumlah Penggunaan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Clax built lite	1	1	2	2	1	1						
2	CLAX 100	1	1	2	2	1	1						
3	CLAX sonril	1	1	1	2	1	1						
4	CLAX neutral	1	1	1	2	1	1						
5	CLAX soft	1	1	1	1	1	1						
6	Snapy	15 L	0	5	15 L	20 L	15 L						
7	Rapika	14 pcs	28 pcs	20 pcs	15 pcs	0 L	0 L						
8	Bayklin	15 L	17 L	16 L	18 L	14 L	13 L						
9	Softener	0	0			10 L	10 L						
10	Liquid matic	30 L	30 L	33 L	20 L	11,2 L	10 L						

Analisa:
Penggunaan chemical laundry selama April–Juni 2026 menunjukkan tren yang relatif menurun dan stabil sesuai kebutuhan operasional. Penggunaan Clax Built Lite, Clax 100, Clax Sonril, dan Clax Neutral menurun dari 2 kali pada April menjadi 1 kali pada Mei dan Juni, sedangkan Clax Soft tetap stabil.
Penggunaan Snapy, Bayklin, dan Liquid Matic juga mengalami penurunan, sementara Rapika tidak digunakan pada Mei dan Juni. Sebaliknya, Softener mulai digunakan sejak Mei dan tetap stabil pada Juni.
Secara umum, penurunan penggunaan chemical menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan dan efisiensi pemakaian bahan, dengan tetap mempertahankan kualitas proses pencucian linen.

- Rencana tindak Lanjut:
1. Melakukan monitoring dan pencatatan penggunaan chemical secara rutin untuk memastikan pemakaian sesuai standar kebutuhan pencucian linen.
 2. Melakukan evaluasi penggunaan masing-masing chemical berdasarkan jumlah linen yang dicuci agar efisiensi penggunaan bahan dapat terus ditingkatkan.
 3. Memastikan ketersediaan stok chemical utama seperti Clax Built Lite, Clax 100, Clax Sonril, Clax Neutral, Bayklin, dan Liquid Matic agar proses laundry tetap berjalan tanpa hambatan.
 4. Melakukan pengawasan terhadap ketepatan dosis penggunaan chemical sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk menjaga kualitas hasil pencucian dan memperpanjang umur linen.
 5. Melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap penyimpanan chemical agar tetap aman, tertata, dan sesuai dengan standar keselamatan kerja.
 6. Memberikan edukasi kepada petugas laundry mengenai penggunaan chemical yang efektif, aman, dan sesuai prosedur untuk mendukung mutu pelayanan laundry.
 7. Melakukan evaluasi berkala terhadap tren pemakaian chemical sebagai dasar perencanaan kebutuhan dan pengadaan bahan pada periode berikutnya.

4.4 Kinerja Bidang Umum

1.4.1 SDM

Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	Profesi Ners	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Casemix Manager	SMK	1	1	1	0	0
7	Farmasi	Profesi Apoteker	39	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		0	0	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
8	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
9	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
10	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
11	Gizi	S1 Ilmu Gizi	15	1	1	0	1
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
12	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
13	ICU dan HCU	Profesi Ners	10	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		4	2	2	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
14	IGD	Profesi Ners	23	10	8	2	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
15	IKO	Profesi Ners	11	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
16	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
17	IPSRS	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0

18	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
19	IRNA 2C	Profesi Ners	7	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
20	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	17	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		9	6	3	0
21	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	12	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
22	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	1	2	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
23	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	22	9	4	5	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
24	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
25	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
26	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	8	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
27	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	6	2	0
28	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
29	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
30	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	12	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		0	0	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	5	1	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
31	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
32	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
33	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
34	SDM	S1 Sosial	1	1	1	0	0
35	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
36	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0

37	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
38	Cleaning Service	SMK	39	12	7	5	0
		SMA		22	18	4	0
		SMP		5	5	0	0
39	Security	SMK	11	5	2	3	1
		SMA		6	6	0	0
40	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
41	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
42	Staf Orientasi	SMK	6	2	0	2	0
		D3 TVF		1	0	1	0
		D3 Perawat Gigi		1	0	1	0
		D3 Gizi		1	0	1	0
		D4 Dizi		1	0	1	0
Total Karyawan			363	363	269	94	2
43	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0
44	Dokter Casemix	Dokter Umum	2	2	0	2	0
45	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	1
46	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
48	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
49	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
50	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
54	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
56	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
57	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
58	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
61	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
63	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
67	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
68	Dokter Spesialis Konservasi Gjai	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0

Total Dokter	65	65	2	63	1
Total Keseluruhan	428	428	271	157	3

Keterangan :
 Pada bulan Juni terdapat 2 staf dan 1 dokter resign

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Nurdyna Zahro Latifa,Amd.Gz	Ahli Gizi	30/06/2026	SIP Baru

Keterangan :
 Pada bulan April 2026 terdapat 5 SIP baru yang terbit.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Security	2	1	1	Baru mendapat 1 kandidat yang sesuai.	Rekrutmen pengganti satpam resign sudah dilakukan dan kandidat akan masuk awal Juli.

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	01 April 2026 – 30 Juni 2026	Khusus	Mohammad Rizki Hidayat	SMK	CS	01 April 2026	Penempatan CS
2	01 Mei 2026 – 31 Juli 2026	Khusus	Putri Sofiana Sari, Amd. Farm	D3	TVF	01 Mei 2026	Penempatan Farmasi
3	01 Juni 2026 – 31 Agustus 2026	Khusus	Mila Zeni Wulandari, Amd. Kes	D3	Perawat Gigi	01 Juni 2026	Penempatan IRJA
4	01 Juni 2026 – 31 Agustus 2026	Khusus	Najiyyatul Fithriyyah, S.Tr. Gz	D4	Ahli Gizi	01 Juni 2026	Penempatan Gizi
5	06 Juni 2026 – 05 September 2026	Khusus	Nurdyna Zahro Latifa, Amd. Gz	D3	Ahli Gizi	06 Juni 2026	Penempatan Gizi
6	01 Juni 2026 – 31 Agustus 2026	Khusus	Rizqi Anugrah Akbar	SMK	Security	01 Juni 2026	Penempatan Security

Keterangan : Pada bulan Juni 2026 ada 6 staf dengan orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT		HASIL EVALUASI DALAM KINERJA SEHARI-HARI	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK	PATUH	TIDAK PATUH

Keterangan:
Pada bulan Juni 2026 belum ada diklat yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Casemix Manager	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	39	0	5	26	7	1	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	2	8	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	0	4	1	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	16	0	10	6	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	0	2	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	10	0	6	4	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	23	0	14	8	1	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	11	0	10	1	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRS	Umum	6	0	4	2	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja

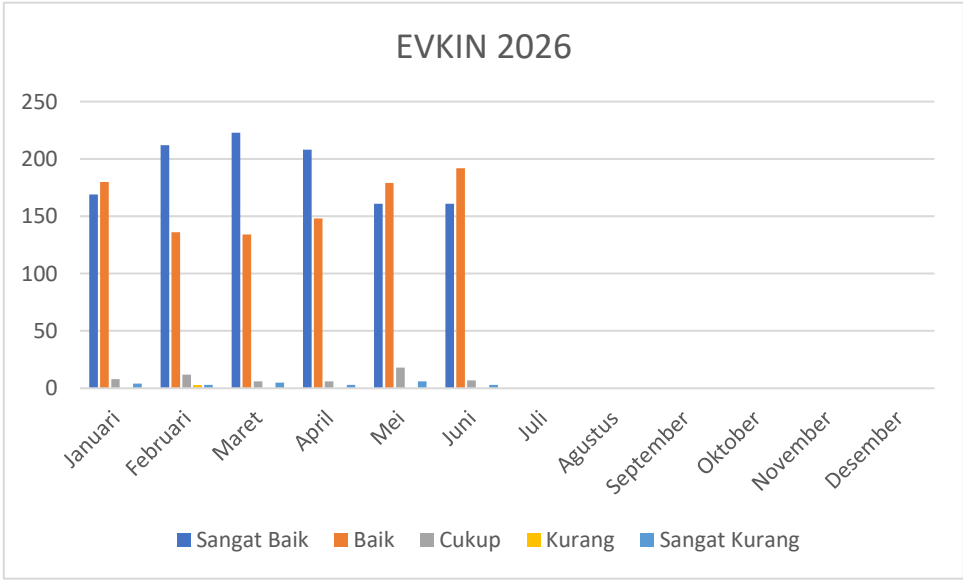
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									umum.
18	IRJA	Umum	27	0	15	10	2	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	7	0	3	4	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	17	0	5	11	0	1	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	12	0	7	5	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	9	0	0	7	1	1	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	22	0	10	10	1	1	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	10	0	4	6	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	8	0	6	2	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	8	0	1	7	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	8	0	1	7	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	1	4	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	7	0	4	3	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	14	0	1	13	0	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	4	0	0	2	2	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	0	1	2	0	Unit IT SIMRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	39	0	23	14	1	1	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	12	0	9	3	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	6	0	4	2	0	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
41	Staf Orientasi	Umum	3	0	0	3	0	0	Staf orientasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Juni 2026.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



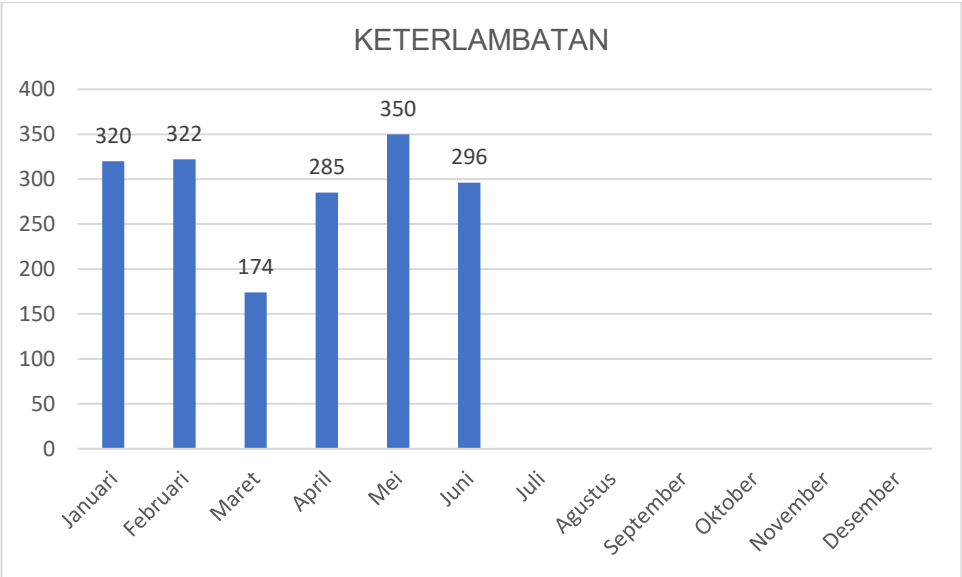
Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	169	212	223	208	161	161						
Baik	180	136	134	148	179	192						
Cukup	8	12	6	6	18	7						
Kurang	0	3	0	0	0	0						
Sangat Kurang	4	3	5	3	6	3						
TOTAL	361	366	368	365	364	363						

Analisa :
Secara umum terdapat kenaikan kategori sangat baik.

- Rencana Tindakanlanjut :**
1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.
 4. Membuat diklat dengan konsep baru sesuai arahan PT

Tabel Keterlambatan Karyawan

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	320	322	174	285	350	296						



Analisa :
Secara umum terdapat peningkatan jumlah keterlambatan pada bulan ini

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	1

4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	0
5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	0
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	0
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	1
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	1
12	ICU	0	0	0	0	0	0	0
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	0
16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	1
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	1
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	0
21	CSDD	0	0	0	0	0	0	0
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	0
23	Keuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	0
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	0
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	1
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	1
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	0
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	7

Analisis :
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.6.1 Supervisi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	0	0	0	0	0						

Analisa:
 Belum dilakukan

Rencana Tindak Lanjut :
 Lebih ditingkatkan supervisi ke tiap unit khususnya unit dengan tingkat temuan banyak.

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
-	-	-	-

Analisis : Pada bulan Juni 2026 tidak terdapat rotasi di unit SDM

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangn		58,97%	82,05%	64,10%	72%	92.3%	79,49%						

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	276	119	43,12%
Februari	276	138	50%
Maret	276	124	44,93%
April	276	112	41%
Mei	276	195	70.65%
Juni	276	134	48,55%
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	8
Februari	16
Maret	13
April	16
Mei	22
Juni	19
Juli	
Agustus	
September	
Oktober	
November	

Analisa :

Pada bulan ini capaian adalah 79,49% untuk ruangan turun dari bulan sebelumnya dan 48,55% untuk capaian per jumlah alat.

Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan PT untuk rekrutmen ATEM sesuai ABK (tidak ada pemenuhan rekrutmen)

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	CAPAIAN	TARGET	PROSENTASE
JAN-26	25	64	39.06%
FEB-26	40	64	62.50%
MAR-26	27	64	42.19%
APR-26	2	64	3.13%
MEI-26	45	64	70.03%
JUNI-26	59	64	92.18%

Analisa :

- 1. Dilakukan pemeliharaan AC secara rutin dan berkala sesuai target.terjadi peningkatan kinerjauntuk produktivitas pemeliharaan AC bulan ini.
- 2. Intensitas pekerjaan diluar lebih minim.
- 3. Penurunan pekerjaan perbaikan ac yg kompleks (berat) ganti outdoor ac,ganti kompresor ac,perbaikan instalasi,perbaikan modul ac.
- 4. Perbaikan prasarana untuk backup team tukang yang intensitas pekerjaannya tinggi.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	4x/bulan	3x/bulan	60%	Belum mencapai target
2	Februari	4x/bulan	4x/bulan	80%	Belum mencapai target
3	Maret	4x/bulan	3x/bulan	60%	Belum mencapai target
4	April	4x/bulan	4x/bulan	80%	Belum mencapai target
5	Mei	4x/bulan	3x/bulan	60%	Belum mencapai target
6	Juni	4x/bulan	3x/bulan	60%	Belum mencapai target
7	Juli	4x/bulan			
8	Agustus	4x/bulan			
9	September	4x/bulan			
10	Oktober	4x/bulan			
11	November	4x/bulan			

Analisis :

Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 3x dan sudah terdokumentasi dengan baik. Bulan Juni Intensitas kerja genset lebih banyak karena ada 4x pemadaman dengan durasi waktu kisaran 3 jam
Pengecekan dan penggantian part genset di renacana kan bulan juni 2026.
Konfirmasi ulang ke PT DPM untuk renovasi rumah genset.karena sirkulasi udara tidak baik saat genset operasional.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi berkala

Melalui link :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/110WG4QS8bLSVMEPsinZvqSZrNmPuELgYBKbsUd89Eo/edit?gid=2003963143#gid=2003963143>

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	3x/bulan	75%	Belum mencapai target
Mei	4x/bulan	1x/bulan	25%	Belum mencapai target
Juni	4x/bulan	2x/bulan	50%	Belum mencapai target
Juli	4x/bulan			
Agustus	4x/bulan			
September	4x/bulan			
Oktober	4x/bulan			
November	4x/bulan			
Desember	4x/bulan			

Analisis :

- 1. Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi.
- 2. Seringnya pemadaman pln di bulan Juni,jadi Monitoring panel berkurang karea fokus pada operasional dan monitoring genset.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

- 1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3AmeFpNj9z9LRM1HECH586kvHODUBC2dxtMaMTx1WQ/edit?gid=1843933243#gid=1843933243>
- 2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWCMAG6OMZK7k/edit?gid=1243237048#gid=1243237048>
- 3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg3l7_SLF6JsafyAZHxZKoPBLPgAbgEV92qYIFZj4M/edit?gid=183386497#gid=183386497
- 4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj662P7GKprEiZdfb8deF4N2QJmVQGokfuJtxTLk8DQ/edit?gid=462403140#gid=462403140>
- 5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pBsP-cAEM1iC5zDKXn4KuGJAyz1vEbGXE73obF9jQ80/edit?gid=0#gid=0>
- 6. Link Pemeliharaan Panel LVMDP
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH5lmQzu3mwTuMa1Qj72tGD5eDJHUXIzD63VM4qWdNQ/edit?gid=0#gid=0>

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

Juni 2026							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/06/2026	2515	2250	265	MMHG			MMHG
02/06/2026	2250	1966	284	MMHG			MMHG
03/06/2026	1966	1691	275	MMHG			MMHG
04/06/2026	1691	1070	621	MMHG			MMHG
05/06/2026	1070	3224	0	MMHG	sesudah pengisian	2154	MMHG
05/06/2026	3224	3115	109	MMHG			MMHG
06/06/2026	3115	2856	259	MMHG			MMHG
07/06/2026	2534	2308	0	MMHG			MMHG
08/06/2026	2308	2232	76	MMHG			MMHG
09/06/2026	2232	1893	339	MMHG			MMHG
10/06/2026	1893	1538	355	MMHG			MMHG
11/06/2026	1538	1178	360	MMHG			MMHG
11/06/2026	1178	3242		MMHG	sesudah pengisian	2064	MMHG
12/06/2026	3242	2959	283	MMHG			MMHG
13/06/2026	2959	2681	278	MMHG			MMHG
14/06/2026	2681	2417	264	MMHG			MMHG
15/06/2026	2417	2153	264	MMHG			MMHG
16/06/2026	2153	1895	258	MMHG			MMHG
17/06/2026	1895	1613	282	MMHG			MMHG
18/06/2026	1613	1316	297	MMHG			MMHG
19/06/2026	1316	917	399	MMHG			MMHG
19/06/2026	917	3314	0	MMHG	sesudah pengisian	2397	MMHG
20/06/2026	3314	3125	189	MMHG			MMHG
21/06/2026	3125	2799	326	MMHG			MMHG
22/06/2026	2799	2481	318	MMHG			MMHG
23/06/2026	2481	2379	102	MMHG			MMHG
24/06/2026	2379	1867	512	MMHG			MMHG
25/06/2026	1867	1364	503	MMHG			MMHG
26/06/2026	1364	3367	0	MMHG	sesudah pengisian	2003	MMHG
26/06/2026	3367	3269	98	MMHG			MMHG
27/06/2026	3269	2956	313	MMHG			MMHG
28/06/2026	2956	2681	275	MMHG			MMHG
29/06/2026	2681	2475	206	MMHG			MMHG
30/06/2026	2475	2194	281	MMHG			MMHG
Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			6946	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						6464	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			537.92	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						3232	MMHG

Analisis :

Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan			
Agustus	1x/bulan			
September	1x/bulan			
Oktober	1x/bulan			
November	1x/bulan			

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi melalui link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuzd_v1pO6Q2IDQr5clmEvCF-S-0EF2VI8LY_e93lQE/edit?gid=342425059#gid=342425059

1.5.2.2.7 Filter Air

3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan			
Agustus	1x/bulan			
September	1x/bulan			
Oktober	1x/bulan			
November	1x/bulan			

Analisis :

Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi melalui

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcAUU1Xi-rY4On3PymLDuNIIv0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 List Lokasi Lift

NO	LOKASI	KONDISI
1	Lift Gedung A Pasien	Baik
2	Lift Gedung A Pengunjung	Baik
3	Lift Gedung B	Baik
4	Lift Gedung C Umum	Baik
5	Lift Gedung C Karyawan	Baik
6	Lift Gedung D (Garansi)	Baik

1.5.2.2.8.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qMBqK_KT7GLwypkDMOm-X2vb5cPJtVV/edit?gid=730491017#gid=730491017

1.5.2.2.9 UPS

1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgB0k6Lufn7skng/edit?usp=sharing

1.5.2.2.10 Air Minum

NAMA	LOKASI	KONDISI
Instalasi Air Minum 1	Lantai 1 Gedung C	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target

April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.11 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

NAMA	LOKASI	KONDISI
Filter Air Bersih Poli Gigi 1	Lantai 2D	Baik
Filter Air Bersih Poli Gigi 2	Lantai 2D	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
Februari	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
Maret	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
April	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
Mei	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
Juni	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.12 Rekapn Kegiatan External

Bulan	Jumlah Kegiatan	Waktu yang Dibutuhkan
Januari	19	47 jam 27 menit
Februari	12	37 jam 7 menit
Maret	15	33 jam 47 menit
April	12	24 jam 9 menit
Mei	6	14 jam 14 menit
Juni	14	38 Jam 9 Menit
Juli		
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		

JUNI 2026									
DATE	TIME	URAIAN PEKERJAAN	UNIT AREA	PETUGAS	SELESAI	HASIL	JAM	MENIT	
07/06/2026	08:30	penggantian oli genset	Gudang upi	M Arifin	12:30	selesai	4		
08/06/2026	14:30	pengecekan genset rumah dokter lovi		Dian T, Yonatan d	18:30	selesai	4		
08/06/2026	09:00	test running genset dan isi tandon air bersih	Gudang upi	M Arifin	11:00	selesai	2		
09/06/2026	09:00	test running gensetdan kuras air sumur	Gudang upi	M Arifin	11:00	selesai	2		
09/06/2026	15:00	perbaikan dan penggantian part pagar otomatis rumah dr lovi		Dian T, Yonatan d	17:00	selesai	2		
11/06/2026	07:30	Perbaikan panel pompa	klirik bedali	M Arifin	11:07	selesai	3	30	
	11:30	warmingup genset dn kuras sumur	Gudang upi	M Arifin	13:00	selesai	1	30	
12/06/2026	10:30	pengecekan genset di gudang upi dan kuras air dengan pak yadi	Gudang upi	M Arifin	13:00	selesai	2	30	
13/06/2026	11:00	pengecekan aki genset	Gudang upi	M Arifin	12:30	selesai	1	30	
15/06/2026	15:00	cleaning ac	klirik bedali	Dian T, Tulus j	19:00	selesai	4		
16/06/2026	14:30	Perbaikan pagar otomatis rumah dr lovi		Dian T, Yonatan d	17:10	selesai	2	40	
22/06/2026	15:30	perbaikan dan maintenace ac 3 klinik	klirik ptp, klinik karlos, klinik bedali	Dian T, Tulus j	22:30	selesai	6		
24/06/2026	15:50	prbaikan dan maintenace ac	klirik bedali	Dian T, Yonatan d	19:15	selesai	2	25	
30/06/2026	14:15	kirim steam ke distributor untuk proses garansi		Dian T	16:00	selesai	2	15	
TOTAL JAM DINAS LUAR							37	110	
PEMBULATAN		TIGA PULUH DELAPAN JAM 9 MENIT					38	9	

Keterangan :
Total 14 jam 14 menit untuk perbantuan eksternal.

Rekapan link : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	1	1	0	0						

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



Analisa :
Tidak ada kehilangan barang bulan ini

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	6	1	4	0	4	3					

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



3.7.6 Tabel Angka Kejadian Berpotensi Kehilangan Barang

ANGKA KEJADIAN BERPOTENSI KEHILANGAN BARANG		
Tanggal	KETERANGAN	RTL
20 – 06 - 2026	Ditemukan kontak karyawan tertancap di kendaraan , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
21 – 06 – 2026	Ditemukan kontak karyawan tertancap di kendaraan , diamankan di pos igd	Sudah diambil pemilik
23 – 06 – 2026	Ditemukan jam tangan milik pasien di area ruang tunggu poli paru , diamankan di ruang security	Di ruang security

Analisis :

Alur berjalan baik. Pencatatan telah dilakukan dengan baik.

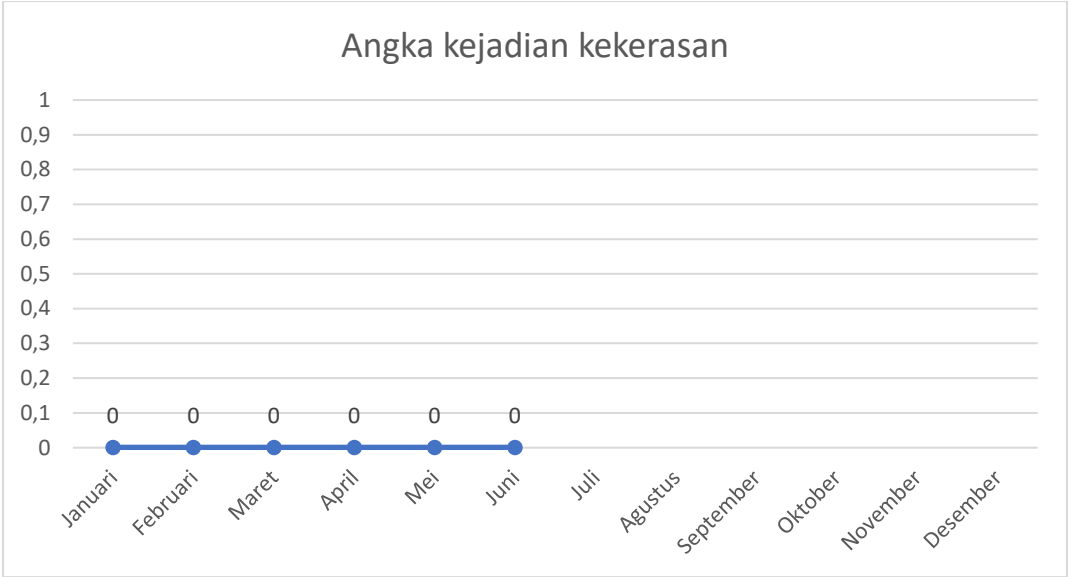
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring dan evaluasi

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0					

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

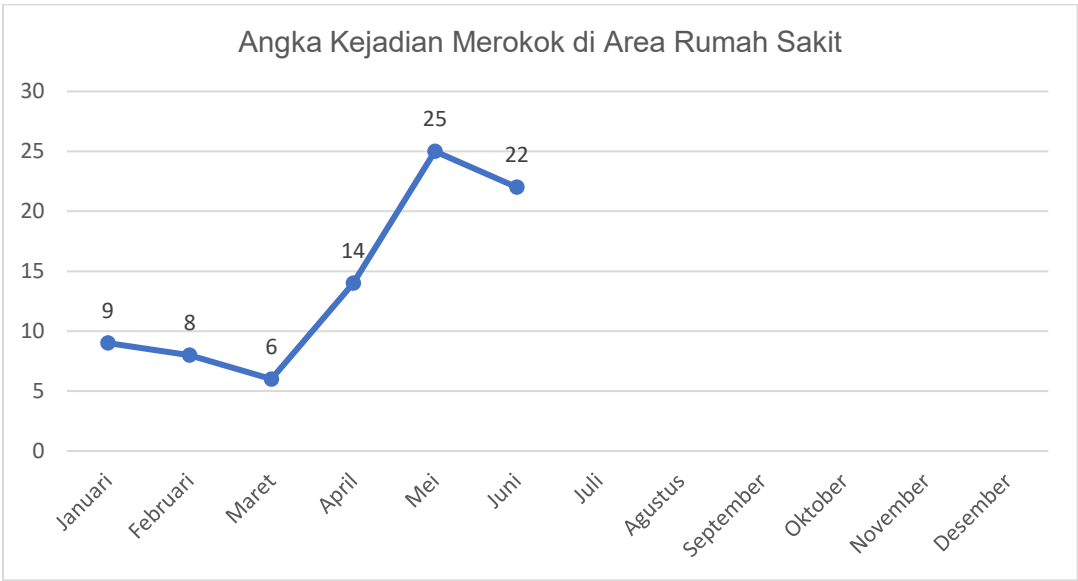


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusuhan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	9	8	6	14	25	22						



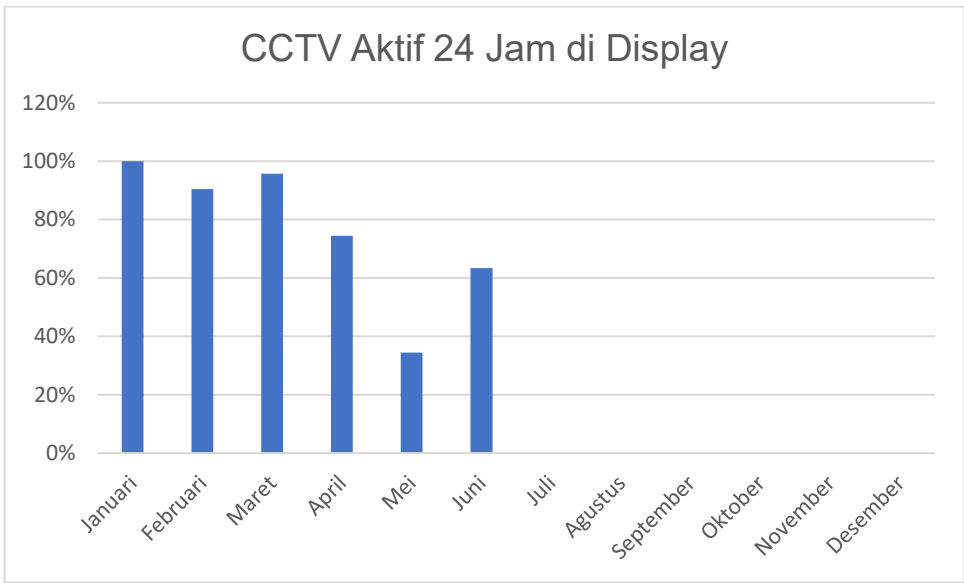
Analisis :
Angka 22 ini ditemukan karena peningkatan keaktifan patrol

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.3.6 CCTV Aktif 24 Jam di Display

Tabel Angka CCTV Aktif 24 Jam di Display

Jenis Aktivitas	Jan	Febr	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
CCTV Aktif 24 Jam di displaySakit	100%	90.48%	95,70%	74.44%	34,41%	63,33%						



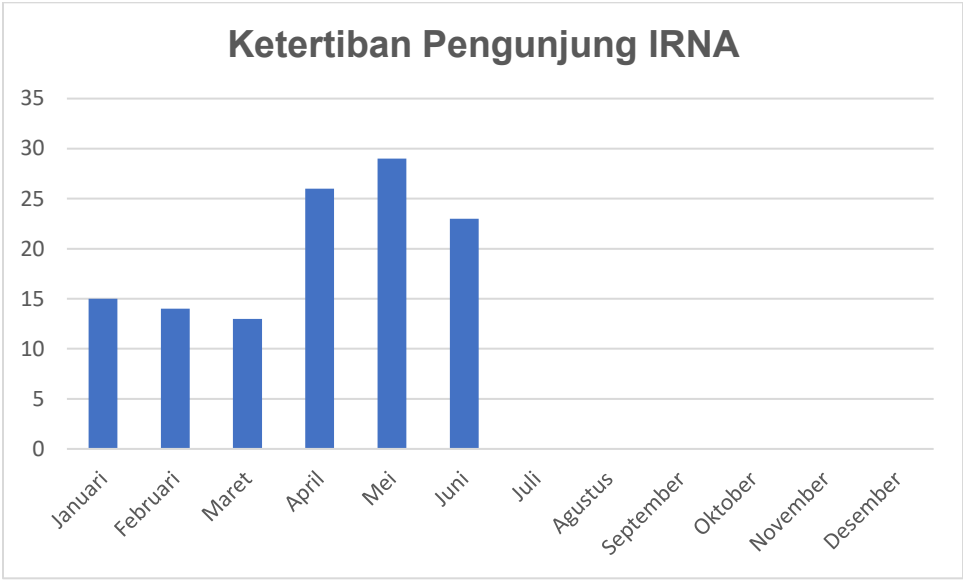
Analisa :
Pada bulan juni pengecekan cctv dalam 1 bulan masih belum tercapai 100% dikarenakan beberapa kendala teknis dan kelayakan sarana prasarana

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.3.7 Ketertiban Pengunjung IRNA

Tabel Ketertiban Pengunjung IRNA

Jenis Aktivitas	Jan	Febr	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Ketertiban Pengunjung IRNA	15	14	13	26	29	23						

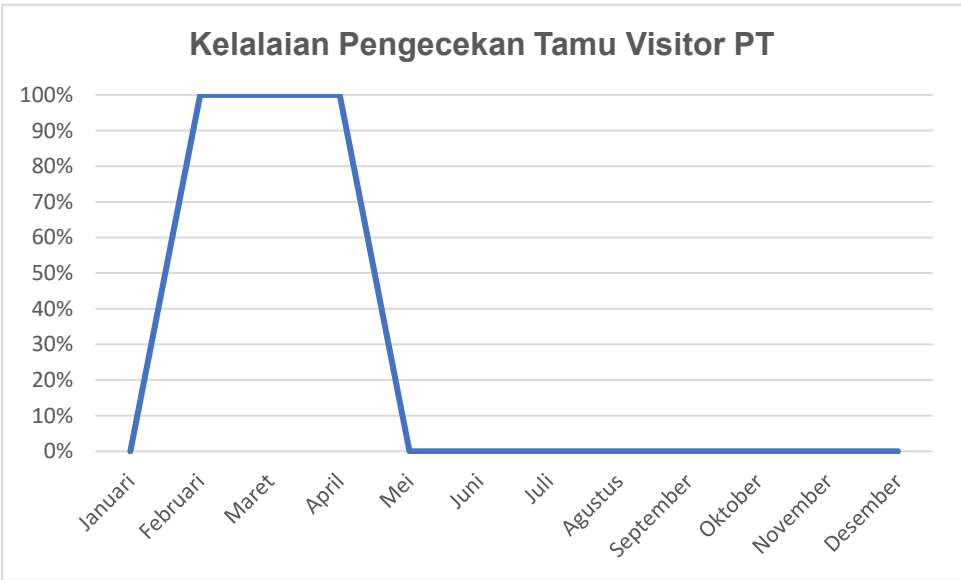


Analisa :
Sudah di TL oleh Tim security. Analisa tidak adanya one gate system untuk IRNA.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring evaluasi.

3.5.3.8 CCTV Kelalaian Pengecekan Tamu Visitor PT

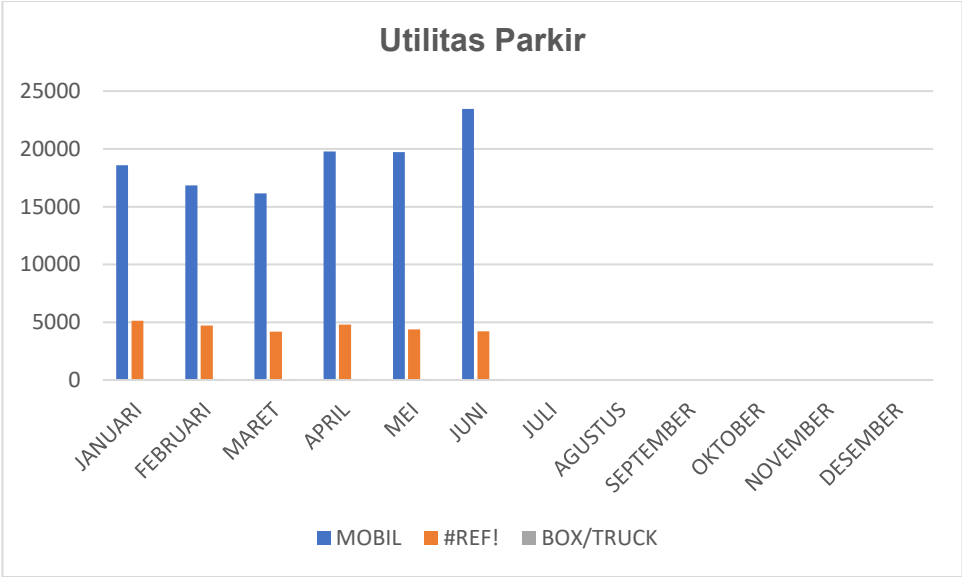
Jenis Aktivitas	Jan	Febr	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Kelalaian pengecekan tamu visitor PT	0	1	0	0	0	0						



Analisa : Minim kesalahan dalam petugas security di IGD.

Rencana Tindak Lanjut : Monitoring evaluasi.

3.5.4 Parkir



Analisis :
Progres parkir fluktuatif sesuai dengan kunjungan pasien dan jumlah hari libur

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

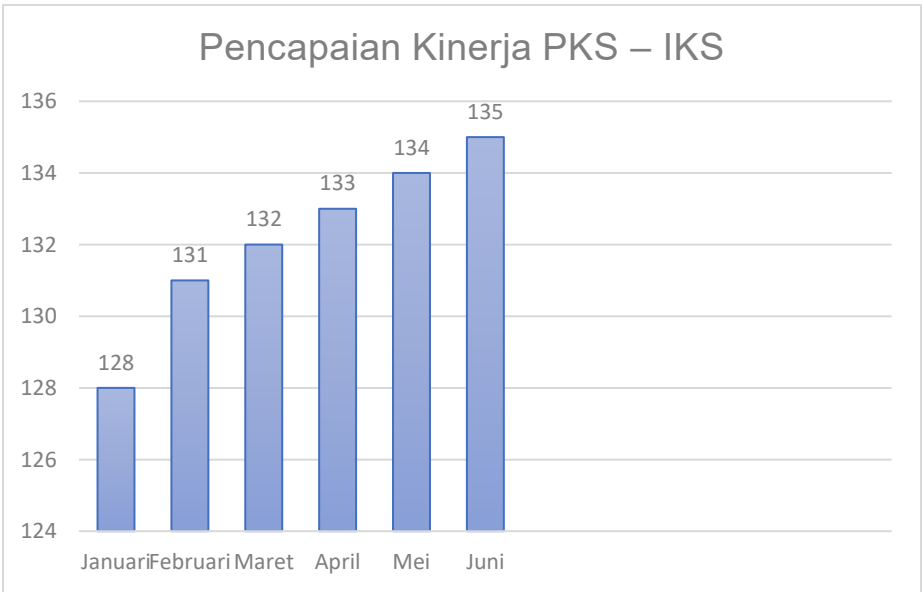
3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Februari 2026

No	Bulan	Target	Jumlah					Total Kurang
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	
1	Januari	1 IKS baru	128	1	1	0	1 (Proses review)	1
2	Februari	1 IKS baru	131	2	1	2	1 (Proses Perpanjangan 2)	2
3	Maret	1 IKS baru	132	1	1	2	2 (Proses perpanjangan)	2
4	April	1 IKS baru	133	2	1	0	2 (Proses Perpanjangan)	1
5	Mei	1 IKS baru	134	1	1	0	2 (Proses Perpanjangan, 1 Proses Review)	3
6	Juni	1 IKS baru	135	2	1	0	1 Proses Perpanjangan	2
Analisis ; 1. Pada bulan Juni 2026, Perpanjangan MOU dengan Taspen masih dalam Tahap Review Pihak ke-2, Perpanjangan MOU dengan Laboratorium Panglima sudirman selesai, MOU Baru dengan PKM Ardimulyo selesai. Rencana Tindak Lanjut : 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
2	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Review
3	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	TTD Pihak ke-2	Selesai
4	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
5	TPA Halodoc	Review	Proses Tanda Tangan
6	Klinik Waras Wiris	Review	Selesai
7	SLB tingkat Nasional Bagian C	Review	Selesai
8	PMI Kota Malang	Review	Selesai
9	PMI Kabupaten Malang	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
10	SK dan PKS Tim Penerjemah untuk Akreditasi	Review	Selesai
11	MOU Kementrian Agama Kabupaten Malang	Review	Selesai
12	MOU Klinik Muslimat Singosari	Review	Proses Pihak Kedua
13	MOU klinik BLK Singosari	Review	Proses Pihak Kedua
14	RSUD Lawang	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
15	Asuransi Astra Life	Review	Selesai
16	Panti Nirmala	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
17	Panglima Sudirman	Review	Proses Review
18	Klinik Muslimat Singosari	TTD Pihak ke-2	Selesai
19	Klinik Wijaya Husada	Review	Proses Review
20	PT CV Kurnia Edi Peni (KEP)	Selesai	Selesai
21	PT Indiratex Spindo	Review	Proses Review
22	Hotel Harris	Review Pihak ke-2	Review
23	Taspen	Review Pihak ke-2	Review
24	Laboratorium Pangsud	Selesai	Selesai
25	PKM Ardimulyo	Selesai	Selesai



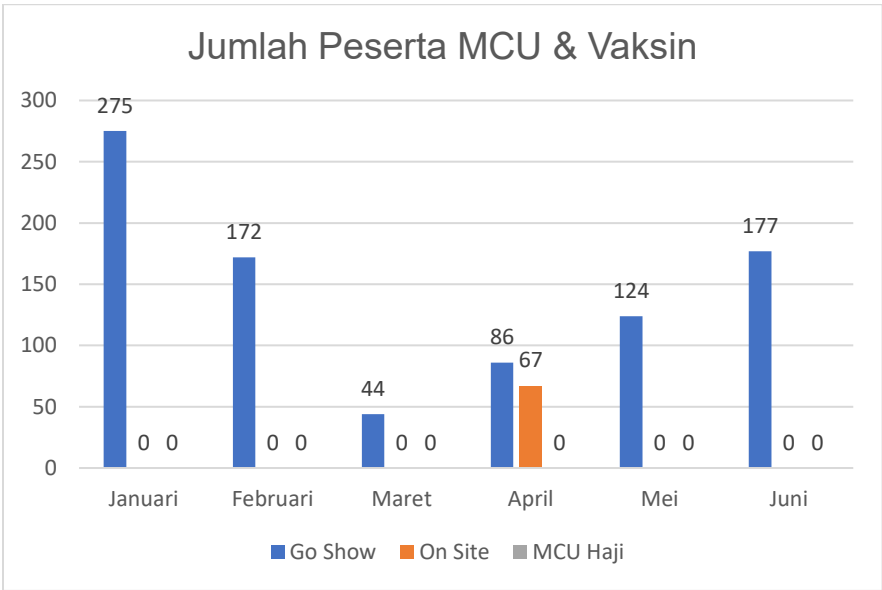
3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

1.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Tahun 2026

No	Bulan	Target	Jumlah Pasien GOSHOW	ON SITE
1	Januari	150	275	-
2	Februari	150	172	-
3	Maret	150	44	-
4	April	150	86	67
5	Mei	150	124	-
6	Juni	150	177	-

Analisis ;
Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Mei mengalami penurunan kunjungan sebesar 53 pasien atau sekitar 42.74% dari periode sebelumnya.

Rencana Tindak Lanjut :
1. Melakukan Promosi kesehatan kembali melalui Social Media
2. Kunjungan Perusahaan dan sekolah untuk menawarkan program MCU



1.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2026

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Sinergi Pangan	Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit
		Travel Kbih Al Muchsinin	Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 24 Jamaah di RSPHM
		Travel King Salman	Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 5 Jamaah di RSPHM
2	Februari	PT Pangan Lestari Malang	Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit
		PT Riset Perkebunan Nusantara	Sudah terlaksana MCU dengan 1 Orang di Rumah Sakit
3	Maret	PT Multi Daya Mitra	Tidak berhasil karena Harga Tinggi
		PT Bangun Sarana Wreksa	Belum terlaksana karena perubahan Pimpinan dan Penawaran masih diajukan kembali
4	April	PT Bangun Sarana Wreksa	Pimpinan belum ingin melaksanakan MCU
		PT Indonesian Tobacco Tbk	Sudah Terlaksana dengan 2 Peserta di Rumah Sakit

		PT Arthawena	Pelaksanaan MCU ikut dengan kegiatan Skrining Klinik Mutiara Sehat
		PT Green Mountains Natural Foods	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 67 Peserta di Perusahaan
		Penelitian FK UMM	Sudah Terlaksana dengan 11 Peserta di Rumah Sakit
5	Mei	Bank BSI	Belum terlaksana karena adanya prosedur penjaminan dengan asuransi MIH dan masih tahap koordinasi kembali
6	Juni	Travel Ibu Dewi Latifah	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 3 Peserta di Rumah Sakit
		Travel Malika	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 7 Peserta di Rumah Sakit
		Travel Al Bakkah Syifaul Qulub	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 13 Peserta di Rumah Sakit
		PT Puninar Jaya Logistics	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 5 Peserta di Rumah Sakit
		PT Indonesian Tobacco Tbk	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 1 Peserta di Rumah Sakit

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

Target	No	Tanggal	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
5 Kunjungan per bulan	1	12/01/2026	PT TENTREM	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	2	12/01/2026	PT KEMAS SUPER INDONESIA (KSI)	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

3	12/01/2026	PT ARTHAWENA SAKTI GEMILANG	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
4	12/01/2026	PT BANGUN SARANA WREKSA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	5	12/01/2026	CV AUMIRETA ANGGUN	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	6	12/01/2026	PT CIPTA SANDHI DARMA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	7	12/01/2026	PT INTAN PRAMADITA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu 3. PIC menanyakan untuk paket Pemeriksaan Narkoba dan sudah dijelaskan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	8	12/01/2026	PT INDOMARINE	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu 3. PIC menyampaikan penawaran akan menjadi bahan referensi	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	9	12/01/2026	PT LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	10	12/01/2026	PT MALINDO INTITAMA RAYA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	11	12/01/2026	PT UNGGUL ANUGRAH SEJAHTERA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. PIC akan menanyakan kepada pimpinan dan bila pimpinan mengadakan program MCU akan di arahkan ke RS	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	12	15/01/2026	PT OTSUKA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	13	15/01/2026	PT RAGAM RAYA RASA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	14	15/01/2026	PT KHARISMA SELARAS	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan

	15	15/01/2026	PT ADI PUTRO	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	16	15/01/2026	PT USTEGRA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan

	17	15/01/2026	PT INDOSTAR BUILDING MATERIAL	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	18	15/01/2026	PT SUMBER ALFARIA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	19	15/01/2026	PT WIM (KTG)	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	20	20/01/2026	PT SINAR TAMAN PLASTINDO	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	21	20/01/2026	PT PADMA INDAH PRIMA PERKASA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	22	31/01/2026	Kegiatan Senam Yoga Lansia	1. Program dengan komunitas Lansia geriatri berupa Yoga 2. Jumlah peserta 56 orang 3. Peserta aktif mengikuti seluruh kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik, peserta sangat antusias mengikuti kegiatan	Koordinasi dengan PKRS untuk agenda selanjutnya
	23	03/02/2026	PT Pangan Lestari	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up untuk Agreement Letter

24	06/02/2026	PT Multi Daya Mitra	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up ulang
25	09/02/2026	PT Bangun Sarana Wreksa	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up ulang akhir bulan
26	11/02/2026	Puskesmas Lawang	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Puskesmas menyampaikan koordinasi dengan tim pelayanan sudah baik dan bagus karena selalu direspon dengan cepat 2. Puskesmas menyampaikan bahwa adanya beberapa pasien yang sudah tidak aktif BPJSnya, walaupun	1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik 2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala

					pemberitahuan Program BPJS baru dinformasikan tetapi dari bulan januari sudah ada peserta BPJS yang dinonaktifkan dan harus melakukan konfirmasi ke pihak desa menerima informasi layanan terbaru. Kritik dan Saran : 1. Puskesmas menyampaikan untuk ltr pasien yang mendapatkan obat yang bisa didapatkan di Faskes apakah bisa jika di PRBkan saja 2. Puskesmas menyampaikan mohon dibantu untuk menginformasikan kepada pasien terkait SRB diberikan ke Puskesmas dan pasien tidak perlu membawa SRB ketika menuju ke RS	
	27	11/02/2026	Klinik Garuda	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Klinik menyampaikan koordinasi dengan tim RS sudah baik dan selalu direspon dengan cepat 2. Klinik menyampaikan bahwa adanya perubahan jadwal di klinik dari yang biasanya buka sampai dengan jam 20.00, berubah hanya sampai jam 15.00, sehingga beberapa peserta klinik ada yang berganti ke faskes lain. Kritik dan Saran : 1. Klinik menyampaikan bahwa ada satu pasien yang diminta untuk kembali ke	1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik 2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala

					klinik dengan memberikan surat pemeriksaan dari IGD dan meminta untuk dibuatkan rujukan, apakah bisa dibantu untuk pemeriksaan dari IGD diberikan surat keterangan bila memang hasil pemeriksaan di IGD menyatakan Perlu untuk dibuatkan rujukan maka pasien diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan agar klinik bisa mengkonfirmasi dengan data tersebut	
	28	11/02/2026	Puskesmas Singosari	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Klinik menyampaikan koordinasi dengan tim RS cukup baik dan selalu direspon dengan cepat Kritik dan Saran : 1. Puskesmas menyampaikan untuk PRB pasien dari RS PHM masih sedikit sedangkan rapot puskesmas di BPJS merah di RS PHM 2. Puskesmas menyampaikan ada satu pasien dengan 2 rujukan yang aktif dan 1 rujukan tersebut obatnya di PRB kan, tetapi dari RS memberikan Obat untuk 2 rujukan sehingga ketika Puskesmas memberikan klaim ke Kimia Farma, mereka meminta untuk obat tersebut dikembalikan karena pihak kimia farma tidak bisa mengklaim obat PRB yang diberikan oleh RS	

					3. Pihak Puskesmas meminta tolong untuk ketika ada pasien yang membutuhkan dua rujukan apakah bisa jika diselangi untuk jadwal kontrolnya sehingga habisnya berbeda 4. Puskesmas menyampaikan untuk diagnosa dokter dicky masih dibuat berbeda dengan kondisi asli pasien, seperti cholelithiasis dibuat ulcerative 5. Pihak Puskesmas meminta saran untuk Print Out resume pulang pasien karena data tersebut digunakan jika ada audit dari BPJS 6. Adapun penolakan dari IGD untuk rujukan jantung dari Puskesmas Singosari di bulan Desember rujukan jantung dengan hasil EKG SVT, dari RS Prima husada menginformasikan bahwa tindakan PCI belum ada dan pasien hanya bisa ditindak rawat inap saja sedangkan ketika puskesmas konfirmasi ke marsudi rujukan langsung diterima dengan tindakan kejut jantung sesuai dengan SOAP yg diberikan oleh tim puskesmas	
	29	16/02/2026	PMI Kabupaten Malang	Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PMI Kabupaten Malang	Sudah diterima oleh PIC PMI Kabupaten Malang	Follow up MOU
	30	16/02/2026	PMI Kota Malang	Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PMI Kota Malang	Sudah diterima oleh PIC PMI Kota Malang	Follow up MOU

	31	24/02/2026	SLB Tingkat Nasional Bagian C	Menyampaikan dokumen MOU dengan SLB Tingkat Nasional Bagian C untuk kebutuhan Penerjemah Bahasa Isyarat	Sudah diterima oleh PIC SLB Tingkat Nasional Bagian C	Follow up MOU
	32	24/02/2026	PMI Kota Malang	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	33	24/02/2026	Kementrian Agama Kabupaten Malang	Menyampaikan dokumen MOU dengan Kementrian Agama Kabupaten Malang untuk kebutuhan Bimbingan kerohanian	Sudah diterima oleh PIC Kementrian Agama Kabupaten Malang	Follow up MOU
	34	27/02/2026	Kementrian Agama Kabupaten Malang	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	35	27/02/2026	SLB Tingkat Nasional Bagian C	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	36	10/03/2026	Klinik Waras Wiris	Mengantarkan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Ibu Kholifa	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	37	10/03/2026	Fitness Plus Singosari	1. Mengantarkan MOU yang sudah selesai 2. Koordinasi terkait Cross selling yang akan terjadi antara Fitness Plus Singosari dengan RS PHM	1. Sudah diterima oleh Mba Nanda 2. Koordinasi dilakukan terkait kerjasam Flyer Membership Fitness Plus 3. Voucher MCU RSPHM 4. Penempatan desain Banner untuk diletakkan di Fitness Plus	Menginformasikan hal tersebut kepada Kepala Bidang dan Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	38	14/03/2026	Klinik Losari Medika	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran atas nama wahyu	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang

						baik
	39	14/03/2026	Bidan Indi (KRI Putra Husada)	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran atas nama diandra	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	40	14/03/2026	Klinik BLK	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Ria	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	41	14/03/2026	Klinik Mitra Prima Care	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Dokter tari	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	42	14/03/2026	Puskesmas Lawang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Reni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	43	16/03/2026	CV Aumireta Anggun	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Team Security	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	44	16/03/2026	PT Kemas Super Indonesia	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Suryono	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	45	16/03/2026	PT Malindo Intitama Raya	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Gunawan	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	46	16/03/2026	PT Molindo Raya Industri	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Yudi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	47	16/03/2026	PT Bangun Sarana Wreksa	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Bapak Nanda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	48	16/03/2026	PT Pesta Pora Abadi	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Reni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	49	16/03/2026	PT Kencana Tiara Gemilang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Andik	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	50	16/03/2026	PT Lawangmas Primapack Indonesia	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Bapak Dian	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	51	16/03/2026	Puskesmas Ardimulyo	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Mailing Ibu Vale	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	52	16/03/2026	Klinik Garuda	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Dinda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	53	16/03/2026	Klinik Brawijaya Lawang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC TU Pak Rizza	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	54	16/03/2026	DPM Lidya Putri	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh ibu resi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	55	16/03/2026	DPM Suhariningsih	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran Rosia	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	56	16/03/2026	DPM Farida Rusniah	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Bapak Setiani	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	57	16/03/2026	KRI Muslimat Singosari	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu devi putri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	58	16/03/2026	Klinik Wijaya Husada	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Yeni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	59	16/03/2026	DPM Wulandarti Wien	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Anak atas nama Ibu Nastiti	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	60	17/03/2026	PT Jasa Raharja	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC bapak Hari	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	61	17/03/2026	Klinik Kartini Medika	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Rendy	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	62	17/03/2026	Klinik Nayaka 02	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Dokter Virda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	63	17/03/2026	DPM Arry Budiarti	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Suami	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	64	18/03/2026	DPM Ida Bagus D.	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh dr Ida Bagus	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	65	18/03/2026	PKM Singosari	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Dokter syamsu	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	66	18/03/2026	DPM Yosephine Pratiwi	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran Novi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	67	18/03/2026	PT Kharisma Selaras	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Ibu Lina	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	68	18/03/2026	PT Indostar Building Material	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Ibu Riri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	69	18/03/2026	Relawan Siaga Utara (RESITA)	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Istri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	70	07/04/2026	Nestle Bear Brand	Mengantarkan kiriman Susu Kloter pertama untuk RS Prima Husada Malang Tahun 2026	Sudah diterima dan sudah diinformasikan untuk bukti penerimaan kepada pihak Bear Brand	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	71	15/04/2026	Fitness Plus Singosari	1. Mengantarkan Banner dan Voucher diskon untuk membership dan Karyawan dari Fitness Plus	1. Sudah disampaikan terkait dengan mekanisme penggunaan voucher dan diterima dengan baik oleh pihak Fitness Plus Singosari	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

				2. Koordinasi terkait dengan promo membership Fitness Plus kepada Staff RS Prima Husada Malang	2. Permintaan Promo untuk karyawan RS Prima Husada Malang sudah di proses, jika ada peserta yang akan daftar membership maka akan dibantu daftar dari Humas	
	72	22/04/2026	Klinik Muslimat Singosari	Mengirimkan Perpanjangan MOU dengan Klinik	Sudah diterima oleh ibu Devi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	73	27/04/2026	Relawan Ambulance (Resita)	Menyerahkan MOU dan Susu Bear Brand serta monitoring apakah ada kesulitan ketika mengantarkan pasien ke RS Prima Husada	1. Susu Bear Brand sudah diterima, MOU sudah diterima langsung dengan Pak Jali 2. Evaluasi sudah baik, tidak ada kesulitan dan pasien yang diantarkan juga diterima dengan baik	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	74	27/04/2026	Indonesian Tobacco Tbk.	Menyerahkan Hasil MCU dan Tagihan MCU kepada Perusahaan	Sudah diterima oleh bapak Bryllian	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	75	27/04/2026	Shanaya Resort	Menyerahkan Hasil MCU dan Tagihan MCU kepada Shanaya Resort	Sudah diterima oleh mba Stefani	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	76	27/04/2026	PT Green Mountains Natural Foods	1. Menyerahkan Tabung Sampling untuk pemeriksaan FL dan penyampaian terkait alur dan tata cara sampling 2. Cek Lokasi untuk bis MCU	1. Sudah diterima oleh Ibu Harnanik. 2. Sudah dilakukan pengecekan terakit dengan Lokasi Bis MCU dan semua aman	Bina komunikasi untuk Koordinasi pelaksanaan MCU
	77	28/04/2026	CV Karunia Edi Peni	Menyerahkan MOU serta monitoring apakah ada kesulitan ketika Koordinasi dengan RS Prima Husada	1. MOU sudah diterima oleh tim Humas RS 2. Evaluasi sudah baik, tidak ada kesulitan dan pasien yang diantarkan juga diterima dengan baik	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	78	07/05/2026	Mandiri InHealth	1. Koordinasi layanan MCU untuk penjaminan karyawan BSI Malang 2. Koordinasi terkait pergantian E-PKS Mandiri	1. Sudah disampaikan bahwa kebutuhan RS adalah pembuatan portal MCU untuk karyawan BSI 2. Pihak Mandiri InHealth menjelaskan bahwa permintaan MCU terlalu	1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

				InHealth dan New Branding Mandiri InHealth menjadi InHealth	mendadak dan akses untuk portal MCU harus dengan approval terlebih dahulu menggunakan BA MCU dan BA itu tidak melekat dengan MOU, 3. permintaan reimburse sendiri harus berasal dari Perusahaan atau Bank BSI kemudian akan disampaikan ke HO, karena peraturan untuk industri besar harus terorganisir dengan cabang" yg lain, jika portal dibuka dan karyawan datang hanya sedikit dan tidak ada kepastian jumlah karyawan setiap tahunnya, maka pihak Mandiri juga tidak mau membuka portal GCU/MCU 4. E-PKS sudah harus diisi dengan template sesuai portal PROVEN	2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala
	79	12 Mei 2026	Pocari Sweat	Penyampaian dan pemberian Pocari Sweat untuk kegiatan Futsal Karyawan RS Prima Husada Malang oleh pihak Pocari Sweat.	Telah diterima oleh Pihak RS Prima Husada Malang yaitu 1 box Pocari Sweat untuk kegiatan Futsal Karyawan RS Prima Husada Malang	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	80	21 Mei 2026	PT Djojonegoro C-1000	Penyampaian dan pemberian You- C1000 untuk Karyawan RS Prima Husada Malang oleh pihak Pocari Sweat.	Telah diterima oleh Pihak RS Prima Husada Malang yaitu 270 pcs You-C1000 untuk Karyawan RS Prima Husada Malang	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	81	25 Mei 2026	PT Lucky Mom Indonesia (Makuku)	Penyampaian produk Makuku, dan keinginan untuk masuk kedalam program PKRS yaitu Senam Hamil	Sudah disampaikan bahwa untuk proses masuk ke RS bisa dengan bersurat terlebih dahulu agar dapat didisposisikan kepada pimpinan	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	82	29 Mei 2026	Jasa Raharja Malang	Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PT Jasa Raharja Malang	Sudah diterima oleh PIC PT Jasa Raharja Malang	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	83	3 Juni 2026	PT Jasa Raharja	Mengirimkan Revisi MOU kepada pihak PT Jasa Raharja	Sudah diterima oleh CS	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	84	12 Juni 2026	Mandiri InHealth	Mengirimkan MOU terbaru Tahun 2026 PROVEN	Sudah diterima oleh team Customer Service	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	85	22 Juni 2026	Klinik Kendedes	1. Konfirmasi dari klinik bahwa rujukan menuju RS tidak muncul pada aplikasi P-CARE	1. Menyampaikan permohonan maaf karena kendala yang terjadi 2. Memberikan informasi kepada PIC BPJS untuk segera tindak lanjut, dan sudah teratasi di hari yang sama	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	86	22 Juni 2026	Puskesmas Pakis	RS melakukan Konfirmasi kepada Puskesmas apakah ada kendala rujukan menuju RS tidak muncul pada aplikasi P-CARE	1. Menyampaikan permohonan maaf karena kendala yang terjadi 2. Memberikan informasi kepada PIC BPJS untuk segera tindak lanjut, dan sudah teratasi di hari yang sama	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	87	22 Juni 2026	Puskesmas Polowijen	RS melakukan Konfirmasi kepada Puskesmas apakah ada kendala rujukan menuju RS tidak muncul pada aplikasi P-CARE	1. Menyampaikan permohonan maaf karena kendala yang terjadi 2. Memberikan informasi kepada PIC BPJS untuk segera tindak lanjut, dan sudah teratasi di hari yang sama	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	88	25 Juni 2026	Pitstop Akreditasi All PJ 2026	Memberikan diklat KE kepada seluruh staff RS Prima Husada	Sudah terlaksana, pendataan nilai dan hasil pitstop sudah diberikan	-
	89	30 Juni 2026	PKM Ardimulyo	1. Bina Rujukan stunting dengan PIC 2. Koordinasi dengan PIC terkait kendala rujukan 3. Koordinasi tanda tangan proses MOU terkait stunting wasting	1. Selama ini belum ada kendala ketika merujuk ke RS 2. Tambahan dari pihak PIC bahwa pihak RS bisa memberikan informasi untuk ibu Hamil yang wilayah rumah berada di daerah Puskesmas Ardimulyo bisa menghubungi Kader bidan setempat agar mendapatkan vitamin A 3. MOU sudah ditandatangani oleh Kepala Puskesmas	Menyampaikan informasi kepada PIC Maternitas, Karu dan Kabid, Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

Tabel Hasil Kinerja Event Eksternal Humas Marketing RSPHM Pada Tahun 2026

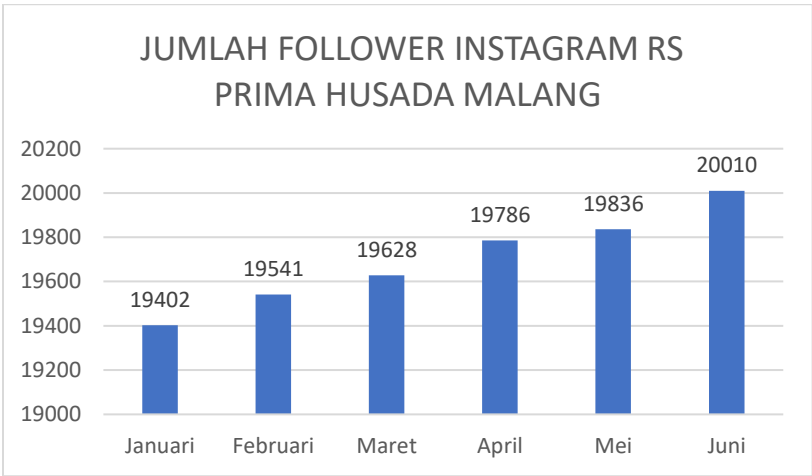
Target	No	Tanggal	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
MCU dan Vaksin	1	09/01/2026	PT Sinergi Pangan Gemilang	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Sinergi Pangan Gemilang	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang	Hasil Pemeriksaan telah diberikan
MCU dan Vaksin	2	14/01/2026	KBIH Al Muchsinin	Program Vaksin 24 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan vaksin untuk 24 orang di tanggal 14 Januari 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	3	26/01/2026	KBIH Alfattah Singosari	Program Vaksin 9 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan Vaksin untuk 6 Orang di tanggal 14 Januari 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	4	26/01/2026	Travel King Salman	Program Vaksin 5 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan untuk vaksin sesuai ketentuan penawaran dengan 6 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	5	04/02/2026	PT Riset Perkebunan Nusantara	Program MCU Karyawan Baru di RS dengan PT Riset Perkebunan Nusantara	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 1 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	6	19/02/2026	PT Pangan Lestari Malang	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Pangan Lestari Malang	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	7	29/04/2026	PT Green Mountains Natural Foods	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Green Mountains Natural Foods	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 67 Orang	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	8	04/05/2025	Shanaya Resort	Program MCU Karyawan baru di RS dengan Shanaya Resort	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 2 Orang	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	9	06/06/2026	Travel Ibu Dewi Latifah	Program Vaksin 3 jamaah Travel	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 3 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	10	18/06/2026	Travel Malika	Program Vaksin 7 jamaah Travel	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 7 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	11	20 Juni 2026	PT Puninar Jaya Logistics	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Puninar Jaya Logistics	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 5 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai
MCU dan	12	23 Juni	PT Indonesian	Program MCU Karyawan baru di RS	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 1	Sudah Selesai

Vaksin		2026	Tobacco Tbk	dengan PT Indonesian Tobacco Tbk	Peserta di Rumah Sakit	
MCU dan Vaksin	13	26/06/2026	Travel Al Bakkah Syifaul Qulub	Program Vaksin 13 jamaah Travel	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 13 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai

1.5.5.2.4 Digital Marketing

1.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

JUMLAH KONTEN BARU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
FEED FOTO	12	5	16	13	12	5						
REELS	4	6	6	8	4	2						
STORY	13	31	28	22	57	40						
TOTAL	29	41	50	43	73	47						0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
FEED FOTO	13	5	16	14	12	5						
FEED VIDEO	4	6	6	8	4	2						
REELS	4	6	6	8	4	2						
STORY	89	85	53	82	58	40						
TOTAL	110	102	81	112	78	49						
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	19402	19541	19628	19786	19836	20010						
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	311	242300	177	285	240	229						
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300



Analisa :

Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 174 Followers atau sebesar 0.88% dari bulan sebelumnya

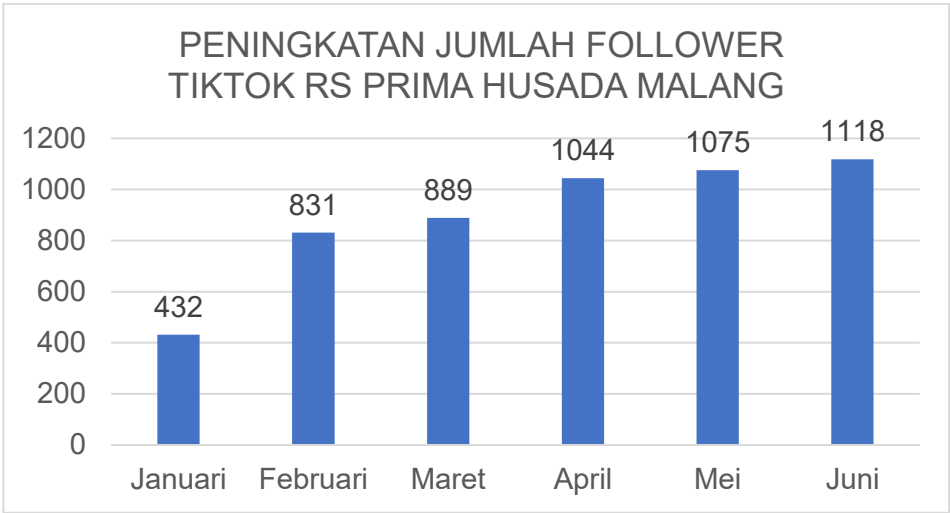
- Rencana Tindal Lanjut :
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya

2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers

3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH KONTEN BARU	2	9	5	5	3	1						
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	432	831	889	1044	1075	1118						
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	23	399	58	155	31	43						
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH LIKE	1876	3374	3753	4477	4676	4881						



Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 43 Followers atau sebesar 4% dari bulan sebelumnya

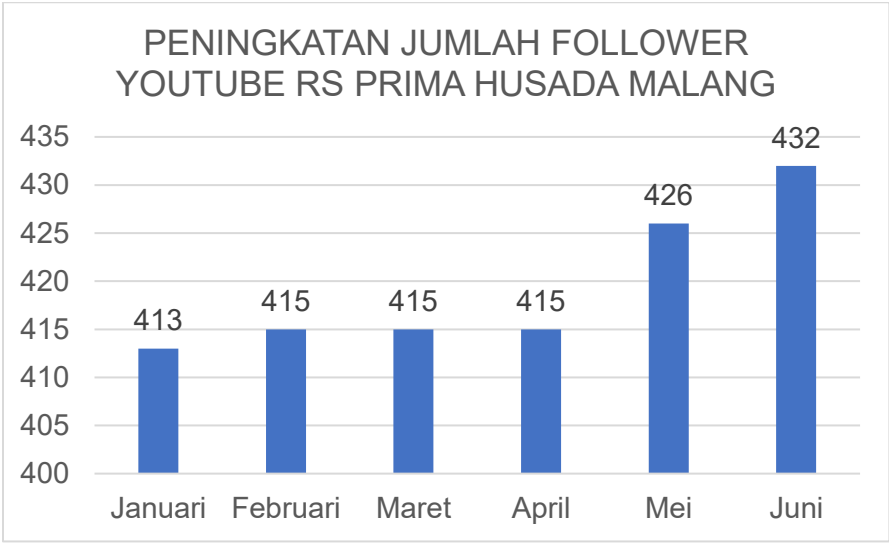
- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH KONTEN BARU	0	0	0	0	0	0						
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
-------	---------	----------	-------	-------	-----	------	------	---------	-----------	---------	----------	----------

JUMLAH SUBS	413	415	415	415	426	432						
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	5	2	0	0	11	6						0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

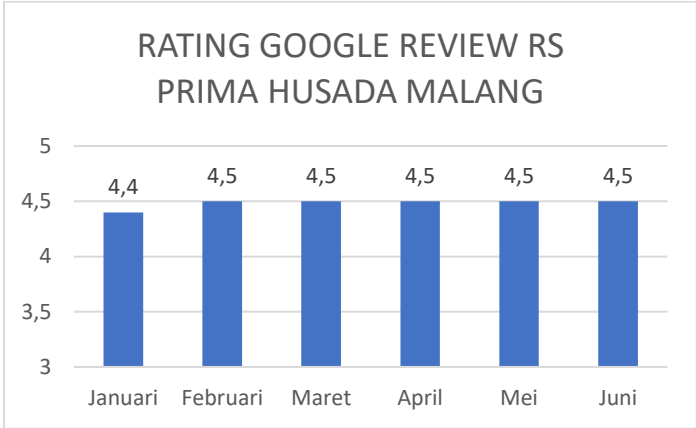


Analisa :
 Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 6 *Followers* atau sebesar 1,41% dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5						



BULAN	RATE CAPAIAN GOOGLE REVIEW	
	POSITIF	NEGATIF
Januari	122	4
Februari	133	3
Maret	114	5
April	149	9
Mei	111	5
Juni	138	2

- Analisa :
- 1. Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan sebelumnya
 - 2. Pengisian Google Review mengalami peningkatan 24 review atau sekitar 20,69% dibanding bulan sebelumnya.
 - 3. Pengisian Google Review dengan Rate Positif mengalami peningkatan 27 review atau sekitar 24,32% dibanding bulan sebelumnya.
 - 4. Pengisian Google Review dengan Rate Negatif mengalami penurunan 3 Review atau sekitar 60% dibanding bulan sebelumnya.

- Rencana Tindal Lanjut :
- 1. Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PERIKER JUNE 2026														
1	Arasat	841.703.146	118.082.379	3.533.001	388.846.348	316.303.000	17.223.301	1.007.033	228.302.282	848.848.002	190.198.909	0.001.001	2.814.913	90.423.423
2	Pemeriksaan	818.211.011	112.781.148	0	111.080.887	807.016.120	--	--	809.167.289	519.325.296	808.000.000	0.000.000	101.816	3.807.808
3	Mbadiri Isukali	888.888.888	112.000.000	1.500.000	21.200.000	91.100.000	--	--	91.100.000	58.000.000	58.000.000	--	--	--
4	Araa Rindaga	112.111.111	104.111.111	1	11.500.000	91.000.000	--	--	91.000.000	91.100.000	91.100.000	--	--	--
5	DRD Rindaga Rindaga	888.888.888	112.000.000	1.500.000	21.200.000	91.100.000	--	--	91.100.000	58.000.000	58.000.000	--	--	--
Total Rindaga									2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	0.000.000	0.000.000	0.000.000

Keterangan : Cut off 30 Juni 2026 sebesar Rp 1.765.066.204

3.5.6 PIPP – MOD – MPP

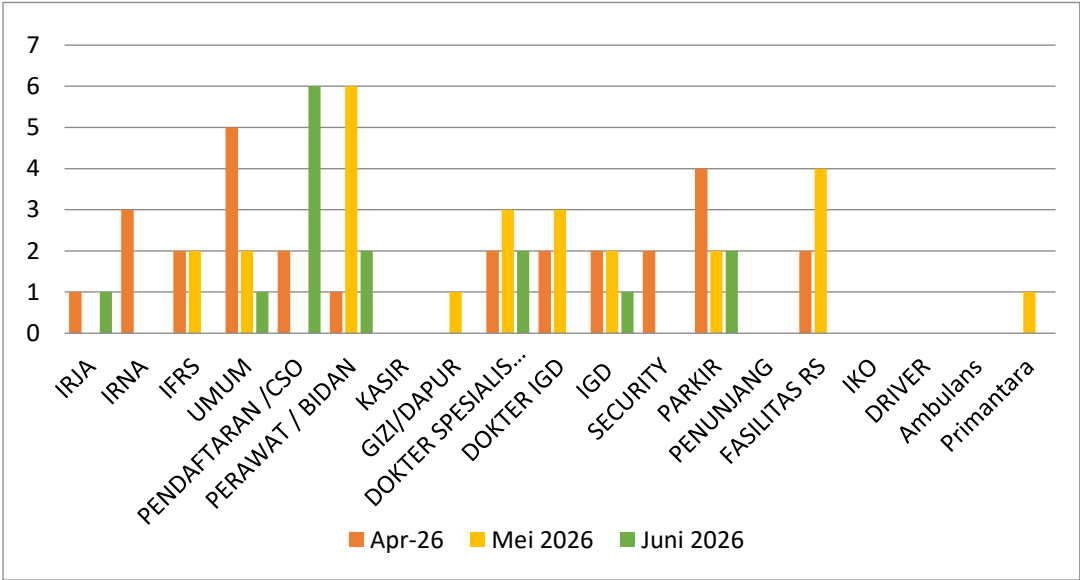
3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Februari 2026

NO	Jumlah Komplain Pasien Terhadap Unit	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
1.	IRJA	1	0	1
2.	IRNA	3	0	0
3.	IFRS	2	2	0
4.	UMUM	5	2	1
5.	PENDAFTARAN /CSO	2	0	6
6.	PERAWAT / BIDAN	1	6	2
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	0	1	0
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	2	3	2
10.	DOKTER IGD	2	3	0
11.	IGD	2	2	1
12.	SECURITY	2	0	0
13.	PARKIR	4	2	2
14.	PENUNJANG	0	0	0
15.	FASILITAS RS	2	4	0
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0

18	Ambulans	0	0	0
19	Primantara	0	1	0
Total		17	28	26

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Juni 2026



Analisis :

Jumlah pasien komplain selama Bulan Juni 2026 mengacu pada komplain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

- Jumlah complain Pada bulan Juni 2026 mengalami penurunan dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan April sebanyak 28 pasien. pada bulan Mei sebanyak 26 pasien. Sedangkan pada bulan Juni sebanyak 16 pasien.
- Komplain terbanyak pada bulan Juni 2026 yaitu dari bagian pendaftaran CSO sebayak 6 kasus, failitas sebanyak 4 kasus, Dokter IGD sebanyak 3 kasus, DPJP sebanyak 3 kasus, Parkir, UMUM dan IFRS sebanyak masing-masing 2 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
- Pada bulan Mei 2026 terdapat 6 complain yang tidak bisa langsung diselesaikan, diantaranya :
 - Parkir

Terdapat 2 kasus diantaranya terkait tarif parkir rawat inap yang terlalu mahal dan permintaan dilakukan pembayaran 1x untuk rawat inap
 - Fasilitas

Terdapat 4 kasus terkait fasilitas yaitu saran untuk perluasan kamar perawatan.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juni 2026

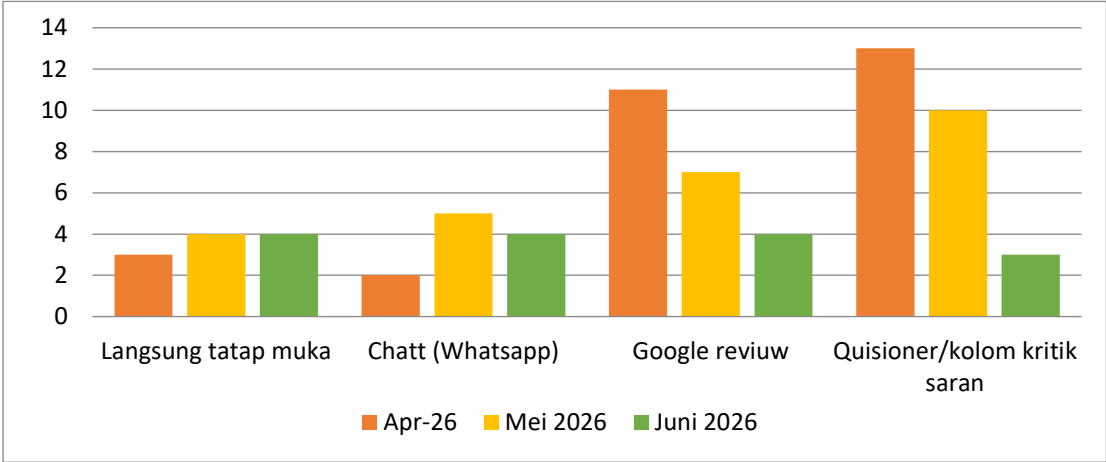
NO	JENIS PASIEN COMPLAIN	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
1.	Langsung tatap muka	3	4	4
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	2	5	4
	b. Google reviuw	11	7	4
3.	Quisioner/kolom kritik saran	13	10	3

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

	KESSAN BPJS	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5
		2	0	4	245	703

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juni 2026



Analisis :

Pada bulan Juni 2026 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari tatap muka, whatsahap dan Google rewiuw yaitu masing-masing sebanyak 4 kasus complain. Sedangkan dari Quisioner sebanyak 3 kasus complain.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Juni 2026

NO	Jenis pasien complain	Waktu tanggap		Waktu penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 ‘	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplai atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 ‘	pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google rewiuw	100%	100%	100%	100%	0	0
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	60%	40%	0
					7	6	

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Juni 2026 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 60%. hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Pada bulan April 2026 terdapat 6 complain yang tidak bisa langsung diselesaikan, diantaranya

- Parkir
Terdapat 2 kasus diantaranya terkait tarif parkir rawat inap yang terlalu mahal dan permintaan dilakukan pembayaran 1x untuk rawat inap
- Fasilitas
Terdapat 4 kasus terkait fasilitas yaitu saran untuk perluasan kamar perawatan.

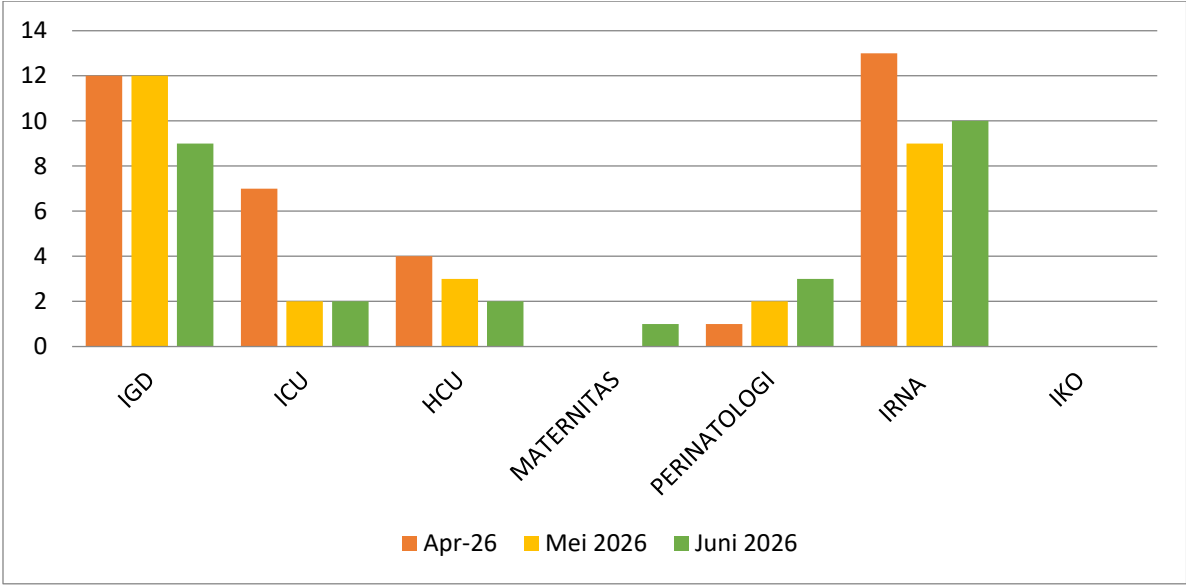
Rencana Tindak Lanjut :

Penyelesaian complain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Mei2026

No	Unit Perujuk	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
1.	IGD	12	12	9
2.	ICU	7	2	2
3.	HCU	4	3	2
4.	MATERNITAS	0	0	1
5.	NEONATOLOGI	1	2	3
6	IRNA	13	9	10
7	IKO	0	0	0
Total		37	28	27

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Juni 2026



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk Juni 2026

NO	NO RM	Nama Pasien	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	PLAVO N HABIS
1	250047	RUSTIN	IGD	CKR TRAUMA 456,	DR ENDRA	RS PRIMA HUSADA SUKOREJO	APS ALIH RAWAT	Tidak
2	117318	NGATMIANTO	8A	HIV, Toksoplasma Cerebri	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RSSA	PRO Perawatan HIV	Tidak
3	066460	ELOK DWI JAYANTI	7A	AKI st 3 Urate nephropathy	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RSUD LAWANG	Pro HD	Tidak
4	185413	EDI SUSANTO	IGD	ICH, IVH	DR DEWI MAHARANI SP. S	RST Soepraoen	PRO EVAKUASI HEMATOME	Tidak
5	250147	SYAIDAH NUR KHASANAH	MTS	G2 P1001AB000 UK 10 - 12 minggu dengan HEG + Hematemesis	DR HUMAIRAH, SP. OG	RSSA	pro perawatan bersama spesialis obgyn dan Sp.PD-KGEH	Tidak
6	250290	BY NY. EKA SAFITRI	NEO	Prematur BBLSR, RDS ok HMD DD neonatal pneumonia	DR FIONA PARAMITHA SP.A	RS Pantj Nirmala	pro penatalaksanaan sub spesialisik neonatologi + Pro surfaktan	Tidak
7	250328	NUR SYAMSIYAH	8A	CKD ST 4, DM HIPERGLIKEMIA	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	RSUD LAWANG	PRO HD	Tidak
8	084274	NINING SYAFA'AH	ICU	Stemi, Krisis hiperglikemia ,Adhf,AKI ,Shock cardiogenik	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	RS UMM	pro PCI back up HD	Tidak
9	250358	SUNARSI	IGD	CKD stage V, obs. dyspneu dt. Susp. ALO	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	RS Kemenkes Surabaya	PRO HD	Tidak
10	250240	WIWIT IFAN AFANDI	HCU	1) Severe Traumatic Brain Injury (COB E1V1M4) + SAH + Fraktur Linier Os Frontal 2) Fraktur ZMC Dextra + Susp. Blowout Fracture Dextra	DR ROSSY ZAKI, SP.B	RS SOEPRAON	PRO Penanganan lanjutan Multispesialistik Bedah Saraf, Bedah Plastik	Tidak

				3) Susp. Fraktur Basis Cranii Fossa Anterior Et Media Dextra 4) Susp. Cervical Spine Injury 5) AKI st 2 6) HT emergency				
11	250351	BY.NY ENDANG MUSTIKA	NEO	RDS dd neonatal pnemonia, susp.PJB	DR RATIH KUSUMAWARDHANI, SP. A	RST Soepraoen	pro tatalaksana subspesialistik neonatologi	Tidak
12	105482	DJUMI'AN	IGD	Dislokasi protesa caput femur dextra	DR KUNTADI, SP. OT	RSSA	PRO REKONSTRUKSI THR	Tidak
13	243075	soedarsih	3A	usp dural hemoragic,obs zeisure,af,ht	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RS SOEPRAON	PRO bur hole	Tidak
14	212205	YAYUK SRI RAHAYU	HCU	cva ich	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RST DR SOEPRAOEN	PRO evakuasi hematoma	Tidak
15	246088	Tn. Supono	2C	DoC ec SDH, Gross hematuria + bph post TURP, CHF (ef 16%)	DR PRADANA, SP.U	RSSA	Rujuk pro SpBS untuk tindakan burhole	Tidak
16	250584	SUPARLAN	7A	CVA INFARK	DR FAHIMMA, SP. N	RSSA	PRO STROKE UNIT	Tidak
17	250725	Ny.ASMANI	IGD	STEMI inferior , DM Hiperglikemia	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RSI Aisiyah Malang	Rujuk pro PCI	Tidak
18	250748	Ny.SAMUAH	IGD	hemiparese S susp CVA, HHD,"AKI dd ACKD	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RS KEMENKES SURABAYA	Rujuk pro HD	Tidak
19	128145	SAMSUL	IGD	RETENSI URINE SUSP RUPTURE URETRA	DR PRADANA, SP.U	RSSA	PRO TINDAKAN CITO	Tidak
20	251093	Tn. Agus Setiawan	6A	Trauma Fascialis OF Zygomatica + CKR 456 + Fr. Frontal	DR SIGIT, SP.BP	RSSA	PRO BEDAH SYARAF	Tidak
21	251464	sulistyowati	ICU	ALO cardiomiopat, ACute CKD	DR YOGA WARANUGRAHA SP JP	RSSA	PRO HD	Tidak
22	251432	By Ny Putri Febriantiningasih	NEO	Prematur, BBLSR, HMD	DR DICKY FATURRACHMAN,SP A,M,BIOMED	RSSA	PRO SURFAKTAN, VENTILATOR	Tidak
23	45331	SISWO MARGONO	IGD	CA BULI + GROSS HEMATURIA	DR PRADANA, SP.U	RSSA	Rujuk tindakan pro kp turb	Tidak
24	142761	Tn Sonny Hari Hidayat	4A	hipoglikemia coma refrakter dt insulinoma dd Dm tipe 1 dd other herpes facialis pvc "	DR ADHYA AJI PRATAMA, SP.PD	RSSA	pro penanganan kemd	Tidak
25	247224	SUWARNO	IGD	Retensi Urin dt Clot Intravesica	DR PRADANA, SP.U	RSSA	Rujuk tindakan clto	Tidak
26	78055	Ny. Suparti	2C	toxoplasmosis cerebri + h20	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	RS Soetomo Surabaya	PRO Penanganan HIV	Tidak
27	242975	Ny. Ngatia	4A	CKD St 5, ALO	DR ZORAIDA DWI WAHYUNI, SP. PD	RSUB	Pro HD	Tidak

Analisis :

- Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Juni 2026. Pada bulan April sebanyak 37 pasien. pada bulan Mei 2026 sebanyak 28 pasien. Sedangkan pada bulan Juni sebanyak 27 pasien
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro PCI

- b) Pro CVCU
 - c) Pro stroke unit
 - d) Pro HD
 - e) MRI
 - f) Pro bedah saraf lanjutan
 - g) Membutuhkan alat khusus
 - h) Membutuhkan pengobatan ARV
3. Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya.
- Pada bulan bulan April 2026 Tidak ada plavon habis yang dilakukan rujuk Sedangkan pada bulan Mei 2026 sebesar Rp. 923.139

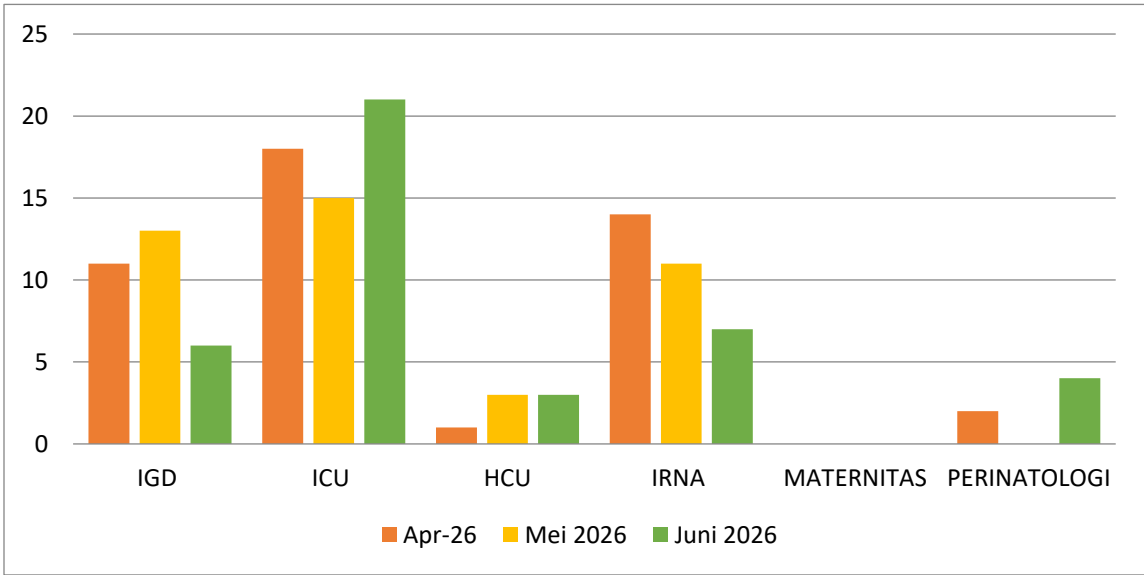
Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- 2. Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Mei 2026

No	Unit Asal Pasien Meninggal	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
1.	IGD	11	13	6
2.	ICU	18	15	21
3	HCU	1	3	3
4.	IRNA	14	11	7
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	2	0	4
Total		46	42	41

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Juni 2026



Tabel Rincian Pasien Meninggal Juni 2026

No	NO RM	Nama Pasien	Lama Rawat	Status	Unit	Penyebab Kematian	Diagnosis	DPJP	EWS
1	248151	DURASIT	2	UMUM	ICU	cardiac arrest	NSTEMI + Pneumonia	DR MIRYANTISP JP	√
2	233190	AHMAD HADI	4	BPJS KESEHATAN	2A	cardiac arrest	DM HIPERGLIKEMIA POST COMA	DR ADHYA AJI, SP.PD	√

3	249322	SULASTRI	2	BPJS KESEHATAN	ICU	cardiac arrest	CKD, ASIDOSIS METABOLIK, DM HIPOGLIKEMI, ASCITES	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
4	250040	MARKAMAH	5	BPJS KESEHATAN	8A	cardiac arrest	CVA INFARK, HF DT HHD, HEMIPARESE DEXTRA	DR AKHMAD SYAHRIR SP N	√
5	249993	JOKO ARUMAN		BPJS KESEHATAN	ICU	cardiac arrest	ARDS nefrolitiasis Jaundice DF	DR ADHYA AJI , SP.PD	√
6	116343	DJUMI'ANAH	3	BPJS KESEHATAN	6A	cardiac arrest	SYOK CONDITION	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
7		By. Ny Hera marta	0	UMUM	NEO	IUFD	IUFD	DR AIDA, SP.OG	√
8	250162	WAHJU WIDJANARKO	2	BPJS KESEHATAN	ICU	cardiac arrest	NSTEASC + Syok Kardiogenik + Krisis Hiperglikemia	DR YOGA SP JP	√
9	97474	Tn. DIMYATI	0	BPJS KESEHATAN	IGD	cardiac arrest	STEMI ANTAROCCEPTAL	DR JHANI	√
10	223546	SIMA	11	BPJS KESEHATAN	ICU	cardiac arrest	tb paru, pneumona psi 128, rf, aki, hipoalbumin, af	DR. ANDY SP. P	√
11	250369	SUMIATUN	4	BPJS KESEHATAN	ICU	cardiac arrest	respiratory failure+doc ec susp cva dd hipoglikemia+syok	DR ADHYA AJI, SP.PD	√
12	250104	By. Ny Hilda Amaliah	1	BPJS KESEHATAN	NEO	cardiac arrest	RDS, susp. Meningitis	DR DICKY FATURRACHMAN,SPA,	√
13	234642	TN SUKIMAN	0	UMUM	IGD	DOA	DOA	DR YENI	√
14	244853	Tn Padi	2	BPJS KESEHATAN	8A	cardiac arrest	CHOLELITIASIS, HIV ON TERAPI	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
15	250595	SITI FATIMAH	0	UMUM	IGD	cardiac arrest	COB	DR JHANI	√
16	250391	IWAN WAHYUDI	0	BPJS KESEHATAN	IGD	cardiac arrest	obs dyspnea susp gagal nafas	DR YOLANDA	√
17	250702	BY. NY. HARTANTRI LESTARI	0	BPJS KESEHATAN	NEO	cardiac arrest	Imatur bblasr	DR HUMAIRAH, SP.OG	√
18	250743	BY. NY. DIAH IRMAWATI	1	BPJS KESEHATAN	NEO	gagal nafas	neonatal dyspneu , BBLR, NP SC	DR RATIH KUSUMAWARDHANI, SP. A	√
19	250835	FAHRUR ROJI	1	BPJS KESEHATAN	HCU	cardiac arrest	cva ich pons	DR AKHMAD SYAHRIR SP N	√
20	250829	BUAMAR	2	BPJS KESEHATAN	ICU	cardiac arrest	CVA INFARK + RF + AF	DR FAHIMMA, SP. N	√
21	243685	MUALLIMAH	2	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	CA METASTASE	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	√
22	097815	TOYIP	2	BPJS KESEHATAN	HCU	CARDIAC ARREST	AF new onset doc, ANEMIA	DR IRA SETYA WATY SP JP	√
23	247707	RASMINI	5	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	pneumonia psi 118 tb paru respiratory failure DM	DR. ANDY SP. P	√

24	145720	HERAWAN KUKUH WIDHIANTO	2	BPJS KESEHATAN	HCU	CARDIAC ARREST	CVA ICH DM hiperglikemia	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	√
25	040793	WALUYO	1	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	pneumonia psi 116 respiratory failure cva azotemia hipoalbumin	DR. ANDY SP. P	√
26	251063	SUPARDI	2	BPJS KESEHATAN	IGD	CARDIAC ARREST	SUSP PNEUMINIA DD BRONKITIS	DR. ANDY SP. P	√
27	71088	SUPINAH	11	BPJS KESEHATAN	5C	CARDIAC ARREST	CHOLELITIASIS, NEFROLITIASIS, FATTY LIVER	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
28	250824	SUPATMI	7	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	CVA ICH, respiratory Failure	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	√
29	226843	SIAMI	6	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	ARDS DM TIPE 2 KOMA HIPERGLIKEMI skizofrenia,Cystitis,	DR HERI YATMO SAID SP PD,M.KES	√
30	251145	YAJI SUSANTO	1	UMUM	IGD	CARDIAC ARREST	DOA	DR ISROTUL	√
31	210944	SUKO SUDIRMAN	3	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	Ards Copd ae	DR CATUR ELVI PURNAMAWATI SP P	√
32	251084	AGUS	2	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	pneumonia + CAD + DM + respiratory failure	DR. ANDY SP. P	√
33	195791	SULISWATI	5	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	CVA 2nd attack dd encephalitis viral	DR DEWI MAHARANI SP. S	√
34	179238	SAMSUL AIMAH	3	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	Necrotizing fascitis pedis cruris D + Septic shock + Trombositopenia	DR ANTON, SP.B	√
35	251278	MOCHAMAD	3	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	COPD + ARDS	DR CATUR ELVI PURNAMAWATI SP P	√
36	250941	ISKAK	2	BPJS KESEHATAN	7A	CARDIAC ARREST	cHOLELITIASIS MULTIPLE	DR ROSSY ZAKI, SP.B	√
37	112798	SUMARMI	10	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	CVA INFARK, ARDS, DM	DR AHMAD FARID WAJDI SP. N	√
38	251447	PURBOSARIWATI SETYO HANDAYANI	11	UMUM	ICU	CARDIAC ARREST	SUSP AIHA	DR ARDHI BUSTAMI,SP.PD	√
39	251439	SITI ALFIJAH	2	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	CVA ICH CEREBELLUM	DR FACHRY, SP.BS	√
40	187180	TARTO BUDI SANTOSO	3	BPJS KESEHATAN	ICU	CARDIAC ARREST	POST CRANIOTOMY, HT	DR FACHRY, SP.BS	√
41	251287	NADIA SALSA BILA	0	BPJS KESEHATAN	3C	CARDIAC ARREST	Cardiac Arrest dt ARDS ec Bronkopneumonia + Scabies + susp. Immunocompromised	DR FIONA PARAMITHA SP.A	√

Analisa :

1. Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Juni 2026 sebanyak 41 pasien
2. Jumlah terbanyak yaitu dari ICU : 21 pasien IRNA : 7 pasien IGD : 6 pasien
3. Pada bulan Juni 2026 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 2 kasus.

4. Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut

Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	Usia lanjut	2	9	17
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	0	9	15
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	0	0	0
4	Perkiraan biaya tinggi	3	18	23
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	0	0	0
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	0	2	0
7	Potensial komplain tinggi	1	7	9
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	0	1	0
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangannya	0	2	5
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	0	3	4
11	Berpotensi masalah hukum	0	1	1
12	Naik kelas pelayanan	7	2	9
13	Lain - lain	10	27	26

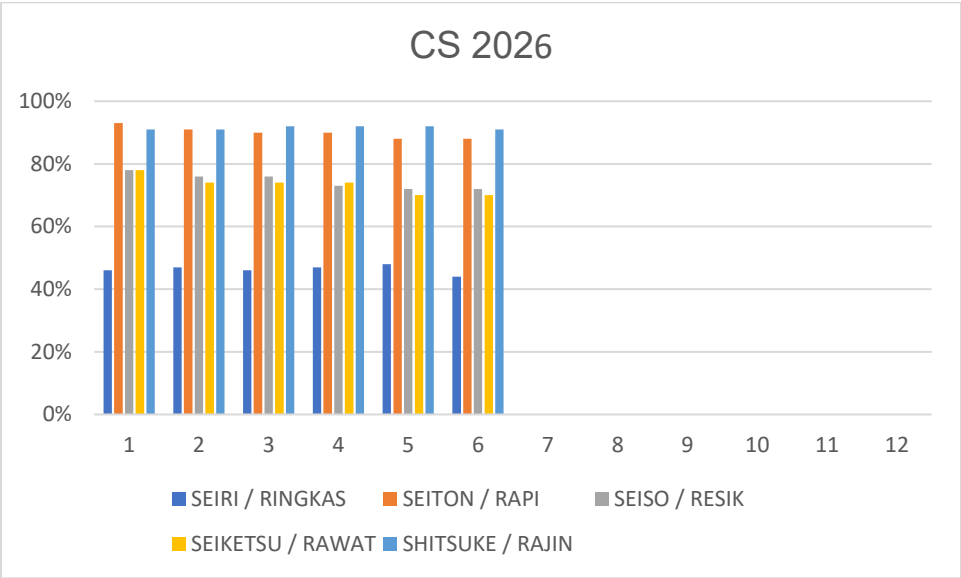
3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas Cleaning Service

NO	JENIS SPV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEIRI / RINGKAS	46%	47%	46%	47%	48%	44%						
2	SEITON / RAPI	93%	91%	90%	90%	88%	88%						
3	SEISO / RESIK	78%	76%	76%	73%	72%	72%						
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	74%	74%	74%	70%	70%						
5	SHITSUKE / RAJIN	91%	91%	92%	92%	92%	91%						



Analisa :
Terdapat progress pada semua factor penilaian bulan ini. Peningkatan perlu dipertahankan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

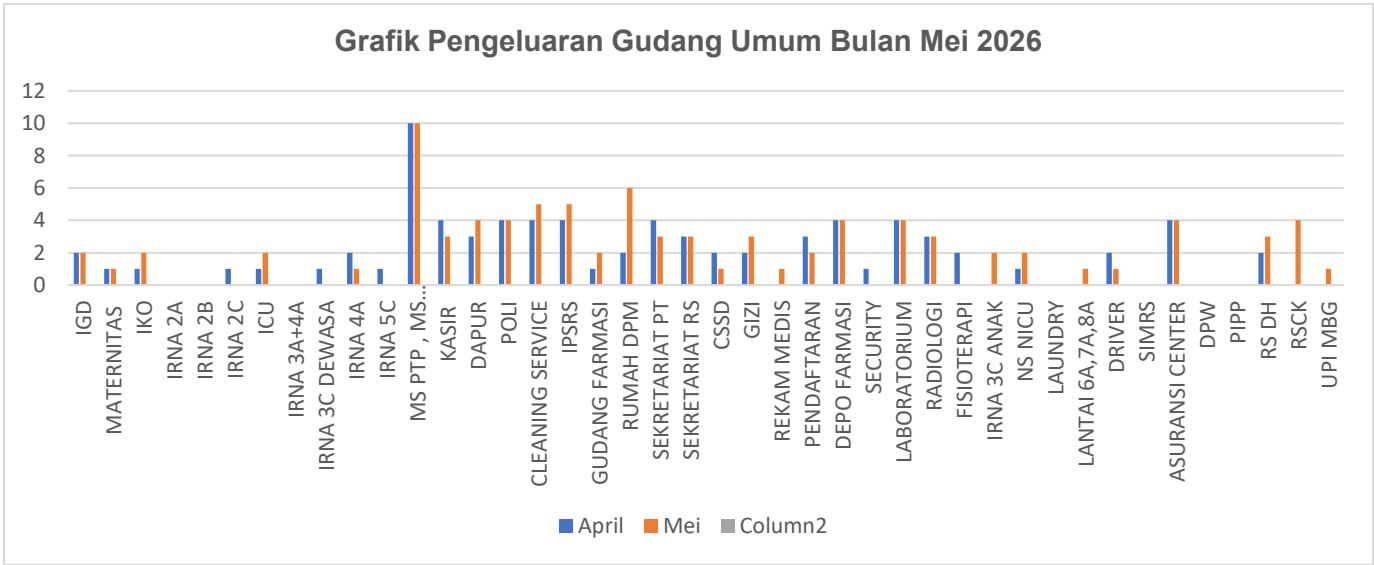
3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		MEI	JUNI	
1	IGD	2	3	↑33,33%
2	MATERNITAS	1	2	↑50%
3	IKO	2	2	↑0%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	0	2	↓100%
7	ICU	2	2	↑0%
8	IRNA 3A+4A	0	0	↓0%
9	IRNA 3C DEWASA	0	2	↑100%
10	IRNA 4A	1	1	↓ 0 0%
11	IRNA 5C	0	1	↑0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	10	10	↑0%
13	KASIR	3	4	↑25%
14	DAPUR	4	6`	↑33,33%
15	POLI	4	6	↑33,33%
16	CLEANING SERVICE	5	4	↓-25%
17	IPSRS	5	3	↓-66,66%
18	GUDANG FARMASI	2	1	↓-100%
19	RUMAH DPM	6	1	↓ -100%
20	SEKRETARIAT PT	3	2	↓-50%
21	SEKRETARIAT RS	3	2	-50%
22	CSSD	1	1	↓0%
23	GIZI	3	3	↑0%
24	REKAM MEDIS	1	3	↑66,66%
25	PENDAFTARAN	2	2	↓0%
26	DEPO FARMASI	4	5	↑20%

27	SECURITY	0	0	↑0%
28	LABORATORIUM	4	4	↑0%
29	RADIOLOGI	3	2	↓-50%
30	FISIOTERAPI	0	1	↑100%
31	IRNA 3C ANAK	2	1	↓-100%
32	NS NICU	2	1	↓-100%
33	LAUNDRY	0	0	↑0%
34	LANTAI 6A,7A,8A	1	1	↑0%
35	DRIVER	1	1	↓0%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	4	3	↓-33,330%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	3	4	↑25%
41	RSCK	4	3	↓-33,33%
42	UPI MBG	1	0	↓0%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat , dan Poli

Rencana Tindak Lanjut :

1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT - SIMRS

1.3.5.10.1 Pemeliharaan PC Server

Tabel 6. Pemeliharaan PC Server

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI	TASI
	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2025	server SIMRS 2, CCTV, INACBG,		

						SIMIPSRs, SYNOLOGY, FINGER, NYESHARE, SIDOKAR, FREENAS	
	FEBRUARI						
	MARET						
	APRIL	4x/tahun	1x	100%	30/01/2026	Selesai	Terlampir
	MEI						
	JUNI						
	JULI	4x/tahun					
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER	4x/tahun					
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.2 Pemeliharaan Mikrotik

Tabel Pemeliharaan Mikrotik

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	mikrotik IT (Ruang Server)	
	FEBRUARI	56x/bulan	56x	100%	Setiap hari	mikrotik IT (Ruang Server)	
	MARET	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	selesai	
	APRIL	60x/bulan	60x	100%	Setiap hari	selesai	Terlampir
	MEI	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	selesai	Terlampir
	JUNI	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	selesai	Terlampir
	JULI						
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.3 Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

Tabel 8. Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	1x/bulan	1x	100%	16/01/2025	Gedung A1, A2, DPM, Gedung B, Gedung C, Maternitas, Gudang Farmasi, Poli sentral It1, It2, Ruang Server IT, Parkiran Karyawan, Blok 3, Parkiran Belakang, Server IPCAM	
	FEBRUARI	1x/bulan	1x	100%	14/02/2025	Selesai	
	MARET	1x/bulan	1x	100%	09/03/2026	Selesai	
	APRIL	1x/bulan	1x	100%	24/04/2026	Selesai	Terlampir
	MEI	1x/bulan	1x	100%	20/05/2026	selesai	Terlampir
	JUNI	1x/bulan	1x	100%	22/06/2026	selesai	Terlampir
	JULI						
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.4 Pemeliharaan Modem Internet

Tabel 9. Pemeliharaan modem internet

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
----	-------	--------	-----------	---------	---------------------	------------	-------------

	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2015	Modem Indibiz, D-NET, Biznet, Indihome	
	FEBRUARI						
	MARET						
	APRIL	4x/tahun	1x	100%	22/04/2026	Selesai	Terlampir
	MEI						
	JUNI						
	JULI	4x/tahun					
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER	4x/tahun					
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

1.3.5.10.5 Pemeliharaan Komputer Unit

Tabel Pemeliharaan Komputer unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	15PC/Bulan	4x	26%	26/01/2025	Gate Parkir, Server Gate Parkir, Server IPCAM, Irna lantai 2A	
	FEBRUARI	15PC/Bulan	7x	47%	17/02/2026	Belum selesai	
	MARET	15PC/Bulan	8x	54%	23 s/d 25 maret 2026	PC all Farmasi	
	APRIL	15PC/Bulan	21x	100%	19 s/d 26 april	Verif,rm, manajemen selesai	Terlampir
	MEI	15PC/Bulan	15PC/Bulan	21x	100%	14 s/d 17 mei	Poli Irja
	JUNI	15PC/Bulan	9	60%	21 s/d 28 Juni	Irna Gedung C	Terlampir
	JULI	15PC/Bulan					
	AGUSTUS	15PC/Bulan					
	SEPTEMBER	15PC/Bulan					
	OKTOBER	15PC/Bulan					
	NOVEMBER	15PC/Bulan					

	DESEMBER	15PC/Bulan					
--	----------	------------	--	--	--	--	--

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target
Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.6 Pemeliharaan Printer Unit

Tabel 11. Pemeliharaan Printer unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	3 Printer /bulan	3x	100%	1/01/2025	PT, Rekam Medis (management), PDF IGD.	
	FEBRUARI	3 Printer /bulan	3x	100%	16/02/2026	Selesai	
	MARET	3 Printer /bulan	3x	100%	19/03/2026	Selesai	
	APRIL	3 Printer /bulan	3x	100%	22/04/2026	Selesai	
	MEI	3 Printer /bulan	3x	100%	22/04/2026	Selesai	Terlampir
	JUNI	3 Printer /bulan	3x	100%	22/04/2026	Selesai	Terlampir
	JULI						
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						

Analisa :
Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.7 Perapian Kabel Internet

Tabel Perapian kabel internet

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/Tahun	1x	25%	2/01/2025	Poli THT, Poli Syaraf 2, Poli Obgyn 2, SPI	
2	FEBRUARI						
3	MARET		1x	50%	19/03/2026		
4	APRIL						
5	MEI	4x/Tahun	1x	50%		Selesai	Terlampir
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						

11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.8 Perapian Kabel Telepon

Tabel Perapian kabel telepon

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	31/01/2025	Ruang Server PABX	
2	FEBRUARI						
3	MARET		1x	50%	19/03/2026	Selesai	
4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.9 Pemeliharaan Access Point

Tabel Pemeliharaan access point

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	04/01/2025	Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1-5, Gedung D 1-4. blok 3, Pdf Paru, Lounge laundry, Gudang farmasi, CSSD, Farmasi depo, Driver, DPM	
2	FEBRUARI						
3	MARET						

4	APRIL	4x/tahun	1x		50%	22/04/2026	Selesai	Terlampir
5	MEI							
6	JUNI							
7	JULI							
8	AGUSTUS							
9	SEPTEMBER							
10	OKTOBER							
11	NOVEMBER							
12	DESEMBER							

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.10 Pemeliharaan Switch Internet di Setiap Panel dan Unit

Tabel Pemeliharaan switch internet di setiap panel dan unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	09/01/2025	Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1-5, Gedung D 1-4. blok 3, Pdf Paru, Lounge laundry, Gudang farmasi, CSSD, Farmasi depo, Driver, DPM	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL	4x/tahun	1x	50%	09/04/2025	Selesai	
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPT						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.11 Pemeliharaan Modem GSM

Tabel Pemeliharaan modem gsm

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2025	Ruang Server PABX	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL	4x/tahun	1x	50%	7/04/2026	1. modem mati (perlu Ganti baru)	Terlampir
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5 10.12 Capaian Kegiatan Lainnya

No	Bulan	Kegiatan	Hasil	Petugas	Keterangan
1	Mei	Setting Bridging sim Khanza MS Klinik	Tuntas	Internal	
2	Mei	Setting Ip Public sim Khanza MS	Tuntas	Internal	
3	Mei	Setting IP public untuk kebutuhan virtual server APISIX	Tuntas	Internal	
4	Mei	Simulasi sursim akreditasi	Tuntas	Internal	
5	Mei	Pemasangan barcode kartu control pc / maintenance	Tuntas	Internal	

3.3.5 10.13 Rencana Kegiatan Lainnya

No	Bulan	Kegiatan	Hasil	Petugas	Keterangan
1	Juni	Setting Server PACS	Tuntas	Internal	
2	Juni	Penarikan kabel untuk server PACS	Tuntas	Internal	

3	Juni	Melengkapi dokumen Akreditasi	Tuntas	Internal	
4	Juni	Penambahan kamera cctv area parkir mobil	Tuntas	Internal	

3.3.6 Penanganan Keluhan

3.3.6.1 Keluhan Terkait Software

Tabel Keluhan Terkait Software

BULAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
Januari	51	51	100%
Februari	32	32	100%
Maret	72	72	100%
April	77	77	100%
Mei	64	64	100%
Juni	22	22	100%
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.2 Keluhan Terkait Hardware

Tabel 17. Keluhan Terkait Hardware

BULAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
-------	----------------	----------------------	----------------

Januari	69	69	100%
Februari	107	107	100%
Maret	54	54	100%
April	43	43	100%
Mei	34	34	100%
Juni	108	108	100%
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.3 Jenis Keluhan

Tabel Keluhan Spesifik

SPESIFIK	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
PC	13	30	16	24	25	21						
PRINTER	17	28	19	15	9	26						
SIMRS	4	6	10	3	2	4						
JARINGAN INTERNET	60	57	61	58	43	64						
TELPON PABX	5	5	1	4	4	5						
CCTV	3	3	3	3	3	3						
UPS	1	0	0	0	0	0						
HP / TAB	3	0	0	0	0	0						
CAMERA	2	0	0	0	0	0						
KEYBOARD DAN MOUSE	3	0	0	0	0	0						
LAINNYA	2	3	9	2	13	6						
TOTAL	113	132	119	109	99	129	0	0	0	0	0	0

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.4 Keluhan lain

No	Kegiatan	Jumlah	Hasil	Petugas	Keterangan
1	Komputer pdf igd konslet	1	Belum Tuntas	Internal	Vga Mati

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.5 Progress Peremajaan

Tabel Data PC

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL PC RS	JUMLAH PC YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH PC YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	188	- RM - Verif	IRNA 2A (pakai pc ex pdf loket 6)		
2	Februari	188	- Verif - PC poli ipd perawat	IGD p2 IRNA 2A		Sudah Dilakukan peremajaan
3	Maret	188	- Verif - PC poli ipd perawat			
4	April	188	- Verif - PC poli ipd perawat - irna 2a			
5	Mei	198	-Pdf igd	-admin mutu -Irna 2a Dokter		Pdf igd mati total karena konslet kesalahan user
6	Juni	198	-	-		-

Tabel Data CCTV

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL CCTV RS	JUMLAH CCTV YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH CCTV YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	100	1 (DPM Depan gerbang rumah 7b)			Pergantian power dvr yang konslet

2	Februari	100				
3	Maret	100	Power supply dvr cctv dpm			Pergantian power dvr yang konslet
4	April	101	Penambahan kamera cctv di area atm	Pindahan chanel dvr parkir ke dvr Gudang farmasi		Pemasangan baru
5	Mei	101	0	101	100%	
6	Juni	103		Penambahan kamera area parker mobil dgn igd		Pemasangan baru

Tabel Data Printer

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL PRINTER RS	JUMLAH PRINTER YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH PRINTER YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	44		1. Printer etiket parkir get in Jaminan		Untuk printer belum dilakukan permajaan dikarenakan akan proses ERM
2	Februari	44		1. Admin Jaminan (Ganti sensor head dengan kanibal unit printer yg sudah rusak)		
3.	Maret	44	2 (printer hasil & pengantar laborat)			Head printer lx 310 sudah mulai bergaris
4.	April	44	2 (printer cso dan radiologi)	Pdf igd		Pergantian karet penarik kertas
5	Mei	44	3 (Poli jantung, cso, printer backup)			Pergantian karet penarik kertas
6	Juni	44	-			-

3.3.6.6 Downtime

Tabel Laporan Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
-	-	-	-	-	-

3.5.11 Driver

Tabel Rekapitulasi Pengantaran Berdasarkan Keperluan

KEPERLUAN	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
RUJUK PASIEN KE RS LAIN	47	44	31	36	35	28						
RUJUK PASIEN KE RSPHS	0	1	0	0	0	0						
JEMPUT RUMAH PASIEN	21	27	19	20	17	22						
ANTAR RUMAH PASIEN	22	21	15	25	18	20						
SAMPEL LAB	31	33	29	29	33	24						
SAMPEL SHK	3	4	3	2	1	2						
KEPERLUAN NONKLINIS STAF RSPHM	8	4	3	6	2	9						
KEPERLUAN NON KLINIS STAF PT	1	0	3	1	0	6						
PENGANTARAN JENAZAH	42	33	34	37	40	36						
RUJUK CT SCAN	0	5	0	12	6	1						
ANTAR MCU RSPHM	0	1	0	0	0	0						
LAIN-LAIN	16	17	18	11	28	9						
TOTAL	191	190	155	179	180	157						

Analisa :
Utilitas pada bulan Juni masih dalam tahap normal sehingga bisa tidak ada kendala

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.12 PRIMANTARA

Tabel Jumlah Pengantaran Obat

BULAN	JUMLAH	RATA-RATA / BULAN
JANUARI	1024	40
FEBRUARI	1025	44
MARET	907	39
APRIL	1152	48

MEI	1086	47
JUNI	1117	47
JULI		
AGUSTUS		
SEPTEMBER		
OKTOBER		
NOVEMBER		
DESEMBER		
TOTAL		

Analisa :
Fluktuatif sesuai hari libur dan kenaikan pasien

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	Judul Indikator	Bulan												Stan- dar	Rata- Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	85,82%	85,87%	85,39%	85,93%	86,36%	86,82%							≥ 85%	86,03%	Ditingkatkan
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	96,82%	96,88%	96,40%	96,48%	97,13%	97,22%							100%	96,82%	PDSA
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	99,96%	99,06%	99,89%	99,97%	99,85%	99,93%							100%	99,78%	PDSA
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							≥ 80%	100,00%	Dipertahankan
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	89,90%	86,30%	89,20%	95,04%	95,98%	93,80%							≥ 80%	91,70%	Dipertahankan
6.	Penundaan Operasi Elektif	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							≤ 5%	0,00%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	66,75%	73,63%	68,35%	87,98%	88,55%	89,86%							≥ 80%	79,53%	PDSA
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							100%	100,00%	Dipertahankan
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	86,13%	86,07%	86,45%	86,33%	85,81%	86,00%							≥ 80%	86,13%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	30,51%	16,11%	18,75%	53,33%	65,22%	87,50%							≥ 80%	45,58%	PDSA
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	91,4%	93,31%	95,60%	96,55%	91,99%	99,06%							100%	94,71%	PDSA

12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							$\geq 80\%$	100,00%	Dipertahankan
13.	Kepuasan Pasien	99,70%	99,89%	99,79%	99,88%	99,41%	99,82%							$\geq 76,61$	99,75%	Dipertahankan

3.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

Gambar 1. Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



Analisis:

Capaian kepatuhan kebersihan tangan selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang relatif stabil dan konsisten berada di atas standar minimal 85%. Pada bulan Januari capaian sebesar 85,82%, meningkat sedikit menjadi 85,87% pada Februari. Pada bulan Maret terjadi penurunan menjadi 85,39%, namun masih memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya capaian kembali meningkat pada bulan April menjadi 85,93%, bulan Mei menjadi 86,36%, dan bulan Juni

mencapai 86,82%. Angka kepatuhan kebersihan tangan tertinggi berasal dari unit IRJA dengan capaian 100%, capaian ini berhasil dipertahankan oleh IRJA selama 2 bulan. Capaian tinggi selanjutnya berasal dari unit ICU dengan capaian 98,04%. Sementara itu, capaian terendah berasal dari unit IRNA 8A dengan capaian 82,41%. Capaian tersebut berada di bawah standar minimal yang ditetapkan ($\geq 85\%$).

Secara keseluruhan terlihat tren peningkatan sebesar 1,00% dari Januari ke Juni. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi, monitoring, dan pengawasan kepatuhan kebersihan tangan yang dilakukan di unit pelayanan telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, capaian yang masih berada pada kisaran 85–86% menunjukkan masih terdapat petugas yang belum konsisten melakukan kebersihan tangan sesuai dengan 5 momen hand hygiene, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan dan mempertahankan capaian yang telah memenuhi standar.

3.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



Analisis:

Capaian kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang baik dengan tren yang cenderung meningkat.

Pada bulan Januari capaian sebesar 96,82%, meningkat menjadi 96,88% pada Februari. Pada bulan Maret terjadi penurunan menjadi 96,40%, kemudian meningkat kembali menjadi 96,48% pada April, 97,13% pada Mei, dan mencapai 97,22% pada Juni.

Capaian tinggi ini mengindikasikan bahwa sudah banyak unit yang mencapai angka kepatuhan penggunaan APD sebesar 100%, yakni IGD, ICU, IKO, IFRS, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, IRNA 2A, IRNA 2C, IRNA 3A, IRNA 3C, IRNA 4A, IRNA 6A, IRNA 7A, IRNA 8A, Maternitas, Neonatologi, dan Perinatologi. Secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 0,40% dari Januari hingga Juni. Meskipun capaian belum mencapai standar ideal 100%, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar petugas telah menggunakan APD sesuai ketentuan yang berlaku. Penurunan yang terjadi pada bulan Maret dan capaian yang belum optimal mengindikasikan masih terdapat petugas yang belum konsisten menggunakan APD secara lengkap atau sesuai jenis tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan APD pada bulan Juni tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan penggunaan APD selama Januari–Juni 2026 belum mencapai standar 100%. Meskipun capaian relatif tinggi, masih ditemukan petugas yang belum menggunakan APD secara lengkap dan sesuai dengan risiko pelayanan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko infeksi dan paparan di lingkungan kerja.
Plan	Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD melalui penguatan edukasi mengenai penggunaan APD sesuai risiko pelayanan, pemasangan media pengingat di area kerja, supervisi oleh kepala unit, serta pemberian umpan balik terhadap hasil monitoring kepatuhan APD.
Do	Melakukan sosialisasi dan refreshment penggunaan APD, memastikan ketersediaan APD di seluruh unit pelayanan, melaksanakan audit kepatuhan APD secara berkala, serta menyampaikan hasil monitoring kepada masing-masing unit sebagai bahan evaluasi.
Study	Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan penggunaan APD dari 96,48% pada April menjadi 97,13% pada Mei dan 97,22% pada Juni. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi, supervisi, dan monitoring yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan petugas dalam penggunaan APD sesuai ketentuan.
Action	Melanjutkan audit dan supervisi penggunaan APD secara rutin, mempertahankan ketersediaan APD di seluruh unit, memberikan pembinaan pada unit yang masih ditemukan ketidakpatuhan, serta mengupayakan peningkatan capaian menuju standar 100%.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan Monitoring Kepatuhan Penggunaan APD	Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	Unit pelayanan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Komite PPI, IPCN • Kepala Ruangan	Berkelanjutan
2	Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar	Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	Seluruh staf unit pelayanan	Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	Setiap bulan
3	Kontroling ketersediaan APD	Mengoptimalkan ketersediaan dan	Unit pelayanan	Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan	• Komite PPI • Farmasi	Setiap bulan

		penggunaan APD		instalasi farmasi		
--	--	----------------	--	-------------------	--	--

3.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



Analisis:

Capaian kepatuhan identifikasi pasien selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten mendekati standar 100%. Pada bulan Januari capaian sebesar 99,96%, kemudian mengalami penurunan menjadi 99,06% pada Februari. Pada bulan Maret capaian kembali meningkat menjadi 99,89%, meningkat lagi menjadi 99,97% pada April, sedikit menurun menjadi 99,85% pada Mei, dan kembali meningkat menjadi 99,93% pada Juni. Secara umum capaian indikator menunjukkan stabilitas yang baik dengan rata-rata di atas 99%. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kejadian ketidaksesuaian dalam pelaksanaan identifikasi pasien yang menyebabkan capaian belum mencapai 100%. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pemberian pelayanan, tindakan, obat, maupun pemeriksaan penunjang apabila tidak dilakukan pengendalian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan seluruh petugas terhadap pelaksanaan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada bulan Mei tahun 2026

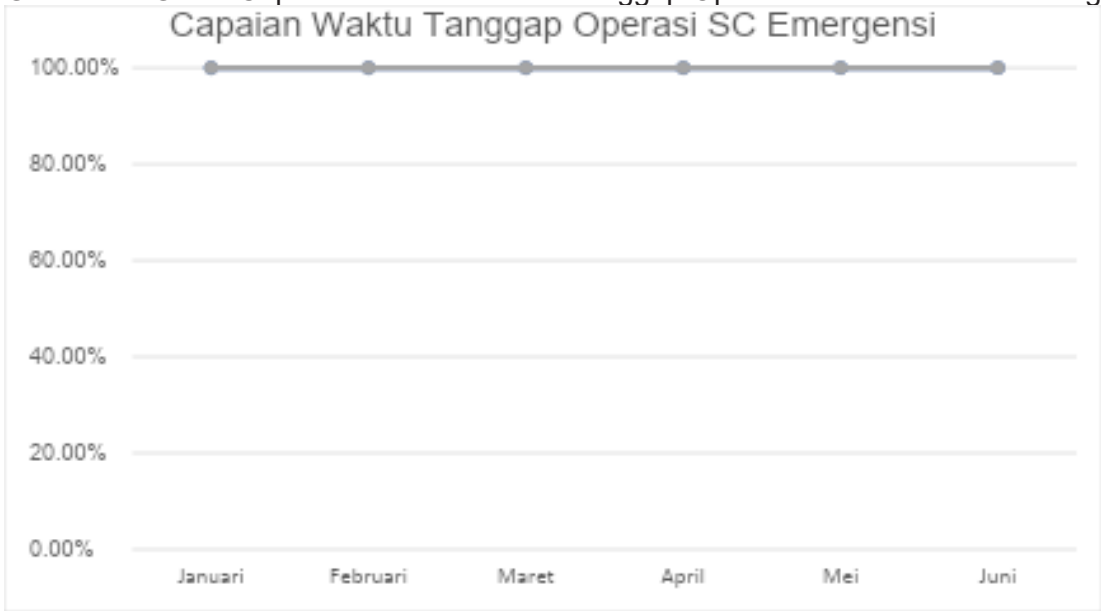
Problem	Capaian kepatuhan identifikasi pasien periode Januari–Juni 2026 belum mencapai standar 100%, dengan capaian Juni sebesar 99,93%. Masih ditemukan petugas yang belum konsisten melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sebelum pemberian pelayanan, tindakan, obat, maupun pemeriksaan penunjang.
Plan	Melaksanakan gerakan "100% Identifikasi Pasien" melalui briefing keselamatan pasien pada setiap pergantian shift, audit observasi rutin oleh kepala unit, pemasangan media pengingat di area pelayanan, serta pemberian umpan balik secara langsung terhadap setiap temuan ketidakpatuhan.
Do	Melaksanakan briefing keselamatan pasien setiap pergantian shift, memasang poster pengingat identifikasi pasien, melakukan audit observasi, dan menyampaikan hasil audit kepada unit terkait.
Study	Hasil monitoring menunjukkan capaian kepatuhan identifikasi pasien meningkat dari 99,85% pada bulan Mei menjadi 99,93% pada bulan Juni 2026. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan audit, edukasi, dan penguatan pengawasan yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien.
Action	Melanjutkan program "100% Identifikasi Pasien", mempertahankan audit dan supervisi rutin, melakukan pembinaan pada unit yang masih ditemukan ketidaksesuaian, serta mengupayakan pencapaian kepatuhan 100% secara konsisten di seluruh unit pelayanan.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan pengawasan oleh kepala unit/ruangan	Meningkatkan kewaspadaan petugas untuk melakukan identifikasi pasien sesuai SOP	Seluruh tenaga kesehatan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala. Kepala ruangan diminta memberikan pengawasan secara langsung serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Edukasi terkait keselamatan pasien akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan identifikasi pasien dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.	Kepala ruangan	1 bulan

3.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Analisis:

Capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 100% pada seluruh bulan pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus seksio sesarea emergensi yang dilakukan telah memenuhi standar waktu tanggap yang ditetapkan rumah sakit, sehingga pelayanan dapat diberikan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan klinis pasien.

Capaian yang konsisten selama enam bulan berturut-turut mencerminkan koordinasi yang baik antara dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter anestesi, perawat kamar operasi, bidan, serta unit pendukung lainnya. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan alur pelayanan emergensi yang efektif turut berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian indikator ini. Meskipun capaian telah memenuhi standar, upaya pemantauan dan evaluasi tetap perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi mutu pelayanan serta mengantisipasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi waktu tanggap di masa mendatang.

3.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

Gambar 5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



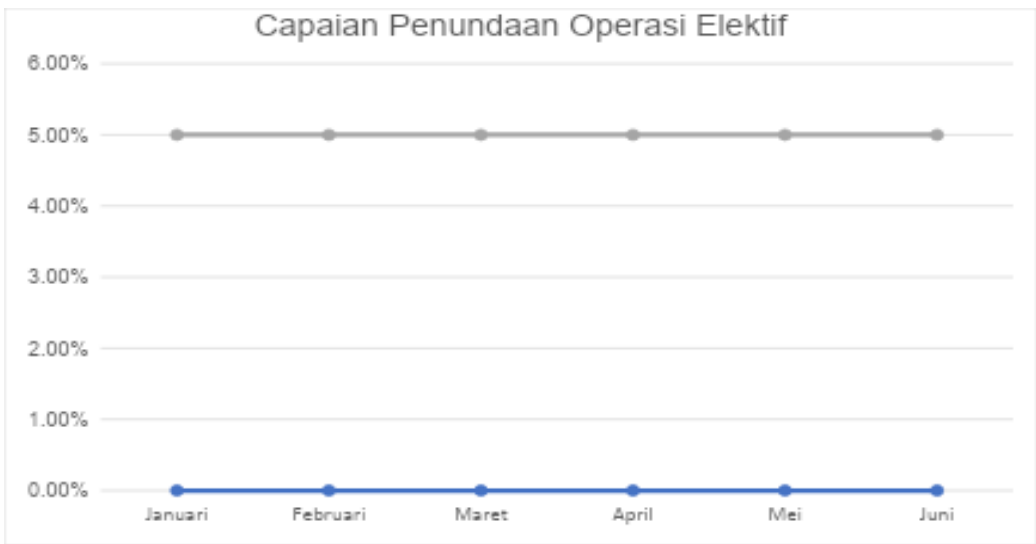
Analisis:

Capaian indikator waktu tunggu rawat jalan selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang telah memenuhi standar $\geq 80\%$, namun masih mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari capaian sebesar 89,90%, menurun menjadi 86,30% pada Februari, kemudian meningkat menjadi 89,20% pada Maret. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada bulan April menjadi 95,04% dan kembali meningkat menjadi 95,98% pada Mei. Pada bulan Juni capaian sedikit menurun menjadi 93,80%, namun tetap berada di atas standar yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan tren yang membaik dibandingkan awal tahun. Peningkatan yang terjadi pada April dan Mei mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan alur pelayanan rawat jalan, koordinasi antarunit, serta pengaturan jadwal pelayanan. Meskipun demikian, masih terdapat pasien yang mengalami waktu tunggu melebihi standar sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian dan mencegah terjadinya penumpukan pasien pada jam-jam tertentu.

3.1.6 Penundaan Operasi Elektif

Gambar 6. Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



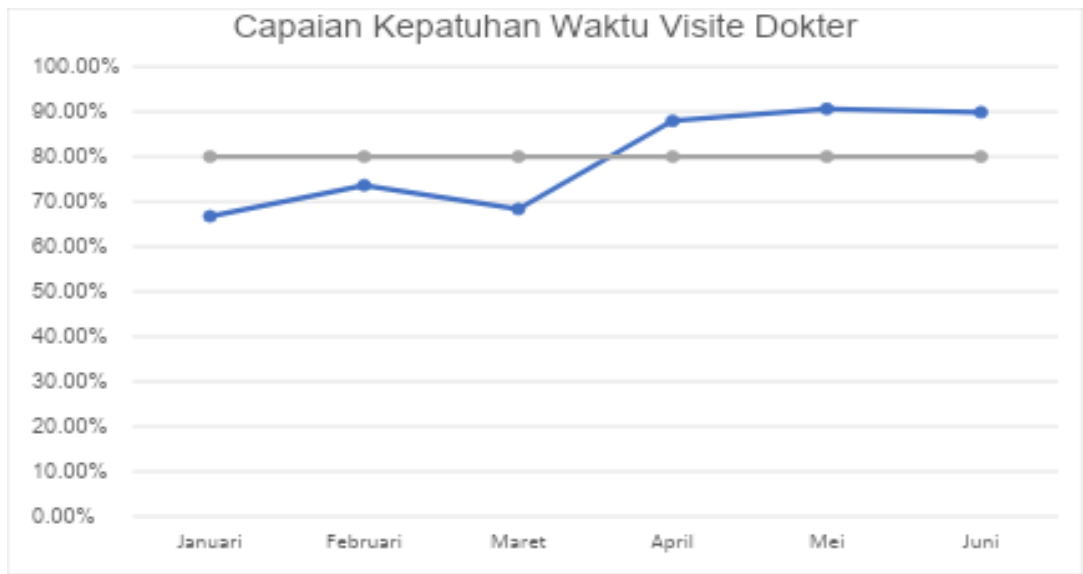
Analisis:

Capaian indikator penundaan operasi elektif selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan angka penundaan sebesar 0,00% pada seluruh periode pengukuran. Dari total 160 tindakan operasi elektif yang telah dijadwalkan, tidak terdapat kasus penundaan operasi, sehingga seluruh operasi dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan operasi, kesiapan pasien, ketersediaan dokter operator, dokter anestesi, ruang operasi, peralatan, bahan medis habis pakai, serta koordinasi antarunit telah berjalan dengan efektif. Tidak adanya penundaan operasi elektif juga mencerminkan pengelolaan pelayanan bedah yang baik sehingga dapat mendukung keselamatan pasien, efisiensi pelayanan, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan rumah sakit.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



Analisis:

Capaian indikator kepatuhan waktu visite dokter selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan meskipun masih belum mencapai standar yang ditetapkan sebesar 100%. Pada bulan Januari capaian sebesar 66,75%, meningkat menjadi 73,63% pada Februari, kemudian menurun menjadi 68,35% pada Maret. Selanjutnya terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan April menjadi 87,98%, meningkat kembali menjadi 90,61% pada Mei, dan sedikit menurun menjadi 89,86% pada Juni.

Secara kumulatif selama periode Januari–Juni 2026, terdapat 1.835 visite dokter yang dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan dari total 2.042 kesempatan visite yang diamati, sehingga diperoleh capaian sebesar 89,86%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dibandingkan awal tahun, namun masih terdapat 207 visite (10,14%) yang belum dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jadwal praktik dokter yang padat, keterlambatan kedatangan dokter, adanya tindakan atau pelayanan lain yang bersamaan, serta kendala koordinasi pelayanan di unit rawat inap.

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



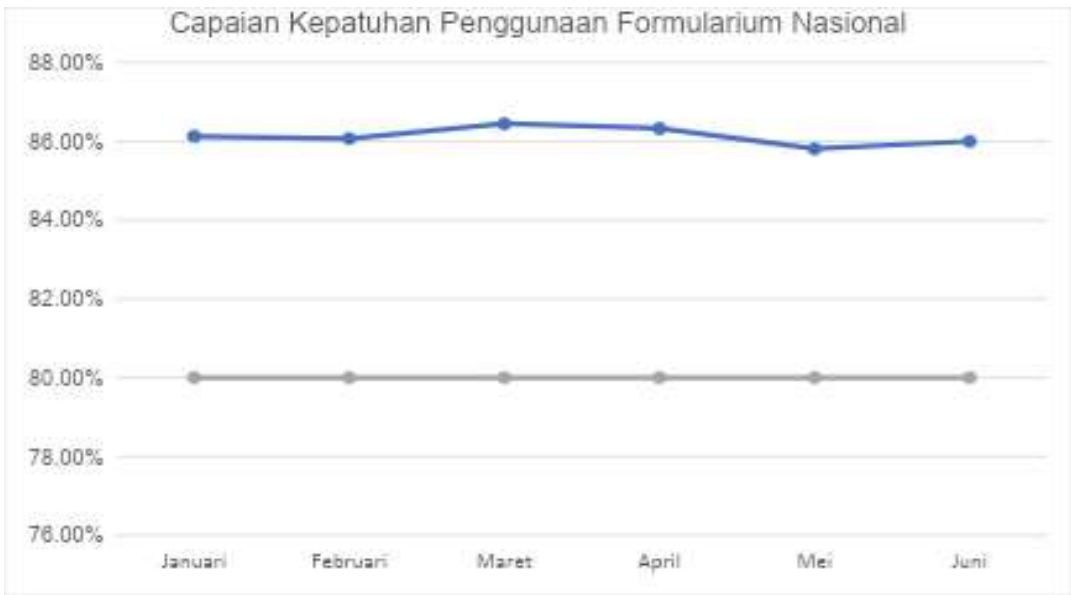
Analisis:

Capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 100% pada seluruh bulan pengukuran. Dari total 130 hasil kritis laboratorium yang teridentifikasi, seluruhnya (130 hasil kritis) telah dilaporkan kepada dokter atau petugas yang berwenang sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga diperoleh capaian 100%.

Capaian yang konsisten ini menunjukkan bahwa sistem identifikasi, komunikasi, dan pelaporan hasil kritis laboratorium telah berjalan efektif. Koordinasi yang baik antara petugas laboratorium dengan dokter penanggung jawab pelayanan maupun unit terkait mendukung tersampainya informasi hasil kritis secara cepat dan tepat, sehingga dapat segera ditindaklanjuti untuk mendukung keselamatan pasien dan pengambilan keputusan klinis. Meskipun capaian telah memenuhi standar, pemantauan tetap perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi pelaksanaan dan mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan di kemudian hari.

3.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Gambar 9. Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



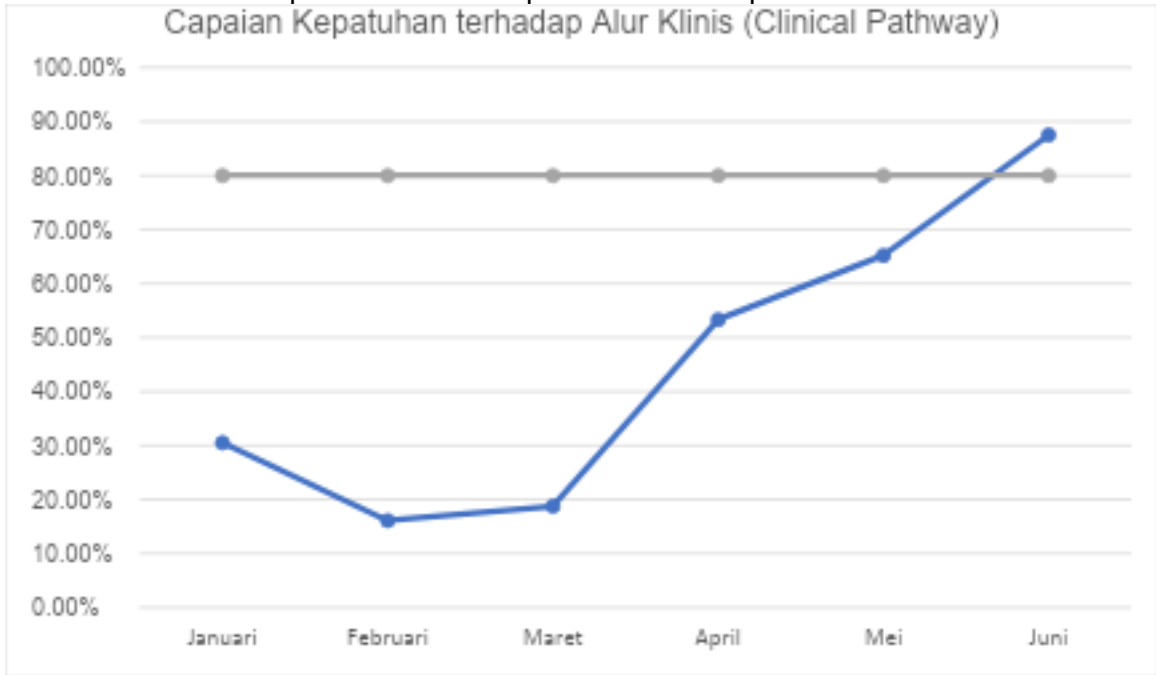
Analisis:

Capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas) selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten berada di atas standar yang ditetapkan yaitu $\geq 80\%$. Pada bulan Januari capaian sebesar 86,13%, sedikit menurun menjadi 86,07% pada Februari, kemudian meningkat menjadi 86,45% pada Maret. Pada bulan April capaian menjadi 86,33%, menurun menjadi 85,81% pada Mei, dan kembali meningkat menjadi 86,00% pada Juni. Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dengan rentang nilai antara 85,81% hingga 86,45%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peresepan telah mengacu pada Formularium Nasional. Namun demikian, masih terdapat sekitar 14% peresepan yang belum sesuai dengan Fornas. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh kebutuhan terapi tertentu yang belum tercantum dalam Fornas, ketersediaan obat, pertimbangan klinis dokter, maupun kebiasaan

peresepan yang belum sepenuhnya mengacu pada Formularium Nasional.

3.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Gambar 10. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Analisis:

Jumlah pasien dan kepatuhan terhadap CP sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Diagnosis	Jumlah Pasien	Kepatuhan CP	
			Patuh	Tidak patuh
1	Hipertensi	0	0	0
2	DM (DM Ulkus)	7	5	2
3	Tuberkulosis	8	8	0
4	HIV	0	0	0
5	Keganasan (Ca Mammae)	1	1	0

Capaian indikator kepatuhan terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Pada bulan Januari capaian sebesar 31,91%, kemudian menurun menjadi 16,11% pada Februari dan sedikit meningkat menjadi 18,75% pada Maret. Mulai bulan April terjadi peningkatan yang cukup besar menjadi 53,33%, meningkat kembali menjadi 65,22% pada Mei, dan mencapai 87,50% pada Juni.

Pada bulan Juni, dari 16 rekam medis yang menjadi sampel evaluasi Clinical Pathway, sebanyak 14 rekam medis telah sesuai dengan alur klinis yang ditetapkan, sehingga diperoleh capaian sebesar 87,50%. Berdasarkan diagnosis yang dievaluasi, terdapat 7 pasien Diabetes Melitus (DM Ulkus) dengan kepatuhan sebanyak 5 kasus (71,43%) dan ketidakpatuhan sebanyak 2 kasus (28,57%). Pada diagnosis Tuberkulosis terdapat 8 pasien dan seluruhnya (100%) telah patuh terhadap Clinical Pathway. Sementara itu, pada diagnosis Keganasan (Ca Mammae) terdapat 1 pasien dan telah memenuhi kepatuhan Clinical Pathway (100%). Tidak terdapat pasien dengan diagnosis Hipertensi maupun HIV yang menjadi sampel evaluasi pada periode ini.

Peningkatan capaian yang terjadi menunjukkan bahwa upaya sosialisasi, pendampingan pengisian Clinical Pathway, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pelaksanaan alur klinis. Namun demikian, masih terdapat 2 kasus pada kelompok DM Ulkus yang belum memenuhi ketentuan Clinical Pathway sehingga perlu dilakukan telaah lebih lanjut untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan, baik terkait pelaksanaan pelayanan maupun kelengkapan dokumentasi.

3.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 11. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Analisis:

Capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada bulan Januari capaian sebesar 91,77%, meningkat menjadi 93,31% pada Februari dan 95,60% pada Maret. Peningkatan masih berlanjut pada April dengan capaian 96,55%, kemudian mengalami penurunan menjadi 91,99% pada Mei. Pada bulan Juni terjadi peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 99,06%.

Pada bulan Juni, dari 3.600 kesempatan observasi yang dilakukan, sebanyak 3.566 tindakan pencegahan risiko jatuh telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga diperoleh capaian sebesar 99,06%. Dibandingkan capaian bulan Januari, terjadi peningkatan sebesar 7,29%. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan risiko pasien jatuh di unit pelayanan telah berjalan semakin baik dan mendekati standar yang ditetapkan.

Meskipun capaian telah sangat baik, masih terdapat 34 observasi (0,94%) yang belum memenuhi seluruh komponen upaya pencegahan risiko jatuh. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh petugas konsisten melaksanakan asesmen risiko jatuh, pemasangan penanda risiko jatuh, edukasi pasien dan keluarga, serta intervensi pencegahan lainnya sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	
Problem	Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh belum mencapai standar 100%. Masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan asesmen risiko jatuh, pemasangan penanda risiko jatuh, edukasi pasien dan keluarga, serta implementasi intervensi

	pengecehan sesuai prosedur.
Plan	Melaksanakan program "Zero Fall Risk" melalui penguatan asesmen risiko jatuh pada pasien, supervisi harian oleh kepala ruang, pemasangan media pengingat pencegahan risiko jatuh di unit perawatan.
Do	Melakukan sosialisasi ulang SPO pencegahan risiko jatuh, audit kepatuhan secara berkala, supervisi pelaksanaan asesmen dan intervensi risiko jatuh, serta edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai langkah-langkah pencegahan risiko jatuh
Study	Hasil monitoring menunjukkan capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh meningkat dari 91,99% pada bulan Mei menjadi 99,06% pada bulan Juni 2026. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penguatan supervisi, edukasi, dan monitoring yang dilakukan telah meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan risiko jatuh sesuai standar.
Action	Mempertahankan pelaksanaan audit dan supervisi rutin, melakukan monitoring rutin pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) serta menjadikan kepatuhan pencegahan risiko jatuh sebagai salah satu fokus monitoring keselamatan pasien untuk mencapai dan mempertahankan capaian 100%.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga/penunggu pasien untuk pencegahan jatuh	Meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai upaya pencegahan risiko jatuh selama perawatan	Pasien risiko jatuh dan keluarga/penunggu pasien	• Memberikan edukasi secara langsung saat pasien masuk rawat inap • Menggunakan media edukasi seperti leaflet/poster • Mengingatkan keluarga untuk mendampingi pasien risiko jatuh • Melakukan dokumentasi edukasi pada rekam medis	• Perawat ruangan • Kepala ruangan • Komite Mutu	Berkelanjutan
2	Monitoring pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)	Meningkatkan kedisiplinan staf dalam pencegahan risiko pasien jatuh	Perawat dan tenaga kesehatan	• Melakukan monitoring harian pemasangan gelang/label/stiker risiko jatuh • Melakukan audit kepatuhan secara berkala	• Perawat ruangan • Kepala ruangan • Komite Mutu	Berkelanjutan

				• Memberikan umpan balik kepada petugas apabila ditemukan ketidaksesuaian • Mengingatkan petugas melalui briefing/safety morning		
--	--	--	--	--	--	--

3.1.12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

Gambar 12. Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Analisis:
Capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 100% pada seluruh bulan pengukuran. Pada periode Juni 2026 terdapat 4 komplain yang diterima rumah sakit dan seluruhnya (4 komplain) telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu tanggap yang ditetapkan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.
Capaian yang konsisten ini menunjukkan bahwa mekanisme penerimaan, pelaporan, koordinasi, dan penyelesaian komplain telah berjalan efektif. Respons yang cepat terhadap komplain merupakan salah satu bentuk komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan, sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh masukan dalam upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
Meskipun capaian telah memenuhi standar, evaluasi terhadap substansi komplain tetap perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area pelayanan yang masih memerlukan perbaikan sehingga tidak hanya berfokus pada kecepatan respons, tetapi juga pada efektivitas penyelesaian masalah yang dikeluhkan oleh pasien atau keluarga.

3.1.13 Kepuasan Pasien

Gambar 3.1.13 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis:

Capaian indikator kepuasan pasien selama periode Januari–Juni 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten berada di atas standar yang ditetapkan. Pada bulan Januari capaian sebesar 99,70%, meningkat menjadi 99,89% pada Februari, kemudian sedikit menurun menjadi 99,79% pada Maret. Pada bulan April capaian kembali meningkat menjadi 99,88%, menurun menjadi 99,41% pada Mei, dan meningkat kembali menjadi 99,82% pada Juni. Pada bulan Juni 2026, dari 1.104 responden yang mengisi survei kepuasan pasien, sebanyak 1.102 responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan rumah sakit, sehingga diperoleh capaian sebesar 99,82%. Hanya terdapat 2 responden (0,18%) yang menyatakan belum puas. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan rumah sakit telah mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pasien dengan sangat baik. Meskipun capaian indikator sangat tinggi dan stabil, evaluasi terhadap aspek pelayanan yang masih menjadi sumber ketidakpuasan tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu berkelanjutan. Masukan dari pasien dapat menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, komunikasi petugas, maupun aspek fasilitas yang masih memerlukan penyempurnaan.

3.2 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	100%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap	92,42%	92,14%	92,90%	92,83%	93,06%	93,00%							100%	92,73%	PDSA
4.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%							100%	98,20%	Dipertahankan
5.	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)	85,05%	85,70%	85,91%	86,59%	83,10%	84,15%							100%	85,08%	PDSA
6.	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)	-	87,11%	92,08%	98,42%	90,16%	99,11%							100%	91,92%	PDSA

Analisis:

1. Berdasarkan hasil pengukuran periode Januari sampai dengan Juni, capaian kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pada pasien

rawat jalan mencapai 100% setiap bulan. Seluruh capaian telah memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit yaitu 100%, menunjukkan bahwa petugas secara konsisten melakukan proses verifikasi identitas pasien sebelum menyerahkan obat.

Pencapaian yang stabil selama enam bulan berturut-turut mencerminkan bahwa implementasi prosedur identifikasi pasien telah berjalan dengan baik dan menjadi budaya kerja di unit pelayanan rawat jalan. Kepatuhan ini juga menunjukkan efektivitas sosialisasi, supervisi, serta pemahaman petugas terhadap pentingnya identifikasi pasien sebagai salah satu sasaran keselamatan pasien.

Keberhasilan mempertahankan capaian 100% berkontribusi dalam mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat akibat salah pasien, sehingga risiko insiden keselamatan pasien dapat diminimalkan. Meskipun target telah tercapai secara konsisten, upaya monitoring dan evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan tetap terjaga serta mengantisipasi potensi penurunan capaian di masa mendatang.

2. Berdasarkan hasil pengukuran periode Januari sampai dengan Juni, capaian kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi mencapai 100% pada seluruh bulan pengamatan. Capaian tersebut telah memenuhi standar rumah sakit yang ditetapkan sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh hasil pemeriksaan radiologi yang termasuk kategori kritis telah dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsistensi capaian selama enam bulan berturut-turut menunjukkan bahwa proses komunikasi hasil kritis radiologi telah berjalan secara efektif, didukung oleh kepatuhan petugas terhadap SPO, koordinasi yang baik antarprofesi, serta mekanisme pelaporan yang telah dipahami dan diterapkan dengan baik oleh seluruh petugas terkait.

Pencapaian ini berperan penting dalam mendukung keselamatan pasien karena memastikan hasil kritis yang memerlukan tindak lanjut segera dapat diterima oleh dokter secara tepat waktu, sehingga keputusan klinis dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Meskipun capaian telah memenuhi target secara konsisten, kegiatan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi tetap perlu dipertahankan untuk menjaga keberlangsungan mutu pelayanan serta mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan hasil kritis di masa mendatang.

3. Berdasarkan hasil pengukuran periode Januari sampai dengan Juni, capaian kepatuhan penempelan label obat LASA (Look Alike Sound Alike) dan obat High Alert di rawat inap berturut-turut sebesar 92,42%, 92,14%, 92,90%, 92,83%, 93,06%, dan 93,00%. Selama periode tersebut, capaian indikator belum mencapai standar 100% yang telah ditetapkan rumah sakit.

Secara tren, capaian menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Pada bulan Februari terjadi penurunan sebesar 0,28% dibanding Januari, kemudian mengalami peningkatan pada bulan Maret menjadi 92,90%. Pada bulan April capaian sedikit menurun menjadi 92,83%, selanjutnya meningkat

pada bulan Mei menjadi 93,06% yang merupakan capaian tertinggi selama semester pertama, dan sedikit menurun pada bulan Juni menjadi 93,00%.

Belum tercapainya standar dapat disebabkan oleh masih ditemukannya obat LASA dan High Alert yang belum ditemplei label sesuai ketentuan, baik akibat kelalaian petugas, ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pengecekan, maupun adanya penambahan stok obat yang belum segera dilakukan pelabelan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pengambilan dan pemberian obat yang dapat berdampak pada keselamatan pasien.

Meskipun capaian menunjukkan kecenderungan membaik dibanding awal tahun, diperlukan upaya perbaikan yang lebih intensif melalui penguatan supervisi, pelaksanaan inspeksi rutin terhadap penyimpanan obat, peningkatan koordinasi antara instalasi farmasi dan unit perawatan, serta pemberian umpan balik kepada petugas terkait hasil monitoring. Dengan upaya tersebut diharapkan kepatuhan penempelan label obat LASA dan High Alert dapat terus meningkat dan mendekati standar yang telah ditetapkan.

4. Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan penandaan lokasi operasi berturut-turut sebesar 100%, 100%, 100%, 100%, 97,78%, dan 91,01%. Pada periode Januari–April, capaian telah memenuhi standar rumah sakit sebesar 100%. Namun, pada bulan Mei terjadi penurunan menjadi 97,78% dan kembali menurun pada bulan Juni menjadi 91,01%, sehingga tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Penurunan capaian menunjukkan masih terdapat pasien yang belum mendapatkan penandaan lokasi operasi sesuai prosedur. Kondisi ini dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan pelaksanaan SPO dan verifikasi praoperasi. Apabila tidak ditindaklanjuti, hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko kejadian salah lokasi operasi.

Untuk meningkatkan capaian, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketidakpatuhan yang terjadi, penguatan pelaksanaan Surgical Safety Checklist, serta peningkatan supervisi dan koordinasi dengan dokter operator dan tim bedah agar kepatuhan kembali mencapai standar 100%.

5. Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan berturut-turut sebesar 85,05%, 85,70%, 85,91%, 86,59%, 83,10%, dan 84,15%. Selama periode tersebut, capaian indikator belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%.

Capaian menunjukkan tren meningkat dari Januari hingga April, kemudian menurun pada Mei dan sedikit meningkat kembali pada Juni. Belum tercapainya target menunjukkan bahwa pelaksanaan 6 langkah cuci tangan masih belum konsisten dilakukan oleh seluruh petugas kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian, perlu dilakukan penguatan edukasi, monitoring dan supervisi rutin, serta pemberian umpan balik kepada unit yang belum mencapai target guna mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

6. Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan berturut-turut sebesar 85,05%,

85,70%, 85,91%, 86,59%, 83,10%, dan 84,15%. Selama periode tersebut, capaian indikator belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%.

Capaian menunjukkan tren meningkat dari Januari hingga April, kemudian menurun pada Mei dan sedikit meningkat kembali pada Juni. Belum tercapainya target menunjukkan bahwa pelaksanaan 6 langkah cuci tangan masih belum konsisten dilakukan oleh seluruh petugas kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian, perlu dilakukan penguatan edukasi, monitoring dan supervisi rutin, serta pemberian umpan balik kepada unit yang belum mencapai target guna mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

3.3 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No.	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	-	7,08%	12,50%	11,9%	3,53%	71,43 %							100%	60,12%	PDSA
2.	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	-	12,1%	21,48%	12,34%	3,5%	100,00 %							100%	100%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)	-	8,31%	12,05%	17,94%	4,94%	71,43 %							100%	22,19%	PDSA

Analisis:

1. Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan pengisian form *discharge planning* pasien DM dengan ulkus sebesar **42,68%, 57,14%, 52,63%, 70,00%, 66,67%, dan 71,43%**. Selama periode tersebut, capaian indikator **belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%**.
Secara tren, capaian menunjukkan peningkatan dibanding awal tahun meskipun sempat mengalami fluktuasi pada bulan Maret dan Mei. Capaian tertinggi diperoleh pada bulan Juni sebesar **71,43%**, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan dan dokumentasi *discharge planning*.
Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan monitoring, supervisi, dan kepatuhan petugas dalam pengisian form agar seluruh pasien DM dengan ulkus mendapatkan *discharge planning* yang terdokumentasi lengkap sesuai standar.
2. Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan pengisian form edukasi pada pasien DM dengan ulkus mencapai **100%** pada seluruh bulan pengamatan. Capaian tersebut telah memenuhi standar rumah sakit sebesar **100%** secara konsisten selama enam bulan berturut-turut.
Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian dan dokumentasi edukasi kepada pasien DM dengan ulkus telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas sesuai ketentuan yang berlaku. Konsistensi capaian juga mencerminkan komitmen tenaga kesehatan dalam mendukung kesinambungan perawatan pasien melalui edukasi yang terdokumentasi dengan lengkap.
3. Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan PPK dan CP pasien DM rawat inap sebesar **57,14%, 42,86%, 73,68%, 60,00%, 83,33%, dan 71,43%**. Selama periode tersebut, capaian indikator **belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%**.
Capaian menunjukkan fluktuasi setiap bulan dengan nilai terendah pada Februari sebesar **42,86%** dan tertinggi pada Mei sebesar **83,33%**. Meskipun terdapat peningkatan dibanding awal tahun, implementasi dan dokumentasi PPK serta CP masih belum dilakukan secara konsisten pada seluruh pasien DM rawat inap.
Diperlukan penguatan monitoring, evaluasi kepatuhan pengisian CP, serta peningkatan koordinasi antarprofesi agar pelaksanaan pelayanan sesuai PPK dan CP dapat berjalan lebih optimal dan mencapai standar yang ditetapkan.

3.4 Tujuan Strategis

NO	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26			
1.	Kejadian komplain pasien / keluarga di <i>google review</i>	5	1	3	11	7	4							0	5,17	PDSA

Analisis:

Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, jumlah kejadian komplain pasien/keluarga melalui Google Review berturut-turut sebanyak 5, 1, 3, 11, 7, dan 4 kejadian. Selama periode tersebut, capaian indikator belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 0 kejadian.

Jumlah komplain mengalami fluktuasi, dengan kejadian tertinggi pada bulan April sebanyak 11 komplain dan terendah pada bulan Februari sebanyak 1 komplain. Komplain yang muncul menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara harapan pasien/keluarga dengan pelayanan yang diterima, sehingga diperlukan evaluasi terhadap faktor penyebab dan tindak lanjut perbaikan.

Upaya peningkatan perlu dilakukan melalui analisis setiap komplain, percepatan respons terhadap keluhan, peningkatan komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga, serta penguatan budaya pelayanan prima agar kejadian komplain dapat diminimalkan.

3.5 Perbaikan Sistem

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26			
1.	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat	100%	100%	100%	100%	100%								100%	100%	Dipertahankan
2.	Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit	89,62%	82,66%	83,15%	86,44%	90,75%								100%	86.52%	PDSA

Analisis:

1. Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit berturut-turut sebesar 89,62%, 82,66%, 83,15%, 86,44%, 90,75%, dan 91,33%. Selama periode tersebut, capaian indikator belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%.
Capaian mengalami penurunan pada bulan Februari, kemudian menunjukkan tren peningkatan secara bertahap hingga bulan Juni dengan capaian tertinggi sebesar 91,33%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pelayanan obat racikan, namun masih terdapat sebagian pelayanan yang melebihi standar waktu yang ditetapkan.
Keterlambatan dapat dipengaruhi oleh proses penyiapan obat racikan yang membutuhkan waktu lebih lama, jumlah resep yang meningkat pada jam tertentu, serta proses verifikasi sebelum obat diserahkan kepada pasien. Diperlukan evaluasi alur pelayanan, optimalisasi koordinasi antara unit pelayanan dan farmasi, serta monitoring rutin agar waktu tunggu obat racikan dapat mencapai target 100%.
2. Berdasarkan hasil pengukuran Januari–Juni, capaian kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat sebesar 50%, 50%, 50%, 40,58%, 70,65%, dan 48,55%, sehingga belum mencapai standar 100%.
Capaian menunjukkan pemeliharaan alat belum dilakukan secara konsisten sesuai jadwal. Meskipun terjadi peningkatan pada bulan Mei, capaian kembali menurun pada Juni. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan monitoring, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan alat untuk mencegah risiko kerusakan alat yang dapat mengganggu pelayanan.

3.6 Hasil Kegiatan Mutu Prioritas Unit

3.6.1 Instalasi Gawat Darurat

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Gawat Darurat bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,05%	86,05%	82,67%	83,35%	83,55%	84,86%							84,42%	Belum mencapai standar (Mar-Jun)
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	96,99%	100%	97,16%	100%							99,03%	Belum mencapai standar (Maret, Mei)
4	Waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi ≤ 30 menit	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	97,16%	100%							99,53%	Belum mencapai standar (Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6	100%	86,05%	86,05%	86,05%	88,24%	87,95%	87,50%							86,97%	Belum mencapai standar

	langkah cuci tangan (SKP 5)															
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan perhitungan	100%	96,59%	96,65%	77,86%	100%							94,22%	Belum mencapai standar (Maret-Mei)
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidaklengkapan e-rm pengkajian awal IGD dan SPRI	0%	Blm dilakukan perhitungan	54,72%	1,41%	0,86%	1,27%	4,82%							12,62%	Belum mencapai standar
2	Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan pasien dengan EWS	0 kejadian	Blm dilakukan perhitungan	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
3	Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD	0 kejadian	Blm dilakukan perhitungan	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

3.6.2. IRNA 2A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 2A bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	85,86%	86,11%	86,21%	86,42%	86,28%	86,28%							86,19%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah

	identifikasi pasien															mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	100%	98,78%	100%	100%	99,32%							99,68%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	63,13%	78,21%	77,44%	72,38%	70,11%	100%							76,88%	Belum mencapai standar (Jan-Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	85,71%	85,96%	85,45%	85,19%	84,62%	84,62%							85,26%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	15,29%	8,43%	5,63%	11,11%	7,07%	100%							24,59%	Belum mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	15,06%	8,82%	5,63%	11,11%	9,24%	100%							24,98%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian	0	0	0	0	0	0	0							0	Sudah

	kesalahan asuhan medis DPJP	kejadian														mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	0%	0%	75%	0%	0%							12,50%	Sudah mencapai standar
3	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	0%	0%	2,44%	3,81%	48,91%	6,37%							10,26%	Belum mencapai standar

3.6.3 IRNA 2C

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 2C bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keteranga n
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	85,11%	87,50%	86,41%	86,93%	86,94%	87,13%							86,67%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	96,53%	100%	100%	100%	100%	100%							99,42%	Belum mencapai standar (Jan)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	83,45%	83,57%	76,06%	85,95%	87,59%	91,74%							84,73%	Belum mencapai standar (Mar)
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	95,62%	100%	98,46%	100%	100%	100%							99,01%	Belum mencapai standar (Jan, Mar)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan	100%	86,28%	86,56%	84,78%	87,72%	87,04%	87,23%							86,60%	Belum mencapai standar

	Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)															
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	20%	24,29%	5.6%	0%	0%							8,86%	Belum mencapai standar (Feb-Apr)
3	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	0%	34,34%	8,62%	0%	0%	14,05%							9,50%	Belum mencapai standar (Feb, Mar, Jun)

3.6.4 IRNA 3A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 3A bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien

	Prioritas)															
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien
3	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien								Tdk ada pasien

3.6.5 IRNA 3C
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 3C bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterang an
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,74%	84,12%	83,43%	83,10%	83,20%	83,20%							83,47%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,14%	100%	100%							99,86%	Belum mencapai

																standar (Apr)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	96,39%	100%	100%	100%	100%							99,40%	Belum mencapai standar (Feb)
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	75,47%	77,36%	76,92%	78,43%	78,43%	78,43%							77,51%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakuka n penguku ran	95,9%	100%	100%	100%	100%							99,18%	Belum mencapai standar (Feb)
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadi an	Blm dilakuka n penguku ran	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakuka n penguku ran	20%	0%	0%	0%	0%							4,00%	Belum mencapai standar (Feb)
3	Ketidakiengkapan asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakuka n penguku ran	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Belum mencapai standar

3.6.6 IRNA 4A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 4A bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	85,34%	85,44%	85,44%	85,00%	85,00%	85,32%							85,26%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	93,62%	90,27%	95,76%							96,61%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	59,36%	60,82%	63,42%	51,14%	93,33%							71,35%	Belum mencapai standar (Feb-Jun)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	86,21%	87,72%	85,96%	88,89%	88,89%	87,23%							87,48%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	86,67%	86,19%	79,51%	99,62%	72,67%	96,54%							86,87%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	(Pelayanan Klinis Prioritas)															
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	49,33%	28,8%	48,24%	8,7%	0%	0%							22,51%	Belum mencapai standar (Jan-Apr)
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	14,44%	20,83%	15,12%	17,12%	9,58%	0%							12,85%	Belum mencapai standar (Jan-Mei)

3.6.7 IRNA 5C

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 5C bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,85%	88,17%	89,49%	85,94%	86,23%	87,53%							87,37%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri	100%	86,77%	86,96%	86,67%	85,81%	90,97%	86,50%							87,28%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	(APD)															
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,06%	100%	89,23%	96,61%							97,48%	Belum mencapai standar (Mar-Jun)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	84,73%	89,47%	83,33%	83,7%	82,68%	90,6%							85,75%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	98,51%	96,09%	98,41%							98,84%	Belum mencapai standar (Apr-Jun)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	87,04%	88,33%	91,07%	91,67%	92,59%	94,44%							90,86%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	96,52%	100%	100%							99,30%	Belum mencapai standar (Apr)
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK	100%	Blm	100%	Tdk ada	Tdk ada	Tdk	100%							100%	Belum

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)		dilakukan pengukuran		pasien DM	pasien DM	ada pasien DM									mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	10,53%	16%	15,96%	10,62%	7,01%							12,02%	Belum mencapai standar
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	3,08%	0%	4,27%	8,08%							3,09%	Belum mencapai standar

3.6.8 IRNA 6A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 6A bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	82,69%	82,79%	83,03%	82,64%	82,76%	83,06%							82,83%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	95%	100%	100%	89,23%	100%							97,37%	Belum mencapai standar (Feb, Apr)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	57,95%	70,91%	60,77%	63,03%	82,68%	69,63%							67,50%	Belum mencapai standar (Jan, Feb, Mar, Apr,

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
																Jun)
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	94,29%	100%	100%	96,09%	100%							98,40%	Belum mencapai standar (Feb, Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	84,44%	82,61%	84,09%	83,72%	85,37%	90,48%							85,12%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM	Tidak ada pasien DM	Tdk ada pasien DM							100%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM	Tidak ada pasien DM	Tdk ada pasien DM							100%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM	Tidak ada pasien DM	Tdk ada pasien DM							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	DPJP															
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	50%	0%	45,65%	21,67%	23,2%							28,10%	Belum mencapai standar
3	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	37,5%	0%	0%	0%	0%							7,50%	Belum mencapai standar (Feb)

3.6.9 IRNA 7A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 7A bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,94%	84,17%	83,70%	83,94%	83,24%	82,76%							83,63%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100,00%	97,78%	100%	100%	100%							99,63%	Belum mencapai standar (Mar)
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	92%	94,92%	100%	100%	95,36%							97,05%	Belum mencapai standar (Feb, Mar, Jun)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	64,91%	82,94%	94,3%	86,7%	79,49%	59,31%							77,94%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6	100%	84,51%	84,72%	84,72%	84,51%	86,76%	87,14%							85,39%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	langkah cuci tangan (SKP 5)															
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	75%	Tdk ada pasien DM							87,50%	Belum mencapai standar (Mei)
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	75%	Tdk ada pasien DM							87,50%	Belum mencapai standar (Mei)
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	83,33%	Tdk ada pasien DM							91,67%	Belum mencapai standar (Mei)
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	28,57%	41,48%	26,44%	24,89%	8,68%							28,75%	Belum mencapai standar
3	Ketidاكلengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	18,93%	20,44%	26%	3,56%							12,70%	Belum mencapai standar

3.6.10 IRNA 8A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 8A bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	84,18%	83,33%	83,92%	83,71%	84,45%	82,41%							83,67%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	79,84%	92,59%	75,83%	76,33%	89,52%	100,00%							85,69%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	53,12%	96,95%	75,38%	92,37%	88,73%	88,7%							82,54%	Belum mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	90,8%	100%	100%							98,47%	Belum mencapai standar (Apr)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	85,25%	88,00%	85,00%	87,93%	87,27%	87,50%							86,83%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	Prioritas)															
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	24,31%	7,88%	11,27%	10,98%							10,89%	Belum mencapai standar
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	26,74%	9,66%	12,37%	11,74%							12,10%	Belum mencapai standar

3.6.11 ICU
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit ICU bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,80%	88,42%	86,58%	87,30%	91,33%	98,04%							89,75%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%							99,83%	Belum mencapai standar

	(APD)															(Jan)
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	94,44%	100%							99,07%	Belum mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,58%	90%	100%	100%	100%	100%							97,76%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	93,1%	100%	94,87%	94,44%	100%							97,07%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	87,10%	88,00%	86,89%	90,00%	89,77%	100,00%							90,29%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	91,04%	100%	94,87%	100%	100%							97,18%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU	0%	Blm dilakukan pengukuran	70,45%	0%	0%	1,82%	0%							0,46%	Belum mencapai standar
2	Kejadian kesalahan saat hand over (serah terima)	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0,00%	Sudah mencapai standar
3	Kejadian keterlambatan pemasangan intubasi pasien	0 kejadian	0	0	1	0	0	0							0,17	Belum mencapai standar (Mar)
4	Angka pasien kembali ke	<3%	0	4	0	1	0%	0%							0,83	Sudah mencapai

	perawatan intensive dengan kasus yang sama <72 jam																standar (Feb, Apr)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

3.6.12 PICU

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit PICU bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	99%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien							99,80%	Belum mencapai standar (Feb)
2	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien							100%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	Tdk ada pasien							0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	28,57%	0%	10%	0%	Tdk ada pasien							7,71%	Belum mencapai standar (Feb, Apr)
3	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	0%	18,75%	33,33%	0%	0%	Tdk ada pasien							10,42%	Belum mencapai standar (Feb,Mar)

3.6.13 Instalasi Rawat Jalan

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRJA bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	87,21%	88,17%	84,71%	86,67%	100%	100%							91,13%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,63%	95,82%	96,31%	97,68%	97,51%	98,06 %							96,67%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	96,09%	100%	99,9%	100%	100%							99,33%	Belum mencapai standar (Feb, Apr)
4	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	100%	86,29%	89,59%	95,04%	95,98%	93,8%							93,45%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	88,46%	88,89%	90,20%	88,24%	82,98%	90,74 %							88,25%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan DPJP terhadap jadwal Praktek	100%	76,78%	87,6%	84,62%	85,31%	85,66%	84,28 %							84,04%	Belum mencapai standar
2	Ketidaklengkap an e-rm asuhan pasien selama di irja	0%	2,43%	2,55%	2,43%	2,14%	2,46%	1,83%							2,31%	Belum mencapai standar
3	Target Pasien PRB dan iterasi	100%	100%	100%	98,49% %	100%	100%	99,7%							99,94%	Belum mencapai standar (Mar)
4	Kegagalan pelaksanaan	0 terjadi	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai

	layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	an															standar
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

3.6.14 Fisioterapi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Fisioterapi bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kegagalan pelaksanaan layanan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	0 kejadian	5	2	0	3	0	0							2	Belum mencapai standar (Jan, Feb, Apr)
2	Pelayanan tidak sesuai program terapi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0	Sudah mencapai standar

3.6.15 Maternitas

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Maternitas bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	90,34%	90,21%	90,21%	89,93%	91,20%	91,80%							90,62%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	identifikasi pasien															mencapai standar
4	Waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi ≤ 30 menit	≥ 80%	Tdk ada op SC emergensi	Tdk ada op SC emergensi	Tdk ada op SC emergensi	Tdk ada op SC emergensi	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	53,38%	49,57%	47,76%	86,09%	87,27%	90,7%							69,13%	Belum mencapai standar
6	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	95,36%	95,45%	100%							98,47%	Belum mencapai standar (Apr-Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	86,30%	86,11%	86,11%	87,67%	88,24%	89,06%							87,25%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas	0%	0%	0%	0%	11,92%	17,27%	20,45%							8,27%	Belum mencapai standar
2	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar
3	Kejadian perdarahan post	0 kejadian	3	3	2	3	0	2							2	Belum mencapai

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	partum															standar
4	Angka kejadian partus macet	< 10%	18,5%	31,3%	33,3%	13,21%	4,7%	10%							18,50%	Belum mencapai standar
5	Kejadian eklamsi	0 kejadian	3	0	0	0	0	0							1	Belum mencapai standar (Jan)
6	Kejadian pre eklamsi	0 kejadian	0	1	1	4	0	4							2	Belum mencapai standar
7	Kejadian infeksi nifas	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
8	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	0%	0%	13,91%	12,73%	6,82%							5,58%	Belum mencapai standar (Apr-Jun)
9	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

3.6.16 Neonatologi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Neonatologi bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	90,88%	89,47%	90,88%	91,03%	90,77%	91,82%							90,81%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	93,33%	100%	95%	89,36%	97,67%							95,89%	Sudah mencapai

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	standar Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	98,25%	98,25%	98,25%	98,28%	98,08%	97,73%							98,14%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka Kematian Bayi	0%	0%	0%	1,59%	0%	1,18%	1,04%							0,44%	Belum mencapai standar
2	Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada pasien dengan indikasi	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
3	Kejadian SHK yang di tolak Dinkes	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

3.6.17 Instalasi Kamar Operasi (IKO)
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IKO bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	94,44%	94,11%	94,44%	94,80%	94,80%	94,80%							94,57%	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%							98,13%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)
4	Penundaan operasi elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%							98,13%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (SKP 4)	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%							98,20%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)
2	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	92,86%	95,35%	92,86%	92,68%	90,24%	90,24%							92,37%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%							98,13%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian re operasi	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
2	Ketidaklengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO	0%	9,45%	9,32%	1,49%	3,83%	2,52%	0,56%							4,53%	Belum mencapai standar
3	Kejadian kegagalan pembiusan SAB, sehingga prosedur dialihkan menjadi pembiusan GA	0 kejadian	0	0	0	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

3.6.18 Instalasi Laboratorium

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Laboratorium bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,26%	83,18%	83,26%	82,86%	83,00%	83,00%							83,09%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
4	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas	100%	79,07%	77,27%	79,07%	78,57%	77,50%	77,50%							78,16%	Belum mencapai

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
	Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)															standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi	0 kejadian	48	24	27	12	69	53							39	Belum mencapai standar
2	Surveilans harian hemovigilance "Kejadian Reaksi Transfusi"	100%	Tdk ada kejadian	Tdk ada kejadian	Tdk ada kejadian	Tdk ada kejadian	100%	Tdk ada kejadian							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan darah	100%	94,51%	92,71%	100%	96%	93,94%	96.83%							95,43%	Belum mencapai standar

3.6.19 Instalasi Radiologi
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Radiologi bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,62%	83,88%	83,33%	83,04%	83,89%	83,88%							83,61%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
1	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (SKP 2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	89,66%	88,52%	89,47%	89,29%	90,74%	93,88%							90,26%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	16	5	5	9	5							8	Belum mencapai standar
2	Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	40	30	30	32	31							33	Belum mencapai standar

3.6.20 Instalasi Gizi
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Gizi bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-Rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	81,02%	81,25%	80,28%	81,94%	75,46%	78,83%							79,80%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	94,64%	94,45%	93,46%	95,57%	93,46%							95,26%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan	100%	73,61%	73,96%	82,61%	39,19%	33,33%	39,19%							56,98%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-Rata	Ket
	Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)															
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	100%	Blm dilakukan pengukuran	91,09%	89%	60,64%	70%	87,18%							79,58%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	100%	100%	100%	99,17%	99,26%	100%	100%							99,74%	Belum mencapai standar
3	Angka kelengkapan pengkajian gizi	100%	100%	100%	99,91%	100%	99,7%	100%							99,94%	Belum mencapai standar
4	Kejadian kesalahan pemberian diet pada pasien rawat inap	0 kejadian	2	1	1	2	1	3							2	Belum mencapai standar
5	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0 kejadian	0	0	0	0	1	0							0	Belum mencapai standar
6	Kejadian makanan basi	0 kejadian	1	1	0	0	0	0							0	Belum mencapai standar

3.6.21 Instalasi Farmasi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Farmasi bulan Mei Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,73%	86,46%	86,60%	86,67%	86,20%	84,67%								Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	≥ 80%	86,13%	86,07%	86,45%	86,33%	85,81%	86,00%								Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (SKP 1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert di rawat inap (SKP 3)	100%	92,42%	92,14%	92,90%	92,83%	93,06%	93,00%								Belum mencapai standar
3	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	83,33%	85,94%	83,18%	82,18%	81,25%	79,31%								Belum mencapai standar
4	Waktu tunggu obat racikan < 60 menit	100%	89,62%	82,66%	83,15%	86,44%	90,75%	91,33%								Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
	(Perbaikan Sistem)															
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit	0%	Blm dilakukan pengukuran	43.56%	43.06%	43,33%	41,14%	7,5%								Belum mencapai standar
2	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0 kejadian	0	0	0	0	0	0								Sudah mencapai standar
3	Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat	0 kejadian	2	4	6	2	1	0								Belum mencapai standar
4	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	0 kejadian	1	2	0	1	0	1								Sudah mencapai standar
5	Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat	0 kejadian	1	0	0	1	0	0								Sudah mencapai standar
6	Kejadian Kesalahan Input E-Resep	0 kejadian	1	4	0	0	1	1								Belum mencapai standar

3.6.22 Pengadaaan Farmasi
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Pengadaaan Farmasi bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Keterlambatan sediaan	0%	Blm dilakukan	20,6%	28%	32,8%	26,76%	40,88%							29,81%	Belum mencapai

	farmasi datang		pengukuran													standar
2	Kesalahan pembelian sediaan farmasi	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar
3	Angka selisih stok opname	0%	Blm dilakukan pengukuran	0,88%	0,73%	0,99%	0,64%	0,55%							0,76%	Belum mencapai standar
4	Respon time memasukkan master barang baru 1X24 Jam	100%	Blm dilakukan pengukuran	93,75%	97,37%	100%	100%	100%							98,22%	Belum mencapai standar (Feb,Mar)

3.6.23 Komite PPI

Tabel Capaian Indikator Mutu Komite PPI bulan Mei Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Komite																
1	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar
2	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤ 3,5‰	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar
3	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0 ‰	0 ‰	1.82%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar
4	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0 ‰	0 ‰	0.81%	0%	0%	0%							0,00%	Sudah mencapai standar
5	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0.35%	0.3%	0.17%	0.33%	0,32%	0,07%							0,20%	Sudah mencapai standar
6	Angka Decubitus	0%	0%	0%	9.09%	0%	2,5%	0%							0,50%	Belum mencapai standar
7	Kejadian	0	0	0	0	0	0	2							0	Belum

	petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	kejadian														mencapai standar (Jun)
--	---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

3.6.24 SDM
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit SDM bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK	0 kejadian	0	0	0	1	0	0							1	Sudah mencapai standar
2	Angka turn over staf	0%	1,38%	0%	0,28%	0,55%	1,38%	0,55%							0,69%	Belum mencapai standar

3.6.25 Instalasi Rekam Medis (Pendaftaran)
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Rekam Medis (Pendaftaran) bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kesalahan pendaftaran pasien	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	25	25	38	32	0							24	Belum mencapai standar
2	Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	4	1	1	0	0							1	Belum mencapai standar
3	Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	1	5	0	1							1	Belum mencapai standar

3.6.26 K3RS

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit K3RS bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidakpatuhan pembuatan PCRA	0%	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0								

3.6.27 IPSRS

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IPSRS bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat (Manajemen Risiko)	100%														
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Waktu tanggap respon dan penanganan pelaporan kerusakan unit	100%	96.83%	98.08%	88.28%	81.25%										
2	Kejadian kerusakan sarana prasarana	0 kejadian	124	156	145											

3.6.28 Asuransi Center

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Asuransi Center bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Waktu	Tanggal 5	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5								Sudah

	Pengajuan Klaim	awal bulan														mencapai standar
2	Klaim pending RJTL	<0,1%	0	-	-	1.9%	11,4%	10,7%								Belum mencapai standar
3	Klaim pending RITL	<1%	0	-	-	8.3%	6,6%	7,1%								Belum mencapai standar
4	Klaim tidak layak	0%						0,03%								
5	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL	< Rp1.000.000														
6	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL	< Rp5.000.000														
7	Nilai selisih negatif klaim RJTL	< Rp50.000.000	251.175.040	232.420.655	151.929.783	251.293.106	209.944.684	Rp266.005.258								
8	Nilai selisih negatif klaim RITL	< Rp100.000.000	- 1.216.032.654	-	-	- 1.462.313.938		Rp-557.824.591								
9	Persentase readmisi pasien rawat inap	0%	3,5%	1,83%	2,34%	3,51%	2,47%	3%								Belum mencapai standar
10	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	66,4%	42,32%	61,43%	69,52%	66,6%	77,3%								Belum mencapai standar

3.6.29 PIPP

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit PIPP bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar
2	Kepuasan Pasien	≥ 76,61%	99,70%	99,89%	99,79%	99,88%	99,41%	99,82%							99,75%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kejadian komplain pasien/keluarga di google review (Tujuan Strategis)	0 kejadian	5	1	3	11	7	4							5	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka Kepuasan Pasien Peserta BPJS	100%	99,89%	100%	100%	100%	99,91%	99,9%							99,96%	Belum mencapai standar
2	Angka terhubungnya display TT dengan mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar
3	Angka terhubungnya operasi dengan mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100,00%	Sudah mencapai standar

3.6.30 Cleaning Service

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Cleaning Service bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
----	-----------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----

Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,74%	87,82%	85,90%	84,72%	84,72%	86,90%							86,63%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	90,95%	90,19%	90,21%	92,01%	92,42%	92,72%							91,42%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	69,23%	69,23%	69,23%	66,67%	66,67%	74,07%							69,18%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Respon time menanggapi keluhan unit <10 menit	≥ 90%	90.91%	79.1%	84.62%	88.07%	92,39%	90%							91,20%	Sudah mencapai standar

3.6.31 Kesekretariatan
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Kesekretariatan bulan Mei Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen <i>meeting</i> RS (saat akhir rapat)	0%	25%	0%	0%	0%	Tidak ada rapat									-

3.6.32 CSSD & Laundry
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit CSSD & Laundry bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
----	-----------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----------	-----

Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	84,41%	89,29%	87,22%	75,56%	79,03%	75,56%							81,85%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry																
1	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0 kejadian	0	16	38	0	0	0							9	Sudah mencapai standar
2	Kejadian tercampur benda asing	0 kejadian	1	0	4	0	0	0							1	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD																
1	Kejadian keterlambatan penyediaan kasa steril	0 kejadian	2	0	0	2	1	0							1	Belum mencapai standar
2	Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang	0 kejadian	0	0	2	0	0	0							0	Sudah mencapai standar

3.6.33 IT
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IT bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian CCTV tidak terecord	0 kejadian	0	0	2	0	0	0							0	Sudah mencapai standar
2	Kejadian komputer dan internet lemot	0 kejadian	60	53	17	17	22	12							30	Belum mencapai standar

3.6.34 Kamar Jenazah

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Kamar Jenazah bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidakpatuhan pencatatan buku transit jenazah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0%	Sudah mencapai standar

3.6.35 Driver

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian permintaan driver yang bersamaan	0 kejadian	0	4	1	2	0	0							1	Sudah mencapai standar
2	Kejadian oncall driver	0 kejadian	3	5	2	2	3	2							3	Belum mencapai standar
3	Penggunaan ambulance luar RS	0 kejadian	12	11	10	5	2	2							7	Belum mencapai standar

3.6.36 Security

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor	0 kejadian	1	0	1	1	0	0							1	Sudah mencapai standar

2	Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap	0 kejadian	15	14	13	26	29	22							20	Belum mencapai standar
---	--	------------	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	----	------------------------

3.6.37 Gudang Umum

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0 kejadian	4	8	1	4	3	2							4	Belum mencapai standar

3.6.38 Kasir

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kesalahan pelunasan yang dilakukan	0 kejadian	2	5	5	7	1	0								Belum mencapai standar
2	Keterlambatan pelunasan pembayaran	0 kejadian	1	1	0	0	0	0								Sudah mencapai standar
3	Kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit	0 kejadian	2	5	5	7	10	0								Belum mencapai standar

3.6.39 Humas

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Keterlambatan perpanjangan perjanjian kerja sama	0 kejadian	0	0	0	1	1	2							1	Belum mencapai standar

3.6.40 Primantara

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian komplain keterlambatan pengantaran obat	0 kejadian	1	1	0	2	2	0							1	Belum mencapai standar

3.6.41 PKRS

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100%	Blm dilakukan pengukuran	Blm dilakukan pengukuran	87%		66,67%									Belum mencapai standar
2	Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi “Read Back” pada Instruksi Verbal	100%	Blm dilakukan pengukuran	Blm dilakukan pengukuran	93%		83,3%									Belum mencapai standar
3	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	100%	Blm dilakukan pengukuran	Blm dilakukan pengukuran	90%		47,06%									Belum mencapai standar

3.6.42 PROGNAS KB

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka capaian pelayanan KB per	100%														

	metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP															
2	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	70%														
3	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0														

3.6.43 PROGNAS TB

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka Pasien Terkonfirmasi Bakteriologis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar

3.6.44 PROGNAS HIV

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka kepatuhan petugas dalam melakukan skrining dan testing pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	Sudah mencapai standar

	dengan resiko HIV/AIDS															
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.45 PROGNAS STUNTING

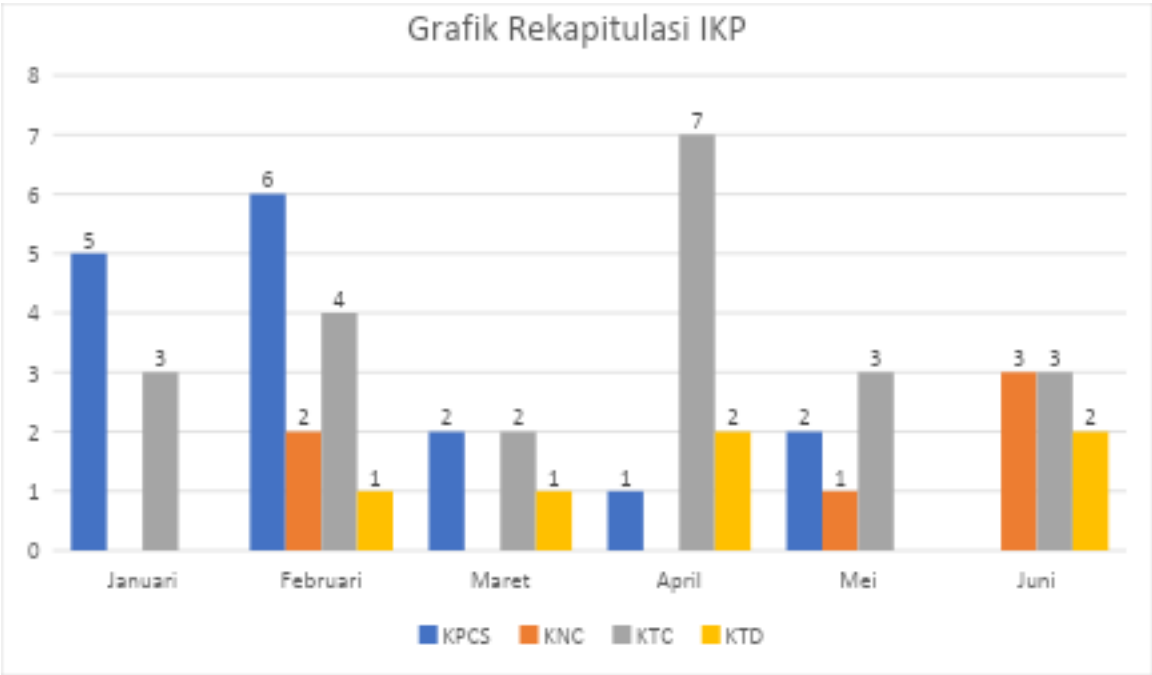
No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien Stunting & Wasting	100%	Blm dilakukan pengukuran	0%	0%	0%	0%	0%								Belum mencapai standar
2	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok sebagai upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/bln)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%								Sudah mencapai standar

3.7 LAPORAN KEJADIAN IKP

Tabel Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden

	KPC	KNC	KTC	KTD	SENTINEL	JUMLAH
JANUARI	5		3			8
FEBRUARI	6	2	4	1		13
MARET	2		2	1		5
APRIL	2		6	2		10
MEI	2	1	3			6
JUNI		3	3	2		8
JULI						
AGUSTUS						
SEPTEMBER						
OKTOBER						
NOVEMBER						
DESEMBER						
JUMLAH	16	3	19	4		41

Grafik Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden



Laporan IKP Bulan Juni 2026

NO.	TGL KEJADIAN	UNIT	Grading	Jenis IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
1	01 Juni	Instalasi Gizi	Hijau	KTD	Kesalahan pemberian minuman (teh manis) untuk pasien dengan RPD DM sehingga gula darah pasien naik.	1. Meningkatkan ketelitian saat membagikan snack dengan tetap melihat pemesanan diet 2. Melakukan crosscheck kepada perawat dan pasien/keluarga pasien mengenai riwayat penyakit sebelum membagikan snack/makanan pasien
2	08 Juni	Instalasi Farmasi	Hijau	KTC	Kesalahan Pemberian Obat LASA (di etiket tertulis Codikaf 10 mg tetapi yang diberikan Codikaf 15 mg)	3. Menghubungi pasien untuk crosscheck obat yang diterima, mengarahkan pasien untuk memberhentikan konsumsi Codikaf 15 mg dan mengirimkan Codikaf 10 mg. 4. Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP, sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket, maupun KIE
3	08 Juni	Instalasi Farmasi, Instalasi Rekam Medis	Biru	KNC	Pasien double Nomor RM dikarenakan 2x daftar dengan penjamin yang berbeda dan salah satunya menggunakan APM.	1. Apoteker melaporkan kepada Kains untuk melakukan telusur apakah terjadi kesalahan pemberian obat
4	02 Juni	IRNA 2C	Hijau	KTC	Kesalahan dosis pemberian obat, obat yang telah diberikan kepada pasien anak karen perawat tidak double check dan ternyata belum dioplos dan obat sudah dispuut full dosis yang seharusnya pasien hanya	1. Meningkatkan pelaksanaan SPO 5 benar dalam pemberian obat

					mendapatkan $\frac{1}{4}$ dosis dari sediaan.	
5	10 Juni	IGD	Hijau	KTD	Kesalahan penulisan SBAR dengan menambahkan advice dokter lain yang tidak seharusnya sehingga menyebabkan melena	Meningkatkan ketelitian dan melakukan double check sebelum mengisi form SBAR pasien
6	16 Juni	Instalasi Gizi	Hijau	KNC	Nyaris terjadi kesalahan pemberian diet untuk pasien dengan RPD DM tapi sejak awal tidak diberikan diet DM	1. Meningkatkan ketelitian dengan melihat riwayat penyakit pasien ketika memberikan diet pasien 2. Double check riwayat penyakit pasien sebelum membagikan diet ke pasien secara langsung
7	20 Juni	Instalasi Gizi	Hijau	KTC	Kesalahan pemberian diet karena ahli gizi tidak melihat hasil lab dengan GDS tinggi, seharusnya diberikan diet DM namun ahli gizi memberikan diet TKTP RG.	1. Mengganti diet menjadi diet DM 2. Mengedukasi keluarga tentang diet DM karen GDS tinggi 3. Meningkatkan ketelitian ahli gizi untuk melihat hasil lab pasien sebelum meresepkan diet
8	29 Juni	IGD	Hijau	KNC	Perawat shift pagi salah memberikan konfirmasi pemberian obat kepada perawat shift sore	Melakukan telusur dan mengirimkan foto antara venax dan lovenox agar dapat dikonfirmasi perawat shift pagi

3.8 Indikator Mutu Pengelolaan Klaim Asuransi Kesehatan

NO	INDIKATOR MUTU	STANDAR	APRIL	MEI	JUNI
1	Waktu pengajuan klaim	< 5 Setiap Bulan	5/5/2026	5/6/2026	5/7/2026
2	% Klaim pending RJTL	< 0,5%			
3	% Klaim pending RITL	< 0,1%			
4	Klaim tidak layak RJTL	0 (Nol)			
5	Klaim tidak layak RITL	0 (Nol)			
6	Audit pasca klaim RJTL	< 1.000.000			
7	Audit pasca klaim RITL	< 5.000.000			
8	Selisih klaim RS vs INACBGs IRJA	< 50.000.000	250.986.654	209.944.648	271.881.714
9	Selisih klaim RS vs INACBGs IRNA	<100.000.000	-964.163.400	-170.866.338	- 175.909.551

3.8 Indikator Mutu Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan

NO.	INDIKATOR MUTU	STANDAR	APRIL	MEI	JUNI
1	Kesesuaian Jadwal Praktik Dokter atau Tenaga Kesehatan	Jadwal praktik 100% sesuai = 100 Jadwal praktik 60% - 99% sesuai = 75 Jadwal praktik 40% - 59% sesuai = 50 Jadwal praktik 20% - 39% sesuai = 25 Jadwal praktik <20% sesuai = 0 Tidak ada kunjungan = 100	75	75	75
2	Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan	Tidak ada pengaduan pada bulan penilaian = 100 Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & bukan merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 75 Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 50 Pengaduan tidak ditindaklanjuti atau tindak lanjut melebihi SLA = 0	50	50	50
3	Umpan Balik Peserta (Customer Feedback)	Σ responden 100% target = 100 Σ responden 75 - 99% target = 75 Σ responden 50 - 74% target = 50 Σ responden 25 - 49% target = 25 Σ responden <25% target = 0	100	100	100
4	Update Data Ketersediaan Tempat Tidur	Σ update ≥ 25 hari dan tidak ada pengaduan terkait ketersediaan kamar rawat inap = 100 Σ update ≥ 25 hari = 75 Σ update 15 - 24 hari = 50 Σ update 10 - 14 hari = 25 Σ update < 10 hari = 0	100	100	100
5	Update Jadwal Tindakan Medis Operatif	Jadwal TMO terinput setiap bulan dan terhubung dengan sistem informasi BPJS Kesehatan = 100 Tidak menginput jadwal TMO = 0	100	100	100
6	Pemanfaatan Antrean Online terintegrasi MJKN dan Waktu Tunggu Rawat Jalan	Pemanfaatan MJKN 100% target dan WTL tercapai = 100	75	75	75

		Pemanfaatan MJKN 91% - 99% target = 75			
		Pemanfaatan MJKN 81% - 90% target = 50			
		Pemanfaatan MJKN 71% - 80% target = 25			
		Pemanfaatan MJKN ≤ 70% target = 0			
7	Penerbitan Surat Kontrol	Surat Kontrol terbit >90% sesuai = 100	100	100	100
		Surat Kontrol terbit 81% - 90% sesuai = 75			
		Surat Kontrol terbit 61% - 80% sesuai = 50			
		Surat Kontrol terbit 51% - 60% sesuai = 25			
		Surat Kontrol terbit ≤50% sesuai = 0			
8	Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik	RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan, digunakan untuk dokumen pengajuan klaim dan waktu pengiriman data < 7 hari = 100	0	0	0
		RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan = 75			
		RME diimplementasikan untuk tingkat layanan rawat jalan dan rawat inap = 50			
9	% Approval SEP	<1%		0,3%	
10	Angka Capaian Iterasi	1854	74	63.00%	
11	Angka Capaian PRB	1370	23	90,68%	92,59%

3.9 Aspek Analisis Mutu Pengelolaan Klaim Asuransi

3.9.1 Klaim Pending Rawat Jalan

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	-	-	-
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	-	-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1. indikasi numpang rujukan 2. kunjungan multipoli 3. pasien dengan dx katarak masih kontrol terus. 4. px ada kunjungan 3 bln berturut2 obat yg sama, maka harusnya prb, jika belum stabil iter	1. Dilakukan sosialisasi kepada 5 SMF terbanyak (untuk penekanan rujuk antar Rumah Sakit) 2. koordinasi dengan fktp dan dpjp 3. koordinasi dengan dpjp terkait indikasi	Dilakukan Sosialisasi pada Rapat Komite medik dan dilakukan diskusi lebih intens Per SMF secara berkala

				kunjungan kontrol berulang post op katarak. 4. sosialisasi dan koordinasi dengan dpjp terkait kriteria prb	
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku			

3.9.2 Klaim Pending Rawat Inap

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis			
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan			
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1.	1.	
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	1.	1.	

3.9.3 Klaim Tidak Layak Rawat Jalan

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	-	-	-
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan	-	-	-

		& penunjang, dan administrasi keuangan			
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1. kunjungan rawat jalan dan rawat inap di hari yang sama	1. koordinasi dengan staf pelayanan terkait kunjungan dihari yang sama	Dilakukan Sosialisasi pada Rapat Komite medik dan dilakukan diskusi lebih intens Per SMF secara berkala
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-

3.9.4
Selisih klaim RS vs INACBGs IRJA

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	1. Tarif tindakan Fisioterapi dan Rawat luka, angkat jahitan yang lebih besar dari pada Inacbg's 2. Pasien DM dengan penunjang dan persepan Insulin	1. Melakukan koordinasi dengan PT terkait dengan pengelompokan tarif tindakan dan koordinasi dengan DPJP terkait pasien dengan rawat luka tatalaksana apabila sudah bisa dilanjutkan di FKTP bisa dikembalikan ke FKTP dan pembatasan pemberian obatnya 2. Melakukan koordinasi dengan DPJP terkait kriteria pemberian insulin	Setiap bulan
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan		-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-

4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-
---	--------	--	---	---	---

3.9.5 Selisih klaim RS vs INACBGs IRNA

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	Tarif tindakan yang lebih besar dari pada Inacbg's	Melakukan koordinasi dengan PT terkait dengan pengelompokan tarif tindakan, sudah ada perubahan terkait dengan pengelompokan tarif tindakan sehingga hasilnya turun tetapi terlihat menjadi selisih negatif yang sangat besar untuk tindakan naik kelas	Bulan juni
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan		-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-

3.10 Evaluasi Mutu APM

Tanggal	Jml. Kunjungan	Jml. Mobile JKN	Jml. APM	Pemanfaatan APM berdasarkan Kunjungan	Pemanfaatan APM berdasarkan Kunjungan MJKN
Januari	10.955	7.477	4.418	40%	59%
Februari	9.712	6.453	4.456	46%	69%
Maret	8.665	5.660	3.709	43%	66%
April	10.819	6.884	5.165	48%	75%

Mei	10.246	6.637	4.996	49%	75%
Juni	10.442	7.028	5.440	52%	77%

No.	Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	APM	40%	46%	43%	48%	49%	52%
2	Petugas	60%	54%	57%	52%	51%	48%
Jumlah		100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.6.1 Komite PPI

1.6.1.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

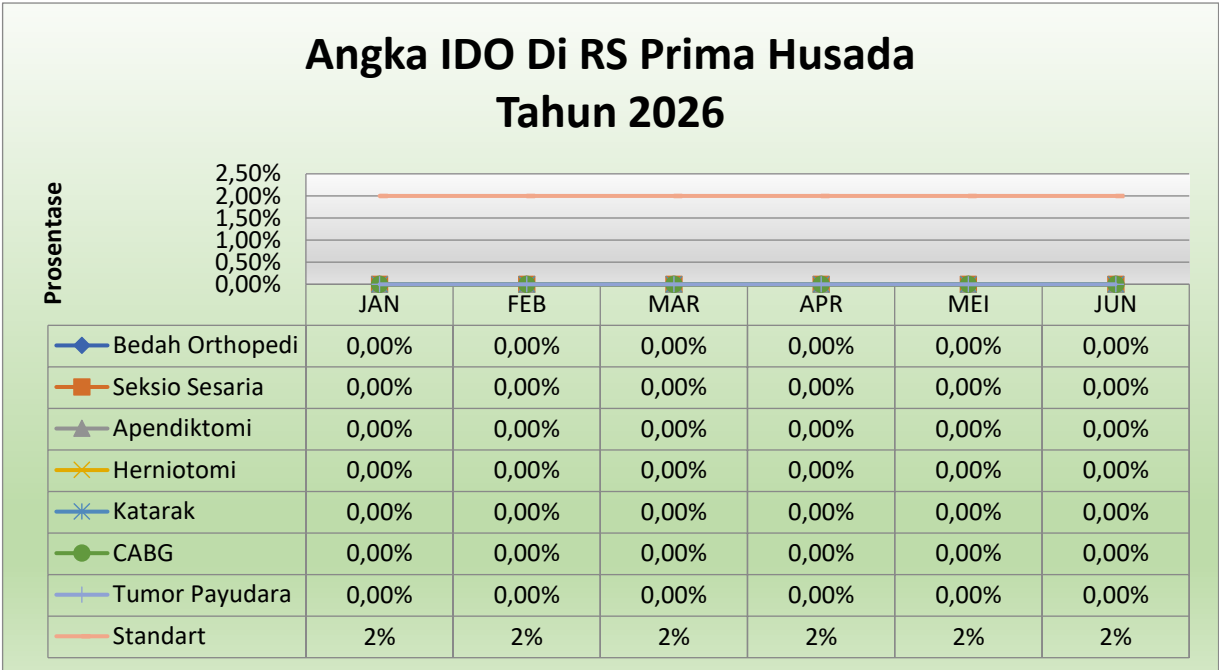
1.6.1.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

SSI 2026	Bedah Orthopedi	Seksio Sesaria	Apendiktomi	Herniotomi	Katarak	CABG	Tumor Payudara
Januari							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	88	73	6	15	46	-	13
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Februari							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	66	67	16	8	51	-	15
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Maret							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	80	76	14	7	23	-	8
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
April							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	87	69	10	11	52		21
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Mei							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	59	76	6	11	36	-	26
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Juni							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah	101	74	6	7	57	-	19

Tindakan operasi							
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Secara keseluruhan angka IDO pada masing-masing jenis tindakan operasi adalah 0%, yang menunjukkan capaian indikator berada dalam kategori baik dan telah memenuhi standar mutu pelayanan rumah sakit. Namun masih perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan under reporting.				
Masalah saat ini	Tidak ditemukan kasus IDO.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ditemukan kasus IDO sebelumnya.				
Tindakan yang dilakukan	- Monitoring rutin bundle/pencegahan SSI. - Monitoring kepatuhan Hand hygiene. - Monitoring pasien operasi dan dokumentasi rekam medis pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan).	Mempertahankan angka IDO ≤2% serta menjamin kekakuratan sistem surveilans.	Tim Bedah, perawat kamar operasi, perawat IRNA/IGD/IRJA.	- Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan). - Menjalankan audit bundle SSI dengan baik. - Menjalankan kepatuhan pemberian antibiotik profilaksis. - Meningkatkan edukasi PPI kepada tenaga kesehatan dan kepada pasien/keluarga.	Komite PPI, Kepala ruang, dokter operator, dan manajemen mutu.	Monitoring bulanan
Pertahankan bundl	Resiko IDO pada pasien berkurang/hilang.	Pasien operasi	Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu	Monitoring bulanan

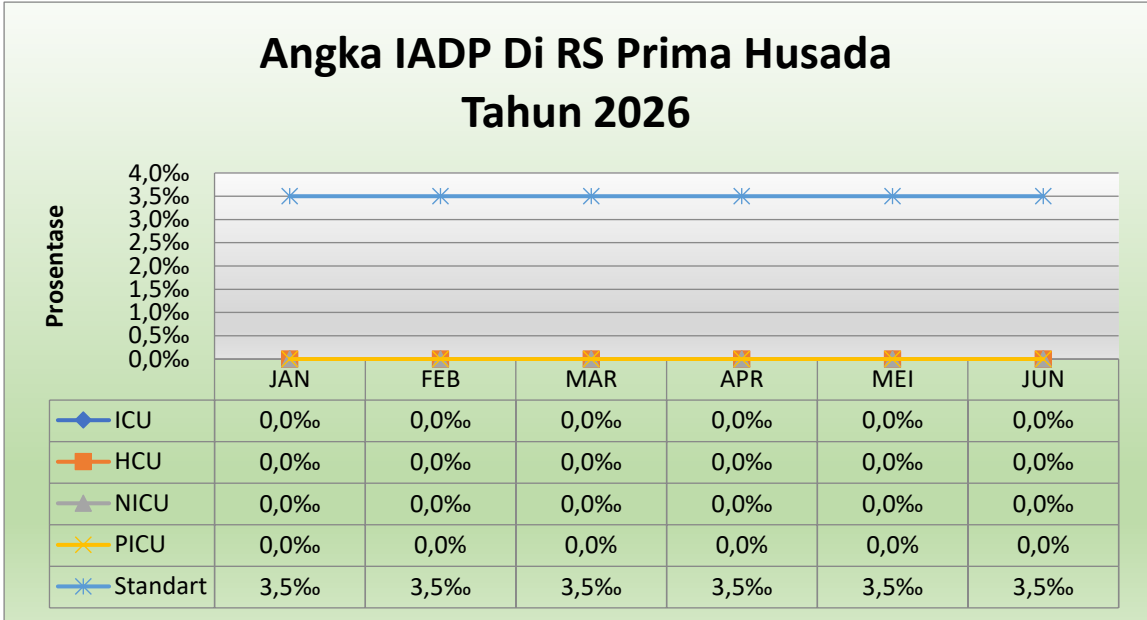
e IDO berjalan dengan baik.			mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. • Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) • Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. • Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	• IPCLN/IPC N	
• Pertahankan evaluasi pemahaman pemberian edukasi perawatan pasien pasca operasi	• Meminimalisir kesalahpahaman penangkapan terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	• Pasien post operasi.	• Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. • Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feedback) • Berikan edukasi terutama terkait pemberian diit tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka. • Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. • Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.	• Perawat /Bidan • Karu • IPCLN/IPC N	• Monitoring bulanan

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes

IADP 2026	ICU	HCU	NICU	PICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
April				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	15	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Mei				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	15	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Juni				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

3.7.8 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



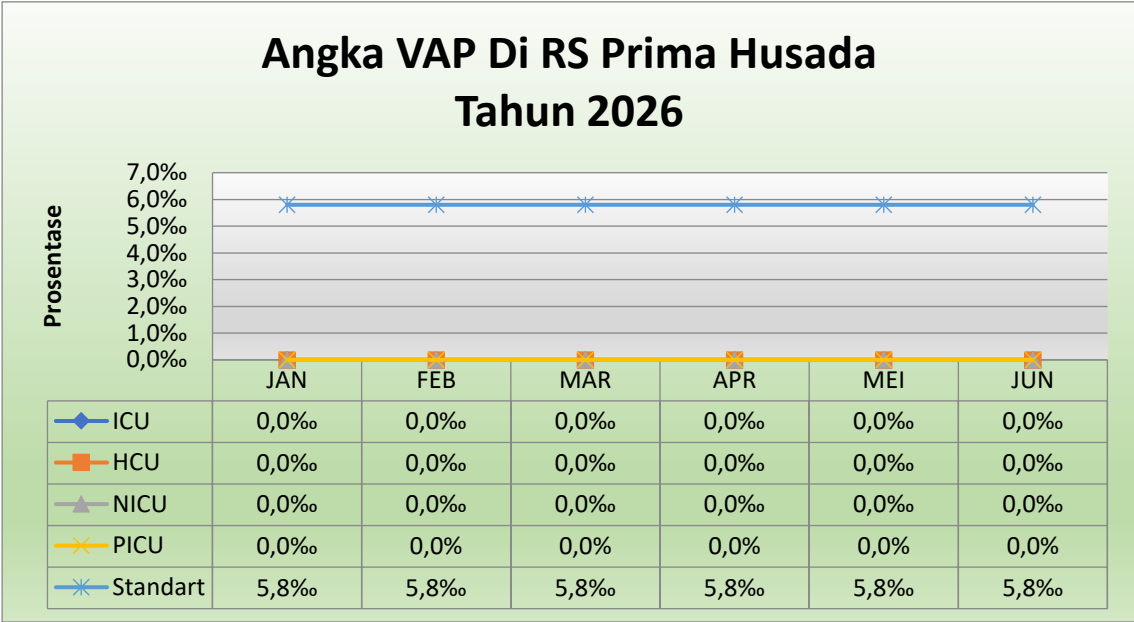
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP karena tidak ada pemasangan CVC pada bulan Juni ini.				
Masalah saat ini	Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	- Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. - Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Melakukan monitoring - perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	Pasien dengan pemakaian CVC.	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. - Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. - Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

1.6.1.1.3 VAP

1.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR
(Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

VAP 2026	ICU	HCU	PICU	NICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	86	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	78	0	12	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	98	0	60	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
April				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	160	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Mei				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	170	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Juni				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	85	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

1.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 85 hari total lama pemasangan ventilator pada 15 pasien di ICU.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. • Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. • Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. • Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. • Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	• Pasien yang terpasang ventilator mekanik	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. • Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. • Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. • Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. • Pemberian tindakan oral hygiene dengan chlorhexidine dan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

1.6.1.1.4 ISK

1.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR
(Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

ISK 2026	ICU	HCU	PICU	NICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	188	40	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	168	78	6	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	180	45	3	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
April				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	246	89	10	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Mei				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	293	61	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Juni				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	206	59	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

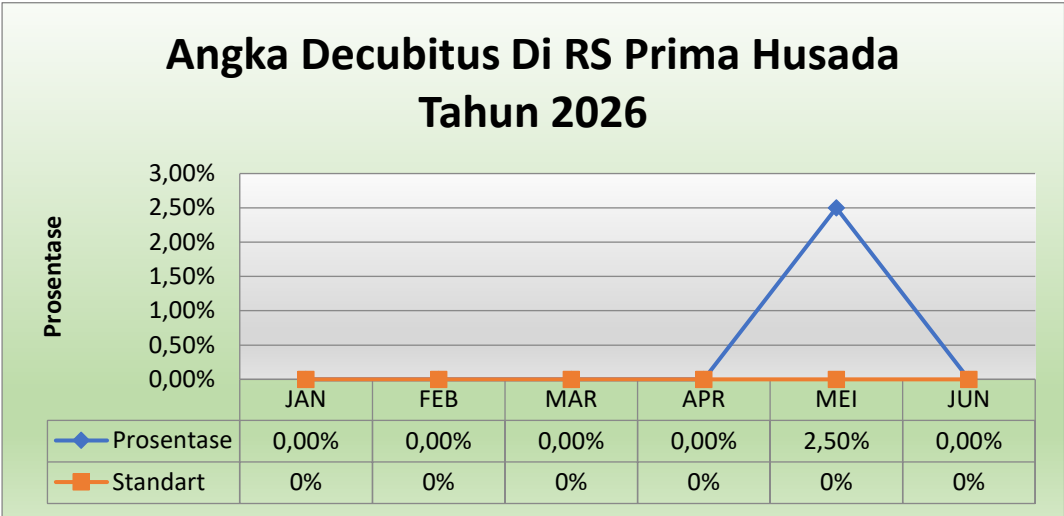
3.7.9 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1450 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. • Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. • Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. • Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	• Pasien yang terpasang kateter	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. • Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. • Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCN	• Satu bulan

1.6.1.1.5 Decubitus

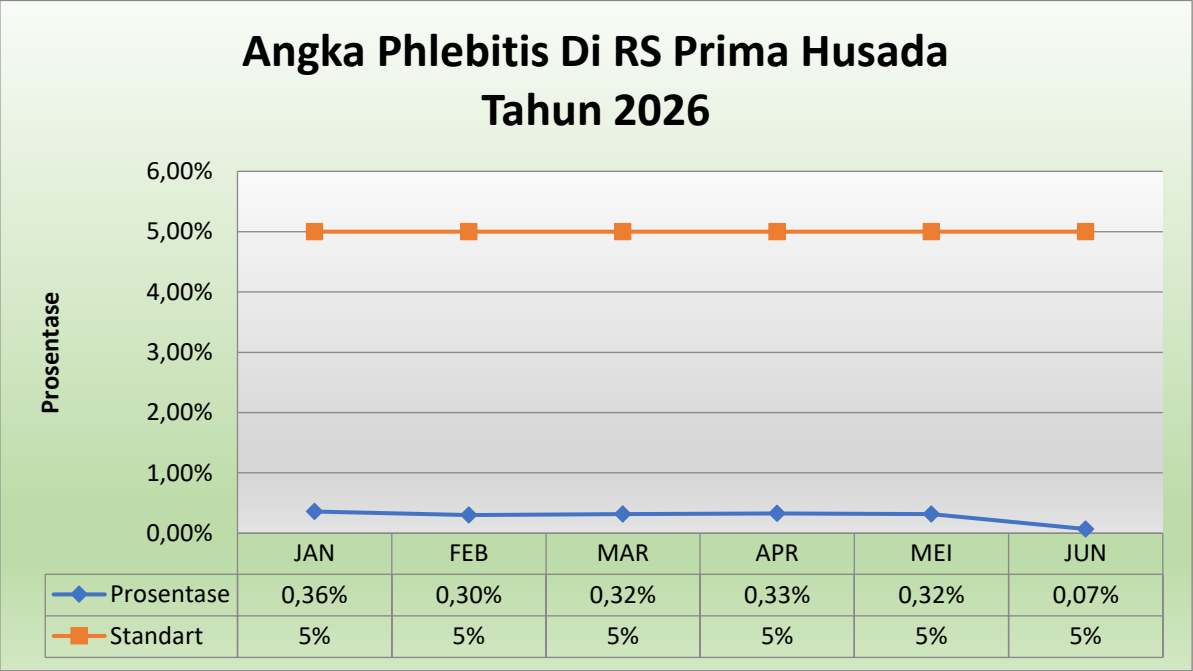
1.6.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



Analisa	Pada bulan ini ditemukan 1 kasus decubitus pada 30 pasien tirah baring lama.				
Masalah saat ini	Pasien mengalami decubitus (lecet pada area pantat) pada hari ke 5 perawatan di ruang ICU. Pencegahan decubitus kurang dijalankan dengan baik.				
Permasalahan sebelumnya	Penggunaan diapers dapat memperburuk kondisi kulit pada pasien yang tirah baring lama.				
Tindakan yang dilakukan	- Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. - Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). - Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. - Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas. - Memastikan pemenuhan nutrisi yang tepat.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	- Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. - Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). - Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain - Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. - Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/PCN	Satu bulan

1.6.1.1.6 Phlebitis

3.7.10 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

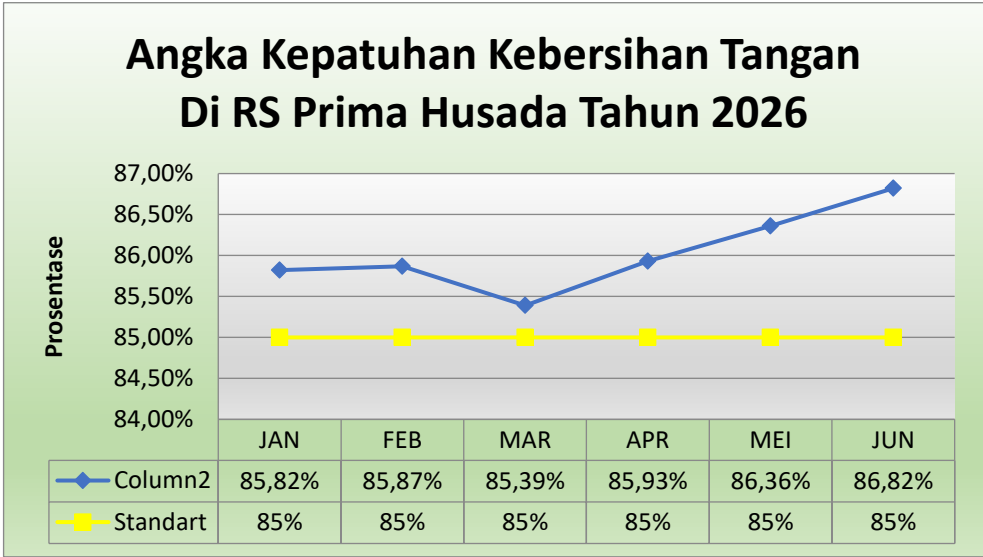


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2848 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,07%, masih memenuhi standar nasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pasien pada bulan ini mengalami penurunan dan upaya pencegahan infeksi dan perawatan akses intravena pada bulan Mei berjalan optimal. Rendahnya angka phlebitis pada perawatan infus karena adanya pelaksanaan monitoring rutin lokasi insersi. Selain itu, efektivitas kolaborasi antara Komite PPI dan Komite Keperawatan, dengan adanya pembinaan serta monitoring berkala turut berkontribusi terhadap penurunan angka phlebitis selain itu karena terjadi penurunan jumlah pasien yang terjadi pada bulan ini sehingga itu juga berpengaruh pada hasil prosentasenya. Kondisi pada bulan ini menunjukkan bahwa tindakan korektif dan penguatan kepatuhan yang telah dilakukan memberikan hasil positif. Dari data yang diperoleh terdapat 2 pasien yang mengalami phlebitis. Faktor penyebab kemungkinan besar: Obat pekat/iritatif/antibiotik, pemberian transfusi darah. Dari 13 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	Penggunaan cairan pekat, antibiotik masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah.				
Permasalahan sebelumnya	- Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. - Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.				
Tindakan yang dilakukan	- Mengkoordinasikan dengan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. - Memberikan edukasi pada pasien setelah pemasangan infus terutama pada pasien yang beresiko tinggi phlebitis karena faktor internal. - Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. - Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. - Menganjurkan perawat untuk terus mengingatkan edukasi tambahan terkait perawatan saat terpasang infus.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	- Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. - Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. - Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. - Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. - Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. - Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

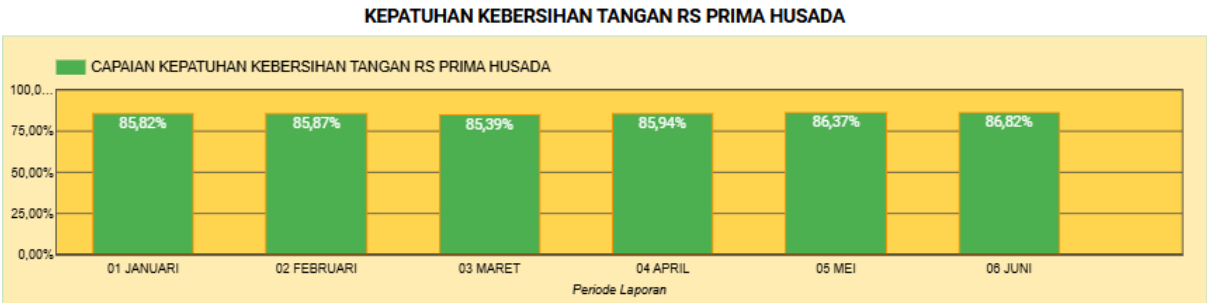
• Pengendalian Penggunaan Obat Iritatif.	• Mengurangi resiko phlebitis karena pemberian obat pekat/iritan.	• Perawat/bidan • Apoteker	• Mewajibkan pengenceran adekuat sesuai standar farmasi. • Laju infus dikontrol untuk antibiotik dan obat pekat. • Koordinasi dengan Instalasi Farmasi untuk memberikan label “Obat Iritatif – Perlu Pengenceran”.	• Perawat /Bidan • Apoteker • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan
• Perbaikan Proses Pemasangan & Perawatan Infus	• Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	• Perawat/bidan	• Re-education SOP pemasangan infus (vena besar, hindari area fleksi). • Pelatihan ulang teknik aseptik untuk perawat yang belum mandiri memamsang infus. • Audit kepatuhan perawatan VAP & manajemen infus setiap bulan. • Checklist harian pemeriksaan lokasi infus oleh perawat jaga.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Tiga bulan

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

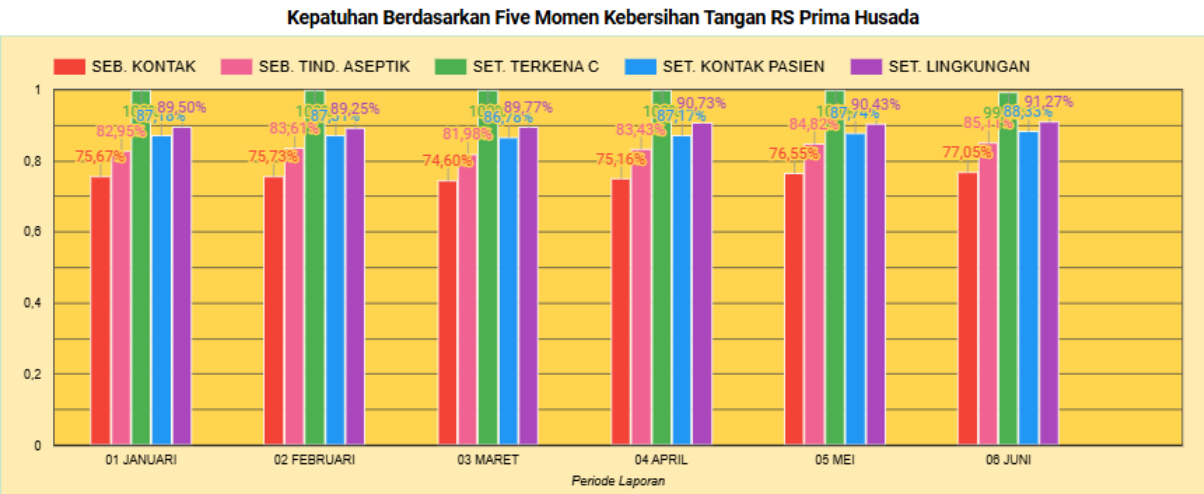
3.7.11 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

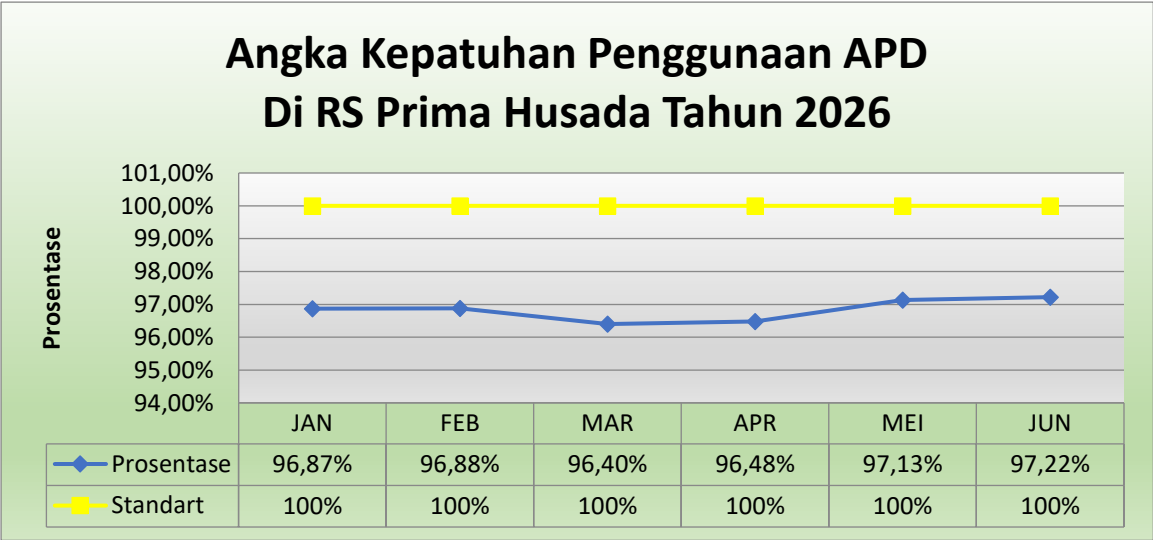


Analisa	Nilai kepatuhan hand hygiene bulan Juni 2026 berada sedikit di atas standar (selisih 1,96%). Meskipun masih memenuhi standar, terjadi sedikit peningkatan kepatuhan, yang berarti ada sedikit peningkatan kedisiplinan atau konsistensi dalam penerapan cuci tangan. Tren ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan motivasi ulang kepada tenaga kesehatan agar tingkat kepatuhan terus meningkat. Nilai kepatuhan terhdap 6 langkah cuci tangan pada bulan ini: 84,06%. Nilai ini lebih tinggi sedikit dibanding bulan sebelumnya (Mei 2026: 83,10%). Artinya, meskipun tenaga kesehatan mencuci tangan, kemungkinan masih belum melakukan seluruh 6 langkah dengan benar. Peningkatan sedikit ini bisa mencerminkan peningkatan perhatian terhadap teknik yang benar dan penurunan proses audit cuci tangan karena kebanyakan dari staf akan melakukan sesuai standar saat diamati, seharusnya sudah menjadi kebiasaan untuk budaya cuci tangan dengan 5 momen dan 6 langkah yang tepat, bukan hanya frekuensi mencuci tangan saja. Pelaksanaan 5 momen cuci tangan di bulan ini sudah cukup baik, namun perlu fokus peningkatan pada momen sebelum kontak pasien melalui edukasi dan reminder visual di area perawatan. Selain itu dengan adanya program "PPI Quick Tips" diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.				
Masalah saat ini	• Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata.				
Permasalahan sebelumnya	• Ketidakonsistenan dalam melakukan 5 momen cuci tangan. • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal.				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. • Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien. • Meningkatkan penerapan program "PPI Quick Tips" untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Peningkatan kepatuhan 5 momen cuci tangan	• Meningkatkan kepatuhan 5 momen cuci tangan	• Seluruh perawat dan tenaga kesehatan di unit pelayanan	• Sosialisasi ulang 5 momen cuci tangan • Edukasi teknik 6 langkah melalui refresh training • Pemasangan poster & reminder visual di area strategis	• Komite PPI • Karu	• 1 bulan

• Peningkatan konsistensi praktik cuci tangan	• Meningkatkan konsistensi praktik kebersihan tangan	• Seluruh staf unit pelayanan	• Audit kepatuhan mingguan • Feedback langsung hasil observasi • Monitoring ketersediaan sarana (handrub, wastafel, sabun)	• Komite PPI • IPCN • Karu	• Mingguan
• Peningkatan kepatuhan 6 langkah cuci tangan	• Meningkatkan ketepatan teknik 6 langkah cuci tangan	• Perawat • Tenaga Kesehatan lainnya	• Simulasi praktik langsung saat supervisi • Supervisi saat jam pelayanan • Evaluasi melalui checklist observasi	• IPCN • IPCLN • Karu	• Mingguan
• Peningkatan kepatuhan kebersihan tangan saat tidak diamati.	• Mengurangi kepatuhan semu karena observer effect	• Seluruh staf	• Observasi acak tanpa pemberitahuan • Penguatan budaya keselamatan pasien koordinasi dengan komite PMKP • Kampanye internal "Hand Hygiene is Safety" jika diperlukan	• Komite PPI • Komite PMKP	• Berkala
• Peningkatan program kebersihan tangan	• Meningkatkan keberlanjutan program kebersihan tangan	• Unit pelayanan	• Implementasi rutin program "PPI Quick Tips" • Reward bagi unit dengan kepatuhan terbaik • Rapat evaluasi bulanan	• Komite PPI • Manajemen RS	• Setiap bulan

2.6.1.1.8 Kepatuhan APD

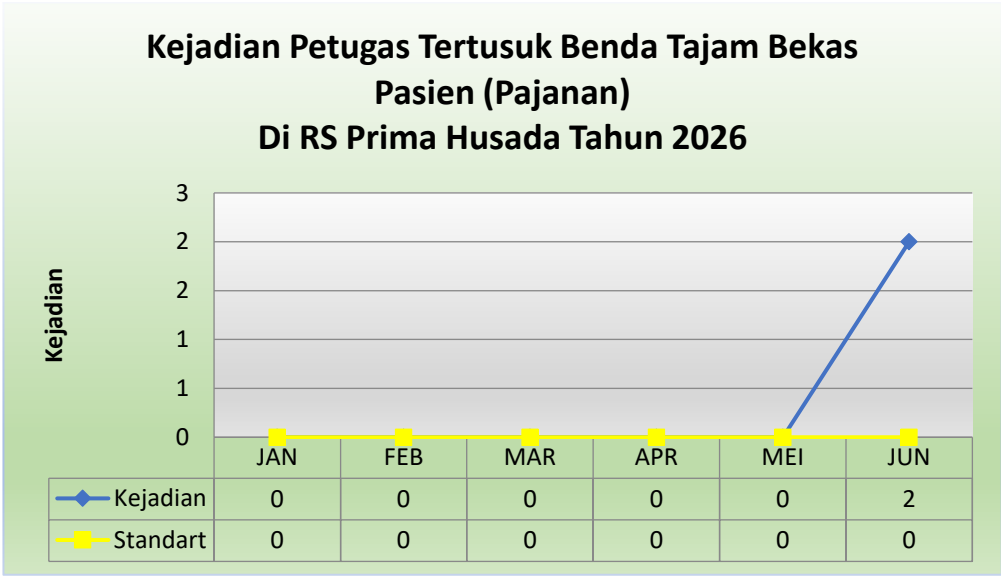
3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas



Analisa	Kepatuhan penggunaan APD masih berada di bawah standar 100%, dengan hasil pada bulan ini 97,22%. Artinya, meskipun staf menggunakan APD, masih terdapat petugas yang tidak tepat atau tidak sesuai indikasi pemakaian APD. Terjadi peningkatan sedikit pada bulan ini, menunjukkan adanya: peningkatan perilaku penggunaan APD, meningkatnya kesadaran staf, atau bertambahnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Nilai tetap belum mencapai standar 100%, sehingga masih ada: ketidakpatuhan dalam penggunaan APD lengkap dan juga pemakaian APD yang berlebihan sehingga dianggap tetap tidak patuh. Perubahan perilaku belum konsisten penggunaan APD masih dipengaruhi faktor situasional, bukan kebiasaan yang terbentuk secara kuat.
Masalah saat ini	• Masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD, baik penggunaan APD yang tidak lengkap maupun penggunaan APD berlebihan yang tidak sesuai indikasi. • Pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata. • Kebiasaan kerja lama masih mempengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten. • Monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan di seluruh unit.
Permasalahan sebelumnya	• Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.
Tindakan yang	• Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya.

dilakukan	• Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. • Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Peningkatan Kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	• Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	• Seluruh tenaga kesehatan	• Sosialisasi ulang standar penggunaan APD sesuai indikasi	• Komite PPI, IPCN	• 1 bulan
• Peningkatan pemahaman staf terkait APD	• Meningkatkan pemahaman staf tentang penggunaan APD yang tepat	• Perawat dan tenaga kesehatan	• Edukasi dan refresh training terkait indikasi dan jenis APD	• IPCN • Kepala Ruangan	• 1–2 bulan
• Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar	• Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	• Seluruh staf unit pelayanan	• Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	• Setiap bulan
• Menurunkan kebiasaan penggunaan APD yang tidak sesuai	• Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	• Tenaga kesehatan di unit pelayanan	• Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Kepala Ruangan • IPCN • Komite PMKP	• Berkelanjutan
• Kontroling ketersediaan APD	• Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	• Unit pelayanan	• Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	• Komite PPI • Farmasi	• Setiap bulan

3.6.1.1.9 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam
3.6.1.1.9.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Pada bulan Juni ini ditemukan 2 kejadian tertusuk jarum bekas pasien pada petugas kebersihan dan perawat IGD.				
Masalah saat ini	• Ditemukan 2 kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan lalu.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengingatkan untuk melakukan penyuntikan yang aman dan pengolahan benda tajam yang baik dan benar. • Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja. • Menyarankan membawa safety box atau wadah khusus untuk langsung membuang jarum/benda tajam setelah tindakan. • Melakukan pemilahan sampah yang benar, terutama benda tajam. • Menggunakan APD yang sesuai untuk meminimalisir resiko pajanan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU

• Pertahankan proses penyuntikan yang aman dan pengelolaan benda tajam yang baik.	• Menurunkan kejadian pajanan sesuai dengan standar 0 kejadian.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. • Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. • Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. • Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. • Monitoring teknik recapping tutup jarum.	• Seluruh petugas pelayanan di RS.	• Satu bulan
---	---	--	---	--	--

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

Unit	Target	Apr	Mei	Juni	%	MANDOK	Keterangan
IRNA 2C	4x/Bulan	100%	50%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 2C Mencapai Target
ICU/HCU	4x/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	Lampiran B	ICU/HCU Tidak mencapai target
IRNA 3C	4x/Bulan	100%	100%	0%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 3C Tidak Mencapai target
MATERNITAS	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	MATERNITAS Mencapai Target
PERINATOLOGI	4x/Bulan	100%	100%	75%	Tercapai	Lampiran B	PERINATOLOGI Tidak Mencapai Target
IRNA 5C	4x/Bulan	0%	0%	25%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 5C Tidak Mencapai Target
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	50%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 2A,3A,4A Mencapai Target
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 6A,7A,8A Mencapai target
IGD	4x/Bulan	100%	100%	50%	Tercapai	Lampiran B	IGD Tidak Mencapai Target
FARMASI	4x/Bulan	100%	75%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	FARMASI Mencapai target
GIZI	4x/Bulan	50%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	Gizi Mencapai Target
IRJA	4x/Bulan	100%	75%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRJA Mencapai Target

- ANALISIS** : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Juni Tahun 2026, Tim PKRS telah melaksanakan edukasi dan mencapai target, beberapa Unit belum mencapai target dan perlu ditingkatkan, berikut: ICU/HCU,IRNA 3C, Perinatologi, IGD, IRNA 5C, FARMASI dan IRJA.
- RTL** : Menyampaikan kepada KARU unit yang belum tercapai untuk mengejar ketertinggalan edukasi, edukasi dilakukan di bulan Juni.

3.6.3.2 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	APR	MEI	JUNI	%	MANDOK	KET
Forum Kesehatan Usia Lanjut (F-KUL) Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Yoga Lansia	2xBulan	Yoga	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hynoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	

General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	0%		Tidak Tercapai	-	
Pembinaan Fatayat	1X/Tahun							

3.6.3.3 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

Unit	Target	Apr	Mei	Juni	%	Bukti di Form Edukasi Terintegrasi atau kolaborasi	Ket
PONEK	4X/Bulan	25%	100%	75%	Tercapai	√	
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	50 %	100%	Tidak Tercapai	√	
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	

ANALISIS : Bulan Juni Penyuluhan PROGNAS belum tercapai, berikut HIV, KB, PONEK, TB
RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

3.6.4 Tim Prognas

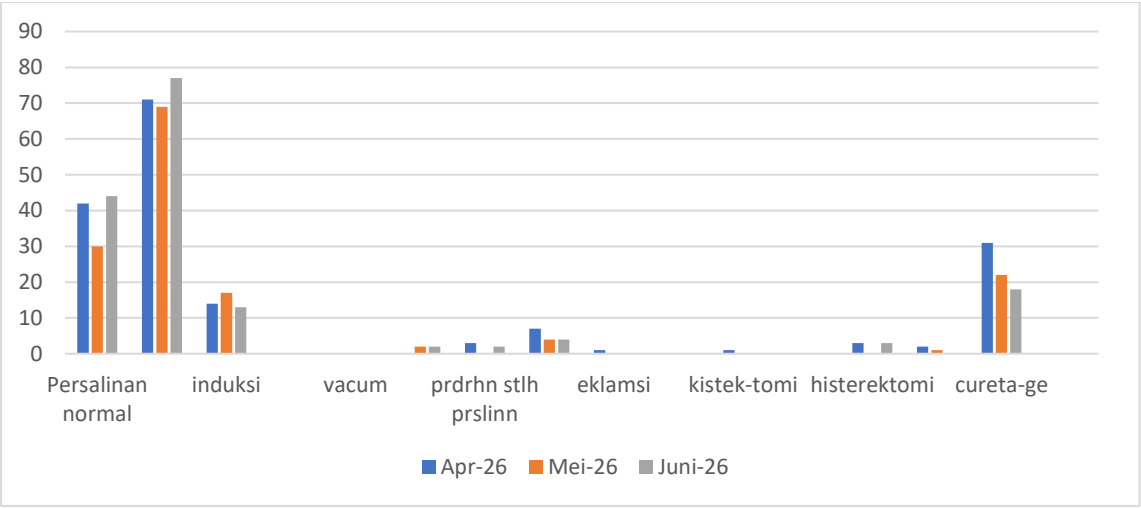
3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Juni 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	42	30	44
	b. <i>SectioCaesaria</i>	71	69	77
2				
	a. Induksi / Drip	14	17	13
	b. Sungsang	0	0	0
	c. Vacuum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	0	2	2
	b. Perdarahan setelah Persalinan	3	0	2
	c. Pre Eklamsi	7	4	4
	d. Eklamsi	1	0	0
	e. Infeksi	0	0	0
4				
	a. Curretage	31	22	18

b. Kistektomi	1	0	0
c. Miomektomi	0	0	0
d. Histerectomy	3	0	3
e. KET	2	1	0

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

1. Pada jenis persalinan normal pada bulan Juni 2026 yaitu 44 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 30 pasien , sedangkan bulan April 2026 yaitu 42 pasien
2. Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Juni 2026 yaitu 77 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 69 pasien, sedangkan bulan April 2026 yaitu 71 pasien
3. Pasien terbanyak yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas SC, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya, CPD atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distres. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi SC cito.
4. Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Juni 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Juni 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
5. Induksi/ Drip pada bulan Juni sebanyak 13 pasien, menurun dibandingkan bulan Mei sebanyak 17 pasien, dan April 2026 yaitu 14 pasien. Ini disebabkan kontraksi pasien inpartu sudah adekuat sehingga tidak perlu diberikan tambahan induksi/drip.
6. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Juni sama dengan bulan mei 2026 yaitu 4, sedangkan bulan April 2026 yaitu 7 kasus.
7. Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah eklamsi. Pada bulan Juni dan Mei 2026 yaitu 0 kasus, menurun dibandingkan dengan bulan April 1 kasus.
8. Jenis pelayanan curretage di bulan Juni 2026 yaitu 18 kasus, menurun jika dibandingkan dengan Mei 2026 yaitu 22 kasus, sedangkan bulan April 2026 yaitu 31 pasien. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa

plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hyperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

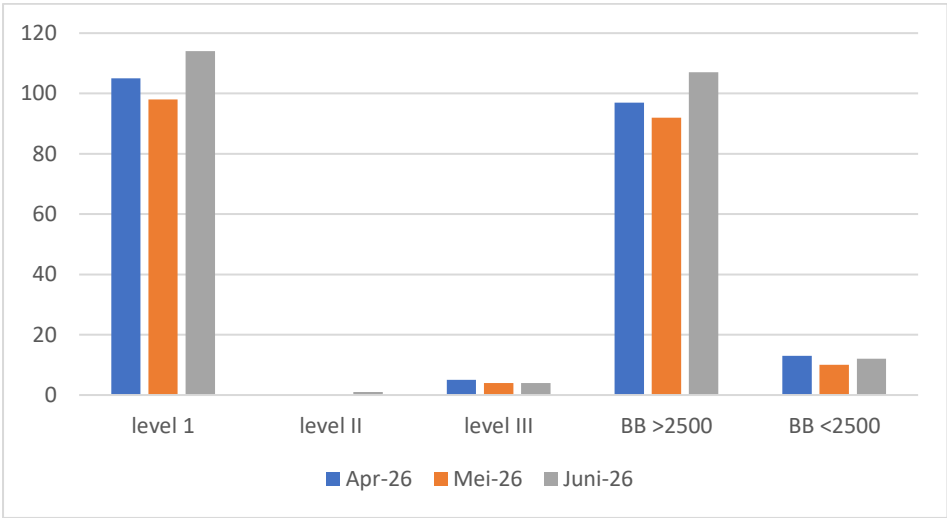
- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.
- 5) Melakukan edukasi kepada pasien ANC untuk melakukan senam hamil

3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponek Juni 2026

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2026	BULAN MEI 2026	BULAN JUNI 2026
1				
	a. Level 1/ rawat gabung	105	98	114
	b. Level II/ rujukan dari luar	0	0	1
	c. Level III/NICU	5	4	4
2				
	a. BB ≥ 2500 gram	97	92	107
	b. BB ≤ 2500 gram	13	10	12

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Juni 2026



Analisis :

- 1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1/ rawat gabung di bulan Juni 2026 yaitu 114 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 98 pasien , sedangkan April 2026 yaitu 105 pasien.
- 2. Pada pelayanan level 2 / rujukan dari luar pada bulan Juni 1 pasien, meningkat dibandingkan bulan Mei dan April 2026 yaitu 0 pasien.

3. Pada pelayanan level 3 pada bulan Juni sama dengan bulan Mei yaitu 4 pasien, sedangkan bulan April yaitu 5 pasien.
4. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah BB >2500 gram di bulan Juni 2026 yaitu 107 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 92 pasien, sedangkan bulan April 2026 yaitu 97 pasien
5. Jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Juni 2026 yaitu 12 pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 10 pasien, dan April 2026 yaitu 13 pasien. Ini disebabkan karena masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.7.12 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponpek April 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
1	ANC	485	371	482

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Juni 2026



Analisis :

- 1) Berdasarkan data kunjungan Ante Natal Care (ANC), Pada bulan Juni, jumlah kunjungan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 482 kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan Mei, terjadi peningkatan sebanyak 111 kunjungan atau sekitar 29,9%. Peningkatan kunjungan pada bulan Juni menunjukkan adanya perbaikan cakupan pelayanan antenatal care setelah penurunan yang

terjadi pada bulan Mei. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pelayanan dan promosi kesehatan kepada ibu hamil mulai memberikan hasil yang positif.

- 2) Secara keseluruhan, tren kunjungan ANC pada periode April- Juni 2026 menunjukkan kecenderungan meningkat. Meskipun demikian, evaluasi dan pemantauan secara berkala tetap perlu dilakukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah kunjungan ANC sehingga seluruh ibu hamil memperoleh pelayanan sesuai standar.

Rencana dan Tindak Lanjut :

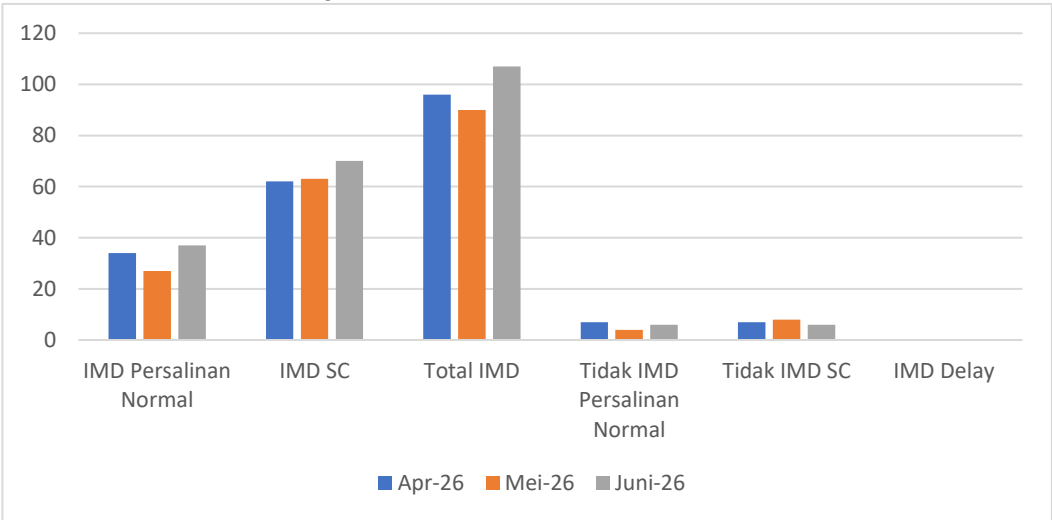
- 1. Melakukan promosi kesehatan terkait pemeriksaan ANC di dokter spesialis Obgyn
- 2. Melakukan Promosi layanan ANC risiko tinggi
- 3. Melakukan Program kelas ibu hamil

3.7.13 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Mei 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	IMD Persalinan Normal	34	82,9%	27	87%	37	86,1%
52	IMD SC	62	89,9%	63	88,7%	70	92,1%
3	Total IMD	96	87,3%	90	88,2%	107	89,9%
4	Tidak IMD Persalinan Normal	7	17,1%	4	12,9%	6	13,9%
5	Tidak IMD SC	7	10,1%	8	11,2%	6	7,9%
6	IMD Delay	0	0%	0	0%	0	0%
	Total Kelahiran Normal	41		31		43	
	Total Kelahiran SC	69		71		76	
	Total kelahiran	110		102		119	

Grafik Jumlah Pelayanan IMD di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

1. Pada bulan Juni 2026 jumlah IMD persalinan normal yaitu 37 (86,1%) pasien, meningkat di dibandingkan bulan Mei yaitu 27 (87%) pasien pasien sedangkan bulan April yaitu 34 (82,9%) pasien Bayi.

2. Sedangkan IMD pada kelahiran SC pada bulan Juni yaitu 70 (92,1%) pasien, meningkat sedikit dibandingkan dengan bulan Mei yaitu 63 (88,7%) pasien, dan bulan April 62 (89,9%) pasien.
3. Kejadian tidak dilakukan IMD pada persalinan normal bulan Juni yaitu 6 (13,9%) pasien, meningkat dibandingkan bulan Mei yaitu 4 (12,9%), sedangkan bulan April yaitu 7 (17,1%)
4. Kejadian tidak dilakukan IMD pada kelahiran SC bulan Juni 2026 yaitu 6 (7,9%) pasien, menurun dibandingkan bulan Mei 2026 yaitu 8 (11,2%) pasien sedangkan bulan April 2026 yaitu 7 (10,1%),
5. Bayi yang tidak dilakuan IMD dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD dikarenakan membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti bayi BBL dengan perawatan infant warmer, bayi dengan pemakaian CPEP.
6. Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Juni 2026

	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
Persalinan Normal			
	Ny Eka Safitri	NKB + BBLSR	Inkubator + CPEP
	Ny Hartantri	Imatur + BBLASR	Infarn Warmer
	Ny Fitri Ardianingsih	NKB + BBLR	Cuvis
	Ny Julia Decha	NCB + BBLR	Infarn Warmer
	Ny Zurotun	NCB + Ibu HBSAG reaktif	Infarn warmer
	Ny Ni'matus	NCB + Ibu HBSAG reaktif	Infarn Warmer
SC			
	Ny Regita Puspita	NCB + BBLR	Cuvis
	Ny Ragil Sahita	NKB + BBLSR + Neonatal Hipoglikemi	Cuvis
	Ny Luthfia Zulfa 1	NKB + BBLR	Cuvis
	Ny Luthfia Zulfa 2	NKB + BBLR	Cuvis
	Ny Diah Irmawati	Dyspnew + BBLR	Inkubator + CPEP
	Ny Putri F	NKB + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP

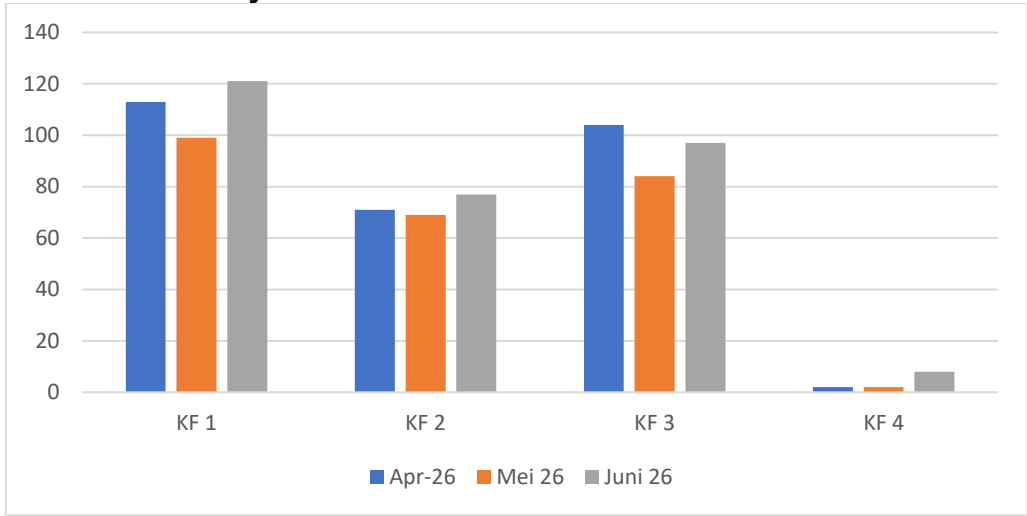
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusu dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak
2. Mempertahankan Konsistensi Pelaksanaan IMD
3. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan IMD
4. Edukasi sejak ANC tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif.

3.7.14 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Mei 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	KF 1 (6-4 jam)	113	100%	99	100%	121	100%
2	KF2: 3–7 hari	71	62,%	69	69,6%	77	63,6%
3	KF 3 (8- 28 hari)	104	92%	84	84,8 %	97	80,2%
4	KF4: 29–42 hari)	2	2,1%	2	2%	8	6,6%
	Σ kelahiran Normal	42		30		44	
	Σ kelahiran SC	71		69		77	
	Total kelahiran	113		99		121	

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

1. Dari tabel dan grafik 3.3.6 Kunjungan PNC KF 1 pada bulan Juni yaitu 121 pasien (100%), pada bulan Mei yaitu 99 pasien (100%), sedangkan pada bulan April yaitu 113 pasien (100%), ini artinya semua pasien post partum melakukan kunjungan pada KF1
2. Pada kunjungan KF 2 pada bulan Juni yaitu 77 pasien (63,6%), pada bulan Mei yaitu 69 pasien (69,6%), sedangkan pada bulan April yaitu 67 pasien (71,2%), capaian KF 2 belum 100% di karenakan pasien post partum normal hari ke 2 sudah diijinkan pulang dan jadwal kontrol ulang hari ke 8 pasca rawat inap.
3. Pada kunjungan KF 3 pada bulan Juni yaitu 97 pasien (80,2%) pada bulan Mei yaitu 84 pasien (84,8%) sedangkan pada bulan April yaitu 104 pasien (92%) capaian KF 3 belum 100% di karenakan masuk laporan bulan sebelumnya atau bulan setelahnya.
4. Pada kunjungan KF 4 pada bulan Juni yaitu 8 pasien (6,6%), sedangkan pada bulan Mei dan April yaitu 2 pasien (2,1%), %, pada KF 4 cakupan hanya sedikit di karenakan pasien post partum dan post SC setelah kunjungan KF 3 pasien tidak ada komplikasi untuk pemantauan di kembalikan ke faskes 1, pasien KF 4 yang masih bisa di layani di faskes 2 dikarenakan ada masalah seperti infeksi luka operasi atau infeksi jahitan perenium, Tekanan Darah pasien tinggi, evaluasi sisa selaput ketuban.

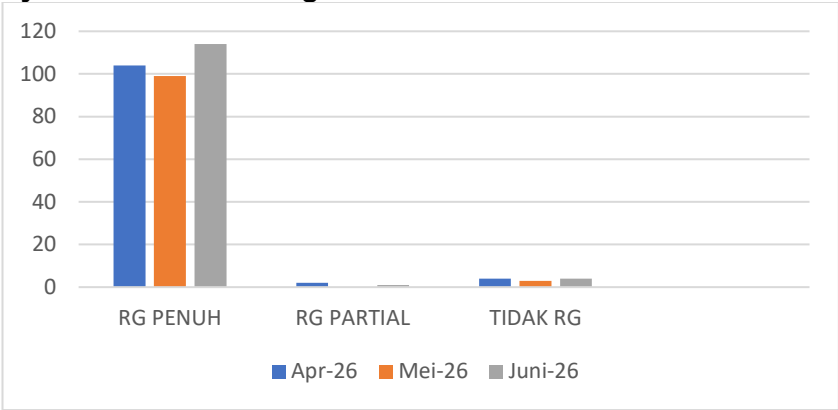
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Melakukan Edukasi pasien dan keluarga Jadwal kontrol nifas sesuai jadwal
2. Melakukan edukasi tanda bahaya nifas
3. Melakukan edukasi pentingnya KB pasca salin
4. Melakukan edukasi pemantauan nifas KF 4 di faskes 1

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponpek Juni 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	Rawat gabung penuh	104	94,5%	99	97 %	114	95,8%
2	Rawat gabung partial	2	1,8%	0	0%	1	0,8%
3	Tidak Rawat gabung	4	3,6%	3	2,9%	4	3,4%
Σ Kelahiran		110	-	102	-	119	-

Grafik Pelayanan Rawat Gabung di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

- Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Juni 2026 yaitu 114 (95,8%) bayi meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 99 (97%) bayi, sedangkan bulan April 2026 yaitu 104 (94,5%) bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Juni 2026 yaitu 4 (3,4%) bayi, menurun jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 3 (2,9%) bayi, dan April 2026 yaitu 4 (3,6%).
- Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
By Ny Eka Safitri	NKB + BBLSR	Inkubator + CPEP
By Ny Hartantri	Imatur + BBLASR	Infarn Warmer
By Ny Putri F	NKB + BBLSR + RDS	Inkubator + CPEP
By Ny Diah Irmawati	Dyspnew + BBLR	Inkubator + CPEP

- Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

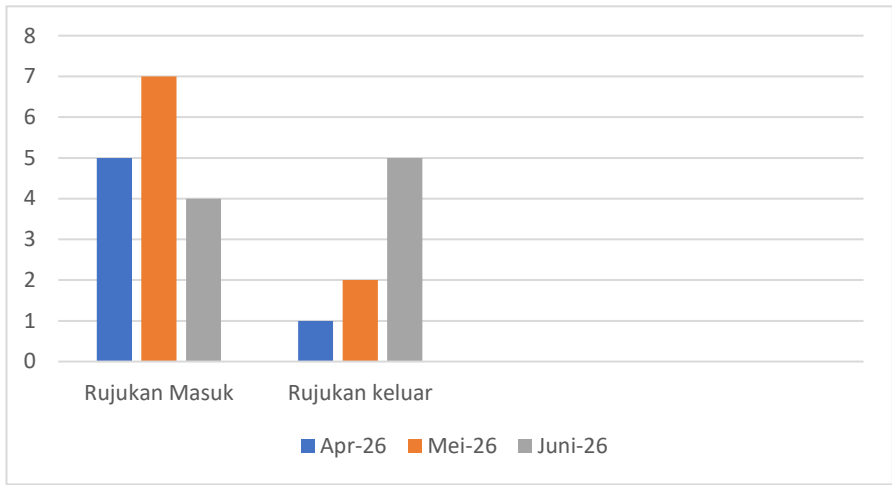
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Setelah kondisi bayi stabil segera dilakukan rawat gabung atau kontak ibu-bayi.
- 2. Fasilitasi ibu untuk memerah ASI sedini mungkin (1–2 jam setelah persalinan)
- 3. Kunjungan ibu ke ruang perinatologi / NICU (jika memungkinkan)
- 4. Pelaksanaan **Kangaroo Mother Care (KMC)** pada bayi BBLR yang sudah stabil.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponek Juni 2026

Rujukan	Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
Rujukan Masuk	5	7	4
Rujukan keluar	1	2	5

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Evaluasi :

- 1. Jumlah rujukan masuk pada bulan Juni 2026 menurun yaitu 4 rujukan, sedangkan pada bulan Mei 2026 menurun yaitu 7 rujukan, dan bulan April 2026 menurun yaitu 5 rujukan
- 2. Jumlah rujukan keluar pada bulan Juni 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 5 rujukan, sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 2 rujukan, dan April 2026 sebanyak 1 rujukan rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM, Puskesmas, Klinik dan RS setempat untuk bekerja sama.
- 2. Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponek Juni 2026

Bulan April 2026			
1	Ny Chusna W	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KIFA	PKM Singosari
2	NY Dwi Oktavianti	G4 P0000 Ab300 UK 38-39 minggu dengan KET	RSUD Lawang
3	Ny Siti fatonah	G2 P1001 Ab000 UK 37-38 minggu dengan Kala 2 + letsu	PMB Lilik

4	Ny Darwati	Syok hipovolemik ec AUB ec Mioma uteri	PKM Lawang
5	Ny Nina	G1 P0000 Ab000 UK 41-42 minggu dengan Kala 2	PKM Jabung
Bulan Mei 2026			
1	Ny Muspita Sari	G4 P2002 Ab100 UK 18-20 minggu dengan IUFD	KRI Putra Husada
2	Ny Sari Kurnia	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Vio Eka	G1 P0000 Ab000 UK 40 minggu dengan impending ekamsia	Klinik Mutiara Sehat
4	Ny Siti Muyassyaroh	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KPD	PMB Munawaroh
5	Ny Alfiah	G1 P0000 Ab000 UK 36-37 minggu dengan letsu + partus prematurus + KIFA + IUGR + PER	PMB Titik S
6	Ny Sofi Andini	G3 P1001 Ab100 UK 38-39 minggu dengan KPD + KIFA	PMB Lilik Agustina
7	Ny Anita	G5 P4004 Ab000 UK 10-12 minggu dengan abortus inkomplit	PMB Titik Idmawanti
Bulan Juni 2026			
1	Ny Cindy Lailia	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 minggu dengan KPD	Klinik Mutiara Sehat
2	Ny Tanti W	G2 P0000 Ab100 UK 36-37 minggu dengan KPD	PMB Wahyu Dewi
3	Ny Hernindya	G2 P0000 Ab100 UK 37-38 minggu dengan KIFA	Klinik Divisi 2 kostrad
4	Ny Ananda Rahma	PMB Lilik Agustina	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan KIFA + CPD

3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponек Juni 2026

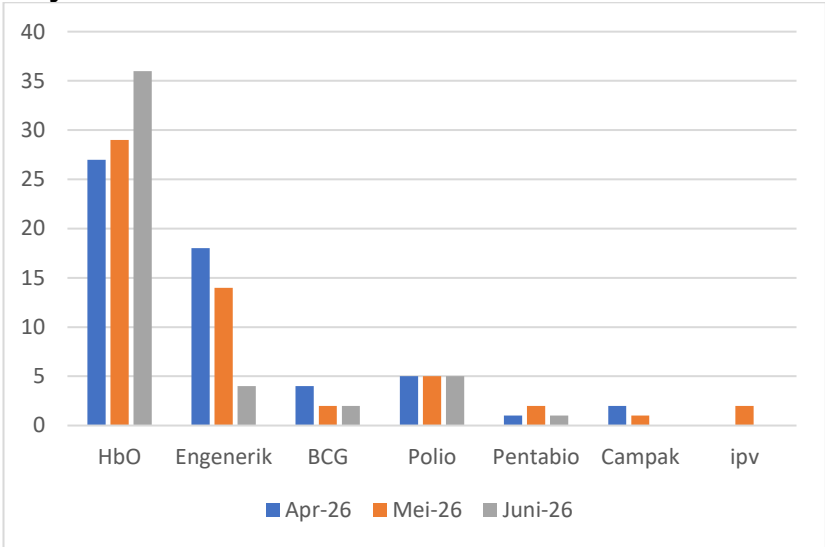
No	Nama	Usia	Unit	Diagnosa	Alasan Rujukan	Tujuan Rujukan
Bulan April 2026						
1	By Ny sufiati	1 hari	NICU	RDS ok HMD DD neonatal Pneumonia, BBLASR	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
Bulan Mei 2026						
1	By Ny Miratus	0 hari	NICU	NKB + BBLR + RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + pro surfaktan	RS Saiful Anwar
2	By Ny Hindun	4 hari	NICU	Obs distres nafas ok Neonatal Pneumonia dd MAS, susp congenital anomaly dd achondroplasia	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
Bulan Juni 2026						
1	Ny Syaidah	25 th	Maternitas	G2 P1001 Ab000 UK 10-12 minggu dengan HEG + Hematomesis	Pro Rawat bersama SP.PD-KGEH	RS Saiful Anwar
2	By Ny Endang	1 hari	NICU	NCB + RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
3	By Ny Weni	3 hari	NICU	NKB	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + Spesialis bedah anak	RS Saiful Anwar
4	By Ny Eka	1 hari	NICU	NKB + BBLSR	Pro Sub Spesialistik	RS Pantі Nirmala

	Safitri				Neonatologi + pro surfactan	
5	By Ny Putri	2 hari	NICU	NKB + BBLSR + RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + pro surfactan	RS Saiful Anwar

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Juni 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	HbO	27	23,9%	29	28,4%	36	30,2%
2	Engerix Junior	18	15,9%	14	13,7%	4	3,3%
3	BCG	4	-	2	-	2	-
3	Polio	5	-	5	-	5	-
4	Pentabio	1	-	2	-	1	-
5	Campak	2	-	1	-	0	-
6	IPV	0	-	2	-	0	-
	Σ Kelahiran	113		102		119	

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

1. Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Juni 2026 yaitu 36 (30,2%) pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2026 yaitu 29 (28,4%) pasien, sedangkan pada bulan April 2026 yaitu 27 (23,9%), dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari atau pembelian vaksin Engerix Junior dengan edukasi Biaya Umum
2. Pada bulan Juni ada 4 (3,3%) bayi yang menggunakan vaksin Engerix Junior, menurun dibandingkan pada bulan Mei ada 14 (13,7%) bayi, sedangkan bulan April ada 18 (15,9%) bayi, Penggunaan vaksin Engerix Junior ini dikarenakan banyak nya bayi baru lahir yang tidak mendapatkan vaksin Hbo disebabkan persediaan Hbo yang sedikit, sehingga ditawarkan untuk pembelian Vaksin Engerix Junior.
3. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Juni dan April 2026, sedangkan bulan Mei 2026 sebanyak 2 2026 dan Maret tidak ada.
4. Ada 2 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Juni dan Mei 2026, dan menurun dibandingkan dengan April yaitu 4 bayi.

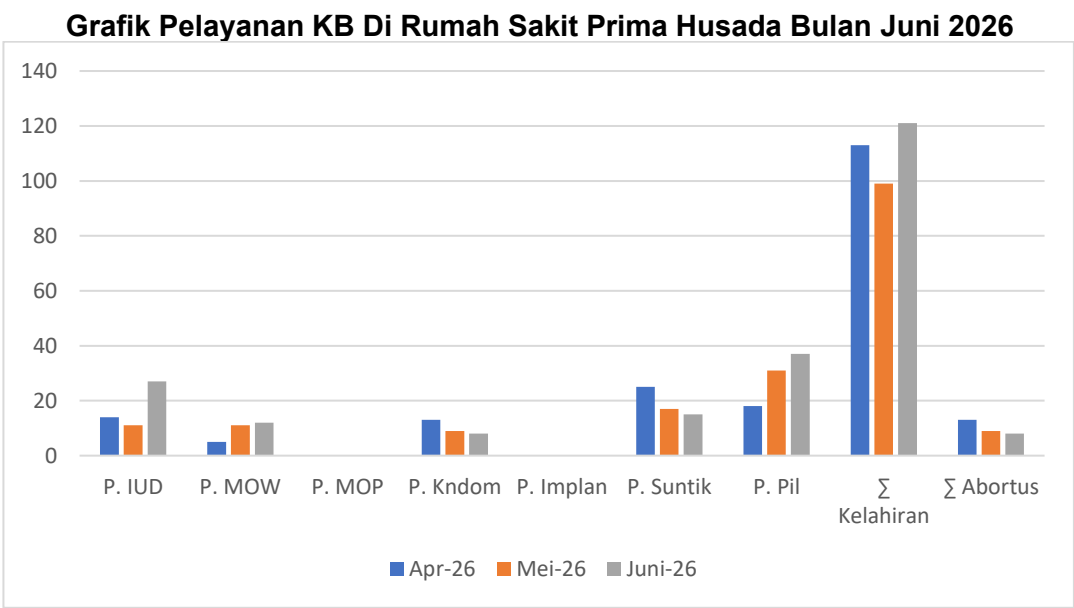
5. Tidak ada bayi yang Imunisasi Campak bulan Mei 2026, sedangkan bulan Mei ada 1 bayi, dan April ada 2 bayi.
6. Ada 5 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Juni dan 2 bulan sebelumnya
7. Ada 1 bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan Juni dan April 2026, sedangkan pada bulan Mei ada 2 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

Rencana dan Tindak Lanjut

1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponpek Juni 2026

No	Jenis	Jumlah Pasang					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	IUD	14	12,4%	11	11,1%	27	22,3%
2	MOW	5	4,4%	11	11,1%	12	9,9%
3	MOP	0	-	0	-	0	-
4	Kondom	13	100%	9	100%	8	100%
5	Implant	0	-	0	-	0	-
6	Suntikan	25	-	17	-	15	-
7	Pil	18		31		37	-
8	Σ Kelahiran	113		99		121	
9	Σ Abortus	13		9		8	



Analisis :

1. Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Juni 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 27 (22,3%) akseptor, pada bulan Mei yaitu 11 (11,1%) sedangkan pada bulan April 14 (12,4%) Pemakaian IUD pasca salin dengan cakupan sedikit dikarenakan ada biaya jasa dokter 400.000 untuk IUD coper T, dan biaya IUD nova T 850.000.
2. Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Juni 2026 sebanyak 12 (9,9%) pasien, sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 11 (11,1%) dan bulan April 2026

sebanyak 5 (4,4%), pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.

- 3. Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Juni 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 8 pasien, sedangkan pada bulan Mei 2026 yaitu 9 pasien dan pada bulan April 2025 sebanyak 13 pasien.
- 4. Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Juni 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 37 pengguna, sedangkan pada bulan Mei 2026 yaitu 31 pengguna, dan bulan April 2026 sebanyak 18 pengguna.
- 5. Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Juni menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 15 pengguna, sedangkan bulan Mei 2026 yaitu 17 pengguna, dan bulan April 2026 sebanyak 25 pengguna.

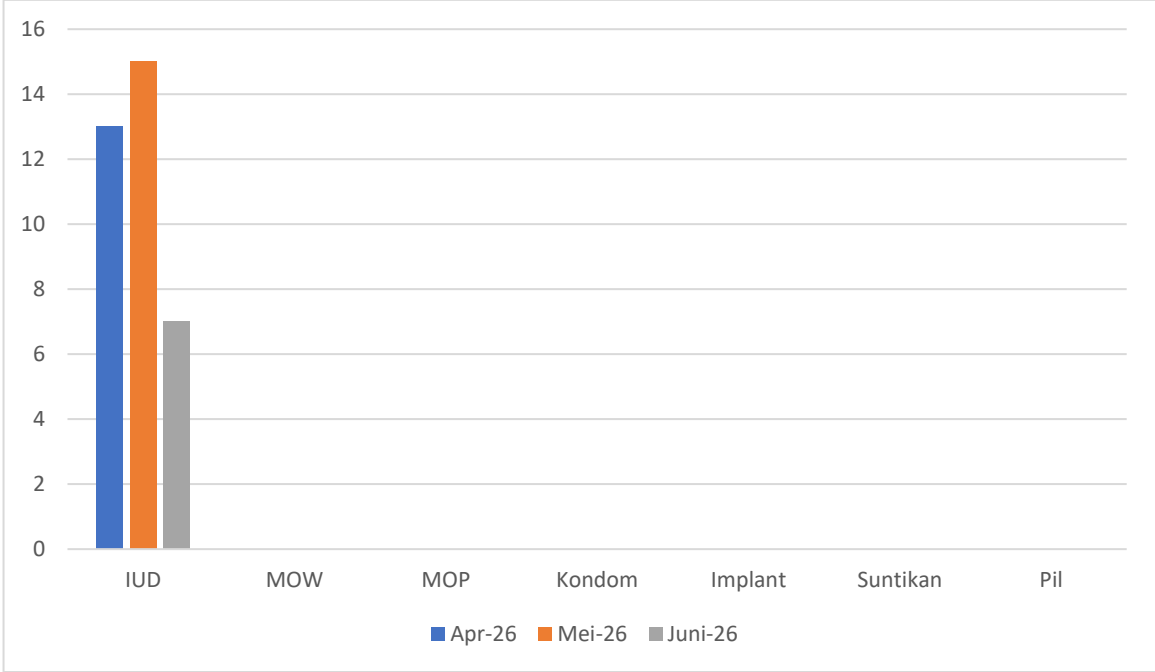
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

Pelayanan Pelepasan KB di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2026

No	Jenis	Jumlah Lepas		
		April 2026	Mei 2026	Juni 2026
1	IUD	13	15	7
2	MOW	0	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0

Grafik Pelayanan KB di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

- 1. Pelepasan KB IUD pada bulan Juni 2026 meningkat yaitu 7 Akseptor, sedangkan pada bulan Mei 2026 yaitu 15 Akseptor, dan bulan April 2026 yaitu 13 Akseptor,
- 2. Pelepasan KB Implan pada bulan Juni 2026 dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut :

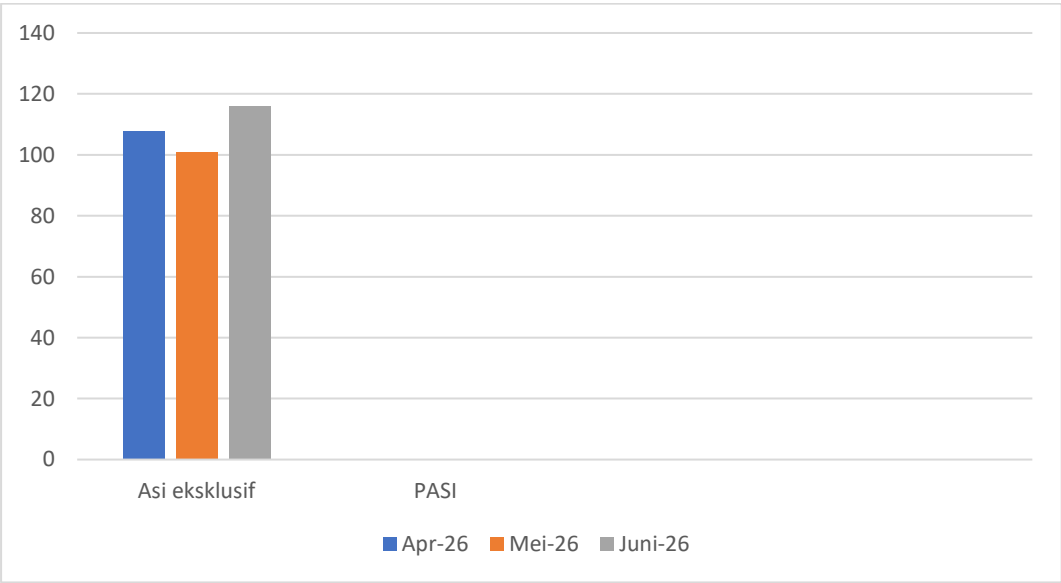
Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Juni 2026

No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien					
		Bulan April 2026	%	Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%
1	Asi eksklusif	108	100%	101	100%	116	97,5%
2	PASI	0	0%	0	0%	0	0%
3	Puasa	2		1		3	2,5%
Σ kelahiran		110	-	102	-	119	

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

- 1. Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Juni yaitu 116 (97,5%) bayi, pada bulan Mei yaitu 101 (100%) bayi, sedangkan April 2026 yaitu 108 (100%) bayi, Pemberian ASI belum memenuhi target yaitu 100% Hal ini dikarenakan ada bayi yang puasa dikarenakan
- 2. Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan April dan 2 bulan sebelumnya. Bayi yang menggunakan susu formula pada bayi dengan kondisi tertentu, dan atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

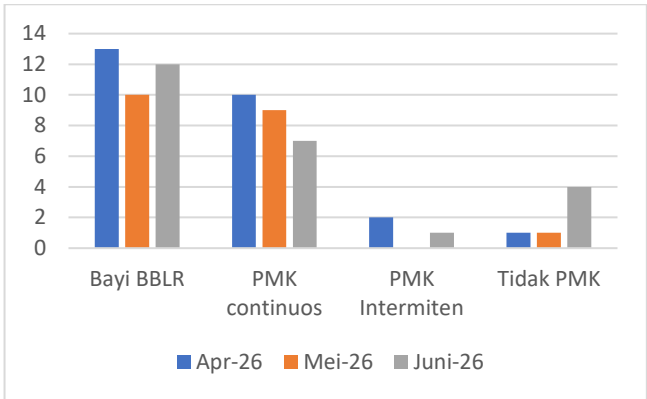
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Edukasi ASI eksklusif sejak antenatal
- 2. Melakukan konseling laktasi oleh dokter, bidan dan perawat

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kangguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Juni 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
1	Bayi BBLR	13	10	12
2	PMK continuos	10	9	7
3	PMK Intermiten	2	0	1
4	Tidak PMK	1	1	4

Grafik Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Juni 2026



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK kontinuus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500 gram.
- 2. Ada 1 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Juni 2026, sedangkan pada bulan Mei tidak ada , dan April 2026 ada 2 bayi.
- 3. Sedangkan metode PMK kontinuus pada bulan Juni 2026 sebanyak 7 bayi, sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 9 bayi , dan April sebanyak 10 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil.
- 4. Ada 4 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Juni 2026, sedangkan pada bulan Mei dan April ada 1 bayi. Hal ini dikarenakan bayi dengan diagnosa NKB, BBLR , dyspnew dan RDS dan bayi di rujuk ke RS lain.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku
- 2. Memberikan edukasi kepada orang tua bayi untuk melakukan PMK

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN			KET
		APRIL	MEI	JUNI	
1.	Pemberian Masker pada Pasien Suspek TB/ Non TB	0	0	0	
2	Pemberian Masker pada Keluarga TB+	0	0	1	
3	Pemberian masker Pasien TB+ yang lupa membawa Masker/Perilaku tidak berubah	0	0	0	

Evaluasi :

- 1. Pada bulan April 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 2. Pada bulan Mei 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 3. Pada bulan Juni 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker

Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker

2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.1 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi

3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis
Bulan April 2026

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	01/04/2026	36 th	-	Positif	Positif	-
2	07/04/2026	24 th	-	Positif	Positif	-
3	08/04/2026	49th	-	Negatif	Positif	-
4	10/04/2026	71th	-	Positif	Positif	-
5	13/04/2026	76th	-	Negatif	Positif	-
6	14/04/2026	74th	-	Positif	Positif	-
7	25/04/2026	2th	Negatif	-	Negatif	Positif
8	29/04/2026	61th	-	Negatif	Positif	-
9						
10						
11						
12						
13						
	Total		1	4	7	1

3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis
Bulan Mei 2026

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	04/05/2026	28th	-	Negatif	Negatif	Positif
2	06/05/2026	42th	-	Negatif	Positif	-
3	07/05/2026	74th	-	Positif	Positif	-
4	14/05/2026	1th	Negatif	-	Negatif	Positif
5	28/05/2026	20th	-	Positif	Negatif	-
6						
7						
8						
9						
10						
	Total			2	2	2

**3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis
Bulan Juni 2026**

No	Pelaksanaan	usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	02-06-2026	3th	Positif	-	Negatif	-
2	08-06-2026	50th	-	Positif	Negatif	-
3	09-06-2026	43th	-	Positif	Positif	-
4	16-06-2026	55th	-	Negatif	Positif	-
5	18-06-2026	58th	-	Positif	Positif	-
6	22-06-2026	28th	-	Positif	Positif	-
7	22-06-2026	25th	-	Negati	Negati	Positif
8	26-06-2026	20th	-	Positif	Positif	-
9						
10						
11						
12						
13						
	Total	8	1	5	5	1

Analisis :

1. Pada bulan April 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 22 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negatif sejumlah 14 pasien
2. Pada bulan Mei 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 5 pasien dan pasien negative 29 pasien
3. Pada bulan Juni 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negative 28 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.1 Penemuan Kasus TB

No	Unit	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Poli Paru	5	2	4
2	Poli Bedah			
3	Poli IPD			1
4	Poli Anak	1	1	1
5	Irna 2C			
6	ICU		1	
7	IGD			
8	Irna 2A			
9	Irna 3C anak			
10	Irna 3A			
11	Irna 4A			
12	Maternitas 4C			

13	Irna 5C	2	1	2
14	Irna 6A			
15	Irna 7A			
16	Irna 8A			
	Total	8	5	

- Analisis :**
1. Pada bulan April 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 22 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negatif sejumlah 14 pasien
 2. Pada bulan Mei 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 5 pasien dan pasien negative 29 pasien
 3. Pada bulan Juni 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negative 28 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:
 Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB di faskes terdekat.

3.1.2.2.2 Jumlah Kunjungan Pasien TB

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			Jumlah Total Pasien TB
		April	Mei	Juni	Total
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	63	49	47	159
2	Pasien RFC (OAT Protolan)	0	4	3	7
3	Pasien RFT	8	5	8	21

- Analisis:**
1. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC di bulan April mencapai 63 pasien, di bulan Mei 49 pasien, dan di bulan Juni 0 pasien.
 2. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFC di bulan Mei 0 pasien, di bulan Mei 4 pasien dan di bulan Juni 3 pasien.
 3. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFT di bulan April 8 pasien, di bulan Mei 5 pasien dan di bulan Juni 8 pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.3 Pemberian Obat Pencegahan

No	Pemberian Obat Pencegahan	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Sasaran keluarga pasien yang kontak dengan pasien TB	8	5	8

Analisis :
 Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB keluarga wajib melakukan skrining di faskes terdekat agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH).
- 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun dan dewasa yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB.

3.1.2.2.4 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		APRIL	MEI	JUNI
1.	Pemberian imunisasi BCG	4	2	2

Evakuasi :

- 1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 4 pasien yang diimunisasi pada bulan April
- 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Mei
- 3. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Juni

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.5 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan April 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny.I	V		
		Ny.H	V		
		Tn. R	V		
		Tn. I	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Ny. S	V		
		Ny.K	V		
		Tn.D	V		
3.	dr. Fiona Paramitha. Sp.A				
3.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed	An. A	V		

3.1.2.2.6 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Mei 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny.D	V		
		Tn. A	V		

2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Tn. NP	V		MENINGGAL SEBELUM PENGOBATA N
		Tn. B	V		
3.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed				
4.	dr. Ratih.Sp.A.M.Biomed	An. A	V		

3.1.2.2.7 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Juni 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny. S	V		
		Ny. R	V		
		Ny. ET	V		
		Tn. A	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Ny. T	V		
		Ny. N	V		
3	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed	An. B	V		
4.	Dr. Farid, Sp.N	Ny. N	V		

Analisis :
 Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.7 Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker N95	100%	100%	
2	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker bedah	100%	100%	
3	Kepatuhan Staf menggunakan APD Gaun/Skort	100%	100%	

Analisis:
 Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.8 Penempatan Pasien TB

No	Penempatan Paien TB	Jumlah Pasien		
		April	Mei	Juni
1.	Penempatan pasien TB IGD	100%	100%	

2	Penempatan pasien TB Poli Paru	100%	100%	
3	Penempatan pasien TB di IRNA 5c	100%	100%	

Analisis:
 Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang IGD isolasi untuk di ruang IGD, di Poli TB untuk pasien TB dan Ruang Isolasi 5c untuk Pasien irna isolasi. hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.9 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Juni 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Juni	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Ny. T	V	-	1	PKM Lawang	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
	Poli Paru	Ny. N	V	-	1	PKM Kendal Kerep	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli Saraf	Ny. N	V	-	1	PKM Polowijen	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

Analisis :
 Pada bulan Juni 2026 terdapat 3 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya

Rencana dan Tindak Lanjut :
Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.10 Stok OAT

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			ED
		April	Mei	Juni	
1.	OAT Anak	3	2	5	01/27
2.	OAT Harian Dewasa	10	4	7	11/26
3.	Ethambutol 250 mg	0	0	300	0
4.	Ethambutol 400 mg	0	0	0	0
5.	Pirazinamid 500 mg	632	632	632	05/27
6.	Isoniazid 300 mg	404	304	204	08/26
7.	Rimfapicin 450 mg	1082	1082	620	03/28
8.	Rimfapicin 300 mg	0	0	0	0

Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.11 Pasien Paru dan Ekstra Paru

No	Jenis TB	Jumlah Pasien					
		April		Mei		Juni	
		Anak	Dewasa	Anak	Anak	Dewasa	Anak
1.	Pasien paru	0	7	0	3	6	1
2.	Pasien Ekstra paru	1	0	1	1	1	0

- Evaluasi :**
- 1. Pada bulan April 2026 terdapat 1 pasien ekstra paru dan 7 pasien paru
 - 2. Pada bulan Mei 2026 terdapat 2 pasien ekstra paru dan 3 pasien paru
 - 3. Pada bulan Juni 2026 terdapat 1 pasien ekstra paru dan 7 pasien paru

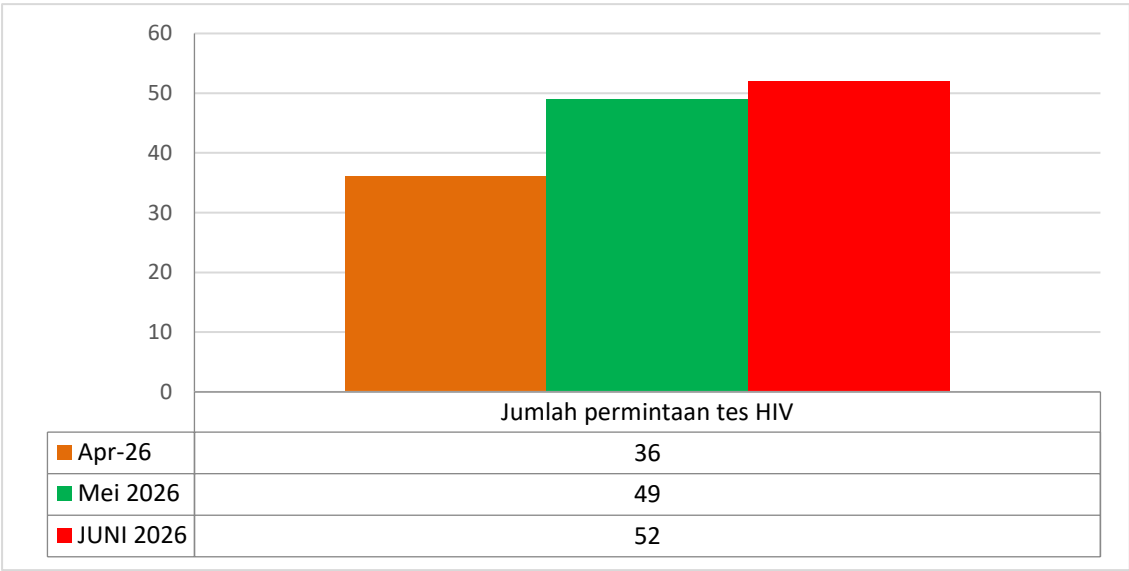
Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama pada pasien ekstra paru

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	Permintaan Test HIV	36	49	52

**Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Juni 2026**



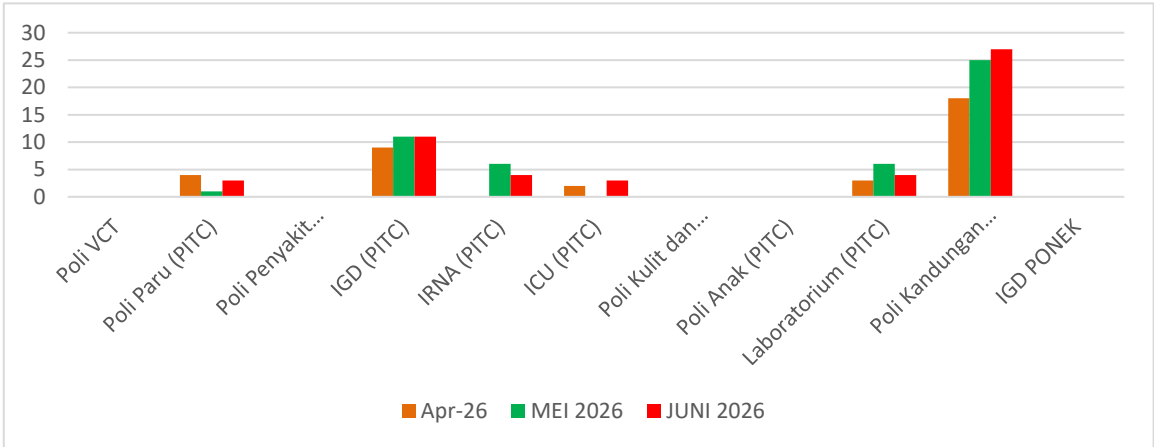
Analisis :
 Jumlah permintaan pelayanan HIV mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Pada Bulan April 2026 sebanyak 36 pemeriksaan, pada bulan Mei 2026 sebanyak 49 pemeriksaan sedangkan pada bulan juni 2026 sebanyak 5 pemeriksaan yang berasal dari Asal permintaan test diantaranya dari poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, Poli kandungan, IGD, IGD PONEK, IRNA, dan ICU.

Rencana Tindak Lanjut :
 Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.15 Asal Permintaan Tes HIV

NO	UNIT / KLINIK ASAL PERMINTAAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru (PITC)	4	1	3
3	Poli Penyakit Dalam (PITC)	0	0	0
4	IGD (PITC)	9	11	11
7	IRNA (PITC)	0	6	4
8	ICU (PITC)	2	0	3
9	Poli Kulit dan kelamin (PITC)	0	0	0
10	Poli Anak (PITC)	0	0	0
11	Laboratorium (PITC)	3	6	4
	Total PITC	18	24	25
12	Poli Obgyn (PMTCT)	18	25	27
13	IGD PONEK	0	0	0
	Total PMTCT	18	25	27
	Total PITC + PMTCT	36	49	52

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

1. Unit Asal permintaan Yang meminta pelayanan HIV PADA Triwulan 2 tahun 2026 diantaranya dari poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, Poli kandungan, IGD, IGD PONEK, IRNA, dan ICU.
2. Jumlah tertinggi permintaan pelayanan pemeriksaan HIV di triwulan 2 tahun 2026 yaitu dari poli Kandungan pada bulan juni 2026 sebanyak 27 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV dan pemeriksaan triple eliminasi.
3. Jumlah terendah permintaan pelayanan pemeriksaan HIV di triwulan 2 tahun 2026 yaitu dari poli VCT yaitu 0 tidak ada permintaan. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS
4. Poli terendah permintaan pelayanan pemeriksaan HIV yaitu dari poli VCT bisa dilakukan peningkatan permintaan pemeriksaan pelayanan HIV dengan dilakukanya edukasi terkait pentingnya screening HIV
5. Unit yang masuk PITC diantaranya, poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, IGD, IRNA dan ICU dengan jumlah total di di bulan Juni 2026 sebanyak 25 pasien. Sedangkan yang masuk PMTCT diantaranya poli kandungan dan IGD PONEK dengan jumlah total di di bulan Juni 2026 sebanyak 27 pasien

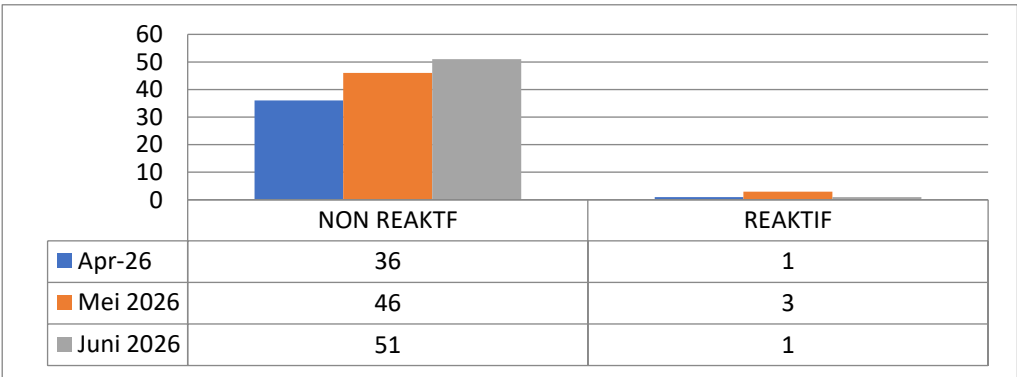
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	Non Reaktif	36	46	51
2	Reaktif	1	3	1

Grafik Status HIV Juni 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada bulan April 2026 terdapat 1 pasien dengan HIV reaktif yang berasal dari ICU isolasi. pada bulan Mei terdapat 1 pasien dengan HIV reaktif yang berasal dari IRNA Sedangkan pada bulan Juni 2026 terdapat 1 pasien dengan HIV reaktif yang berasal dari IGD

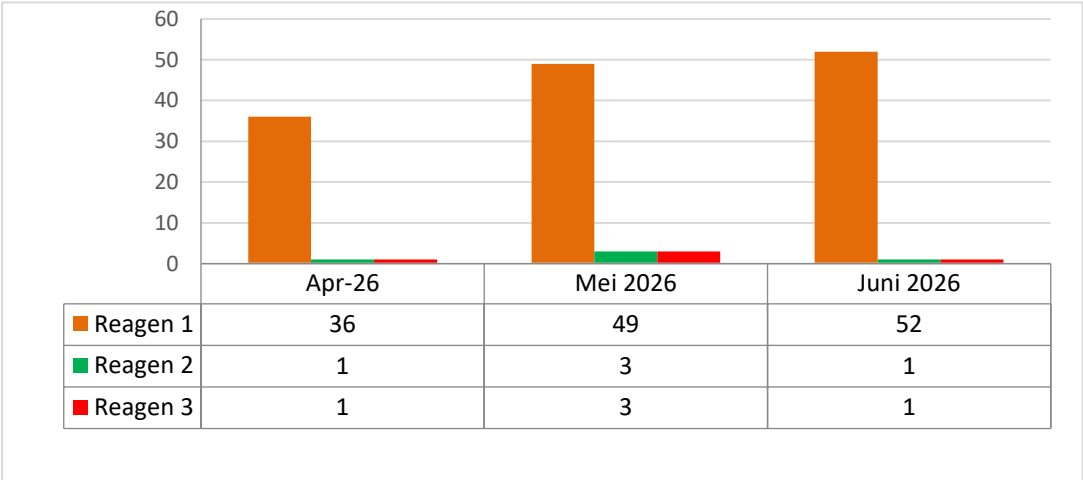
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.16 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	Reagen 1	36	49	52
2	Reagen 2	1	3	1
3	Reagen 3	1	3	1

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Juni 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan April 2026 memakai reagen 3 dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien. pada bulan Mei 2026 memakai 3 reagen dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 3 pasien. Sedangkan pada bulan Juni 2026 memakai 3 reagen dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien

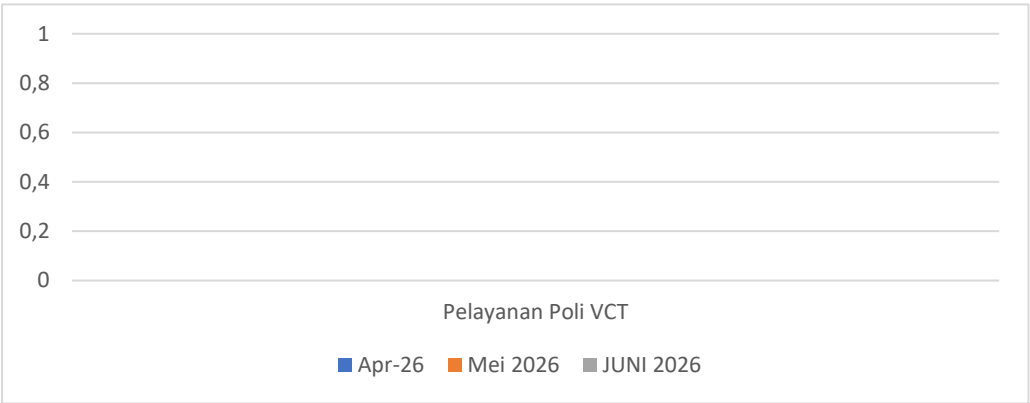
Rencana Tindak Lanjut :

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.7.17 Pelayanan Poli VCT (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Juni 2026



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

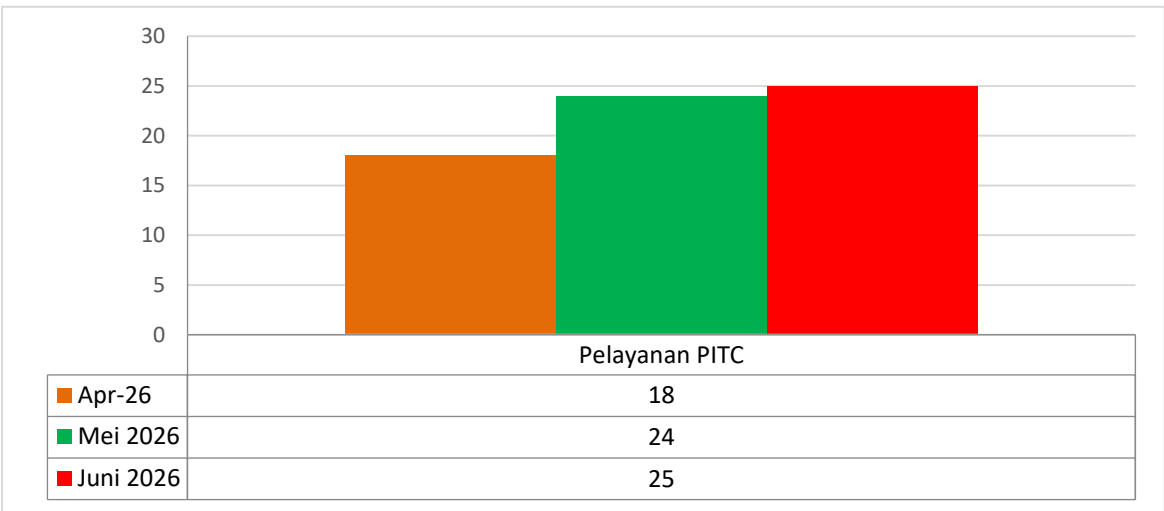
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.7.18 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	Pelayanan PITC	18	24	25

Grafik Pelayanan PITC Juni 2026



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan pada bulan April 2026 sebanyak 18 pasien, pada bulan Mei 2026 sebanyak 24 pasien sedangkan pada bulan

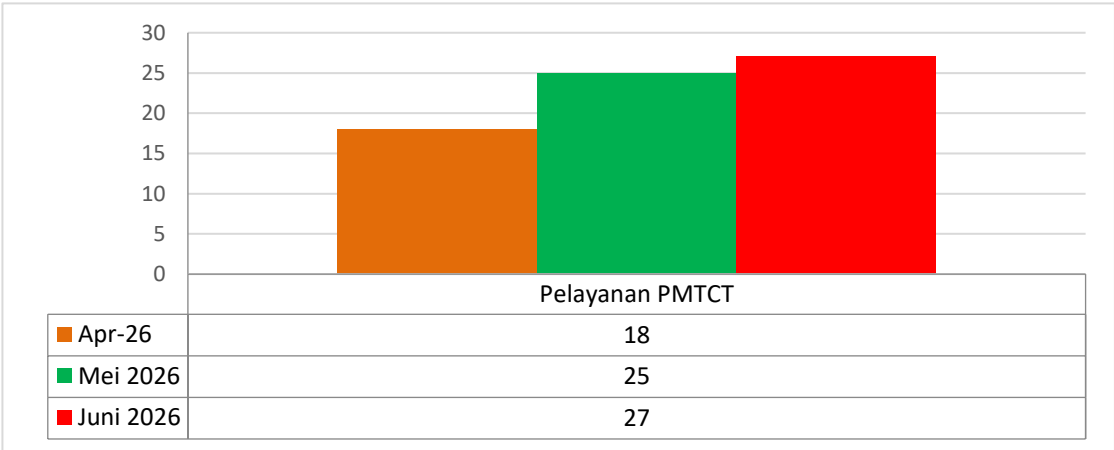
Juni 2026 sebanyak 25 pasien.
Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukkan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjarangan pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.7.19 Pelayanan PMTCT (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	Pelayanan PMTCT	18	25	27

Grafik Pelayanan PMTCT Juni 2026



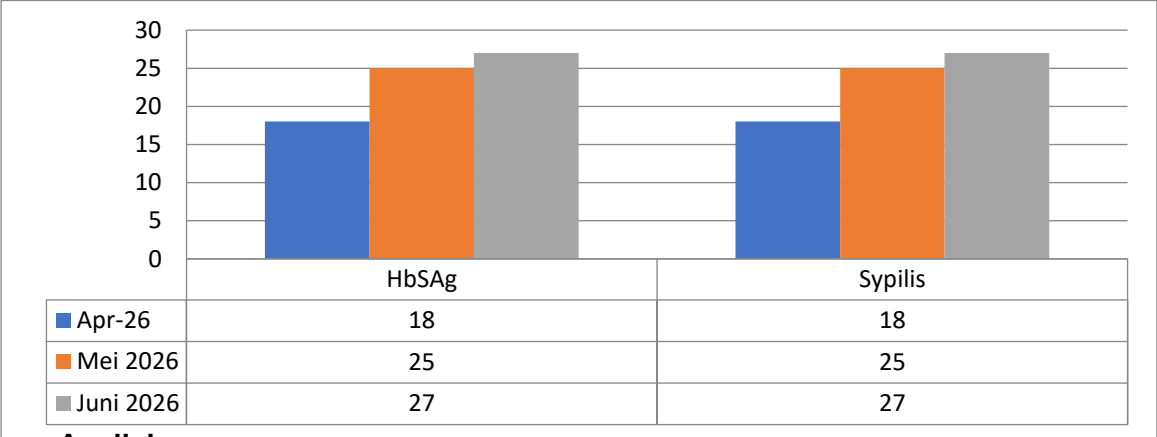
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan April 2026 naik menjadi 18 pasien. pada bulan mei 2026 sebanyak 25 pasien. Sedangkan pada bulan Juni 2026 sebanyak 27 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut :
Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.7.20 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	HbSAg	18	25	27
2	Sypilis	18	25	27

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Juni 2026



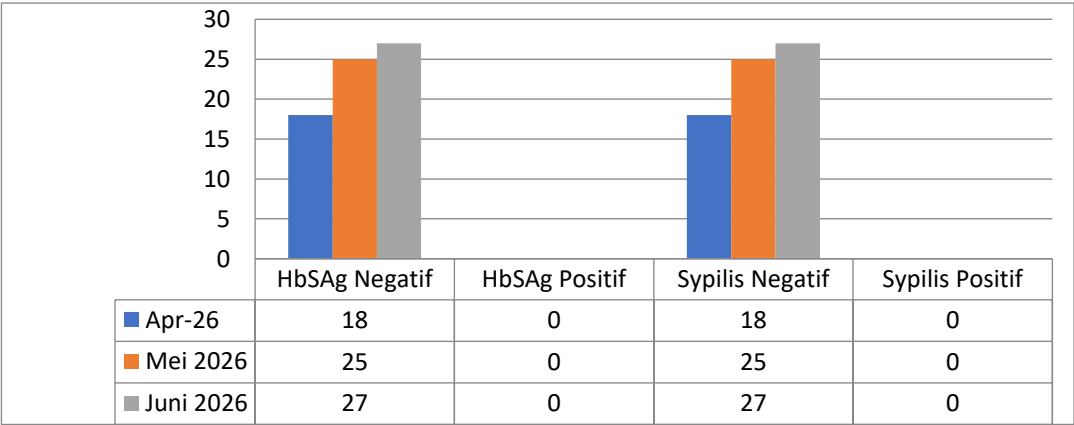
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Syphilis pada bulan April 2026 sebanyak 18 pasien. pada bulan Mei 2026 sebanyak 25 pasien Sedangkan pada bulan Juni 2026 sebanyak 27 pasien
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Syphilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.21 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	HbSAg			
	Negatif	18	25	27
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	18	25	27
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil Juni 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan Maret, April dan mei 2026 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif

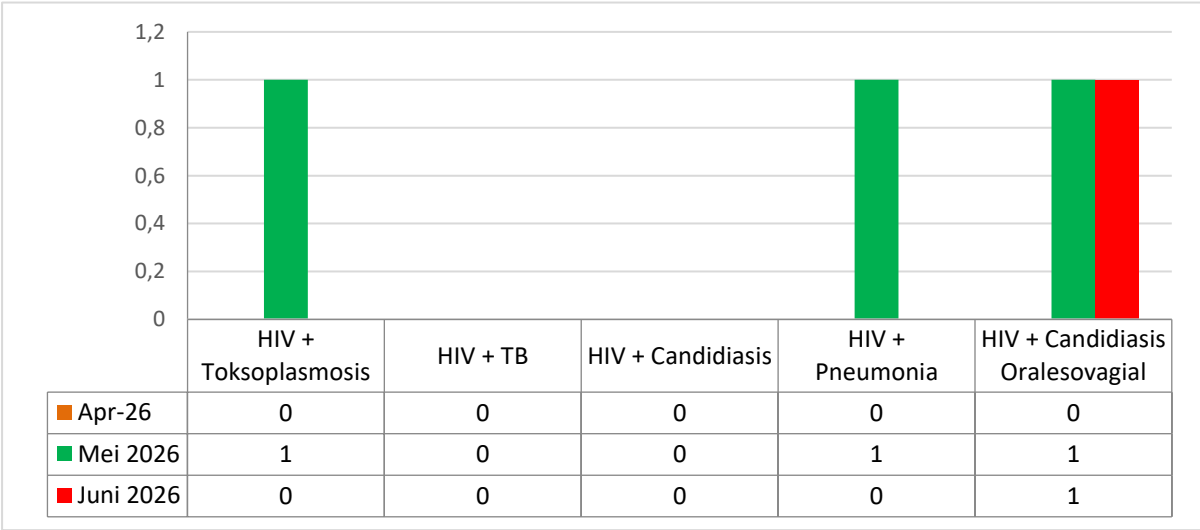
Rencana Tindak Lanjut :

1. Pada pasien HbSAg
- Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
2. Pada pasien Sypilis
- Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.7.22 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

NO	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	HIV + Toksoplasmosis	0	1	0
2	HIV + TB	0	0	0
3	HIV + Candidiasis	0	0	0
4	HIV + Pneumonia	0	1	0
5	HIV + Candidiasis Oralesovagial	0	1	1

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Juni 2026



Analisis :

1. Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Jumlah Pelayanan ODHA Dengan IO (Factor Resiko Infeksi Oportunistik) pada Triwulan 2 tahun 2026 sebanyak 4 pasien
2. Rincian pasien ODHA Dengan IO (Factor Resiko Infeksi Oportunistik) tahun 2025 sebagai berikut : Pasien dengan HIV + Toksoplasmosis sebanyak 1 orang, Pasien dengan HIV + TB sebanyak 0 orang, Pasien dengan HIV + Candidiasis sebanyak 0

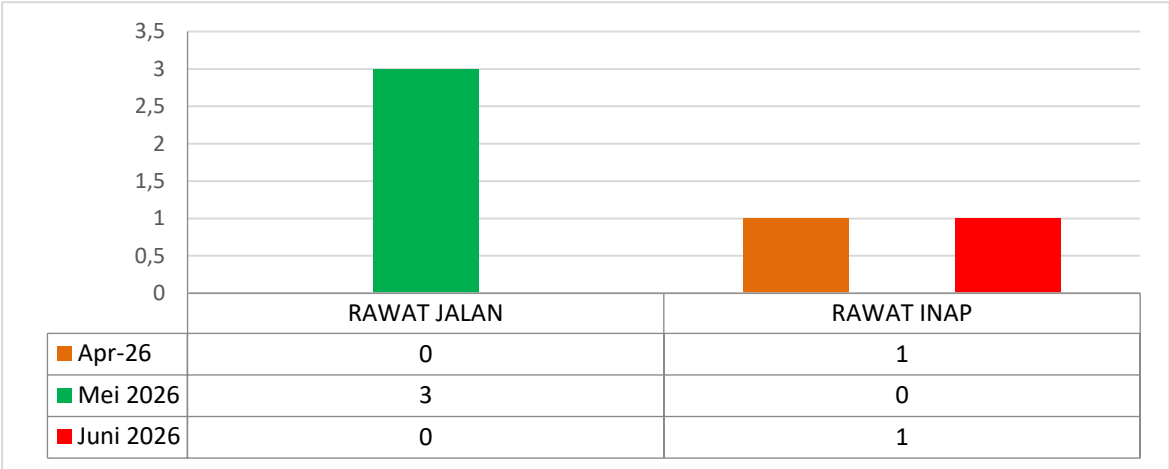
orang, Pasien dengan HIV + Pneumonia sebanyak 1 orang sedangkan pasien dengan HIV + Candidiasis Oralesovagial sebanyak 2 pasien.

Rencana Tindak Lanjut :
ODHA Dengan IO (Factor Resiko Infeksi Oportunistik) dilakukan rujuk eksternal sebagai rencana pelayanan terkait rencana pengobatan lanjutan pasien

3.7.23 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
1	Rawat Jalan	0	3	0
2	Rawat Inap	1	0	1

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Juni 2026



Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan April 2026 terapat 1 pasien yang dilakukan rujuk dari ICU isolasi. pada bulan Mei 2026 terdapat 3 pasien yang dirujuk dari IRNA. Sedangkan pada bulan Juni 2026 terapat 1 pasien yang dilakukan rujuk dari IGD dengan status rawat inap.
Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV dengan kebutuhan perawatan lanjutan pengobatan dan pemberian terapi ARV.

Rencana Tindak Lanjut :
Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting
1.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Juni 2026

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan

		wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
7	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
8	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
9	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
10	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
11	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
12	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah skait.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas

Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai 1000 hari pertama kehidupan	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1x	1x	1x
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1x	1x	0x
	2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Poli kandungan	485 pasien	371 pasien	483 pasien
Pemberian PMT Ibu Hamil	1.Pemberian PMT pemulihan dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Senam hamil	2x	2x	2x
	2.Pemberian PMT penyuluhan pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam hamil	1x	1x	2x
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	108 pasien	103 pasien	119 pasien
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita	Pasien poli anak dan IRNA Anak	IRJA	2x	1x	1x

	2. Pemberian makanan Bayi dan Anak	Pasien IRNA Anak	IRNA	164 pasien	198 pasien	193 pasien
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan pencatatan dan pengukuran berat badan dan tinggi badan anak terdeteksi stunting/ wasting	Pasien IRNA Anak terdeteksi wasting/ stunting	IRJA anak	4 pasien	6 pasien	8 pasien
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	12 pasien	15 pasien	11 pasien
Pemberian vitamin A	Penyuluhan mengenai pentingnya pemberian vitamin A pada anak-anak	Pasien anak	IRJA anak	2x	0x	0x
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	5 pasien	5 pasien	4 pasien
Pemberian Taburia pada Baduta	Penyuluhan mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	1x	0x	0x
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Penyuluhan mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	1x	1x	0x

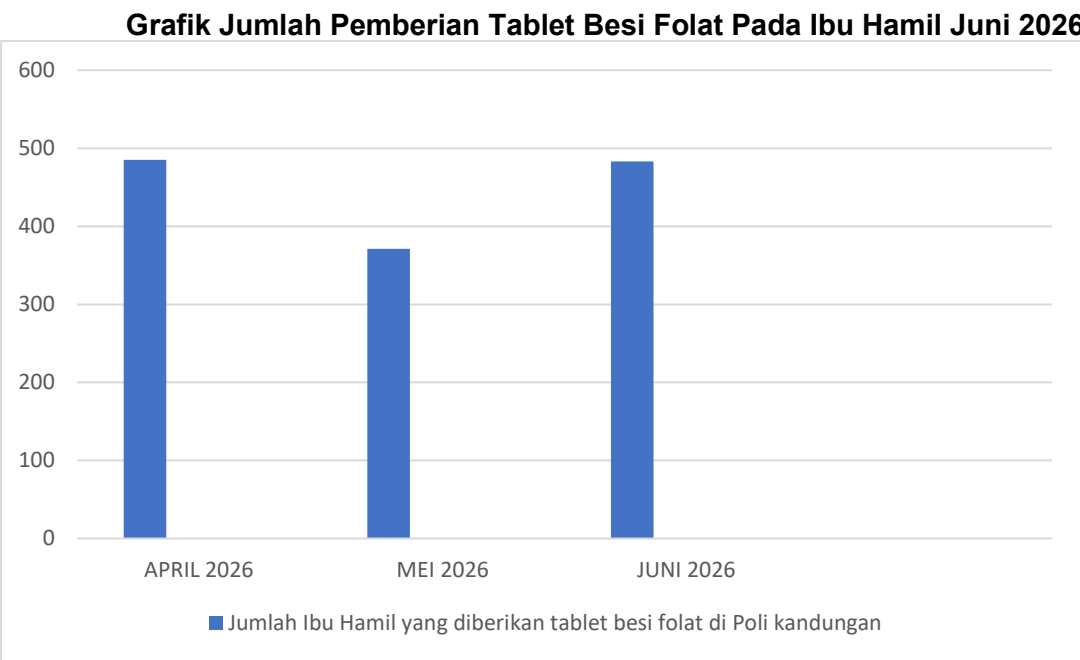
Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas, Rumah Sakit hanya memberikan dalam bentuk PMT penyuluhan.

Rencana Tindak Lanjut :

Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	485	371	483



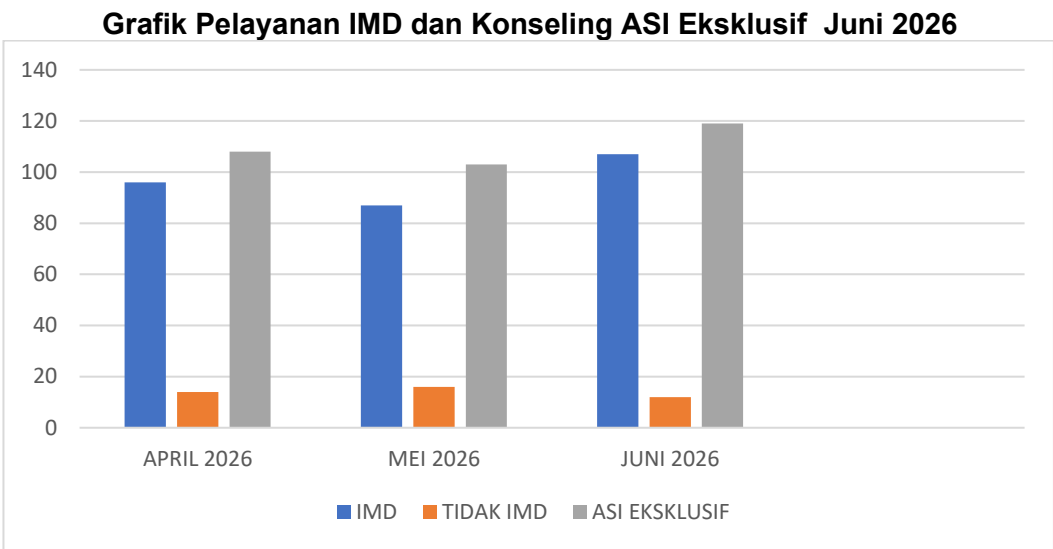
Analisis :
Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat meningkat dari sebelumnya 371 di bulan Mei menjadi 483 pada bulan Juni yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

- Rencana Tindak Lanjut:**
- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 - 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN APRIL 2026	BULAN MEI 2026	BULAN JUNI 2026
1	IMD	96	87	107
2	Tidak IMD	14	16	12
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	108	103	119



- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juni sebanyak 107 bayi.
 - 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juni 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 12 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan penurunan jumlah pasien
 - 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
 - 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif menurun pada bulan Juni 2026 yaitu sebanyak 119 pasien.

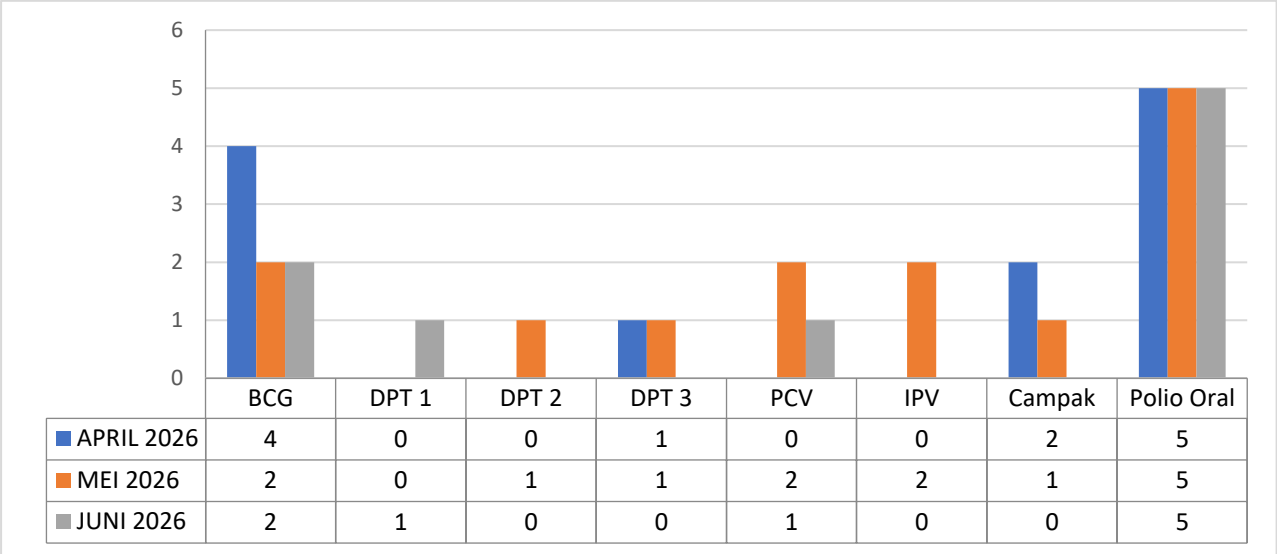
Rencana Tindak Lanjut:
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026
1	BCG	4	2	2
2	DPT 1	0	0	1
3	DPT 2	0	1	0
4	DPT 3	1	1	0
5	PCV	0	2	1
5	IPV	0	2	0
6	Campak	2	1	0
7	Polio Oral	5	5	5
8	Rotavirus	0	1	2

Grafik Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Prima Husada Juni 2026



Analisis:

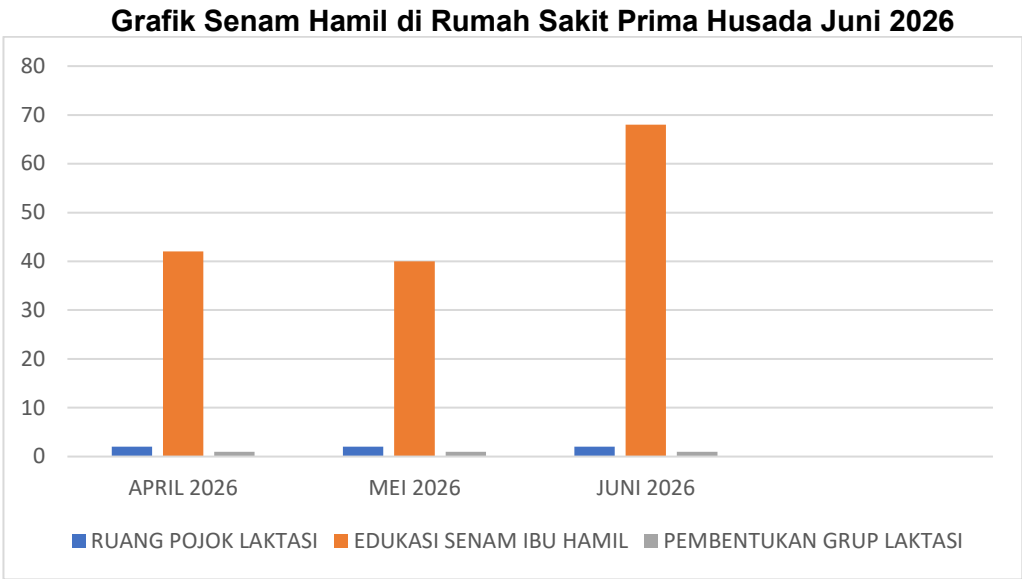
- 1. Pada bulan Juni sebanyak 2 balita melakukan imunisasi BCG dan rotavirus.
- 2. Sebanyak 1 balita melakukan imunisasi DPT 1, PCV di Prima Husada Malang pada bulan Juni.
- 3. Pada bulan Juni tidak ada yang melakukan imunisasi DPT 2, DPT 3, IPV, dan campak.
- 4. Terdapat 5 balita melakukan imunisasi polio oral pada bulan Juni 2026.

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	42	40	68
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan Mei edukasi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan gizi seimbang, makanan tinggi energi tinggi protein, PMT ibu hamil sebanyak 68 peserta, penyuluhan dilakukan di senam hamil.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

**3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi**

Rujukan Masuk				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Rujukan Keluar				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan Juni 2026



Analisis :
Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS pada bulan Juni. Rujuk masuk RS tidak ada karena Puskesmas sekitar lebih mengarahkan pasien langsung datang ke IGD tanpa menunggu rujukan dari puskesmas.

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjaring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan
Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	APRIL 2026	MEI 2026	JUNI 2026
Jumlah Pasien Stunting	6	6	5
Jumlah Pasien Wasting	6	6	4

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :
Pada bulan Juni 2026 ditemukan sebanyak 4 balita berat badan kurang, 4 balita pendek, dan

1 balita pendek dengan gizi kurang. Permasalahan yang ditemukan rata-rata balita kurang bervariasi dalam pola makannya, dan porsi makan tidak adekuat namun balita aktif. Selain itu, terdapat balita yang sakit dalam kurun waktu lama sehingga mengalami BB turun

Pemberian makanan tinggi energi dan tinggi protein di rumah sakit. Edukasi terhadap orang tua bagaimana dalam memberikan makanan gizi seimbang sesuai usia. Dan kolaborasi terhadap Ahli Gizi dan DPJP terus dilakukan.

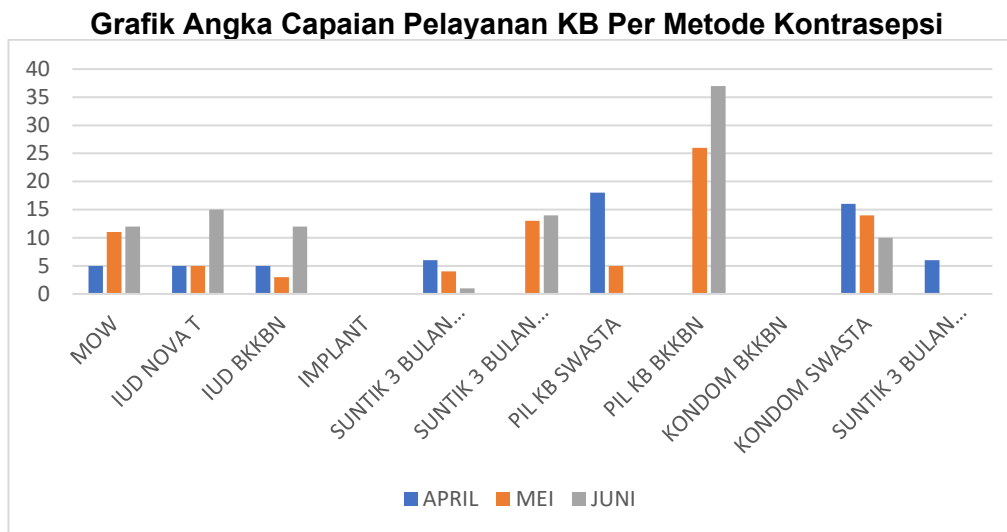
Rencana Tindak Lanjut :

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada lebih gencar dalam melakukan pengukuran dan pelaporan pasien anak baik di rawat inap maupun rawat jalan. Penginputan pasien stunting dan wasting di aplikasi eppgbm. Pemberian diet Tinggi Kalori dan Tinggi Protein (TKTP). Kolaborasi antar ahli gizi, DPJP, serta Ahli gizi puskesmas balita.

3.1.2.5 KBRs

3.7.24 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien			Target sasaran per metode kontrasepsi dalam satu tahun
		Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	
1	MOW	5	11	12	26
2	IUD Nova T	7	5	15	49
3	IUD BKKBN	7	3	12	
4	IMPLANT	0	0	0	111
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	6	4	1	187
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN BKKBN	13	13	14	
7	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN SWASTA	6	0	0	
8	PIL KB BKKBN	0	26	37	135
9	PIL KB SWASTA	18	5	0	
10	KONDOM BKKBN	0	0	0	30
11	KONDOM SWASTA	16	14	10	



Evaluasi :

1. Peserta MOW pada bulan April turun (5) Mei naik (11) Juni naik (12)
2. Peserta IUD Nova T pada bulan April naik (7) Mei turun (5)Juni naik (15)
3. Peserta IUD BKKBN pada bulan April naik (7) Mei turun (3) Juni (12)
4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan April naik (6) Mei turun (4) Juni turun (1)
5. Peserta KB suntik progestin bkkbn pada bulan April naik (13) Mei tetap (13) Juni naik (14)
6. Peserta KB pil kombinasi, April (0) karena stok kosong Gudang BKKBN, Mei naik (26) Juni naik (37) karena sudah mendapat stok dari BKKBN
7. Karena stok pil kombinasi BKKBN kosong, Maka peserta KB menggunakan pil kombinasi swasta April turun (18) Mei turun (5) Juni (0) karena sudah ada stok dari BKKBN
8. Peserta KB Kondom BKKBN pada bulan karena stok habis April (0) Mei (0) Juni (0) karena kosong dari BKKBN
9. Peserta KB Kondom swasta April (16) Mei turun (14) Juni (1100) disediakan karena stok kondom dari BKKBN kosong

Analisis :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn dan poli KB salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Melakukan edukasi individu kepada pasien bersalin tentang pentingnya KB

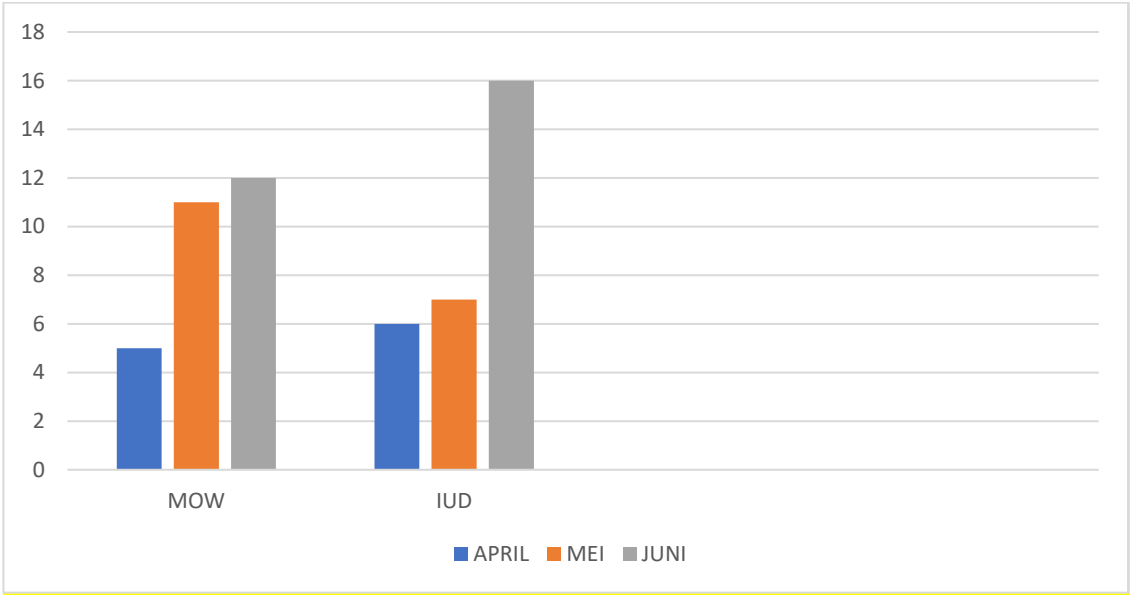
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD, Implan serta pemasangan IUD pasca plasenta, dan diadakan Pelayanan KB oleh bidan setiap hari Senin-Jumat

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan

No	Jenis Pelayanan pasca persalinan	Jumlah Pasien KB Bulan April 2026	Jumlah pasien bersalin bulan April 2026	Jumlah Pasien KB Bulan Mei 2026	Jumlah pasien bersalin bulan Mei 2026	Jumlah Pasien KB Bulan Juni 2026	Jumlah pasien bersalin bulan Juni 2026
1	MOW	5	101	11	92	12	115
2	IUD	6	101	7	92	16	115

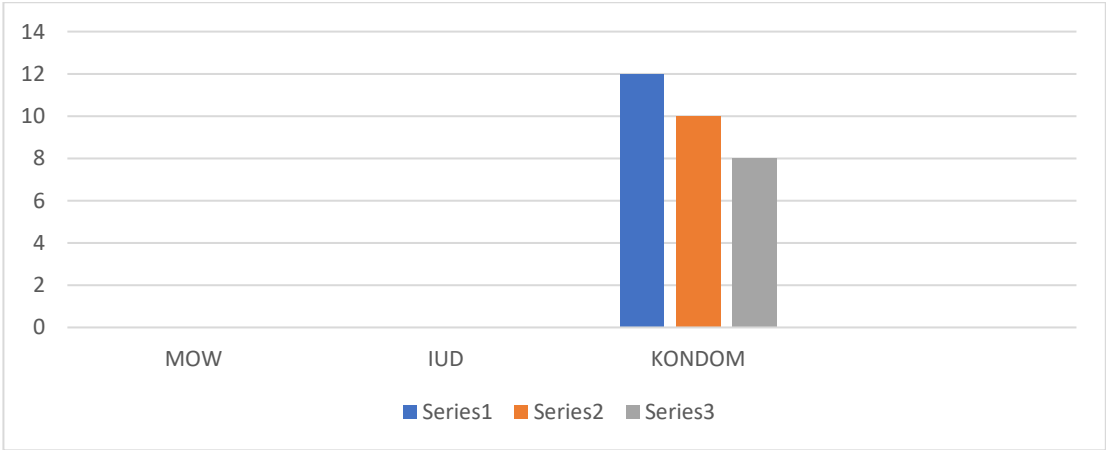
Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

No	Jenis Pelayanan pasca keguguran	Jumlah Pasien kb Bulan April 2026	Jumlah pasien abortus Bulan April 2026	Jumlah Pasien kb Bulan Mei 2026	Jumlah pasien abortus Bulan Mei 2026	Jumlah Pasien kb Bulan Juni 2026	Jumlah pasien abortus Bulan Juni 2026
1	MOW	0	12	0	10	0	8
2	IUD	0		0		0	
3	KONDOM	12		10		8	

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan April-Mei-Juni meningkat tapi belum memenuhi target dengan alasan pasien ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis
2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan April-Mei-Juni sudah memenuhi target dengan pemberian kondom dan bukan KB jangka panjang dengan alasan pasien ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis

Analisis :

1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Melakukan edukasi individu kepada pasien bersalin diruang maternitas tentang pentingnya berKB

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan 2026

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan April 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Dita Andriyani	P/33	dr. Aida, Sp. OG	231521	Multiple mioma uteri	31/03/2026	03/04/2026	4	Cefazoline	1	1x2	2	3	0,67
2	Qurotu Ngainina	P/18	dr. Aida, Sp. OG	246780	Colic abdomen ec ovrial cyst	01/04/2026	02/04/2026	2	Ceftriaxone	1	2x1	3	2	1,5
3	Dian Astutik	P/26	dr. Humaira, Sp. OG	008496	Gravida SC	01/04/2026	03/04/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
								Cefadroxile	2x0,5		1,5	2	0,75	
4	Fanny Kartika	P/35	dr. Aida, Sp. OG	132363	Post SC + BSC	02/04/2026	04/04/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
								Cefadroxile	2x0,5		1,5	2	0,75	
5	Poppy Annisa	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	214099	Abortus incomplete post curet	10/04/2026	11/04/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
								Cefadroxile	2x0,5		1	2	0,5	
6	Sufiati Ulfa	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	073950	Gravida partus normal + post curetage	11/04/2026	12/04/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
								Cefadroxile	2x0,5		1	2	0,5	
7	Siti Lutfiah	P/21	dr. Humaira, Sp. OG	236450	Post SC + KPD	14/04/2026	16/04/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
								Cefadroxile	2x0,5		1,5	2	0,75	
8	Siti Arba'yah	P/33	dr. Aida, Sp. OG	127022	Post Partum Normal	19/04/2026	20/04/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
9	Richa Damayanti	P/320	dr. Humaira, Sp. OG	199190	Post Curetage + Misseda Abortion	22/04/2026	23/04/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
								Amoxicillin	3x0,5		1	1,5	0,67	
10	Qurrotul Aini	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	130109	Post Curetage + Misseda Abortion	26/04/2026	27/04/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
								Amoxicillin	3x0,5		1	1,5	0,67	
11	Dendy hutama	L/32	dr. Oka, Sp. OT.	226731	Union Humerus Proximal Dextra	10/04/2026	12/04/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
								Cefazolin	2x1		2	3	0,67	

12	Ferry K	L/45	dr. Oka,Sp.OT.	247577	Finger tip injury digiti 4 manus dextra	10/04/2026	12/04/2026	3	Cefazolin	2	2x1	6	3	2
13	Hadi kurniawan	L/42	dr. Pradana,Sp.U.	073780	Bt Ureter D	10/04/2026	12/04/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
14	Wahyu nanang	L/32	dr. Oka,Sp.OT.	247653	Crush injury dengan bone expose digit 4 pedis dextra	12/04/2026	13/04/2026	2	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	1	3	0,33
15	Hartono	L/64	dr. Pradana,Sp.U.	157710	BPH	14/04/2026	16/04/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Farida Maimunah	P/652	dr. Anton,Sp.B.	151192	Necrotizing fascitis pedis dextra	17/04/2026	19/04/2026	3	Picyn	3	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
									Metronidazole (PO)		3x0,25	1,25	2	0,63
17	Sumarmi	P/76	dr. Oka,Sp.OT.	011074	Fracture Humerus	18/04/2026	20/04/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
18	Suparman	L/75	dr. Edi,Sp.OT.	181099	BPH	20/04/2026	22/04/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
19	Supardi	P/54	dr. Oka,Sp.OT.	141301	Finger tip injury digiti 3 manus dextra	25/04/2026	26/04/2026	2	Cefazolin	2	2x1	2	3	0,67
20	Rosyidatul M	P/28	dr. Anton,Sp.B	144748	Appendicitis acute	28/04/2026	30/04/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	3	6	0,5
21	Nabila Aprilia	P/18	dr. Ardhany, Sp. Pd	234237	Nephrolithiasis	01/04/2026	03/04/2026	3	Asam pipemidat	1	2x0,4	3,2	0,8	4
22	Ahlul Fadli	L/45	dr. Ardhi, Sp. Pd	247243	Chronic diare + Anemia	03/04/2026	05/04/2026	3	Ciprofloxacin po	1	2x0,5	1,5	1	1,5
23	Ahlul Fadl	L/45	dr. Elvi, Sp. P	050074	COPD AE	03/04/2026	05/04/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
24	Okta Miliani		dr. Zora, Sp. Pd	247272	GEA dehidras sedang diare	04/04/2026	06/04/2026	3	Ciprofioxacin po	1	2x0,5	2	1	2
25	Hartawan Hari	L/45	dr. Heri, Sp. Pd	247408	DF	07/04/2026	09/04/2026	3	Cefixime	1	2x0,1	0,5	0,4	1,25
26	Mualifin	L/58	dr. Mira, Sp. JP	247502	Chest Pain unspecified	09/04/2026	11/04/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
27	Sulastri	P/61	dr. Andy, Sp. P	056285	Pneumonia + CVA	14/04/2026	16/04/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
28	R. Noeriwan	L/53	Dr. Zora, Sp. Pd	245787	GEA + Vomiting	18/04/2026	20/04/2026	3	Ciprofoloxacin po	1	2x0,5	3	1	3
29	Sutrisnowati	P/31	dr. Ardhi, Sp. Pd	248189	Cholelithiasis	21/04/2026	23/04/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	7	2	3,5
30	Supadmi	P/71	dr. Andy, Sp. P	248372	Pneumonia psi 91 + COPD AE	25/04/2026	28/04/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Mei 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Wilda Nurmala	P/24	dr. Humaira, Sp. OG	201062	Post Partum Normal	01/05/2026	02/05/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
2	Tri Lindah M	P/33	dr. Aida, Sp. OG	152777	Gravida SC + KPD	03/05/2026	05/05/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Karlina	P/38	dr. Aida, Sp. OG	237457	Makrosomia + Gravida SC	12/05/2026	15/05/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
4	Siska Nurkhoiriya	P/30	dr. Puti F, Sp. OG	063844	Kista Ovari	14/05/2026	17/05/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
5	Sekar Mastiti	P/30	dr. Humaira, Sp. OG	241444	Gravida SC + Mioma Uteri	15/05/2026	17/05/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
6	Agustina Dwi	P/38	dr. Humaira, Sp. OG	248958	Kista Bartolini	18/05/2026	19/05/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
7	Virsa Novita	P/22	dr. Humaira, Sp. OG	240348	Gravida SC	20/05/2026	23/05/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
8	Paisri	P/39	dr. Humaira, Sp. OG	247736	Post SC + Oligohidramnion	21/05/2026	23/05/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
9	Mauliddy Sari	P/25	dr. Puti F, Sp. OG	139820	Post SC + BSC	22/05/2026	24/05/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
10	Tarisa Adinda	P/25	dr. Humaira, Sp. OG	247721	Post Partum Normal	26/05/2026	27/05/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
11	M Afrizal Dwi	L/20	dr. Oka, Sp. OT.	246289	Union Phalank	01/05/2026	03/05/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
12	Iwan	L/44	dr. Oka, Sp. OT.	248995	Vulnus laceratum regio antebrachia sinistra	01/05/2026	03/05/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	4	3	1,33

13	Junaidi	L/33	dr. Zaki,Sp.B.	221724	Stt Temporo A	05/05/2026	07/5/2026	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
14	M Sururi	L/47	dr. Anton,Sp.OB	103822	Necrotizing Fascitis Frontalis	07/05/2026	09/05/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
15	Misnati	P/49	dr. Anton,Sp.OB	249183	Necrotizing Fascitis Pedis D	13/05/2026	15/05/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	7,5	6	1,25
16	Adi Wiyono	L/45	dr. Arianto,Sp.OT.	066470	Crush Injury Digiti 1 Manus Sinistra	22/05/2026	24/05/2026	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
17	Karsi'in	L/69	dr. Pradana, Sp. U	216168	Bt buli	19/05/2026	21/05/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
18	Elok Kusuma N	P/19	dr. Oka,Sp.OT.	249330	CF Clavicula Dextra	22/05/2026	24/05/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
19	Adinda N	P/20	dr. Oka,Sp.OT.	247674	Schapoid dislocation	22/05/2026	24/05/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
20	Atim	L/71	dr. Edi, Sp. U	249539	BPH	25/05/2026	27/05/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
21	Sariani	P/80	dr. Andy, Sp. JP	248668	Pneumonia	02/05/2026	05/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2.5
22	Umi Prihatin T	P/50	dr. Zora, Sp. Pd	076079	GEA + Volume Depletion	04/05/2026	06/05/2026	3	Ciprofloxacin	1	2x0,5	2	1	2
23	Widarto	L/64	dr. Mira, Sp. JP	248736	NSTEMI + Lung edema	04/05/2026	07/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	3	2
24	Tabri	L/57	dr. Andy, Sp. P	236852	COPD AE + ALO	05/05/2026	08/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	3	2
25	Misdi	L/66	dr. Elvi, Sp. P	249047	Sepsis + Pneumonia	11/05/2026	14/05/2026	4	Meropenem	1	3x1	9	3	3
26	Fransiska C	P/86	dr. Heri, Sp. Pd	146544	Hematemesis + Cystitis	12/05/2026	14/05/2026	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,2	0,8	1,5
27	Asri	P/67	dr. Ira, Sp. JP	237276	NSTEMI + ALO + Tumor Abdomen	13/05/2026	16/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
28	Rokayatin	P/60	dr. Farid, Sp.N	101720	CVA Infark + Bronkitis	14/05/2026	17/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2.5
29	Suhartono	L/42	dr. Ardhi, Sp. Pd	248749	Cholelitis multiple	23/05/2026	26/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
30	Ngatiman	L/65	dr. Ardhi, Sp. Pd	249910	Colic Abdomen + Hydronefrosis	28/05/2026	30/05/2026	3	Ciprofloxacin	1	2x0,5	1	1	1

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juni 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Nurul Laily	P/25	dr. Humaira, Sp. OG	167262	Post Partum Normal	02/06/2026	03/06/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
2	Hera Marta	P/33	dr. Aida, Sp. OG	055697	Post SC + PEB	06/06/2026	08/06/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Trainingtyas P	P/25	dr. Humaira, Sp. OG	167262	Post Partum Normal	09/06/2026	10/06/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
4	Zaeti Nur	P/29	dr. Humaira, Sp. OG	242550	Post SC + KPD	10/06/2026	12/06/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
5	Endang Budi A	P/57	dr. Humaira, Sp. OG	124573	Mypma Uteri	10/06/2026	13/06/2026	4	Ceftiaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
6	Aulia Rahman	P/24	dr. Humaira, Sp. OG	211658	Post SC + BSC	11/06/2026	14/06/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
7	Karina Putri	P/29	dr. Aida, Sp. OG	183297	Post SC + KPD	11/06/2026	14/06/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
8	Dwi Hariyani	P/35	dr. Puti F, Sp. OG	234047	Post SC + Oligohidramnion	12/06/2026	14/06/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
9	Annisa Aprilia	P/27	dr. Puti F, Sp. OG	250997	KET + Anemia	19/06/2026	21/06/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,67
10	Putri Febrian	P/32	dr. Aida, Sp. OG	251427	Gravida SC	27/06/2026	29/06/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,67
11	Darsono Kaseri	L/63	dr. Anton,Sp.B	250266	Gangrene Anogenital	04/06/2026	06/06/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	6	6	1
12	Laras Maya	P/23	dr. Anton,Sp.B	155514	Appendisitis Akut	04/06/2026	06/06/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
13	Aris Aji	L/35	dr. Sigit, Sp. BP	158367		04/06/2026	07/06/2026	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5

					Vullnus laceratum regio frontalis				Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
14	Mustani Eko	P/56	dr. Oka,Sp.OT.	250372	CF sital tibia D	06/06/2026	08/06/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
15	Rastomo	L/61	dr. Edi, Sp. U	250128	BPH	08/06/2026	10/06/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Yunifa Mei	P/31	dr. Zaki,Sp.B.	181653	Tumor Coli Posterior	09/06/2026	11/06/2026	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
17	Rahmat Hidayatullah	L/19	dr. Oka,Sp.OT.	250701	Vulnus laseratum regio cruris sinistra	13/06/2026	15/06/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
18	Ahmad Ari	L/24	dr. Oka,Sp.OT.	249290	Union phalank dextra	19/06/2026	21/06/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
19	Rastomo	L/67	dr. Pradana, Sp. U	074273	BPH	23/06/2026	25/06/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
20	Suminto	L/36	dr. Oka,Sp.OT.	038639	Open wound distal phalank	26/06/2026	28/06/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
21	Warisan	L/61	dr. Andy, Sp. P	250155	Efusi Pleura + Hipokalemi	02/06/2026	04/06/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
22	Firda Ayu M	P/28	dr. Ardhi, Sp. Pd	233112	Cholelitisias	07/06/2026	11/06/2026	5	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
23	Ika Eny D	P/42	dr. Heri, Sp. Pd	157292	Cholelitisias + Nefrolithiasis	16/06/2026	18/06/2026	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,2	0,8	1,5
24	Buang	L/59	dr. Ardhi, Sp. Pd	207764	DM Hiperglikemi + GEA	08/06/2026	11/06/2026	4	Ciprofloxacin	1	2x0,5	3	1	3
25	Suriyanto	L/48	dr. Heri, Sp. Pd	250884	DF + TF	18/06/2026	21/06/2026	4	Levofloxacin Tab	1	1x0,75	2,25	0,3	7,5
26	Saridan	L/81	dr. Andy, Sp. P	248668	Pneumonia Psi 81	19/06/2026	22/06/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
27	Ahmad Santoso	L/69	dr. Zora, Sp. Pd	130884	Bacterial Infection + AKI	20/06/2026	23/06/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
28	Rumini	P/59	dr. Fahima, Sp. N	251037	Syok Sepsis + ISK	22/06/2026	24/06/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
29	Ika Yulianti	P/38	dr. Elvi, Sp. P	251101	COPD Ae	22/06/2026	24/06/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
30	Samiatun	P/67	dr. Heri, Sp. Pd	204810	Anemia + Cystitis	22/06/2026	24/06/2026	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,2	0,8	1,5

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap 2026

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	-	-	-	-	1090	93,70	61	6,30	1080	93,37	69	5,16	1147	99,66	4	0,34
Februari	-	-	-	-	920	84	119	16%	929	86,4	110	13,6	1005	97	34	3
Maret	-	-	-	-	1001	95,30	54	16	1000	94,93	55	5,07	1031	96,67	24	,33
April	1244	99	12	1	1070	88	149	12	1113	89	142	11	1162	93	94	7
Mei	14	100	0	0	996	85	179	15	1039	87	157	13	1087	93	81	7
Juni	1149	99	7	1	790	70	345	30	1007	87	156	13	701	60	462	40
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1013	97,18	38	2,82	-	-	-	-	1051	100	0	0	1051	100	0	0
Februari	1008	98	27	2	-	-	-	-	1034	100	2	0,3	1036	100	0	0
Maret	1047	100	7	0	-	-	-	-	1043	100	11	0	1054	100	0	0
April	1148	91	107	9	1203	96	52	4	1203	96	52	4	1220	97	35	3
Mei	1112	93	84	8	1154	96	42	4	1171	98	25	2	1080	90	116	10
Juni	1099	95	62	6	1113	96	48	4	1140	98	21	2	1093	94	68	6
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	556	52	484	48	1040	100	0	0	1133	100	0	0	1010	91	123	9
Februari	528	61	398	39	926	100	0	0	1027	100	0	0	965	94	62	6
Maret	587	65	341	35	927	100	1	0,07	1034	90	13	10	291	33	756	67
April	564	99	99	3	1130	99	11	1	1206	97	42	3	1171	99	13	1
Mei	517	98	8	2	1061	99	14	1	1121	94	72	6	1067	98	21	2
Juni	522	98	12	2	994	96	40	4	1117	96	42	4	1043	97	33	3
Juli																
Agustus																
September																
Oktober																

Analisis :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP

Pada bulan Juni 2026, kelengkapan Ringkasan Keluar Masuk tetap baik sebesar 99%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada Pengkajian Awal Medis menjadi 70% dibandingkan bulan Mei (85%) dan pada Ringkasan Pulang menjadi 60% dibandingkan bulan Mei (93%). Kelengkapan CPPT DPJP tetap stabil di angka 87%. Penurunan pada pengkajian awal medis dan ringkasan pulang menunjukkan masih perlunya peningkatan kepatuhan pengisian dokumen oleh DPJP.

2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:

Kelengkapan dokumen keperawatan pada bulan Juni menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Pengkajian Keperawatan meningkat menjadi 95%, CPPT Perawat tetap baik di 96%, Asuhan Keperawatan meningkat menjadi 98%, dan Resume Keperawatan meningkat menjadi 94%. Secara umum, kepatuhan pengisian dokumen oleh perawat sudah baik dan menunjukkan tren perbaikan.

3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker

Kelengkapan dokumentasi ahli gizi pada bulan Juni tetap tinggi, dengan Pengkajian Awal Gizi sebesar 98% dan CPPT Ahli Gizi sebesar 96%. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada CPPT dibandingkan bulan Mei (99%), secara umum dokumentasi gizi masih berada dalam kategori baik. Kelengkapan Rekonsiliasi Obat pada bulan Juni mencapai 96%, meningkat dibandingkan bulan Mei (94%). Kelengkapan CPPT Apoteker juga tetap baik sebesar 97%. Hal ini menunjukkan kepatuhan dokumentasi farmasi klinis sudah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan monitoring untuk mencapai kelengkapan 100%.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP:
 - 1) Melakukan sosialisasi dan reminder kepada DPJP terkait kelengkapan pengisian Pengkajian Awal Medis dan Ringkasan Pulang.
 - 2) Melakukan monitoring dan audit kelengkapan dokumen secara rutin setiap bulan.
 - 3) Melakukan konfirmasi kepada DPJP terhadap dokumen yang belum lengkap sebelum pasien pulang.
 - 4) Mengoptimalkan penggunaan ERM untuk meminimalkan dokumen yang belum terisi.
2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:
 - 1) Mempertahankan kepatuhan pengisian dokumentasi keperawatan yang sudah baik.
 - 2) Melakukan monitoring berkala terhadap dokumen yang masih belum lengkap.
 - 3) Memberikan umpan balik kepada unit dengan tingkat kelengkapan yang masih rendah.
3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker:
 - 1) Meningkatkan monitoring pengisian CPPT dan pengkajian gizi secara tepat waktu.
 - 2) Melakukan reminder kepada ahli gizi untuk melengkapi dokumentasi sebelum pasien pulang.
 - 3) Melakukan evaluasi rutin terhadap kepatuhan dokumentasi gizi.
 - 4) Mempertahankan kepatuhan pengisian rekonsiliasi obat dan CPPT farmasi klinis.
 - 5) Melakukan monitoring terhadap dokumen yang belum lengkap dan segera melakukan tindak lanjut.
 - 6) Mengoptimalkan koordinasi dengan unit pelayanan dan pemanfaatan ERM untuk mencapai kelengkapan dokumentasi 100%.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

1.7.1 Permasalah Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Kehabisan linen saat ada operasi pagi	P	1. Mengidentifikasi penyebab kekurangan linen di kamar operasi. 2. Memastikan ketersediaan linen sesuai kebutuhan pelayanan.
		D	1. Monitoring stok linen setiap hari. 2. Koordinasi dengan unit laundry dan CSSD untuk pemenuhan linen.
		S	Ditemukan 1x kejadian kehabisan linen yang menyebabkan keterlambatan tindakan operasi saat pagi hari
		A	1. Menetapkan stok minimum persiapan linen kamar operasi sesuai dengan SPO 2. Melakukan monitoring stok dan evaluasi koordinasi dengan unit terkait secara berkala.
2	Keterlambatan penyiapan alat dari PT BOS saat durante operasi karena saat durante, alat tersebut tidak disiapkan dengan lengkap	P	1. Melakukan koordinasi dengan PT BOS dan tim kamar operasi. 2. Menggunakan checklist kelengkapan alat sebelum operasi dimulai.
		D	1. Melakukan koordinasi dengan PT BOS dan tim kamar operasi. 2. Menggunakan checklist kelengkapan alat sebelum operasi dimulai.
		S	Ditemukan keterlambatan selama operasi (<i>durante</i>) karena alat yang disiapkan PT BOS tidak lengkap.
		A	1. Mewajibkan verifikasi kelengkapan alat sebelum operasi. 2. Melakukan evaluasi bersama PT BOS dan monitoring kepatuhan penggunaan checklist sebelum setiap tindakan operasi.
3	Tampilan ERM laporan operasi untuk pasien asuransi dobel-dobel sehingga mempengaruhi proses klaim	P	1. Mengidentifikasi penyebab tampilan laporan operasi yang dobel pada ERM pasien asuransi. 2. Berkoordinasi dengan tim IT dan rekam medis untuk perbaikan sistem
		D	1. Melakukan pelaporan dan verifikasi terhadap kasus yang ditemukan. 2. Monitoring tampilan ERM pada pasien asuransi
		S	Ditemukan tampilan laporan operasi ganda pada ERM yang memengaruhi proses verifikasi dan klaim asuransi.
		A	1. Melakukan perbaikan sistem ERM bersama progammer 2. Monitoring hasil perbaikan dan evaluasi berkala agar kejadian tidak terulang.

1.7.2. Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Tren kunjungan pasien IGD menurun	P	1. Mengidentifikasi penyebab penurunan kunjungan IGD. 2. Menganalisis tren kunjungan dan pola rujukan. 3. Memastikan mutu pelayanan IGD tetap sesuai standar
		D	1. Melakukan rekapitulasi data kunjungan IGD 2. Monitoring response time dan kesiapan SDM. 3. Evaluasi sarana, prasarana, dan alur pelayanan.
		S	1. Terjadi penurunan kunjungan dibanding bulan sebelumnya. 2. Tidak ditemukan kendala pelayanan maupun sarana. 3. Mutu pelayanan dan response time tetap memenuhi standar.
		A	1. Melanjutkan monitoring tren kunjungan setiap bulan. 2. Meningkatkan koordinasi dengan fasilitas kesehatan jejaring. 3. Mengoptimalkan promosi layanan IGD dan melakukan evaluasi berkala
2	Respon time di IGD lama	P	Salah satu penyebab respon time di IGD lama adalah pasien dengan diagnosa kompleks seperti sesak, bisa mengarah ke jantung atau paru.
		D	Membutuhkan observasi dan konsul untuk memastikan leader dpjp yang merawat pasien tersebut
		S	DPJP lebih selektif dalam MRS pasien terutama untuk pasien BPJS Kesehatan harus memenuhi kriteria rawat inap sesuai dengan kompetensi/SMF nya
		A	Apabila ada pasien yang terlalu lama observasi, bisa dikonsulkan ke yanmed (jam kerja), MOD (lur jam kerja) untuk mitigasi resiko agar pasien dan keluarga tidak komplain dan paham jika masih di observasi perbaikan K/U di igd
3	Pasien rencana rujuk yang tidak diperkenankan menunggu di IGD	P	Pasien advice rujuk dari awal dan DPJP minta untuk tidak boleh pindah ruangan karena takut klaim menjadi rawat jalan
		D	Koordinasi antara dokter casemix dan DPJP agar pasien diidentifikasi permasalahan yang bisa diatasi oleh RS
		S	Koordinasi agar pasien distabilkan dan tidak terburu-buru rujuk karena pertimbangan tidak langsung diterima atau bisa dirujuk penuh per poli
		A	Koordinasi dengan Dokter casemix dan PIPP

			dilibatkan karena pasien termasuk dalam kriteria kompleks
4	Adanya keterlambatan penerbitan SPRI dari IGD	P	1. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan input SPRI. 2. Meningkatkan kepatuhan pengisian ERM tepat waktu.
		D	Monitoring ketepatan waktu input SPRI.
		S	Masih ditemukan keterlambatan input SPRI yang memengaruhi proses administrasi pasien
		A	1. Membuat SPO penginputan SPRI 2. Melakukan sosialisasi ulang alur input SPRI dan membuat grup WA 3. Monitoring dan evaluasi kepatuhan secara berkala.

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ketidaklengkapan ERM rawat inap	P	1. Mengidentifikasi penyebab ketidaklengkapan pengisian ERM. 2. Meningkatkan kepatuhan pengisian ERM sesuai standar
		D	1. Monitoring kelengkapan pengisian ERM. 2. Mengingatkan DPJP dan perawat serta PPA lain untuk melengkapi
		S	Masih ditemukan ERM rawat inap yang belum terisi lengkap sesuai ketentuan.
		A	1. Melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala. 2. Memberikan umpan balik kepada unit dan DPJP terkait hasil monitoring
2.	Keterlibatan MPP dalam pengisian discharge planning belum berjalan	P	1. Mengidentifikasi penyebab belum optimalnya keterlibatan MPP dalam pengisian <i>discharge planning</i>. 2. Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan sesuai SPO
		D	1. Monitoring pelaksanaan <i>discharge planning</i> oleh MPP. 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada MPP serta unit terkait
		S	Masih ditemukan <i>discharge planning</i> yang belum melibatkan MPP sesuai ketentuan.
		A	1. Melakukan evaluasi kepatuhan secara berkala. 2. Memberikan umpan balik dan pendampingan kepada MPP serta unit pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan
3.	Pasien terganggu karena pengunjung yang masih banyak diluar jam besuk	P	Pasien terganggu karena pengunjung yang masih banyak diluar jam besuk
		D	Koordinasi dengan security untuk penertiban

			secara halus pada keluarga pasien yang besuk di rawat inap
		S	Ada warning atau himbauan yang terdengar di rawat inap
		A	KIE pada pasien yang akan istirahat, bahwa kondisi kamar akan steril sesuai jam minum obat dan istirahat malam jam 19.00 keatas

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Form perencanaan operasi masih ada kendala sehingga masih menggunakan hardcopy	P	Form perencanaan operasi belum bisa terinput tanggal real time, di review cetak, pemeriksaan yang tidak tercentang otomatis sudah terisi sehingga menjadi rancu
		D	Form perencana tidak link dengan rawat inap, sehingga rawat inap kesulitan membaca operan/ noted dari poli
		S	Lapor dan koordinasi dengan programmer, rencana perbaikan dan ditindaklanjuti
		A	Untuk layanan pasien lodingan, memakai hardcopy dan masih order ke RM untuk di print kan
2	Kebijakan konsul internal	P	Pasien poli yang mempunyai rujukan lebih dari satu, untuk kunjungan selanjutnya harus dilakukan konsul internal
		D	Potensi fragmentasi jika diidentifikasi pasien menggunakan 2 rujukan untuk kontrol ke RSPHM
		S	Jika pasien kronis, maka salah satu harus di PRB, jika pasien membutuhkan 2 DPJP sekaligus diberlakukan konsul internal (kecuali rujukan poli gigi), dan monitoring target untuk PRB atau stabilnya kapan
		A	Pasien yang mempunyai 2 rujukan, di list di grup pelayanan yang isinya PDF, Poli , farmasi dan Asce. Diharapkan jika ada pasien dengan 2 rujukan, salah satu harus ditarget dan di warning ke DPJP untuk PRB. Jika tidak bisa di PRB, harus disertakan alasannya.
3	Angka rujukan rawat jalan bulan Mei 2026 masih tinggi sebanyak 212 pasien	P	Angka rujukan rawat jalan bulan Mei 2026 masih tinggi sebanyak 212 pasien
		D	Rujukan rawat jalan diantaranya pro MRI, Pro EEG, pro Audiotimpanometri, pro sub spesialis onkologi, spesialis spine dan lain-lain
		S	Asce koordinasi dengan rawat jalan dan pendaftaran untuk mengkaji rujukan transit (perpanjangan rujukan)
		A	Identifikasi pasien yang bisa ditujuk tanpa harus berkunjung di poli RSPHM agar tidak terjadi pe

3.7.5 Permasalahan Unit Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Keterlambatan hasil PA menyebabkan keterlambatan berkas klaim.	P	Mengurangi keterlambatan hasil Patologi Anatomi (PA) agar tidak menyebabkan keterlambatan penyelesaian berkas klaim. Target: ≥90% hasil PA diterima sesuai target waktu yang ditetapkan.
		D	Melakukan koordinasi dengan laboratorium PA rujukan terkait estimasi waktu penyelesaian hasil, membuat monitoring status spesimen PA, serta melakukan reminder secara berkala terhadap pemeriksaan yang mendekati batas waktu klaim.
		S	Menganalisis jumlah kasus keterlambatan hasil PA, rata-rata waktu penyelesaian hasil, serta dampaknya terhadap keterlambatan pengajuan klaim. Mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan, baik dari proses pengiriman spesimen maupun proses pemeriksaan di laboratorium rujukan.
		A	Menyusun mekanisme monitoring dan eskalasi untuk hasil PA yang belum selesai, memperbaiki alur komunikasi dengan laboratorium rujukan, serta melakukan evaluasi berkala agar keterlambatan hasil PA tidak menghambat proses klaim rumah sakit.

3.7.6 Permasalahan Unit Gizi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	E-RM poli rawat jalan gizi masih belum terlaksana	P	Pemberian asuhan gizi harus dilakukan secara terintegrasi melalui penulisan CPPT
		D	Kolaborasi antara ahli gizi, programmer, dan pihak management RS dalam realisasi penulisan E-RM Poli gizi
		S	Risiko pemberian asuhan gizi tidak terintegrasi dan tidak adanya bukti ahli gizi telah melakukan edukasi kepada pasien rujukan poli dokter spesialis
		A	Tim gizi, programmer, dan pihak manajemen RS dalam realisasi penulisan ERM Gizi
2	Jarak rak penyimpanan bahan makanan kering kurang dari 15 cm	P	Mengidentifikasi penyebab jarak rak penyimpanan bahan makanan kering kurang dari standar minimal 15 cm dari lantai serta memastikan seluruh area penyimpanan memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Target: 100% rak penyimpanan memiliki jarak minimal 15 cm dari lantai.
		D	Memindahkan bahan makanan ke rak yang sesuai, menambahkan alas/palet apabila tinggi rak belum memenuhi standar, serta melakukan sosialisasi kepada petugas mengenai standar penyimpanan bahan makanan.
		S	Melakukan evaluasi dan inspeksi ulang terhadap jarak rak dari lantai, memantau kepatuhan petugas dalam penataan bahan makanan, serta

			menilai potensi risiko kontaminasi, kelembaban, dan keberadaan hama sebelum dan sesudah perbaikan dilakukan.
		A	Menetapkan standar penataan gudang bahan makanan kering dalam SPO, memasukkan pemeriksaan jarak rak sebagai checklist monitoring sanitasi instalasi gizi, serta melakukan monitoring berkala untuk memastikan kondisi tetap sesuai standar.

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis dan Pendaftaran

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ketidaklengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA	P	Mengajukan sosialisasi ke PPA terkait pengisian DRM yang baik dan benar
		D	Karu koordinasi dengan KABID
		S	Mengecek ulang setiap DRM yang akan di setor ke RM dan melengkapi yang kurang sehingga DRM sudah lengkap waktu di setor ke RM
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap
2.	Belum optimalnya penggunaan APM (Anjungan Pasien Mandiri): - Masih minim penggunaan aplikasi JKN mobile pasien.	P	Melakukan upaya peningkatan pemanfaatan APM dan aplikasi Mobile JKN untuk mempercepat proses pendaftaran pasien, mengurangi antrean loket, serta mendukung transformasi digital pelayanan rumah sakit.
		D	Melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penggunaan APM dan aplikasi Mobile JKN melalui petugas pendaftaran, media informasi, banner, serta pendampingan langsung bagi pasien yang mengalami kesulitan saat registrasi.
		S	Hasil monitoring menunjukkan penggunaan APM dan aplikasi Mobile JKN masih belum optimal karena sebagian pasien belum memahami cara penggunaan aplikasi, belum mengaktifkan akun Mobile JKN, serta lebih memilih melakukan pendaftaran secara langsung melalui loket.
		A	Meningkatkan sosialisasi penggunaan Mobile JKN dan APM secara berkelanjutan, menyediakan petugas pendamping pada jam sibuk, memasang petunjuk penggunaan yang mudah dipahami, serta melakukan monitoring jumlah pendaftaran melalui APM dan Mobile JKN sebagai indikator keberhasilan implementasi digitalisasi pelayanan.
3	Form-form yang sudah ERM masih ada yang belum muncul di biling validasi Rekam Medis	P	Mengajukan koordinasi dengan tim SIMRS/programmer untuk menelusuri penyebab form ERM belum terbaca di validasi RM.
		D	Karu berkoordinasi dengan KABID dan tim SIMRS/programmer, untuk sinkronisasi data ERM dengan sistem validasi RM.
		S	Melakukan uji coba penginputan ERM dan memastikan semua form muncul di billing serta

			tervalidasi di Rekam Medis
		A	Melakukan evaluasi berkala terhadap integrasi ERM dan billing. Memberikan laporan hasil evaluasi ke KABID dan programmer untuk perbaikan sistem jika masih ditemukan kendala.

3.7.8 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Kerusakan part CT Scan	P	Melakukan identifikasi penyebab gangguan operasional CT Scan yang sering mengalami error mengingat usia alat telah mencapai 6 tahun dan frekuensi penggunaan yang tinggi. Menyusun rencana perbaikan bersama vendor untuk menjaga kontinuitas pelayanan radiologi.
		D	Melaporkan kerusakan kepada vendor Philips dan melakukan koordinasi dengan teknisi. Pada tanggal 30 Mei 2026 dilakukan penggantian spare part oleh teknisi Philips (Bapak Rozy) sebagai tindakan perbaikan terhadap gangguan yang terjadi selama periode 1–30 Mei 2026.
		S	Setelah dilakukan penggantian spare part, dilakukan pengujian fungsi dan monitoring operasional alat. Hasil evaluasi menunjukkan CT Scan dapat kembali beroperasi normal dan pelayanan pemeriksaan CT Scan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
		A	Melakukan monitoring performa CT Scan pasca perbaikan, meningkatkan pelaksanaan preventive maintenance sesuai rekomendasi vendor, menyusun rencana pengadaan atau penggantian komponen kritis berdasarkan usia alat, serta mengusulkan kajian penggantian alat dalam perencanaan investasi apabila frekuensi kerusakan meningkat seiring bertambahnya usia alat.
2	Respon Time Pelayanan Radiologi >3 jam. Akar masalah: Diluar jam praktek dokter pembacaan foto masih lebih dari 3 jam, terlebih diatas jam 22.00.	P	Menurunkan angka response time pelayanan radiologi >3 jam menjadi ≤3 jam pada hasil pemeriksaan yang dilakukan di luar jam praktik dokter radiologi.
		D	Melakukan sosialisasi kepada dokter spesialis radiologi mengenai penggunaan dan akses link PACS yang telah diperbarui, termasuk pemberitahuan otomatis apabila terdapat pemeriksaan yang belum dibaca.
		S	Melakukan monitoring jumlah pemeriksaan dengan response time >3 jam setiap bulan, khususnya pemeriksaan yang selesai setelah pukul 22.00. Mengevaluasi kepatuhan dokter dalam membuka link PACS dan menganalisis penurunan rata-rata waktu pembacaan setelah sosialisasi dilakukan.
		A	Apabila masih ditemukan response time >3 jam, dilakukan evaluasi ulang mekanisme pembacaan di luar jam praktik, penyempurnaan sistem notifikasi PACS, serta penyusunan kebijakan pembacaan on-

		call/teleradiologi untuk pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari.
--	--	--

3.7.9 Permasalahan Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT		
1	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2025 dan belum mencapai target selisih 0.	P	Pertanggungjawaban	Selisih Hasil Stok Opname
		D	Berdasarkan Surat Edaran dari PT. Disa Prima Medika Nomor 103/DPM/I-SE/DIR/II/2026 tentang Pembebanan Selisih Stok Opname (SO)	
		S	Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0	
		A	Berdasarkan Surat Edaran dari PT. Disa Prima Medika Nomor 103/DPM/I-SE/DIR/II/2026 tentang Pembebanan Selisih Stok Opname (SO) : Terhitung mulai Januari 2026, setiap selisih stok opname (SO), baik positif maupun negatif, wajib dianalisis penyebabnya. Apabila terbukti melibatkan unit lain, maka pembebanan selisih ditanggung oleh unit terkait bersama PJ Rak, Kepala Instalasi, dan Kepala Bidang. Jika tidak ditemukan keterlibatan unit lain, maka selisih SO langsung dibebankan kepada PJ Rak, Kepala Instalasi, dan Kepala Bidang.	
2	Obat tertinggal rawat 2x24 jam dan obat RF rawat inap	P	Perbaiki kebijakan obat tertinggal.	
		D	Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.	
		S	1. Obat tertinggal bulan Mei mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi. 3. RF banyak yang menumpuk tidak diambil oleh pasien krs	
		A	1. Setiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. 2. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan. 3. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru. 4. PJ shift irna dan apoteker irna mengecek resep RF jika ada pasien yang belum mengambil RF, konfirmasi ruangan pasien tsb kenapa belum mengambil resep RF melalui WA, bias diambil atau meggunakan primantara	
3	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.	
		D	Membuat surat edaran untukDPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari	

			Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan menjadi death moving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negosiasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur
4	Klaim bpjs kesehatan : 1. Pasien iter 2x datang tidak sesuai tanggal. 2. Petugas input kadang terlewat centang kronis pada resep kronis	P	Sosialisasi ke tim farmasi
		D	Menjelaskan ke tim farmasi saat rapat internal farmasi
		S	1. Jika ada pasien iter yang terlambat dan harus mengubah tanggal iter kedua di bulan depan. 2. Petugas input terlewat tidak centang kronis pada resep kronis, 4. baru diketahui pada saat diverif oleh admin farmasi, beberapa resep harus dibatal verif dulu baru bisa diedit
		A	1. Jika ada pasien iter yang terlambat dan harus mengubah tanggal iter kedua di bulan depan, pastikan tanggal kontrol selanjutnya. di bulan depan sesuaikan dengan jadwal dokter di screenshot di bagian iter 2x nya. 2. Untuk meminimalkan batal verif oleh admin farmasi, pada saat klik ambil obat diperhatikan jika muncul data lab maka resep tersebut sudah dicentagn kronis, tetapi bila di klik ambil obat tidak muncul data lab maka resep kronis tersebut belum tercentang.

3.8 Profil SDM

3.8.3 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	Profesi Ners	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Casemix Manager	SMK	1	1	1	0	0
7	Farmasi	Profesi Apoteker	39	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		0	0	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
8	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan		8	7	1	0

		Informasi Kesehatan					
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
9	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
10	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
11	Gizi	S1 Ilmu Gizi	15	1	1	0	1
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		2	2	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
12	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
13	ICU dan HCU	Profesi Ners	10	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		4	2	2	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
14	IGD	Profesi Ners	23	10	8	2	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
15	IKO	Profesi Ners	11	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
16	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
17	IPSRs	S1 Teknik Elektro	6	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
18	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
19	IRNA 2C	Profesi Ners	7	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
20	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	17	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		9	6	3	0
21	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	12	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
22	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	1	2	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
23	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	22	9	4	5	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
24	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0

		D3 Kebidanan		7	7	0	0
25	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
26	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	8	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
27	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	6	2	0
28	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
29	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
30	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	12	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		0	0	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	5	1	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
31	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
32	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
33	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
34	SDM	S1 Sosial	1	1	1	0	0
35	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
36	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
37	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
38	Cleaning Service	SMK	39	12	7	5	0
		SMA		22	18	4	0
		SMP		5	5	0	0
39	Security	SMK	11	5	2	3	1
		SMA		6	6	0	0
40	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
41	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
42	Staf Orientasi	SMK	6	2	0	2	0
		D3 TVF		1	0	1	0
		D3 Perawat Gigi		1	0	1	0
		D3 Gizi		1	0	1	0
		D4 Dizi		1	0	1	0
Total Karyawan			363	363	269	94	2
43	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	0

44	Dokter Casemix	Dokter Umum	2	2	0	2	0
45	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	5	5	1	4	1
46	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
48	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
49	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
50	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
54	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
56	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
57	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
58	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
61	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
63	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
67	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
68	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total Dokter			65	65	2	63	1
Total Keseluruhan			428	428	271	157	3

Keterangan :

Pada bulan Juni terdapat 2 staf dan 1 dokter resign.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Juni 2026 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Juli 2026, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Juli 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES	PERUSAHAAN	01 Mei	30 APRIL 2013	PELAYANAN KESEHATAN		

	INDONESIA		2012	(selanjutnya perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/II/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

			2024				
41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS-RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

			2019				
55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E- PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUNAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E- PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA- JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA	INSTANSI	02	01 September		262/DPM/E-	B-MKT 01/001/623/VII/2024

	MEGA	KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/II/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-

84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus 2023	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E- PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I- PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E- PKS/VI/2022	/YMPI/HI/PKS/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E- PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E- PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/II/2024

98	RSUD Bangil	INSTANSI KESEHATAN	22 Juli 2024	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	

112	RSU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	22 Agustus 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025